

Hochschule Aalen
Fakultät Optik und Mechatronik
User Experience



Bachelorarbeit zum Thema:

**Untersuchung der Bereitschaft von Patienten zur
Beteiligung an Flächenhygiene in Krankenhäusern
anhand von Desinfektionstüchern**

Zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Studiengang User Experience Engineering

Vorgelegt von: Kristina Gräfenstein

Matrikelnummer: 81246

Fachsemester: 8

Abgabedatum 15.04.2024

Erstbetreuer: Prof. Dr. Constance Richter

Zweitbetreuer: Dr. Martin Grünewald

Hochschule Aalen

Fakultät Optik und Mechatronik

Studiengang mit Schwerpunkt User Experience

Thema: Untersuchung der Bereitschaft von Patienten zur Beteiligung an
Flächenhygiene in Krankenhäusern anhand von Desinfektionstüchern

Bachelorthesis Wintersemester 2023/24

Kristina Gräfenstein, 81246

Betreuer: Prof. Dr. Constance Richter, Dr. Martin Grünewald

Abgabedatum: 15.04.24

Sperrvermerk Bachelorarbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel „Untersuchung der Bereitschaft von Patienten zur Beteiligung an Flächenhygiene in Krankenhäusern anhand von Desinfektionstüchern“ beinhaltet vertrauliche Daten der Firma Hartmann AG und des Klinikum Heidenheim. Sie darf nur von dem Erst- und Zweitgutachter sowie berechtigten Mitgliedern des Prüfungsausschusses eingesehen werden. Eine Veröffentlichung und Vervielfältigung der Bachelorarbeit – auch in Teilen – ist innerhalb der Sperrfrist untersagt. Dritten darf diese Arbeit während der Sperrfrist nur mit der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers und Unternehmens zugänglich gemacht werden.

Höchstädt, 15.04.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gräfenstein', written in a cursive style.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen sowie Hilfsmittel genutzt habe. Alle Ausführungen, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind deutlich kenntlich gemacht. Außerdem versichere ich, dass die vorliegende Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.

Name, Vorname: Gräfenstein, Kristina

Matrikelnummer: 81246

Datum, Unterschrift: 15.04.2024, 

Danksagung

Zu Beginn möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Constance Richter für ihre hilfreiche und fachliche Unterstützung während des Bearbeitungszeitraums. Außerdem gebührt mein Dank Herr Hans Eberhardt aus dem Klinikum Heidenheim, der mir während des gesamten Entstehungsprozesses als Ansprechpartner zur Seite stand und mich stets bei organisatorischen Fragen umfangreich unterstützte. Zudem bedanke ich mich bei Dr. Martin Grünewald aus dem Klinikum Heidenheim und Herr Thomas Häni von der Hartmann AG für den fachlichen Einblick in die Medizinbranche, sowie die Möglichkeit mich mit einem Produkt der Firma befassen zu dürfen. Abschließend gebührt mein Dank allen Interviewpartnern, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können.

Gender Erklärung

Zur besseren Lesbarkeit und für ein besseres Textverständnis, wurde in den folgenden formulierten Texten das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Abstract

Jährlich gibt es eine Vielzahl an Infektionen im Krankenhaus mit schwerwiegenden Folgen. Aus diesem Grund ist die Einhaltung von Maßnahmen zur Infektionsprävention lebenswichtig. Dazu gehören die Hände- und Flächenhygiene. Vor allem Patienten würden davon profitieren, wenn sie diese Maßnahmen zusammen mit dem Personal umsetzen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, wie weit Patienten bereit sind, sich eigenständig an der Flächenhygiene zu beteiligen, um so Übertragungswege von Keimen und Bakterien zu minimieren und Ansteckungen zu verhindern. Mit Hilfe einer Handlungsempfehlung sollen die Teilnahme an Flächenhygiene gefördert werden.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden die ersten zwei Phasen der menschenzentrierten Gestaltung genutzt, indem der Nutzungskontext im Fokus steht. Durch Beobachtung, Interviews und einem Usability Test, sollen die Umgebung, Herausforderungen und Ziele der Patienten näher betrachtet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Wunsch zur selbständigen Flächenhygiene anhand der Desinfektionstücher vorhanden ist und vor allem im Bad als wichtig erachtet wird. Die Teilnahme daran soll aber nicht die professionellen Tätigkeiten des Personals ersetzen, sondern lediglich unterstützen. Die Handlungsempfehlung weist hierfür Wege auf, wie die Beteiligung an der Flächenhygiene sichergestellt und erweitert werden kann.

Die weitere Forschung könnte die Umsetzung und Untersuchung der Maßnahmen auf andere Stationen ausweiten.

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Projekthintergrund	1
1.2	Motivation	2
1.3	Ziel der Arbeit	3
1.4	Kooperationspartner	3
1.5	Struktur der Arbeit	6
2	Angewandte Methodiken.....	8
2.1	Bearbeitungsansatz.....	8
2.1.1	Design Thinking	8
2.1.2	Menschenzentrierter Gestaltungsprozess.....	10
2.2	Literaturrecherche	15
2.3	Interviews	16
2.4	Beobachtung	17
2.5	Unmoderierter Usability-Test.....	17
2.6	Datenauswertung	19
2.6.1	Affinity Diagram	19
2.6.2	Card-Sorting.....	21
2.7	Persona	21
3	Theoretische Grundlage	23
3.1	Flächenhygiene und Infektionsprävention.....	23
3.1.1	Basishygiene.....	23
3.1.2	Hygieneplan.....	24
3.1.3	Übertragungswege.....	26
3.1.4	Patientennahe und patientenferne Flächen	28
3.1.5	Flächendesinfektion	30
3.2	Desinfektionstücher	32
4	Empirische Datenerhebung	34

4.1	Patienteninterviews	34
4.1.1	Vorbereitung und Rekrutierung	34
4.1.2	Interviewleitfaden	36
4.1.3	Interviewdurchführung.....	37
4.2	Interviews mit medizinischem Personal.....	38
4.2.1	Vorbereitung und Rekrutierung	38
4.2.2	Interviewleitfaden	39
4.2.3	Interviewdurchführung.....	40
4.3	Interviews HARTMANN AG	41
4.3.1	Vorbereitung und Rekrutierung	41
4.3.2	Interviewleitfaden	41
4.3.3	Interviewdurchführung.....	42
4.4	Unmoderierter Usability-Test	42
4.4.1	Vorbereitung und Rekrutierung	42
4.4.2	Testskript	43
4.4.3	Durchführung.....	44
4.5	Reflexion der Methoden.....	45
4.6	Beobachtung	46
5	Ergebnisse der Auswertung.....	48
5.1	Patienteninterviews	48
5.2	Interviews mit medizinischem Personal.....	54
5.3	Interviews HARTMANN AG	60
5.4	Unmoderierter Usability-Test	62
6	Persona	66
7	Handlungsempfehlung.....	68
7.1	Informationen und Aufklärung für Patienten	68
7.2	Platzierung der Tücher in den Patientenzimmern.....	69
7.3	Förderung von Feedback	71

8	Fazit.....	73
9	Ausblick.....	75
10	Literaturverzeichnis.....	76
11	Anhang.....	81

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Menschenzentrierter Gestaltungsprozess (Geis & Tesch 2019, S. 38) ..	11
Abbildung 2: Übertragungswege ausgehend von kontaminierten Oberflächen („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1076)	28
Abbildung 3: Bacillol® 30 Sensitive Tissues (HARTMANN GROUP 2024b)	32
Abbildung 4: Bacillol® 30 Sensitive Tissues Wirksamkeit (sortimentskatalog- desinfektion-hygiene-2023, S. 35)	33
Abbildung 5: Ergebnisse Nutzungshäufigkeit von Desinfektionsprodukten (eigene Darstellung)	48
Abbildung 6: Angst vor Ansteckung (eigene Darstellung)	50
Abbildung 7: Aktiver Schutz der Besucher durch Patienten (eigene Darstellung) ...	52
Abbildung 8: Anzahl Patienten zur Beteiligung an Flächenhygiene (eigene Darstellung)	53
Abbildung 9: Wunsch nach Desinfektionstüchern für Krankenhausaufenthalt (eigene Darstellung)	65
Abbildung 10: Marianne Förster (eigene Darstellung)	66
Abbildung 11: Persona Marianne Förster Anhang (eigene Darstellung)	82
Abbildung 12: Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 1	227
Abbildung 13: Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 2	228
Abbildung 14: Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 3	229
Abbildung 15: Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 4	230
Abbildung 16: Information Besuchertoilette in Kabine (eigene Darstellung)	231
Abbildung 17: Feedbackbögen im Besucherraum (eigene Darstellung)	231
Abbildung 18: Patientenzimmer (eigene Darstellung)	232
Abbildung 19: Nachtkästchen (eigene Darstellung)	232
Abbildung 20: Patientenbadezimmer Teil 1 (eigene Darstellung)	233
Abbildung 21: Patientenbadezimmer Teil 2 (eigene Darstellung)	234
Abbildung 22: Patientenbadezimmer Teil 3 (eigene Darstellung)	234
Abbildung 23: Patientenzimmer Handschuhspender und Desinfektionsmittel (eigene Darstellung)	235

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Interviewte Patienten.....	38
Tabelle 2: Übersicht Patienten Usability-Test	44

1 Einleitung

1.1 Projekthintergrund

Händehygiene ist ein wichtiger Schritt bei der Vermeidung von Ansteckung mit Krankheiten und Weitergabe von Erregern. In vorausgehenden Bachelorarbeiten wurde bereits ein tiefer Einblick in die Thematik der Händehygiene gewährt und Konzepte entwickelt, wie die Händehygiene-Compliance verbessert werden kann.

Jährlich erkranken in Deutschland 400.000 bis 600.000 Patienten an einer nosokomialen Infektion (RKI - 2019 - Neue Schätzung zur Krankheitslast durch Krankenhaus-Infektionen 2024). Diese werden entweder durch körpereigene oder durch aus der Umgebung stammenden Erregern ausgelöst. Die mangelnde Händehygiene spielt hierbei eine große Rolle und zählt zur Hauptursache (RKI - Nosokomiale Ausbrüche 2024).

Jedoch zählt neben Händehygiene, auch Flächenhygiene als Maßnahme zur Prävention von nosokomialen Infektionen. Beide Maßnahmen gehen Hand in Hand und sollten nicht nur von dem Krankenhauspersonal, sondern auch von Patienten beachtet werden. Meistens wird aber bei Patienten vor allem Wert auf die Händehygiene gelegt, sodass die Flächenhygiene in den Hintergrund rutscht. In Kooperation mit der Paul HARTMANN AG soll im Klinikum Heidenheim die Einstellung der Patienten zu dem Thema Flächenhygiene näher betrachtet und untersucht werden, ob Patienten sich eigenständig daran beteiligen würden.

1.2 Motivation

Die Motivation für die vorliegende Arbeit entsprang der Neugier und dem Wunsch, einen Einblick in den medizinischen Bereich zu bekommen und mich im Kontext der User Experience an einem Projekt im Gesundheitsfeld zu beteiligen. Als das Thema als potenzielles Forschungsgebiet angeboten wurde, war mein Interesse geweckt.

Das Thema Schutz und Prävention von Krankheiten ist von großer Wichtigkeit, vor allem in einer Welt, in der die Gesellschaft immer noch von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet und konfrontiert wird. Trotz der Herausforderungen während der Pandemie, den Fortschritten in der medizinischen Forschung, sowie den verfügbaren Maßnahmen zur Prävention, bleibt die Compliance der Menschen oft niedrig.

Vor allem in klinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, sollte eine sichere Umgebung geleistet sein, indem man sich aktiv an Maßnahmen zur Prävention, wie zum Beispiel Einhaltung der Flächenhygiene, beteiligt. Erreger und Bakterien stellen eine große Gefahr für Patienten, Personal und Besucher dar, sodass man sich stets an diese Regelungen halten sollte. Leider versterben dennoch jährlich etwa 10.000 bis 20.000 Menschen in Deutschland an Krankenhausinfektionen (Krankenhaushygiene 2024). Trotzdem sind viele Menschen überfordert und müde von der Hygiene – und Schutzmaßnahmen. Es wird eine Lösung benötigt, um das Bewusstsein für das Thema zu stärken und die Compliance zu verbessern.

1.3 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Bachelorthesis ist es, die Bedeutung und Wirksamkeit von Flächenhygiene im Krankenhaus zu beleuchten und herauszufinden, wie die Patienten zu dem Thema eingestellt sind. Es soll untersucht werden, wie groß ihre Bereitschaft ist, sich eigenständig an Flächenhygiene zu beteiligen, wobei im Fokus ein Produkt der Paul HARTMANN AG steht, welches bereits auf dem Markt ist und im Klinikum genutzt wird. Dabei sollen mögliche Herausforderungen aufgezeigt, sowie eine daraus resultierende Empfehlung für eine mögliche Implementierung von Hygienemaßnahmen oder Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Literaturrecherche durchgeführt, um den Hintergrund und Umfang der Flächenhygiene zu verstehen, sowie Methoden des menschenzentrierten Gestaltungsprozesses eingesetzt, um die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder zu erfassen und Herausforderungen zu identifizieren. Die Ergebnisse werden evaluiert, um eine Handlungsempfehlung abzuleiten.

1.4 Kooperationspartner

Die Bachelorarbeit entsteht im Rahmen einer Kooperation zwischen der Hochschule Aalen, dem Klinikum Heidenheim und der Paul HARTMANN AG.

Klinikum Heidenheim

Das Klinikum Heidenheim versorgt jährlich, durch den Einsatz von 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 60.000 Patienten vollstationär, teilstationär und ambulant rund um die Uhr. Das Klinikum ist ein wichtiger

Bestandteil der Gesundheitsversorgung im Landkreis Heidenheim und der Region Ostwürttemberg (www.kliniken.de 2024).

Es besitzt über 15 Fachabteilungen, in denen Patienten mit unterschiedlichen Beschwerden geholfen werden kann. Dazu gehören zum Beispiel die Neurologie, die Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie, die Urologie, die Orthopädie und Unfallchirurgie und viele weitere (Kliniken und Fachabteilungen- Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH 2024).

Was das Krankenhaus aber hervorhebt ist das hauseigene Institut für Krankenhaushygiene, welches 2016 gegründet wurde, um Patienten, Mitarbeiter und Besucher vor Infektionen zu schützen. Die Hauptaufgaben dieser Fachkräfte bestehen darin, ...

- ... Patienten und Mitarbeiter bei hygienischen Maßnahmen zu beraten.
- ... Arbeitsprozesse bezüglich ihrer Hygiene zu analysieren.
- ... einzelne Bereiche zu überprüfen.
- ... Mitarbeiter zur Prävention von Infektionen zu schulen.
- ... Umbaumaßnahmen zu begleiten.
- ... Trink- und Badewasser zu kontrollieren.
- ... neue Maßnahmen der Prävention von Infektionen zu erforschen und zu entwickeln (Institut für Krankenhaushygiene- Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH 2024).

Des Weiteren gibt es eine Hygienekommission, die dafür verantwortlich ist, hygienische Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Durch die Arbeit und den Einsatz des Institutes für Krankenhaushygiene wird für die Sicherheit

des Patienten gesorgt und stets weiter verbessert, um den Schutz zu gewährleisten. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Aufgaben darin, ...

- ... Maßnahmen zu entwickeln, um krankenhauserworbene Infektionen zu vermeiden.
- ... den Hygieneplan zu gestalten.
- ... Maßnahmen an einzelne Bereiche im Klinikum zu kommunizieren.
- ... den Tätigkeitsbereich des Institutes für Krankenhaushygiene zu prüfen.
- ... Infektionen und multiresistente Erreger zu erfassen.
- ... bei der Auswahl hygienerelevanter Geräte zu beraten.
- ... Fortbildungen zu Themen der Krankenhaushygiene festzulegen (Institut für Krankenhaushygiene- Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH 2024).

Paul HARTMANN AG

Die Paul HARTMANN AG ist mit 10.000 Mitarbeitenden in 36 Ländern vertreten. Das Unternehmen hat sich im Gesundheitswesen auf vier Segmente spezialisiert:

- Inkontinenzmanagement
- Wundversorgung und Diagnostik
- Infektionsmanagement
- Komplementäre Divisionen der Gruppe (Ihr Einblick in die HARTMANN-DNA 2024)

Begonnen hat aber alles 1818, als Ludwig von Hartmann die Spinnerei Meebold erwarb und zu einer der größten Baumwollspinnereien Deutschlands wurde. Das Unternehmen wurde aber erst in den 1870er Jahren um Medizinprodukte ergänzt, nachdem das Geschäft von den Söhnen, unter anderem Paul Hartmann, übernommen wurde. Dadurch wurde die Wundversorgung revolutioniert und über Jahre stets verbessert (HARTMANN's Werte und Traditionen 2024).

Heutzutage hat die Paul HARTMANN AG sein Sortiment um ein Vielfaches erweitert. Darunter fallen Produkte für die Versorgung von Wunden, sowie Wundheilung, Diagnosegeräte, Desinfektionsprodukte und chirurgische Instrumente, aber auch mehrere Tochtergesellschaften (HARTMANN's Werte und Traditionen 2024).

Bereits in den vergangenen Jahren sind schon zwei weitere Bachelorarbeiten in dieser Kooperation zu dem Thema Händehygiene Compliance entstanden. Die vorliegende Thesis beschäftigt sich jedoch mit dem Thema der Flächenhygiene.

1.5 Struktur der Arbeit

Die Arbeit beginnt in Kapitel 2 mit der Einführung in die angewandten Methodiken, die zur Bearbeitung der Bachelorarbeit verwendet wurden, gefolgt von einer thematischen Grundlage zum Thema Flächenhygiene in Kapitel 3. Kapitel 4 widmet sich der Umsetzung der empirischen Datenerhebung. Die Beantwortung der Forschungsfrage folgt in Kapitel 5, wo die Ergebnisse aus den Interviews und dem Usability-Test präsentiert werden. In Kapitel 6 wird die Persona vorgestellt, die basierend auf den erhobenen Daten entstanden ist, sowie Handlungsempfehlung in Kapitel 7.

Die Arbeit endet mit einem Fazit und einem Ausblick, welche die Ergebnisse der Arbeit zusammenfassen, und weitere Forschungsmöglichkeiten aufzeigen.

2 Angewandte Methodiken

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert, das für die Bearbeitung der vorliegenden Bachelorarbeit genutzt wurde.

2.1 Bearbeitungsansatz

Zu Beginn dieser Arbeit wurde das Thema, sowie das angestrebte Ziel mit allen Beteiligten dieses Projektes besprochen und festgelegt. Somit besteht die erste Aufgabe darin, genau zu definieren, wie die Forschungsfrage „Inwieweit sind Patienten im Krankenhaus dazu bereit die Desinfektionstücher als Mittel zur Flächenhygiene eigenständig zu nutzen?“ bearbeitet und beantwortet werden kann. Hierfür werden zwei Methoden genauer betrachtet.

2.1.1 Design Thinking

Die Methode **Design Thinking** ist ein iterativer, nicht linearer Prozess mit dem Ziel neue Lösungen für bestehende Probleme zu entwickeln. Dazu orientiert man sich an den Nutzern (Schallmo & Lang 2020, S. 33–34). Die Vorgehensweise unterteilt sich in sechs Phasen, zu denen jederzeit zurückgekehrt werden kann. Diese Phasen sind auf einen Problemraum und einen Lösungsraum unterteilt und bestehen aus sechs Teilschritten:

1. Verstehen
2. Beobachten
3. Standpunkt definieren
4. Ideen finden
5. Prototyp entwickeln
6. Testen

In der Phase „Verstehen“ wird die Problemstellung definiert und die Aufgabe beschrieben, die gelöst werden soll. Die Phase „Beobachten“ fokussiert sich darauf, bereits vorhandene Lösungen zu betrachten und Nutzer zu beobachten oder zu befragen. Beim „Standpunkt definieren“ werden die gesammelten Informationen zusammengetragen, um ein Fundament zu schaffen und wichtige Daten, von nicht relevanten zu trennen. Die Veranschaulichung kann in Form einer Persona, einer fiktiven Figur, erfolgen, die den gewonnen, typischen Merkmalen entspricht. Mit diesem Schritt verlässt man den Problemraum und begibt sich in den Lösungsraum. In der Phase „Ideen finden“ werden erste Lösungen im Team mit Hilfe eines gemeinsamen Brainstormings gesammelt. Diese Ideen werden einzeln betrachtet und bewertet. Anschließend wird beim Schritt „Prototypen entwickeln“ aus den gesammelten Ideen eine Lösung für den Nutzer entwickelt. Hierbei spielt es keine Rolle wie ausgeprägt und ausgearbeitet der Prototyp ist. Es soll nur möglichst verständlich für den Anwender sein, um Feedback zu generieren. Ist der Prototyp so weit fertig, kann in der letzten Phase „Testen“ die Zielgruppe, unter Beobachtung der UX-Experten, damit interagieren. Jegliche Art von Herausforderungen oder Problemen, Verbesserungsvorschlägen oder Wünschen werden erfasst, um diese in einem späteren Verfahren miteinzubeziehen und den Prototypen weiterzuentwickeln. Ist diese Phase beendet, endet auch der Design Thinking Prozess. Da dieser jedoch iterativ ist, kann jederzeit zu einer der vorherigen Teilschritte zurückgekehrt werden, um Änderungen vorzunehmen (Schallmo & Lang 2020, S. 39–40).

2.1.2 Menschenzentrierter Gestaltungsprozess

Die **menschzentrierte Gestaltung** beschreibt eine „Herangehensweise bei der Gestaltung und Entwicklung von Systemen, die darauf abzielt, interaktive Systeme gebrauchstauglicher zu machen, indem sie sich auf die Verwendung des Systems konzentriert und Kenntnisse und Techniken aus den Bereichen der Arbeitswissenschaft/Ergonomie und der Gebrauchstauglichkeit anwendet“ (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 9). In der Praxis wird hierbei aber auch oft von „benutzerzentrierter Gestaltung“ gesprochen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass letzteres die Stakeholder nicht in dem Prozess als Nutzer berücksichtigt. Jedoch werden beide Begrifflichkeiten oft als synonym angewendet (Geis & Tesch 2019, S. 31).

Bei den **Stakeholdern** handelt es sich um eine „Einzelperson oder Organisation, die ein Anrecht, einen Anteil, einen Anspruch oder ein Interesse auf ein bzw. an einem System oder an dessen Merkmalen hat, die ihren Erfordernissen und Erwartungen entsprechen“ (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 10). Somit werden alle Personen miteinbezogen, die eine Bezug zu dem Produkt oder System haben. Die **Benutzer** sind wiederum Personen, die mit dem System, Produkt oder Dienstleistung interagieren (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 10).

In diesem Gestaltungsprozess werden vier Phasen durchlaufen:

- „1. Verstehen und Beschreiben des Nutzungskontextes*
- 2. Spezifizieren der Nutzungsanforderungen*
- 3. Erarbeitung der Gestaltungslösungen*
- 4. Evaluieren der Gestaltung“ (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 19).*

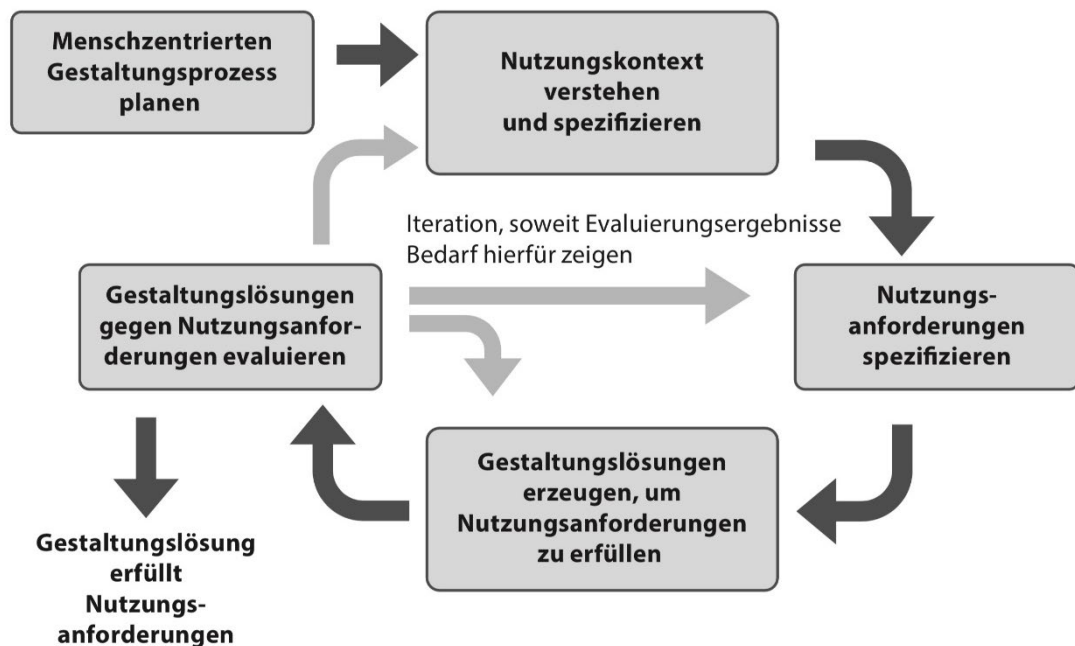


Abbildung 1: Menschenzentrierter Gestaltungsprozess (Geis & Tesch 2019, S. 38)

Der Prozess läuft iterativ ab bis das System, das Produkt oder die Serviceleistung allen Anforderungen der Nutzer entsprechen. Bei der Umsetzung ist es wichtig, dass die Grundsätze der menschenzentrierten Gestaltung verstanden worden sind und befolgt werden (Geis & Tesch 2019, S. 36).

„Die Gestaltung beruht auf einem umfassenden Verständnis der Benutzer, Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebungen“ (Geis & Tesch 2019, S. 36).

Ohne die Berücksichtigung der Nutzer und der direkten oder indirekten Stakeholder kann das Produkt, das System oder die Dienstleistung nicht gestaltet werden. Ohne das vollständige Verständnis für die Merkmale der Benutzer, die Aufgaben, die Ziele, die Ressourcen und die Umgebung, die den **Nutzungskontext** bilden, können keine Benutzererfordernisse gebildet

werden. Der Nutzungskontext spielt also eine wesentliche Rolle in dem Gestaltungsprozess (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 14).

„Die Benutzer sind während der Gestaltung und Entwicklung einbezogen“

(Geis & Tesch 2019, S. 37).

Es ist wichtig, die Nutzergruppe stets in den Entwicklungsprozess miteinzubeziehen, da sie ja auch diejenigen sind, die das System, Produkt oder Dienstleistung in Zukunft nutzen werden. Die Art und Weise und wie oft diese Gruppe involviert wird, kann in Abhängigkeit des Projektes angepasst werden. Die Benutzer bilden die wichtige Informationsquelle über den Nutzungskontext, sodass bei der Evaluierung der Lösung weitere wichtige Daten erfasst werden können und das Projekt jederzeit angepasst werden kann (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 14).

„Das Verfeinern und Anpassen von Gestaltungslösungen wird fortlaufend auf der Basis der benutzerzentrierten Evaluierung vorangetrieben“ (Geis & Tesch 2019, S. 37).

Die Gefahr, dass ein System gestaltet wird, welches nicht den Anforderungen der Benutzer entspricht kann vermieden werden, indem man das Feedback der Benutzer in den Gestaltungsprozess einbezieht und die Bewertung der Lösung zur Verbesserung nutzt. Die frühzeitige Evaluierung anhand eines realen Szenarios kann die Lösung in der späteren Entwicklung nochmal optimieren. Am Ende sollte das System erneut getestet werden, um zu bestätigen, dass alle Anforderungen erfüllt sind (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 15).

„Der Prozess ist iterativ“ (Geis & Tesch 2019, S. 37).

Während der Entwicklung ist es wichtig regelmäßig Veränderungen vorzunehmen, wenn neue Informationen gesammelt werden, um Fehler und Unsicherheiten stückweise zu entfernen. Da es unmöglich ist, alle Details gleich zu Beginn des Projektes zu identifizieren, bietet sich der iterative Prozess der menschenzentrierten Gestaltung ideal für die komplexe Entwicklung eines interaktiven Systems an. Viele Erfordernisse werden erst im Laufe des Projektes erfasst und der Nutzungskontext wird schrittweise detaillierter. Damit kann eine Lösung entwickelt werden, die besser auf den Nutzer zugeschnitten ist (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 15).

„Bei der Gestaltung wird die gesamte User Experience berücksichtigt“ (Geis & Tesch 2019, S. 37).

Die **User Experience** ist die „Wahrnehmung und Reaktion einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Systems, eines Produktes oder einer Dienstleistung resultieren“ (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 11). Sie besteht „aus der Darstellung, Funktionalität, Systemleistung, dem interaktiven Verhalten und den unterstützenden Ressourcen eines interaktiven Systems“ (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 16). Die Entwicklung muss alle Aspekte wie zum Beispiel frühere Erfahrungen und Interaktionen des Benutzers mit einem ähnlichen System, aber auch Erwartungen, Einschränkungen und Wahrnehmung berücksichtigen. Es müssen auch organisatorische Auswirkungen, Benutzerdokumentation und die Verpackung betrachtet werden (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 16).

„Im Gestaltungsteam sind fachübergreifende Kenntnisse und Perspektiven vertreten“ (Geis & Tesch 2019, S. 37).

Der letzte Grundsatz beschreibt die Vielfalt, die ein Team bei der menschenzentrierten Gestaltung besitzen sollte. Die Gestaltungslösung profitiert davon, wenn unterschiedliche Personen mit verschiedenen Perspektiven und Fachwissen daran arbeiten und viele vielfältige Ideen zusammengetragen werden. Aus der Kreativität, der unterschiedlichen Fachbereiche, ergeben sich Ansätze, die zuvor nicht betrachtet wurden oder erkenntlich waren. Somit können Hindernisse in anderen Bereichen frühzeitig festgestellt werden und die Teammitglieder können diese Aspekte bei der Entwicklung berücksichtigen. Einige Beispiele für Kompetenzbereiche, die vertreten sein sollten wären die Benutzer, Fachexperten, Personen aus dem Bereich der Geschäftsanalyse und Personalwesen, Programmierer, Designer und natürlich User Experience Spezialisten (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 17).

Hat man die Grundsätze verstanden, wird in der ersten Phase des menschenzentrierten Gestaltungsprozesses „Nutzungskontext verstehen“ Informationen zum Kontext, in dem das System genutzt werden soll, gesammelt und analysiert. Hierfür betrachtet man die Benutzer, die das Produkt nutzen sollen oder weitere Stakeholder, die Ziele, die erreicht werden sollen, Aufgaben, Ressourcen, sowie die physische und soziale Umgebung (Geis & Tesch 2019, S. 52). Der Nutzungskontext kann mit Hilfe von Beobachtungen und Interviews erhoben werden. In der zweiten Phase „Spezifizieren der Nutzungsanforderungen“ werden die Nutzungsanforderungen aus dem Nutzungskontext der Benutzer des Systems hergeleitet (Geis & Tesch 2019, S. 97). In der dritten Phase „Erarbeiten der Gestaltungslösungen“ werden die Nutzungsanforderungen erfüllt zum Beispiel in Form von Prototypen, welche anschließend von den

Nutzern bewertet werden können und sich somit weitere Nutzungsanforderungen ergeben können (DIN EN ISO 9241-210:2020-03, S. 24). In der letzten Phase „Evaluierung der Gestaltung“ wird der entwickelte Prototyp getestet. Möglich Evaluierungsmethoden können Usability-Tests mit Nutzern, Usability-Inspektionen durch UX Professionals oder Benutzerbefragungen sein (Geis & Tesch 2019, S. 169). Mit der letzten Phase ist der menschenzentrierte Gestaltungsprozess auch beendet. Da er wie der Design Thinking Prozess auch iterativ ist, kann jederzeit zu einer der vorherigen Schritte zurückgekehrt werden.

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde der menschenzentrierte Gestaltungsprozess gewählt, da der Fokus darauf liegt den Nutzungskontext der Benutzer und weiterer Stakeholder zu untersuchen und zu analysieren. Die erste Phase bietet sich also hervorragend für die Bearbeitung dieser vorliegenden Arbeit an. Am Ende dieser Arbeit soll ein klares Verständnis über den Ist-Zustand, die Frage nach der Bereitschaft der Patienten, sich an der Flächenhygiene selbstständig zu beteiligen und eine Handlungsempfehlung vorliegen.

2.2 Literaturrecherche

Um ein allgemeines Verständnis für das Thema Flächenhygiene aufzubauen, wurde zu Beginn dieser Bachelorarbeit eine Literaturrecherche durchgeführt. Es handelte sich hierbei um eine Kombination aus Versuchsstudien, wissenschaftlichen Artikeln, sowie weiteren online Quellen. Da die Forschung am Klinikum Heidenheim durchgeführt werden sollte, bot die Literaturrecherche eine hilfreiche Basis, um einen Fragenkatalog zu erstellen, um die ermittelten Informationen aus der Recherche mit der realen Situation

und dem Ablauf im Krankenhaus zu vergleichen und um ergänzende Informationen zu erlangen.

2.3 Interviews

Zum Zweck der Nutzungskontextanalyse wird die Methodik **Interviews** gewählt, um weitere Informationen zu erheben. Es ist eine „Methode zur Datensammlung, die einige sorgfältig ausgewählte Personen eingehend befragt, um ein besseres Verständnis des Nutzungskontextes für ein vorhandenes oder geplantes interaktives System zu gelangen. Durch die Befragung und Interpretation werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der Benutzer eines interaktiven Systems aufgedeckt“ (Geis & Tesch 2019, S. 60).

Eine richtige Anzahl an Interviewteilnehmern ist nicht vorgegeben, jedoch gehen Experten davon aus, dass fünf Nutzer pro Benutzergruppe ausreichen, um genügend Daten für die Herleitung der Anforderungen im weiteren Verlauf zu formulieren (Geis & Tesch 2019, S.60).

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, wurde auf Grundlage der Literaturrecherche ein Fragenkatalog erstellt. In Vorbereitung auf die Interviews wird diese Liste zur Strukturierung genutzt und in Form eines Leitfadens angewendet, um nicht vom Thema abzuweichen und den Fokus zu verlieren. Dieser Interviewleitfaden dient zur Orientierung und muss nicht zwanghaft in der Reihenfolge abgearbeitet werden. Es soll ein natürlicher Redefluss, ein Gespräch, entstehen, wobei der Interviewer die Rolle des „Schülers“ und der Interviewpartner die Rolle des „Meisters“ einnimmt. Dieses Meister-Schüler-Modell dient dazu die Ziele und Aufgaben des Nutzers zu verstehen (Geis & Tesch 2019, S. 61).

Um so viele Informationen wie möglich zu sammeln, sollen offene Fragen gestellt und geschlossene Fragen vermieden werden. Geschlossene Fragen und Suggestivfragen werden bereits in eine bestimmte Richtung gelenkt und bringen keine ehrlichen und ausführlichen Antworten hervor, während offene Fragen einen freien Raum bieten und auch durch Nachfragen erweitert werden können (Geis & Tesch 2019, S. 62).

2.4 Beobachtung

Neben Interviews wird auch die Beobachtung zur Erhebung von Informationen zum Nutzungskontext genutzt. Dabei bleibt der Beobachter im Hintergrund und verfolgt die Nutzer bei ihren Tätigkeiten in ihrem Kontext (Geis & Tesch 2019, S. 64–65). In diesem Fall wird die unsystematische Beobachtung gewählt. Somit hat der Beobachter keine fest vorgeschriebenen Richtlinien und Kategorien, an denen man sich orientieren muss und unvorhergesehene Ereignisse können leicht erfasst werden. Der Beobachter kann sich flexibel an die Situation anpassen und besitzt mehr Freiraum. Im Klinikum wurde diese Methode genutzt, um die Umgebung im Nutzungskontext der Patienten nachzuvollziehen und ihr Verhalten zu verstehen (Pfeiffer, 2018).

2.5 Unmoderierter Usability-Test

Als unterstützende Maßnahme zur Beobachtung wird zum Schluss ein unmoderierter Usability-Test durchgeführt. Ein Usability-Test ist „[e]ine Usability-Evaluierung, bei der repräsentative Benutzer bestimmte Aufgaben mit dem interaktiven System ausführen, um Usability-Probleme zu erfassen oder die Messung von Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung zu ermöglichen“ (Geis & Tesch 2019, S. 170).

Wie bereits in Kapitel 2.1.2 Menschenzentrierter Gestaltungsprozess erklärt wird, findet ein Usability-Test für gewöhnlich in der vierten und letzten Phase des Prozesses statt. Da es aber Ziel dieser Arbeit ist, die Bereitschaft der Patienten an der Teilnahme an Flächenhygiene mit Hilfe von Desinfektionstüchern zu untersuchen, ist es wichtig die Nutzergruppe mit dem Produkt interagieren zu lassen, damit Informationen zu der Einschätzung, Wahrnehmung und Ansichten zu dem Thema und dem Produkt selbst, als zusätzliche Datensätze dem Nutzungskontext hinzugefügt werden können und diesen verfeinern.

Der unmoderierte Usability-Test zeichnet sich dadurch aus, dass die vorgegebenen Aufgaben auch in Abwesenheit des Moderators erledigt werden können. Die Patienten haben dadurch die Möglichkeit die Desinfektionstücher nicht nur für einen kurzen Zeitraum von einer Stunde, sondern diese über mehrere Tage zu nutzen und zu testen. Die Aufgaben werden in einem Usability-Testskript, einer Checkliste für den Moderator, welche unter anderem auch die Informationen zu den Rekrutierungsfragen, dem Briefing am Anfang und den Post-Session-Interview beinhaltet, dem Testteilnehmer vorgetragen (Geis und Tesch 2019, S. 182–184). Danach kann der Teilnehmer mit dem Produkt interagieren, die Aufgaben ausführen und Erfahrungen sammeln. Am Ende stellt der Moderator Fragen. Auf diese Weise können Usability-Probleme aufgedeckt werden, die zum Beispiel aufzeigen können, welche Herausforderungen der Nutzer hat und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt, damit die Teilnahme an Flächenhygiene problemlos erfolgen kann. Im Kontrast dazu werden in einem Interview nur Meinungen und Einschätzungen zu dem Produkt gesammelt (Geis & Tesch 2019, S. 171).

2.6 Datenauswertung

Zur Auswertung und Strukturierung der erhobenen empirischen Daten wurden zwei Methoden angewendet, die im Folgenden erklärt werden.

2.6.1 Affinity Diagram

Zur Auswertung der empirischen Daten, ermittelt durch Interviews, wird die Methode Affinity Diagram genutzt. Diese Methode bietet eine einfache Möglichkeit Daten zu sortieren und zu strukturieren. Damit können verschiedene Themengebiete, Probleme oder Schlüsselerkenntnisse hervorgehoben und die Methodik an jedes Projekt individuell angepasst werden (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 127).

Zu Beginn werden alle Notizen aus den Interviews in unbestimmter Reihenfolge auf einzelnen Zetteln festgehalten. Daraufhin werden in einem Team die einzelnen Aussagen sortiert und in kleinen Gruppen zusammengefasst. Jede formierte Kategorie besteht dabei aus vier bis sechs Notizzetteln und hebt ein Problem oder eine Thematik hervor (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 127). Die Bearbeitung erfolgt „bottom-up“, das heißt, es wird nicht mit einer vorgeformten Kategorie gearbeitet, sondern die Gruppierung erfolgt basierend auf dem Inhalt der einzelnen Aussagen. Man betrachtet einen Notizzettel und sucht nach einem weiteren passenden Zettel (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 129–130). Sind alle Themenblöcke gebildet, erhält jede Gruppierung eine Bezeichnung, welche die Erkenntnis und den Inhalt daraus wiedergibt (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 132). Daraus können wiederum Untergruppen gebildet werden, die sich auf zweiter und dritter Ebene befinden und diverse Herausforderungen aufspalten und näher beschreiben (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 132). Die Bezeichnungen der

Gruppen sollen dem Leser helfen, die Hauptaussage und die Schlüsselerkenntnis der Kategorie zu verstehen, ohne die Notizzettel lesen zu müssen (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 136). Das Ziel dieser Methode ist nicht eine perfekt „Affinity“ zu erschaffen, sondern die Daten so zu strukturieren, sodass der Gestaltungsprozess, sowie Design Thinking angeregt wird. Am Ende erhält man eine Struktur, die alle Daten der Nutzer, ihr Wissen und Erkenntnisse für den Nutzungskontext aufzeigt (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 140–142).

Diese Methode wird für gewöhnlich in einem großen Team zur Bearbeitung großer Datensätze verwendet und kann sich über den ganzen Tag oder sogar mehrere Tage erstrecken. Dabei werden physische Notizzettel an einem Whiteboard verwendet. Während der Vormittag dafür genutzt werden kann, um sich einen groben Überblick zu verschaffen und erste Gruppierungen zu bilden, werden am Nachmittag erste Überschriften für die einzelnen Gruppierungen gebildet (Holtzblatt & Beyer 2017, S. 139). In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde für die Umsetzung dieser Methodik das Tool „Miro“ verwendet. Die Auswertung in diesem Tool kann dem Anhang entnommen werden. Des Weiteren erfolgten die Anwendung und Bearbeitung der Methodik nicht in einem Team, sondern allein. Daher konnten keine weiteren Beiträge und Ansichten oder externen Ideen einbezogen werden. Aufgrund dessen könnten potenzielle, weitere Themenbereiche nicht genauer betrachtet oder ergänzt werden. Diese Methode wurde zur Auswertung der Interviews mit den Patienten und dem medizinischen Personal genutzt. Weil es sich um eine Vielfalt an gesammelten Informationen handelt, konnten unterschiedliche Gruppierungen und Untergruppierungen gebildet werden.

2.6.2 Card-Sorting

Eine weitere Methode zur Strukturierung von Informationen ist das „Card-Sorting“ oder auch wörtlich übersetzt „Sortierung von Karten“ (Geis & Tesch 2019, S. 157). Dieser Ansatz kann vor allem hilfreich zum Beispiel beim Entwickeln einer Navigationsstruktur sein. Man differenziert zwischen zwei Varianten dieser Methode, nämlich zwischen offenem und geschlossenem Card-Sorting. Beim offenen Card-Sorting werden die Karten frei nach Einschätzung der Teammitglieder sortiert und die entstandene Gruppe mit einem Titel gekennzeichnet. Beim geschlossenen Card-Sorting sind die Bezeichnungen für die Gruppen bereits vorgegeben und die Karten werden nach Inhalt zugeordnet (Geis & Tesch 2019, S. 158).

Dieser Prozess ähnelt in seiner Vorgehensweise sehr dem Affinity Diagram. Jedoch eignet sich diese Methodik vor allem für kleine, einfache Datensätze, um diese schnell zusammenzustellen und zu vergleichen. Für dieses Projekt wurde das offene Card-Sorting zur Auswertung der Interviews mit den Vertretern der HARTMANN AG, sowie die Auswertung der Post-Session Interviews des unmoderierten Usability-Tests genutzt. Die Bearbeitung erfolgte ebenfalls in Miro und kann dem Anhang entnommen werden.

2.7 Persona

Mit Personas werden Benutzer bildlich dargestellt. Sie basieren auf gesammelten Daten aus Interviews und Beobachtungen und sollen anhand erfundener Beispiele die Nutzer repräsentieren. Es handelt sich dabei also um eine fiktive Person. Sie verfügen über Informationen wie Namen, Alter, Hintergrundinformationen, Ziele, Wünsche und Frustrationen. Dadurch

können Projektbeteiligte sich ein klares Bild davon machen, wer das interaktive System in Zukunft nutzen wird (Geis und Polkehn 2018, S. 86).

3 Theoretische Grundlage

In diesem Kapitel werden der Wissensstand und die Kenntnisse, die durch die Literaturrecherche erarbeitet wurden, aufgeführt. Diese theoretische Grundlage half dabei, ein allgemeines Verständnis für das Thema Flächenhygiene aufzubauen und die Ausgangssituation besser zu verstehen. Des Weiteren wurden Interviews mit den Mitarbeitern des Klinikums Heidenheim geführt, um die Literatur mit dem Ist-Zustand des Krankenhauses abzugleichen und die Meinung und Expertise zu dem Thema mit Hinblick auf die Teilnahme der Patienten an Flächenhygiene einzuholen. Außerdem wurden Informationen über das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissues gesammelt und Vertreter des Herstellers ebenfalls zum Thema Flächenhygiene und zur korrekten Anwendung des Produktes befragt.

3.1 Flächenhygiene und Infektionsprävention

In diesem Unterpunkt werden die wichtigen Grundlagen der Flächenhygiene und Infektionsprävention erklärt. Auf diesen Informationen basierend, wurden die Interviewleitfäden für die Interviews mit den Mitarbeitern des Klinikums erstellt.

3.1.1 Basishygiene

Die Basishygiene beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur Prävention von Übertragung von Erregern und Keimen. Durch die strenge Einhaltung soll die Erregerübertragung vermieden und somit nosokomiale Infektionen gesenkt werden. Diese Maßnahmen werden für alle Patienten eingehalten, unabhängig von Ihrer Diagnose. Bei Patienten, die mit hochinfektiösen Erregern infiziert sind, wird die Basishygiene strikter eingehalten und durch Isolation ergänzt. Dennoch ist auch Vorsicht bei Patienten ohne

nachgewiesenen Keimen geboten, da sie einen unbekannten multiresistenten Erreger haben könnten (Barkhausen & Babikir 2017, S. 1). Zu den Maßnahmen der Basishygiene gehören:

- Hygienische Händedesinfektion
- Flächendesinfektion
- Verwendung von Schutzkleidung, wie Kittel, Maske und Handschuhe
- Aufbereitung von medizinischen Produkten
- Einbezug von Patienten, Besuchern und Personal in das Hygienemanagement (Barkhausen & Babikir 2017, S. 2).

Die aufgelisteten Maßnahmen werden in einem Hygieneplan festgehalten.

3.1.2 Hygieneplan

Der Hygieneplan ist ein Dokument, in dem alle Informationen und Anweisungen festgehalten werden, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Wie bereits in Kapitel 1.4 der vorliegenden Arbeit beschrieben, wird dieser von der Hygienekommission, bestehend aus den Hygienefachkräften, den Hygienebeauftragten und Krankenhaushygieniker erstellt (Hygieneverordnung & Infektionsschutz 2021). Laut dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) (2024, §23, Absatz 5, Satz 1) müssen die Leiter der Einrichtungen, wie

- Krankenhäuser,
- Einrichtungen für ambulant Operieren,
- Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,
- Dialyseeinrichtungen,

- Tageskliniken,
- Entbindungseinrichtungen,
- Behandlungs- oder Vorsorgeeinrichtungen, die vergleichbar sind mit den zuvor genannten Einrichtungen,
- Rettungsdienste und Einrichtungen des Zivil oder Katastrophenschutzes,

ein Verfahren besitzen, um Infektionshygiene anhand von Hygieneplänen festzuhalten und zu gewährleisten. Meistens enthalten Hygienepläne eine Beschreibung, wie die Mitarbeiter vor nosokomialen Infektionen geschützt werden können, sodass der Einbezug der Patienten in den Plan vernachlässigt und das richtige Handlungsverfahren für sie im Falle eines ansteckenden Erregers nicht näher beschrieben wird (RKI - Krankenhaushygiene Themen A - Z - Hygieneplan 2024). Für den Inhalt und Aufbau eines Hygieneplans gibt es keine Vorgaben. Jedoch beinhaltet ein typischer Plan eine Gefährdungsanalyse, eine Risikobewertung, die daraus abgeleiteten Maßnahmen, die Maßnahmenevaluation und Schulungsmaßnahmen (Hygieneverordnung & Infektionsschutz 2021).

Die Gefährdungsanalyse beschreibt welche Risiken bei verschiedenen Tätigkeiten entstehen können, wie zum Beispiel durch benutztes Material oder durch Fehlverhalten. Die Risikobewertung beinhaltet die Einschätzung und das Ausmaß des Risikos. Daraus leiten sich die Maßnahmen ab, die eingehalten und befolgt werden müssen. Diese beziehen sich auf verschiedenen Bereiche der Hygiene, wie zum Beispiel die Basishygiene oder die Lebensmittelhygiene, Tätigkeiten, die in der Pflege und bei der Behandlung ausgeführt werden, sowie Vorschriften zur Wäsche-Hygiene und der

Entsorgung von Materialien. Durch die Evaluation der Maßnahmen werden diese überprüft und im Falle von schlechten Ergebnissen überarbeitet.

Zuletzt wird in den Schulungsmaßnahmen festgelegt, welche Gruppe in welchen Bereichen geschult werden muss (Hygieneverordnung & Infektionsschutz 2021).

Hierfür wurde als Ansichtsbeispiel ein Hygieneplan des Klinikums Heidenheim für den Fall der Rotavirus-Enteritis betrachtet. Am Anfang wird der Erreger, seine Inkubationszeit und Übertragungswege genau beschrieben. Es werden Schutzmaßnahmen sowohl für das Personal als auch die Patienten aufgezählt. Im Falle einer Ansteckung, wird der Patient in ein Einzelzimmer, mit einem eigenen Bad verlegt und hat damit keinen Kontakt mehr zu anderen Mitmenschen. Der Erreger ist sehr ansteckend, sodass streng vom Personal darauf geachtet werden muss, dass Händehygiene, aber auch Flächenhygiene betrieben wird, wenn der Patient verlegt wird. Selbst nach akuter Krankheit und abklingen der Symptome, kann der Rotavirus bis zu acht Tagen weiterhin ansteckend bleiben und somit gefährlich sein für andere Menschen. Aus diesen Gründen würde das Personal und der Patient profitieren, wenn der Patient sich auch an diese Vorschriften hält und nach der Benutzung der Nasszelle Hände- und Flächenhygiene betreibt. Der Hygieneplan wird regelmäßig kontrolliert und erneuert. Der Plan ist im Anhang dieser Arbeit vorzufinden. Wie in dem Beispiel zu sehen ist, ist dieser bis zum 25.03.2024 gültig.

3.1.3 Übertragungswege

Krankheitserreger können auf verschiedene Wege übertragen werden. Um herauszufinden, wie die Erreger von der Ausgangsperson auf andere Personen weitergegeben werden, wurde eine Studie durchgeführt, um diese

Übertragungswege und Ausbreitung näher zu untersuchen. Dazu wurde eine Studentengruppe, die in dem gleichen Haushalt wohnen, als Testpersonen hergenommen. In diesem Versuch wurde die Virusgattung PhiX174 gewählt, da sie den resistenten Viren, die für den Menschen gefährlich sein können, wie zum Beispiel Polioviren, ähnelt. Diese wurden auf Türklinken und auf den Händen einer freiwilligen Testperson verteilt. Nach mehreren Berührungen der kontaminierten Türklinke durch andere Mitmenschen, wurde bei 14 Personen der Testvirus wiedergefunden. Beim Händeschütteln konnte der Virus bis hin zur sechsten Person weiterverfolgt werden, nachdem sich alle nacheinander die Hand gaben (Rheinbaben et al. 2000, S. 61).

In einer weiteren Studie wurde die Situation in einem Krankenhaus betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass das Personal, aufgrund von mangelnder Händehygiene, nosokomiale Mikroorganismen über ihre Hände an Patienten weitergeben können (Bhalla et al. 2004, S. 166). Des Weiteren kann der Patient bei Kontakt mit kontaminierten Flächen, sekundär über Medizinprodukte und andere Materialien oder auch über die Luft, nach Aufwirbelung von Staub auf einer verseuchten Fläche, mit Erregern in Berührung kommen („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1075).

Betrachtet man es ausgehend von einer kontaminierten Oberfläche, so unterscheidet man zwischen einem direkten und indirekten Übertragungsweg. Über die Hände der Mitarbeiter oder Dritter werden Keime und Erreger, nach Kontakt mit dem infektiösen Patienten, an Oberflächen indirekt weitergegeben. Hier wiederum besteht die Gefahr, dass

andere Patienten, beim Berühren dieser Flächen, sich direkt mit den Erregern anstecken. Umso wichtiger ist hierbei die Einhaltung der Basishygiene, damit dieser Kreislauf und die Wahrscheinlichkeit der Übertragung unterbrochen oder verringert wird („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1076).

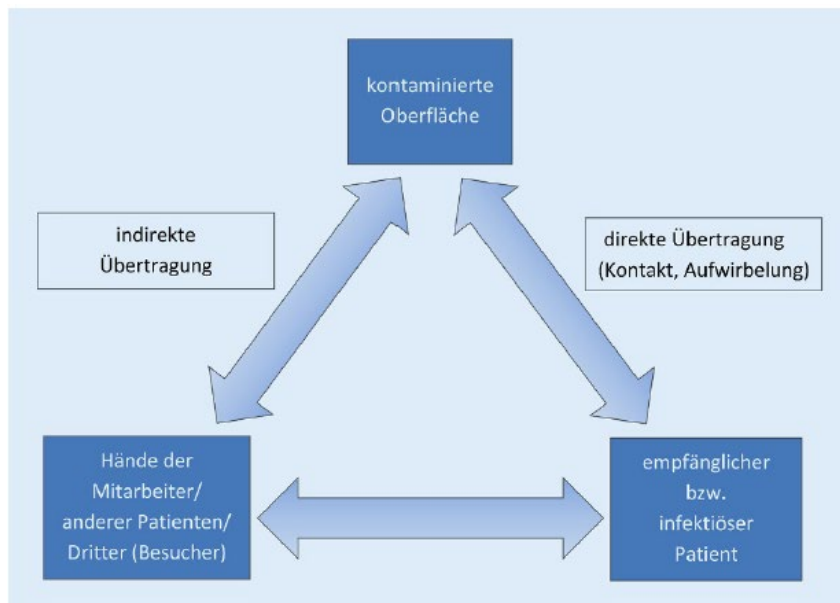


Abbildung 2: Übertragungswege ausgehend von kontaminierten Oberflächen („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1076)

3.1.4 Patientennahe und patientenferne Flächen

Im Krankenhaus wird zwischen patientennahen und patientenfernen Flächen differenziert. Die patientennahen Flächen oder auch „high-touch“ genannt, sind die Oberflächen, mit denen der Patient und das Personal am meisten in Berührung kommen und ein hohes Risiko einer Kontamination besteht („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1079).

Zu den patientennahen Flächen zählen....:

- Nachttisch,
- Bettgestell,
- Monitore,
- Klingel,
- Griffe am Bett,
- Fernbedienung,
- Armlehnen,
- Sanitärbereich,
- Instrumententische,
- Verbandswagen,
- und medizinische Geräte (Barkhausen & Babikir 2017, S. 10; Flächen Desinfizieren – So Wird Es Richtig Gemacht, 2023).

Hierbei wird darauf geachtet, dass diese Flächen mindestens einmal täglich gereinigt und desinfiziert werden. Auf Normalstationen ist eine einmalige Reinigung ausreichend, während auf Intensivstationen eine regelmäßige Routine empfohlen wird, um Risikopatienten vor einer Ansteckung zu schützen und die Zahl der Erreger zu senken. Bei sichtbaren Verunreinigungen durch Blut oder Exkremente muss eine sofortige Desinfektion stattfinden (Barkhausen & Babikir 2017, S. 11).

Zu den patientenfernen Flächen gehören alle Flächen, die selten mit den Händen und der Haut in Berührung kommen und eine niedrige Wahrscheinlichkeit besitzen, mit Erregern kontaminiert zu werden. Es

handelt sich um sogenannte „low-touch“ Oberflächen („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen", 2022, S. 1079). Dazu gehören zum Beispiel Treppenhäuser, Wände oder Flure (Flächen desinfizieren: So geht's richtig | MedSolut 2024).

3.1.5 Flächendesinfektion

Wie bereits erläutert, sind patientennahe Flächen oft in Kontakt mit den Händen verschiedener Personen und können somit zu dem Übertragungsweg kritischer Erreger zählen. Um die Ausbreitung und den Ausbruch nosokomialer Infektionen zu unterbrechen, muss, zusätzlich zur regelmäßigen Händedesinfektion, eine Flächendesinfektion durchgeführt werden. Hierbei unterscheidet man zwischen verschiedenen Ausgangslagen und Gründen, in welchen Fällen eine Flächendesinfektion angebracht ist und benötigt, wird.

Die desinfizierende Flächenreinigung ist Teil der Basishygiene und wird routinemäßig bei der Behandlung und Pflege von Patienten durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein zweistufiges Verfahren. Dabei werden in erster Linie sichtbare Verschmutzungen bei der Flächenreinigung mit Hilfe von Wasser und Zusätzen mechanisch entfernt, ohne dass eine beabsichtigte Abtötung von Mikroorganismen stattfindet. Im zweiten Schritt erfolgt die Desinfektion. Hierbei werden die vermehrungsfähigen Mikroorganismen beabsichtigt mit einem Flächendesinfektionsmittel auf eine Anzahl reduziert, die harmlos ist und somit keine weitere Infektion mehr möglich ist („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen", 2022, S. 1081).

Dieses Verfahren ist auch einstufig möglich, ohne dass dabei aktiv ein bestimmter Erreger vorhanden sein muss. Die ungezielte Flächendesinfektion wird ohne zusätzlichen Reinigungsprozess umgesetzt und dient der Reduzierung von Flächenverunreinigungen. Dieses einstufige Verfahren wird vor allem auf Arbeitsflächen vor aseptischen Tätigkeiten wie zum Beispiel beim Umgang mit Spritzen, bei Patientenwechsel oder Entlassung genutzt („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1081–1082).

Bei der gezielten Flächendesinfektion ist der Erreger des Patienten bekannt und es wird ein Mittel mit einem speziellem Wirkungsspektrum angewendet, um die Bakterien zu inaktivieren. Dieses Verfahren wird besonders bei isolierten Patienten oder bei Ausbrüchen angewendet, sowie als Schlussdesinfektion, bei ansteckenden Personen am Ende der Infektion. Erfolgt die Kontamination mit einem erregerhaltigem Material, wie Blut, Urin, Erbrochenes oder Exkrete, muss dies zuerst mechanisch, also im zweistufigen Verfahren, entfernt und anschließend desinfiziert werden („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1081).

Zusammengefasst lassen sich also fünf Fälle ableiten, in denen eine Flächendesinfektion benötigt wird:

- Ungezielte Flächendesinfektion auf patientennahen Flächen,
- gezielte Flächendesinfektion nach Verschmutzung mit erregerhaltigem Material,
- desinfizierende Flächenreinigung zur Kontrolle von Ausbrüchen,

- Flächendesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten,
- und Schlussdesinfektion („Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“, 2022, S. 1081)

3.2 Desinfektionstücher

Als Forschungsgegenstand, der in dieser Bachelorarbeit untersucht werden soll und im Fokus steht, wurde ein Produkt der Paul HARTMANN AG gewählt. Bei dem Produkt handelt es sich um die **Bacillol 30 Sensitive** Tücher. Dieses Produkt wird bereits im Klinikum Heidenheim von dem medizinischen Personal genutzt.



Abbildung 3: Bacillol® 30 Sensitive Tissues (HARTMANN GROUP 2024b)

Die Desinfektionstücher zeichnen sich durch ihre schnelle Wirksamkeit gegen Viren, Bakterien und Sprosspilze aus. Die Wirkzeit wurde bei verschiedenen Erregern anhand von EN-Normen getestet. Das Ergebnis kann der folgenden Abbildung entnommen werden.

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid	EN 14348	hoch	3 Min.
Mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzte viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid/Levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

Abbildung 4: Bacillol® 30 Sensitive Tissues Wirksamkeit (sortimentskatalog-desinfektion-hygiene-2023, S. 35)

Somit eignet es sich hervorragend für die routinemäßige Flächendesinfektion in einem Krankenhaus. Zudem wurde das Produkt auch dermatologisch auf Hautverträglichkeit und Asthma- und Allergiker Freundlichkeit getestet und schnitt sehr gut ab. Das Material der Tücher eignet sich für sensible Oberflächen wie Displays, Tastaturen oder Bedienfelder, Tablets, nicht invasive Medizinprodukte, Acrylglas und Kunstleder. Des Weiteren hat ein Tuch eine hohe Reichweite und ist reißfest (HARTMANN GROUP 2024a). Diese Eigenschaften bilden eine anwenderfreundliche Basis und einfache Nutzung für Patienten.

Im Verlauf der Bearbeitung dieser Bachelorarbeit wurde dieses Produkt von Mitarbeitern des Klinikums und dem Hersteller selbst bewertet und eingeschätzt, sowie von einigen Patienten getestet.

4 Empirische Datenerhebung

In diesem Kapitel werden die Vorgehensweisen zur Vorbereitung der Interviews mit den unterschiedlichen Gruppen, der Interviewleitfaden und Erkenntnissinteresse und die Durchführung erläutert. Am Ende folgt auch eine Reflexion zu der Methodik.

4.1 Patienteninterviews

4.1.1 Vorbereitung und Rekrutierung

In erster Linie sollte der Fokus auf die primären Nutzer gelegt werden. Primäre Benutzer sind „Benutzer, [die] das interaktive System für [ihren] beabsichtigten Zweck verwend[en]“ (Geis & Tesch 2019, S. 54). In diesem Projekt sind das die Patienten. Die Zielgruppe der Interviews beschränkte sich auf die Patienten des Klinikums Heidenheim. Da das Krankenhaus eine Vielfalt an Stationen besitzt, wurde im Voraus die Anzahl der möglichen Stationen, die besucht werden können, ermittelt und die Zahl eingeschränkt. Aus Sicherheitsgründen wurden isolierte Stationen und Patienten nicht in der Planung des Interviewprozesses berücksichtigt, um sowohl den isolierten Patienten als auch den Interviewer zu schützen. Trotzdem gehört diese Patientengruppe zu der Zielgruppe hinzu und sollte in den Ergebnissen berücksichtigt werden. Am Ende wurden vier Stationen gewählt, um eine genügende Anzahl an potentiellen Interviewpartnern zu gewährleisten. Da sich alle Patienten im Klinikum und somit an einem Ort befinden und zugänglich sind, bat sich die Möglichkeit an, gleich mehrere Interviews an einem Tag zu führen. Um die Arbeitslast aufzuteilen, wurde der Besuch der einzelnen Stationen auf zwei Tage gleichmäßig aufgeteilt.

Zielgruppe

Im nächsten Schritt wurde die Zielgruppe näher betrachtet. Die Zielgruppe Patient umfasst ein breites Spektrum an unterschiedlichen Gruppen. Da es den Rahmen der Arbeit sprengen würde, wenn man jede einzeln betrachtet, wurde diese breit gehalten. Im Krankenhaus ist man bei der Wahl der Interviewpartner auf die vorhandenen Menschen angewiesen. Bei der Vorbereitung und Planung wurde deshalb um die Unterstützung der Pfleger und der Mitarbeiter gebeten, da sie einen besseren Überblick über die vorhandenen Patienten haben und somit wissen, wer am besten geeignet ist. Es wurde im Voraus eine E-Mail versendet, um die einzelnen Stationen über den geplanten Besuch zu informieren und über den Plan aufzuklären. Trotz der breit gehaltenen Zielgruppe gab es ein paar Kriterien, damit ein gutes Gespräch zwischen Interviewer und Patient gegeben ist. Zum einen wurde der Verweis auf Patienten gebeten, die der deutschen Sprache mächtig und somit in der Lage sind, sich mit dem Interviewer zu unterhalten. Somit gab es keine Schwierigkeiten bezüglich der Sprachbarriere. Zum anderen war es wichtig, dass die zu interviewende Personen kognitiv fit und geeignet sind, für einige Minuten ein paar Fragen zu beantworten. So wurde an den Tagen der Interviews sichergestellt, dass eine genügende Anzahl an potenziellen Interviewpartnern vorliegt. Die Mitarbeiter auf jeder Station verwiesen jeweils auf eine Menge von Patienten, die einzeln aufgesucht wurden. Die Rekrutierung für die Interviews war damit abgeschlossen, wenn die Patienten, nach einer kurzen Vorstellung, Erklärung über das Vorhaben und die Bitte, an einem Interview für eine Studie teilzunehmen, immer noch motiviert und aufgeschlossen waren und zustimmten, ein Gespräch zu führen. Es wurde darauf geachtet, dass das Wohlbefinden und die

Gesundheit der Patienten stets oberste Priorität behielten. Aus diesem Grund wurde kein Interview geführt, wenn die gegenüberliegende Person sich nicht gut genug fühlte, um sicherzustellen, dass die Genesung nicht beeinträchtigt wird. Aus diesem genannten Grund kamen einige der Interviews nicht zustande.

4.1.2 Interviewleitfaden

Für die Durchführung der kontextuellen Interviews wurde ein Interviewleitfaden vorbereitet. Das kontextuelle Interview ist ein „Interview, das dort stattfindet, wo die Interaktion des Benutzers mit dem interaktiven System üblicherweise erfolgt und das auf den Nutzungskontext des Benutzers abzielt“ (Geis & Tesch 2019, S. 64). Der Leitfaden ist im Anhang zu finden. Darin stehen das Ziel für das Gespräch und das Erkenntnisinteresse, sowie ausformulierte Fragen, die jeweils in grobe Kategorien eingeteilt sind. Die Fragen zielen darauf ab herauszufinden,...:

- ...wie die Patienten allgemein, persönlich zum Thema Hygiene, auch im privaten Umfeld eingestellt sind,
- ...wie die Meinung zu den Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ist,
- ...ob spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um die Hygiene im Krankenhaus zu fördern und sich oder andere zu schützen,
- ...ob der Umgang mit Desinfektionstüchern gewünscht ist
- ...und ob es ihnen bewusst ist, dass bei Kontakt mit kontaminierten Flächen eine Übertragung von Krankheitserregern möglich ist.

Als letzte Frage wird sich nach der Bekanntheit bezüglich der Paul HARTMANN AG erkundigt, um herauszufinden, ob bereits Produkte

genutzt werden und ob die Desinfektionstücher Teil davon sind. Zum Schluss wird zur Abrundung des Interviews nach der Bereitschaft gefragt, sich an der Flächenhygiene zu beteiligen, wenn Desinfektionstücher zur Verfügung gestellt werden würden.

Die ausformulierten Fragen dienten der Orientierung und wurden der Interviewsituation angepasst. Zu Beginn wurde eine übergestellte Frage gestellt, die durch weitere vertiefende Fragen und Nachfragen erweitert wurde. Einige Fragen wurden weggelassen, wenn diese bereits in einem anderen Kontext beantwortet wurden.

4.1.3 Interviewdurchführung

Die Interviews wurden zum größten Teil in den Zimmern der Patienten durchgeführt. Da die meisten Patienten sich ein Zimmer mit anderen teilen, wurde das Interview nach Möglichkeit in einen anderen Raum oder Gemeinschaftsraum verlegt, soweit die Personen noch mobil waren. Somit wurde eine angenehme Atmosphäre für ein Gespräch geschaffen, Bettnachbarn nicht gestört, und das Pflegepersonal bei der Arbeit nicht behindert. Bei den Patienten, die das Bett nicht, oder nur schwer, verlassen konnten wurde das Interview im Zimmer gehalten.

Es wurden insgesamt 11 Interviews im Zeitraum 24.01 bis zum 25.01 geführt. Das Alter der befragten Personen lag zwischen 41 und 82 Jahren. Davon waren fünf der Interviewpartner weiblich und sechs männlich. Sechs der Patienten teilten sich ein Zimmer mit anderen, während fünf ein Privatzimmer hatten.

Tabelle 1: Übersicht Interviewte Patienten

Patient ID	Geschlecht	Alter	Zimmer
C4_01	W	54 Jahre	Mehrbettzimmer
C4_02	M	64 Jahre	Mehrbettzimmer
C4_03	W	55 Jahre	Mehrbettzimmer
C6_04	M	73 Jahre	Mehrbettzimmer
C6_05	W	57 Jahre	Mehrbettzimmer
C6_06	M	59 Jahre	Mehrbettzimmer
C6_07	M	75 Jahre	Allein
C8_08	M	41 Jahre	Allein
K4_09	M	82 Jahre	Allein
K4_10	W	57 Jahre	Allein
K4_11	W	79 Jahre	Allein

4.2 Interviews mit medizinischem Personal

4.2.1 Vorbereitung und Rekrutierung

Um das Verständnis für den Nutzungskontext zu erweitern, sollte eine weitere Benutzergruppe befragt werden, die mit dem System, also der Flächenhygiene und den Desinfektionstüchern, interagiert. Das medizinische Personal zählt somit, neben den Patienten, ebenfalls zu den primären Benutzern und wurde für die Befragung ausgewählt. Für die Rekrutierung

wurden eine Mail an das zuständige Sekretariat des Klinikums Heidenheim und über weitere Ansprechpartner verschickt, mit der Bitte an einem Interview zum Thema „Flächenhygiene und Teilnahme der Patienten an der Flächenhygiene“ teilzunehmen. Die Zielgruppe wurde hierbei nicht eingeschränkt, da die Erfahrung, Meinung und Expertise, unabhängig davon, wie lange die Person ihre Berufstätigkeit oder Rolle ausübt, erfasst werden soll und so eine Vielzahl von Perspektiven betrachtet werden kann.

4.2.2 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden für diese Zielgruppe wurde basierend auf der Literaturrecherche erstellt. Das Ziel dieser Interviews war zum einen, die Informationen aus der Recherche mit der Praxis am Klinikum abzugleichen und den Wissensstand zu erweitern, wie bestimmte Abläufe und Tätigkeiten in Heidenheim erfolgen, und zum anderen, um die persönliche Meinung des medizinischen Personals zu dem Thema kennenzulernen, sodass der Nutzungskontext weiter optimiert werden kann. Der Aufbau des Leitfadens ist auch hier in grobe Kategorien geteilt und verfügt über ausformulierte Fragen, die durch ergänzende, vertiefende Fragen unterstützt werden. Der erste Teil der Fragen beschäftigt sich mit allgemeinen Informationen zu den Patienten, dem Aufenthalt und Behandlungsbedarf und ob seitens der Patienten Hygienethemen angesprochen werden. Im nächsten Teil werden Fragen zur Reinigung und Desinfektion im Krankenhaus gestellt. Danach wird der Fokus auf die Flächenhygiene und die mögliche Teilnahme der Patienten daran, gelenkt. Mit diesem Abschnitt soll auch herausgefunden werden, ob es im Interesse des Personals ist, dass die Gruppe involviert wird und welche Probleme oder Herausforderungen dabei gesehen werden. Dabei

wird auch das Produkt Bacillol 30 Sensitive und die Handhabung damit in den Mittelpunkt gestellt. Mit der letzten Frage werden weitere Hygienemaßnahmen oder Ergänzungen zu dem Thema erfragt. Der Leitfaden kann dem Anhang entnommen werden.

4.2.3 Interviewdurchführung

Um sicherzustellen, dass die Interviews nicht zu ausgedehnt und lang werden, wurden Fragen priorisiert und auf wesentliche Aspekte reduziert. Im Ganzen belief sich die Dauer eines Interviews auf ca. 45 – 60 Minuten. Damit die Organisation und Terminplanung möglichst flexibel gestaltet werden kann, wurden die Interviews über eine Videokonferenz mit dem Tool „Zoom“ abgehalten. Dies hatte den Vorteil, dass dadurch nicht die Hin- und Rückfahrt zwischen Heidenheim und der Heimat ausgiebig geplant und in den Zeitplan miteinberechnet werden musste, sondern auch, dass kurzfristige Absagen oder Planänderungen problemlos angepasst werden konnten, ohne dass ein Tag verloren geht. Zudem erleichterte die Nutzung der Funktion „Audioaufnahme“ in Zoom die Transkription der Interviews. Dadurch konnte der Interviewer sich besser inhaltlich auf die Antworten konzentrieren und Gegenfragen stellen. Die Interviews wurden vollständig transkribiert und sind im Anhang zu finden. Insgesamt wurden die Befragungen über einen Zeitraum vom 08.01.24 bis zum 19.01.24 geführt. Die Zahl belief sich auf insgesamt acht Personen, von verschiedenen Stationen des Klinikums.

4.3 Interviews HARTMANN AG

4.3.1 Vorbereitung und Rekrutierung

Für die letzte Interviewreihe sollten weitere Stakeholder, oder auch sogenannte Interessenvertreter, befragt werden. Dies sind Personen oder Organisationen, die ein Interesse an dem System haben und die Ergebnisse verwenden, aber nicht direkt mit dem System interagieren. Sie zählen somit zu der Gruppe der indirekten Benutzer (Geis & Tesch 2019, S. 55).

Da im Rahmen dieser Bachelorarbeit ein Produkt der HARTMANN AG im Fokus steht, war es auch wichtig, den Gegenstand selbst genauer zu betrachten und sich beim Hersteller über die Leitlinien für die korrekte Benutzung der Desinfektionstücher zu informieren. Aus diesem Grund wurden Kontaktpersonen aus dem Unternehmen über E-Mail kontaktiert und zu einem Gespräch eingeladen.

4.3.2 Interviewleitfaden

Der Inhalt des Leitfadens fokussierte sich auf Fragen rund um die Tücher. Jedoch war es auch interessant von der Seite des Herstellers aus herauszufinden, ob und warum sich Patienten an der Flächenhygiene beteiligen und warum dafür explizit die Bacillol 30 Sensitive Tücher genutzt werden sollten. Dazu war es auch wichtig herauszufinden, wie die korrekte Nutzung aussieht, was beachtet werden muss und welche Flächen sich für die Teilnahme an Flächenhygiene im Krankenhaus eignen. Im Bezug darauf sollten die Interviewpartner auch Herausforderungen und Risiken, die dabei auftreten könnten, einschätzen. Zum Schluss wurde gefragt, ob der Interviewpartner schon aktiv an Hygienemaßnahmen und Flächenhygiene im Krankenhaus teilgenommen hat oder etwas zu dem Thema aufgefallen

ist. Da die Interviewpartner sich täglich mit unterschiedlichen Desinfektionsmittelprodukten auseinandersetzen, wäre es faszinierend zu erfahren, wie die Sichtweise in der Praxis aussieht. Der Leitfaden ist ebenfalls im Anhang zu finden.

4.3.3 Interviewdurchführung

Wie auch bei dem medizinischen Personal erfolgte ein Interview über eine Videokonferenz mit Hilfe von Zoom. Die Interviews wurden in einem Zeitraum vom 08.01.24 bis zum 19.01.24 durchgeführt und die Dauer belief auf 30 – 45 Minuten. Es wurden dabei zwei Personen befragt. Ursprünglich war eine Anzahl von drei Gesprächspartnern geplant, jedoch musste die Zahl aufgrund von Uneinigkeiten im Terminkalender auf zwei reduziert werden.

4.4 Unmoderierter Usability-Test

4.4.1 Vorbereitung und Rekrutierung

Als letzter Arbeitsschritt zur empirischen Datenerhebung wurde ein unmoderierter Usability-Test geplant, um die Patienten mit den Desinfektionstüchern interagieren zu lassen und Eindrücke zu sammeln. Da es aber nicht möglich ist, die Patienten rund um die Uhr zu beobachten, wie bei einem üblichen Usability-Test, wurden einige Aufgaben vorbereitet, die in Anwesenheit und unter Beobachtung des Moderators erledigt werden und einige Aufgaben, die selbstständig, ohne den Moderator erfüllt werden müssen. Anschließend sollen in einer Post-Session die Erfahrung der Patienten bei der Benutzung, ihre Herausforderungen und Anwendungssituationen gesammelt werden. Mit Hilfe der Mitarbeitenden wurden, wie bei den Interviews auch, passende Patienten für das Testing

herausgesucht. Es sollten fünf Testpersonen ausgewählt werden, die über einen Zeitraum von drei Tagen jeweils eine eigene Packung Bacillo1 30 Sensitive Tücher erhalten und diese situationsabhängig verwenden dürfen. Die Ressourcen wurden freundlicherweise von dem Krankenhaus zur Verfügung gestellt und netterweise am Ende auch dem Patienten komplett überlassen.

4.4.2 Testskript

Nach einigen Rekrutierungsfragen werden in einem Briefing das Ziel der Studie erklärt. Bevor aber die Verpackung dem Patienten überreicht wird, müssen wichtige Warnhinweise abgegeben werden. An erster Stelle sollten Patienten während des Testings nicht zu Schaden kommen. Deshalb muss darauf hingewiesen werden, dass die Tücher nur für die Flächendesinfektion und nicht für die Händedesinfektion oder andere Körperregionen geeignet sind. Natürlich darf aber auch die Ausstattung des Krankenhauses nicht beschädigt werden. Deshalb wurde auch hier dringendst verdeutlicht, dass damit keine medizinischen Gerätschaften selbständig gesäubert werden dürfen und die Entsorgung nur in einem Mülleimer stattfinden darf, da im Falle einer fehlerhaften Entsorgung über die Toilette die Rohre verstopfen können. Anschließend werden den Testpersonen die Verpackung überreicht und erste kleine Aufgaben gegeben. Hierbei können schon Beobachtungen angestellt werden, wie die Patienten die Packung auffassen und welche Wirkung es auf sie hat. Danach dürfen sie ein Tuch entnehmen, es benutzen und entsorgen. Für den Zeitraum in Abwesenheit des Moderators werden weitere Aufgaben aufgetragen. Die Patienten sollen die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf patientennahen Flächen, im Sanitärbereich, bei Besuch

durch Dritte und bei aktiver Kontamination benutzen. In einem Interview am folgenden Tag werden die Personen rückblickend zu den Aufgaben und den Umständen befragt. Die Fragen für das Post-Session-Interview sind im Testskript notiert, sollen aber nur der Orientierung dienen und müssen nicht in der Reihenfolge beantwortet werden. Das Testskript ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

4.4.3 Durchführung

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Tücher über einen Zeitraum von zwei Tagen genutzt werden sollen und an Tag drei die Befragung stattfindet. Somit hätten die Testpersonen genügend Zeit, um das Produkt ausgiebig zu nutzen und genug Eindrücke zu sammeln. Weil es aber schwer ist, Patienten mit den bereits erwähnten Kriterien und dem gleichen Entlassungsplan zu koordinieren, wurde der Test auf zwei Tage verkürzt. Aus diesem Grund wurden die Desinfektionstücher an Tag eins in der Früh verteilt und an Tag zwei schon die Befragung durchgeführt. Unabhängig davon zeigten sich alle Probanden aufgeschlossen und motiviert. Der Testzeitraum fand vom 18.03.24 bis zum 19.03.24 statt. Das Post-Session Interview dauerte 10 – 20 Minuten.

Tabelle 2: Übersicht Patienten Usability-Test

Patient ID	Geschlecht	Alter	Zimmer
P1	W	75 Jahre	Allein
P2	W	77 Jahre	Mehrbettzimmer
P3	M	65 Jahre	Mehrbettzimmer
P4	M	64 Jahre	Mehrbettzimmer
P5	M	65 Jahre	Mehrbettzimmer

4.5 Reflexion der Methoden

Der Anteil der befragten und getesteten Patienten belief sich auf eine Anzahl von insgesamt 16 Personen. Die Teilnehmenden befanden sich alle in einer Altersgruppe von 54 bis 82 Jahren, mit einer Ausnahme von einem Patienten im Alter von 41 Jahren. Alle Patienten waren auf einer der vier gewählten Studienstationen und hatten eine gute kognitive Leistungsfähigkeit. Diese Faktoren spiegeln aber nur einen Teil der Patienten im Klinikum Heidenheim wider und sind nicht repräsentativ für das komplette Krankenhaus, da nicht alle diese gleichen Merkmale teilen. Für eine detaillierte Erfassung des Nutzungskontextes, sollten Informationen über weitere Patientengruppen auf anderen Stationen erhoben werden. Bei den Interviews fielen viele der Antworten knapp aus. Hier bestand die Schwierigkeit darin die Patienten zu einem ausführlichen Gespräch zu animieren. Das kann aber darauf zurückgeführt werden, dass sie sich gerade im Genesungsprozess befinden und somit vielleicht nicht die Kraft haben ein langes Interview zu führen und sich deshalb bei den Antworten kurzhalten. Es könnte darauf geachtet, dass in Zukunft Patienten bei ihrer Entlassung, wenn sich das Wohlbefinden verbessert hat, interviewt werden.

Bei dem unmoderierten Usability-Test basieren die Ergebnisse auf einer Vertrauensgrundlage und es kann nicht direkt überprüft werden, ob die Probanden die Aufgaben auch wirklich so durchgeführt haben, wie gewünscht. Zudem wären eine längere Testphase und Interaktion mit dem Produkt von Vorteil gewesen, da noch mehr Aspekte im Laufe der Nutzung hätten auftreten können.

Einige allgemeine Fragen zu den Patienten, wie zum Beispiel zum Aufenthalt, Alltag und Verlegung, in den Interviews mit dem medizinischen Personal waren sehr generisch und glichen sich oft in der Antwort. Da sich der Vorgang von Station zu Station nicht viel unterscheidet hätte man bereits nach den ersten Interviews den Leitfaden anpassen können.

4.6 Beobachtung

Zusätzlich zu den Interviews und dem Usability Test wurde eine Beobachtung durchgeführt. Hierbei wurde der Fokus auf die Umgebung der Patienten gelegt. Jedes Patientenzimmer verfügt unabhängig davon, ob es ein Mehrbettzimmer oder Privatzimmer ist über ein Bett mit einem Nachtkästchen, einem Bad mit Dusche und Toilette, und Desinfektionsmittelspender und Handschuhe an der Wand neben der Eingangstüre. Es wurden jedoch weder im Zimmer noch im Bad, Informationen zur Hände- oder Flächenhygiene vorgefunden.

Im Besucherbereich am Ende des Flures auf jeder Station gibt es einen Schrank mit Lesematerial, Getränken und ausfüllbare Feedbackblätter zum Thema Krankenhausaufenthalt, wo Kritik oder Lob geäußert werden kann. Der Besucherbereich schien aber stets menschenleer und die ausgedruckten Feedbackbögen gingen auf dem Schrank neben den anderen Gegenständen unter, sodass sie fast nicht bemerkt wurden.

In der Eingangshalle des Krankenhauses gibt es Toiletten für die Besucher. In jeder Toilettenkabine ist ein Hinweis angebracht auf dem geschrieben steht, dass die Klobrille mittels Desinfektionsmittel und Toilettenpapier vor der Benutzung gesäubert werden soll. Die Besucher werden hiermit zur Flächenhygiene aufgefordert. Leider scheint diese Information etwas

ungünstig platziert zu sein, da man diesen Hinweis erst nach dem Betreten und Abschließen der Kabine bemerkt. In der Kabine selber gibt es keine Desinfektionsmittelspender, sondern erst außerhalb, neben dem Waschbecken. Man müsste also hierfür wieder rausgehen und sich das benetzte Tuch holen. Für die Besucher wäre das ein zusätzlicher, umständlicher Schritt und wird vermutlich in der Praxis weniger umgesetzt. Bilder zu der Patientenumgebung sind im Anhang eingefügt.

Die Desinfektionstücher Bacillol 30 Sensitive werden nur von dem Pflegepersonal genutzt und diese liegen in den Arbeitsräumen aus. In den Patientenzimmern sind aber vereinzelt Verpackungen vorgefunden worden, wenn diese dort vom Personal für die Flächenhygiene verwendet wurden und liegen, gelassen worden sind.

5 Ergebnisse der Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Auswertung der Interviews und des unmoderierten Usability-Tests beschrieben. Die Analyse und Strukturierung der gewonnenen Informationen erfolgte mit den Methoden Affinity Diagram und Card Sorting, welche in Kapitel 2 erklärt werden.

5.1 Patienteninterviews

Die Patienteninterviews zielten darauf ab die Einstellung zum Thema Hygiene und den Umgang damit zu erfassen. Für die Auswertung wurden die Antworten in ähnlichen Themenfelder zusammengefasst.

Nutzung von Desinfektionsprodukten im privaten Umfeld

Die Patienten wurden gefragt, wie häufig sie in ihrem privaten Umfeld Desinfektionsprodukte verwenden.

Nutzung von Desinfektionsprodukten im privaten Umfeld

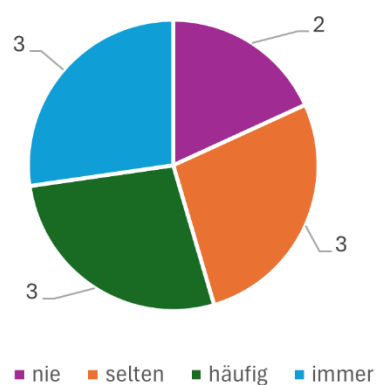


Abbildung 5: Ergebnisse Nutzungshäufigkeit von Desinfektionsprodukten (eigene Darstellung)

Aus den Ergebnissen lässt sich herauslesen, dass zwei der interviewten Patienten überhaupt keine Desinfektionsmittel zuhause oder im privaten Umfeld verwenden, während die Nutzungshäufigkeit der anderen neun

Patienten von selten, häufig bis zu immer variiert. Als Grund für die Benutzung wurde häufig der Besuch von öffentlichen Toiletten genannt. Des Weiteren werden die Produkte auch in öffentlichen Einrichtungen wie beim Besuch eines Pflegeheims (C4_01) oder beim Einkaufen (C6_06; C8_08), bei sozialen Interaktionen mit anderen Menschen (C6_06; K4_10; C6_07), bei Kontamination durchs Niesen (K4_10), im Auto (C4_02), oder auch für den Hausputz (C8_08; K4_10) genutzt.

Einschätzung und Umgang mit Hygiene

Patienten geben an, dass ihnen die Hygiene an öffentlichen Orten überaus wichtig ist, weil die Ansteckungsgefahr durch die Vielzahl anderer Menschen erhöht ist. Oft wird die Grippezeit, aber auch die Coronazeit erwähnt, durch die viele Menschen erkrankt sind. Bei der Vielfalt an Bakterien und Viren im öffentlichen Raum ist es schnell möglich, dass man sich anstecken kann. Zudem wird auch erwähnt, dass es oft schon an der Sauberkeit selbst mangelt (C6_04; C4_02; C4_01) und es deshalb wichtig ist, die Umwelt für die anderen Mitmenschen sauber zu halten. Aus diesen Gründen ist allen Teilnehmern entsprechend auch der Schutz vor Krankheitserregern sehr wichtig. Auf die Frage, ob es ihnen auch bewusst ist, dass Erreger über Flächen übertragen werden können, war es allen bekannt, aber drei der Patienten machen sich nicht aktiv Gedanken darüber.

Zudem wurde gefragt, wie die Teilnehmer den Umgang mit Hygiene ihrer Bettnachbarn beim Teilen eines Patientenzimmers einschätzen. Nur einer der Befragten hat sich dazu äußern können. Es wird angemerkt, dass das Hygieneniveau nicht so hoch ist und das Händewaschen nach dem Toilettengang oft vernachlässigt wird (C4_03). Die restlichen Patienten

achten entweder nicht darauf oder wollen sich nicht in die Angelegenheiten einmischen (C6_04). Trotzdem sollte laut den Aussagen, der ideale Bettnachbar darauf achten, dass vor allem das Bad sauber gehalten wird und die Hände desinfiziert werden.

Einschätzung der Krankenhaushygiene

Nach der Betrachtung der Hygiene im öffentlichen Raum, war auch die Einschätzung der Krankenhaushygiene interessant. Allen Befragten ist die Krankenhaushygiene sehr wichtig, da es viele Bakterien und Viren gibt, die man sich einholen kann. Die Betonung liegt hier auf dem eigenen Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden.

Angst vor Ansteckung mit anderen Erregern
während Krankenhausaufenthalt

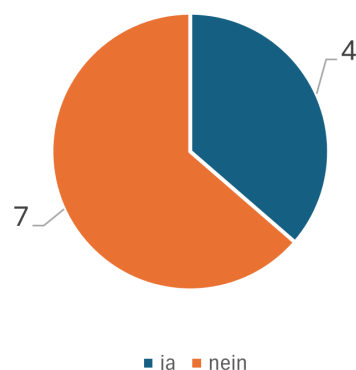


Abbildung 6: Angst vor Ansteckung (eigene Darstellung)

Vier der Patienten geben an, dass sie während ihres Krankenhausaufenthalts Sorgen haben, dass sie sich mit anderen Erregern anstecken, weil es sich dabei um Risikopatienten handelt oder weil bereits eine Infektion, während eines Aufenthalts im Krankenhaus in der Vergangenheit, mit schweren Komplikationen stattgefunden hat. Die restlichen Patienten teilen nicht die gleichen Sorgen bezüglich der Verbreitung von Erregern, weil die

Umgebung als sauber eingeschätzt wird. Alle Patienten sind mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden. Trotzdem sind einige Mängel zur Sprache gekommen. Zwei Teilnehmer haben einen negativen Eindruck bezüglich der Reinigung im Krankenhaus. Es wird angemerkt, dass die Reinigung nicht ordentlich erfolgt und Verschmutzungen hinterlassen werden (C4_03). Ein weiterer Kritikpunkt wird zum Reinigungskonzept geäußert. Dem Patient fiel auf, dass augenscheinlich das komplette Zimmer, samt Sanitäranlage, mit nur einem Lappen abgeputzt wird. Laut dem Patienten sollte man das trennen, vor allem beim Esstisch, da man dort seine Mahlzeiten zu sich nimmt (C6_06). Auf die Frage, ob die Patienten darum gebeten werden, bestimmte Vorgaben oder Vorschriften bezüglich Hygiene zu beachten, wird diese von allen verneint. Somit muss die Teilnahme an Hygiene aus eigener Initiative erfolgen.

Schutz der Besucher

Da die Meinung und Einschätzung zum Umgang mit Hygiene anderer Mitmenschen ermittelt wurde, sollte auch das eigene Handeln näher betrachtet werden. Hierbei wurde gefragt, ob die Patienten bei Besuch im Krankenhaus irgendwelchen Maßnahmen vornehmen, um ihre Verwandten und Freunde vor Ansteckung zu schützen.

Aktiver Schutz der Besucher vor möglicher Ansteckung

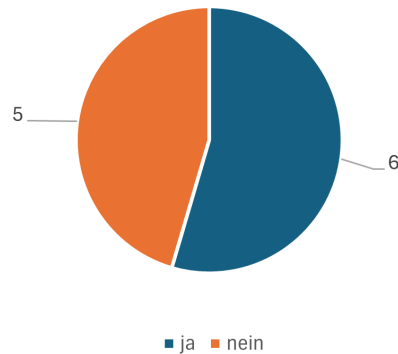


Abbildung 7: Aktiver Schutz der Besucher durch Patienten (eigene Darstellung)

Knapp die Hälfte gibt hierbei an, dass sie keine aktiven Maßnahmen vornehmen, um ihre Besucher vor Ansteckung zu schützen. Vielmehr wird erwartet, dass die Besucher selbstständig Vorkehrungen treffen, indem sie sich die Hände waschen und desinfizieren, Masken aufsetzen oder Flächen desinfizieren, die sie anfassen (C6_04; C4_01; K4_10; C8_08). Mehr als die Hälfte hat keine Befürchtungen, dass eine Ansteckung erfolgen kann. Nur ein kleiner Teil macht sich aktiv Gedanken dazu, jedoch kann es überall passieren, auch außerhalb des Krankenhauses.

Beteiligung an Flächenhygiene

Im nächsten Schritt wurde betrachtet, welche aktuellen Hygienemaßnahmen von den Patienten durchgeführt werden. An erster Stelle stehen hier die Händedesinfektion und das Händewaschen. Einer der befragten hatte bereits eine Packung Desinfektionstücher im Zimmer vorgefunden und diese zum Desinfizieren des Toilettenrandes genutzt. Unter anderem werden als weitere Maßnahmen das Lüften und Verlassen des Zimmers, um Abstand zu schaffen, genannt.

Gründe für diese Tätigkeiten sind....:

- der persönliche Anspruch und Ekelfaktor, wenn man sein Zimmer mit anderen teilt (C4_03; C4_01),
- die Selbstverständlichkeit zur Ordnung (C6_04; C4_02),
- zum Schutz der Familienmitglieder (K4_10)
- und die Gefahr sich als Risikopatient etwas einzuholen (C8_08; C6_06).

Würde man Desinfektionstücher standardisiert, neben Desinfektionsmittelspendern und Handschuhen, im Patientenzimmer anbieten, wird am meisten das Bad und die Sanitäreanlage als Einsatzort genannt. Besonders bei der Nutzung der Toilette wird der Wunsch nach den Tüchern geäußert, sodass man die Möglichkeit hat diese nochmal zu säubern, bevor man sich selber draufsetzt (C6_05; C6_04; K4_10; C4_01; C4_02; C6_04). Auch die Möglichkeit seine persönlichen Flächen jederzeit selbstständig bei Verschmutzung abwischen zu können wäre vorteilhaft.

Beteiligung an Flächenhygien

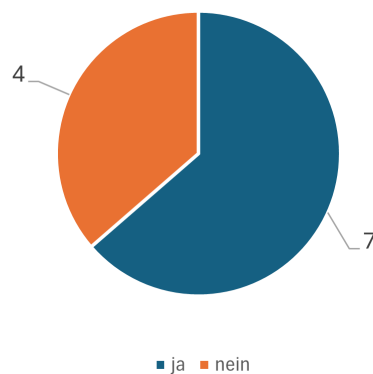


Abbildung 8: Anzahl Patienten zur Beteiligung an Flächenhygiene (eigene Darstellung)

Sieben der Befragten Patienten würden sich an Flächenhygiene beteiligen, wenn Desinfektionstücher ausliegen würden. Die restlichen vier würden sich nicht an der Flächenhygiene beteiligen. Gründe dafür sind...:

- die zufriedenstellende Reinigung und Desinfektion durch das Personal, sodass eine zusätzliche Desinfektion nicht als nötig angesehen wird,
- soziale Hemmungen, wenn der Bettnachbar einen beobachten würde,
- Allergien und Abneigung gegen die Chemikalien im Produkt,
- und aus Umweltgründen, wenn jeder Patient eine eigene Packung erhält und so mehr Müll entsteht.

Hartmann AG Produkte

Die HARTMANN AG ist unter allen Patienten bekannt und es wurden schon einige Produkte aus dem Sortiment genutzt. Die Bacillol Tücher sind aber noch kein Teil davon gewesen. Aus diesem Grund konnte keine Meinung zum Produkt abgegeben werden. Abgesehen davon gab es aber nur positive Bewertungen. Vor allem Verbandszeug und Desinfektionsmittel wurden in der Vergangenheit genutzt.

5.2 Interviews mit medizinischem Personal

Patientenaufenthalt

Die Zuteilung der Patienten auf die Patientenzimmer erfolgt über eine definierte Positivliste. Infektiöse Patienten, mit schwerwiegenden Erregern, wie zum Beispiel Noroviren oder sporenbildende Erkrankungen, werden in erster Linie auf der Infektionsstation isoliert. Dabei bekommt der Patient ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad. Jedoch sind diese Plätze begrenzt und

somit muss bei großem Andrang oft priorisiert werden. So kann es auch sein, dass Covid-Patienten auf eine Normalstation kommen können. Alle anderen nicht-infektiösen Patienten kommen auf eine Normalbettstation mit Drei- oder Vierbettzimmern. Die Dauer des Aufenthalts eines durchschnittlichen Patienten beläuft sich auf 3 – 5 Tage. Es gibt Kurzlieger, die bereits schon am nächsten Tag entlassen werden und es gibt auch Ausnahmefälle, die über mehrere Wochen im Krankenhaus verweilen können, wenn es Komplikationen gibt. Die Patienten halten sich dabei überwiegend in ihren Patientenzimmern auf. Mobile Patienten suchen aber auch den Aufenthaltsbereich am Ende des Flures auf oder gehen an die frische Luft. Der Tagesablauf ist hierbei sehr monoton. In der Früh erhalten die Patienten Hilfe bei der Pflege, soweit diese benötigt wird. Um 8:00 Uhr gibt es Frühstück und danach laufen erste Untersuchungen ab, Vitalwerte werden gemessen, Infusionen werden verabreicht und es kommen Therapeuten. Um 12:00 Uhr gibt es das Mittagessen. Danach finden nur noch wenige Untersuchungen ab. Um 17:00 Uhr folgt das Abendessen und der letzte Rundgang vor der Abendruhe.

Desinfektion und Reinigung

Die Desinfektion und Reinigung wird im Hygieneplan festgelegt und durch die Hygienekommission freigegeben. Die Reinigungskräfte werden darin geschult, welche Mittel wie verwendet werden müssen und arbeiten den Plan ab. Die Reinigung und Desinfektion ist ein täglicher Prozess und auch abhängig vom Nutzungsgrad. Einmal täglich und bei Patientenwechsel werden die patientennahen Flächen und elektronische Gerätschaften vom

Pflegepersonal und die Zimmer und Bäder von der Reinigung geputzt. Im Arbeitsumfeld betreibt das Personal im Büro Pflegehygiene nach Bedarf.

Informationen und Äußerungen zur Flächenhygiene von Patienten

Bei der Verlegung eines Patienten auf eine Station findet keine Aufklärung über die Flächenhygiene oder Vorgaben zur Hygiene statt. Es existieren Informationen in Form eines Flyers, die aber den Patienten nicht direkt zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten gibt es nur im Falle eines ansteckenden Bettnachbarn eine kurze Information darüber, dass Händedesinfektion und Flächendesinfektion im Bad betrieben werden sollte. Von der Seite der Patienten äußern sich nur wenige zu Hygienethemen. Meistens handelt es sich dabei um weibliche Patienten oder Risikopatienten, die ihre Meinung äußern. Für gewöhnlich ist es in Form von Kritik. Grund für das mangelnde Feedback der Patienten könnte die Angst davor sein, dass die Äußerung negativ aufgenommen und die Wertschätzung für die Arbeit des Personals verringert wird. Die Furcht davor, daraus resultierend, eine verminderte Pflegeleistung zu erhalten, könnte ebenfalls eine Hemmschwelle sein. Für gewöhnlich wird die Kritik mündlich an das Personal herangetragen und es wird versucht, den Fehler sofort nachzubessern.

Beteiligung an Flächenhygiene

Die Meinungen des medizinischen Personals darüber, ob sich Patienten an der Flächenhygiene beteiligen sollten, sind vielfältig und unterscheiden sich stark. Es wurden viele Pro- und Kontra Argumente zusammengetragen. Die Gründe und Vorteile, warum Patienten in der Flächenhygiene involviert werden sollten, werden zuerst betrachtet.

Der erste Grund, der die Beteiligung befürwortet ist, natürlich die Tatsache, dass die Patienten im Krankenhaus von Keimen umgeben sind. Trotz der täglichen Reinigung findet man an verschiedenen Flächen ein bestimmtes Spektrum an Keimen vor und durch den Hautkontakt werden diese auf den Patienten übertragen. Vor allem auf der Toilette wird das Händewaschen oft vergessen, sodass es schnell zu einer Schmierinfektion kommen kann. Es wäre von großem Vorteil, wenn Kreuzkontaminationen vermieden werden könnten und der Patient sich nichts zuzieht. Ein weiterer Grund ist die Unterstützung des eignen Genesungsprozesses. Der Patient sollte die Möglichkeit haben eine gewisse Selbstverantwortung zu übernehmen und seine Genesung zu verkürzen, damit er schnell entlassen werden kann. Es sollte eine Teamaufgabe sein, bei der die Pflege und der Patient zusammenarbeiten. Des Weiteren wäre das Personal in geringen Maßen entlastet. Durch die hohe Belastung kann nicht erwartet werden, dass das Personal stündlich bei jedem Patienten einfache Oberflächen bei Verschmutzung, wie zum Beispiel beim Essen den Tisch, reinigt. Es wäre somit eine unterstützende Maßnahme, wenn der Patient hierbei selbständige Schritte ergreifen würde. Der letzte und wichtige Grund wäre der Schutz anderer Mitpatienten und des Personals. Der Patient würde nicht nur die eigene Genesung unterstützen, sondern auch andere Personen vor Infektionen bewahren und Übertragungswege reduzieren, wenn Ärzte und Pfleger von einem Patienten zum anderen wechseln und dabei etwas anfassen sollten, was kontaminiert ist.

Neben den Gründen dafür, werden auch Probleme und Herausforderungen genannt, die gegen die Beteiligung der Patienten an Flächenhygiene sprechen. Viele der Patienten können krankheitsbedingt nicht das Bett

verlassen oder sind nicht kognitiv fit genug, um die Anforderungen umzusetzen. Die Genesung sollte hierbei an erster Stelle stehen. Zudem besteht die Gefahr, dass diese Menschen die Tücher falsch anwenden und sich dabei Verletzungen, wie zum Beispiel Hautirritation, zuziehen. Des Weiteren könnte aufgrund fehlender Kenntnisse die Flächendesinfektion unvollständig oder falsch ausgeführt werden, sodass es in dem Sinne trotzdem beim Personal bleibt, dass die Desinfektion korrekt durchgeführt wird. Andersherum würden sehr hohe Kosten entstehen, wenn Patienten bei der Desinfektion übertreiben und bei jeder Kleinigkeit ein Tuch brauchen. Die Verschwendung wäre ebenfalls zu groß, wenn jeder Patient auch eine Packung mit nach Hause nehmen würde, weil es aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich ist die Verpackung an den nächsten Patienten zu überlassen und zu nutzen. Bei falscher Entsorgung besteht die Gefahr, dass die Leitungen verstopft werden oder Gerätschaften kaputt gehen. Außerdem wären eine Koordinierung und Organisation nötig. Es müsste einen Verantwortlichen geben, der die Patienten aufklärt und sich darum kümmert, dass die Tücher ausgeteilt werden. Aktuell gibt es keine Person, die sich dafür verantwortlich fühlen würde. Zuletzt scheitert es meistens natürlich an der Compliance selber. Die Patienten, die ins Krankenhaus kommen, erwarten oft, dass alle Aufgaben für sie übernommen werden und sie nichts mehr weiter zu tun haben. Somit wäre es unsicher, ob sie sich freiwillig an der Flächenhygiene beteiligen, wenn das Personal sowieso dafür zuständig ist.

Trotz der vielen Pro- und Kontra Argumente wurden Flächen überlegt, an denen eine Beteiligung möglich wäre. Laut dem medizinischen Personal sind vor allem patientennahe Flächen, wie Nachtkästchen oder Tisch, die

Klobrille und das Waschbecken, sinnvolle Bereiche, um die sich Patienten kümmern könnten. Wo es aber Uneinigkeiten gibt, ist die Anlaufstelle und Platzierung der Tücher. Für die Benutzung der Desinfektionstücher im Bad müsste die Platzierung dort so gestaltet sein, dass die Tücher nicht durch Kontakt bei Spritzgefahr oder beim Rausziehen kontaminiert werden. Für die Verteilung im Patientenzimmer gibt es mehrere Vorschläge:

- Kleine Verpackungseinheiten pro Patient
- Im Pflegeschränk
- Neben dem Handschuhhalter und Desinfektionsmittelspender an der Wand
- An einer Halterung neben dem Patient

Jeder dieser Platzierungen hat seine Vor- und Nachteile. Was aber hierbei sehr entscheidend wäre, ist eine Anleitung, wie man mit den Tüchern umzugehen hat. Das wo, wie und wann, genaue Angaben der Flächen, die Häufigkeit und die Einwirkzeit sollten genau beschrieben werden.

Bacillol 30 Sensitive

Das Produkt wird von dem medizinischen Personal größtenteils für technische Geräte und Monitore verwendet. Für die Desinfektion werden die Tücher eines anderen Herstellers verwendet. Jedoch eignen sich die Bacillol Tücher aufgrund ihres Wirkungsspektrums auch für die Schnelldesinfektion von Oberflächen und werden auch nebenbei verwendet. Bei der Wirkung der Tücher wird auf das Versprechen des Herstellers vertraut. Das Produkt überzeugt mit seiner kurzen Einwirkzeit, rückstandsfreien Anwendung, der einfachen Handhabung, auch ohne Handschuhe, der Feuchtigkeit und dem

Verpackungssystem. Einer der wenigen negativen Aspekte bezieht sich auf die mangelnde Nachhaltigkeit der Tücher, weil so viel Müll und Kunststoff übrigbleibt. Jedoch ist hier bewusst, dass es oft nicht möglich ist die Tücher aufgrund der Wirkstoffe umweltfreundlicher zu gestalten.

Weitere möglichen Hygienemaßnahmen

Neben der Händedesinfektion und der Flächenhygiene, wäre eine Anregung zum regelmäßigen Händewaschen ebenfalls wichtig, da dies oft vernachlässigt wird. Auch wäre Feedback und Kritik hilfreich. Als dritter Punkt wird eine Schulung zur korrekten Pflege und Nutzung von Medizingeräten genannt, da Patienten manchmal mit eigenen Gräten von zuhause kommen und oft nicht genau wissen, wie man hygienisch korrekt damit umgeht.

5.3 Interviews HARTMANN AG

Beteiligung an Flächenhygiene

Die Beteiligung würde beim Patienten ein Bewusstsein schaffen und diesen sensibilisieren, wie wichtig Hygiene ist und wie man selber dazu beitragen kann ein Übertragungsrisiko zu minimieren. Zudem wäre das Personal ein wenig entlastet und der Patient wäre bei kleinen Verschmutzungen nicht von ihnen abhängig. Man möchte dabei auch die Arbeit des Pflegepersonals nicht bemängeln. Wenn gute Erfahrungen mit dem Produkt Bacillol 30 Sensitive gemacht werden, kann man diese nach dem Krankenhausaufenthalt nachkaufen.

Bacillol 30 Sensitive

Die Tücher eignen sich für den alltäglichen Gebrauch und die Basishygiene. Sie sind gegen Bakterien, Viren und Coronaviren wirksam. Sie können problemlos ohne Handschuhe angewendet werden und haben eine gute Materialverträglichkeit. Somit ist der Umgang sehr einfach und praktikabel, da direkt nach der Entnahme aus der Packung keine weiteren Arbeitsschritte benötigt werden. Das Produkt wurde dermatologisch und auf Allergien getestet und ist damit sehr verträglich. Die Reichweite eines Tuches ist ausgiebig und die Entsorgung nach der Benutzung unkompliziert, da es in den gewöhnlichen Müll geworfen werden kann. Die Tücher können auf allen patientennahen Flächen und der Sanitäreinrichtung genutzt werden.

Leitlinien zur Anwendung

Bei der Nutzung der Tücher sollte die Einwirkzeit eingehalten werden, damit die Desinfektion der Fläche gewährleistet ist. Für jede Fläche sollte ein eigenes Tuch verwendet werden. Jedoch sollte dem Patienten klar sein, dass er nicht die volle Verantwortung trägt und er davon als zusätzliche Maßnahme für seinen Selbstschutz profitiert. Damit das verständlich ist, sollten dies den Patienten in Form einer kurzen Schulung übermittelt werden.

Herausforderungen bei der Anwendung

Es besteht die Möglichkeit, dass die Tücher falsch oder missbräuchlich angewendet werden. Ein Beispiel dafür wäre, wenn die Packung offen stehen gelassen wird und die Tücher austrocknen. Wenn man dann versucht, diese unter dem Wasserhahn wieder zu befeuchten, wird der Wirkstoff abgewaschen, sodass das Tuch seine Wirkung verliert und keine

Desinfektion garantiert ist. Wird das Tuch fälschlicherweise für die Haut, zum Beispiel der Make-Up Entfernung verwendet, können Hautirritationen hervorgerufen werden. Auch eine Kontamination der Verpackung oder des Inhaltes wäre vorstellbar, da der Deckel zum Öffnen berührt werden muss oder Tücher bei der Herausnahme wiederzurückgestopft werden. Es wäre nicht mehr ganz hygienisch und steril.

Platzierung der Tücher

Es werden zwei Ablageorte genannt. Zum einen im Bad an der Wand und im Patientenzimmer. Hierbei wäre ein gemeinsamer Ablageort, an dem die Desinfektionstücher gut erreichbar sind, wie eine Halterung in der Nähe des Patienten oder ein Schranksystem mit einer Öffnung vorstellbar. Alternativ könnte auch jeder Patient eine Packung bekommen.

5.4 Unmoderierter Usability-Test

Beobachtungen

Die Testteilnehmer hatten keine Schwierigkeiten die Verpackung zu öffnen und ein Tuch zu entnehmen.

Die Verpackung wurde griffbereit am Nachtkästchen neben dem Patientenbett abgelegt und aufbewahrt.

Die Entsorgung der Tücher nach der Nutzung erfolgte in einer am Nachtkästchen angehängten Plastiktüte.

Während der Nutzung hatte keiner der Patienten eine Anmerkung.

Post-Session Interview

Die Patienten haben die Tücher für den Tisch, Nachtschrank, Toilette, Griffe, Türklinken, Bettgestell und Waschbecken abgewischt. Es wird betont, dass es

vor allem auf der Toilette hilfreich ist. Ein Patient hat die Tücher auch für den eignen Rollator verwendet.

Es wurden an einem Tag im Durchschnitt 4 – 6 Tücher verwendet.

Zwei der Patienten würden sich eine separate Packung im Bad wünschen (P3; P2). Die restlichen Teilnehmer brauchen keine weitere Packung im Bad. Ein Patient würde es bevorzugen, wenn jeder eine eigene, kleine Verpackung bekommen würde, da es bei einer großen, wie die, die für das Testung genutzt wurde, nicht nachhaltig wäre (P5).

Die Testteilnehmer haben sich positiv zu dem Produkt geäußert. Die Feuchtigkeit wird gut bewertet, sowie der Geruch als angenehm empfunden. Durch den alkoholischen Geruch wird die Fläche als desinfiziert angesehen.

Als Verbesserungsvorschlag wird eine kleinere Packung mit weniger Tüchern genannt, da nicht eingeschätzt werden kann, wie lange die Tücher nach dem Öffnen feucht bleiben (P1). Ein weiterer Patient findet die Tücher für Chrome Oberflächen ungeeignet, weil sie Rückstände hinterlassen (P5). Das klebrige Gefühl an den Händen nach der Nutzung wird als störend empfunden, aber wurde durch das Händewaschen wieder gelöst (P1). Ein Patient würde eine feste Box bevorzugen, weil sich bei der Verpackung die Klebeöffnung nach einigen Malen nicht mehr zukleben lässt (P3).

Einer der Patienten hat angemerkt, dass sie durch die Desinfektionstücher ein erhöhtes Sicherheitsgefühl verspürt habe, da sie laut eigener Einschätzung sehr pingelig ist und im öffentlichen Bereich nicht gerne Flächen berührt, an die viele Menschen fassen, wie zum Beispiel der Handlauf bei der Rolltreppe. Während des Aufenthalts hat sie die Reinigungskraft beobachtet und festgestellt, dass mit einem Lappen jegliche

Oberflächen und das Bad geputzt werden. Daraufhin hat sie mit den Tüchern nochmal alles nachgeputzt (P1).

Einer der Testteilnehmer wurde im Mehrbettzimmer durch seine Bettnachbarn zur Flächenhygiene motiviert. Die Verpackung wurde von allen gemeinsam genutzt und als positiv aufgefasst (P3).

Einer der Patienten hat festgestellt, dass die gleichen Tücher auch im Bad liegen. Aber aufgrund der fehlenden Aufklärung wusste dieser nicht, ob er diese benutzen darf oder nicht. Jedoch sollte die Information über die Flächenhygiene nicht wie ein Vortrag oder Vorlesung erfolgen, da man als Patient in dem Moment andere Sorgen hat und diese Informationen die Person überfordern würden und eher zum Gegenteil führen. Würde man die Desinfektionstücher standardisiert in jedem Patientenzimmer auslegen, sollte man beachten, ob der Patient überhaupt in der Lage ist an der Flächenhygiene teilzunehmen, da es oft vom Zustand der Person abhängt. Zudem sollte die Verantwortung nicht allein auf den Patienten liegen und trotzdem den Profis überlassen werden. Es wurde die Sorge geäußert, dass wenn die Verpackung von allen geteilt wird, nicht festgestellt werden kann ob die Tücher richtig und sinngemäß verwendet werden (P5).

Zusammengefasst würden sich drei der fünf getesteten Patienten Desinfektionstücher auf dem Patientenzimmer für den Krankenhausaufenthalt wünschen. Für die restlichen zwei würde es keinen Unterschied machen.

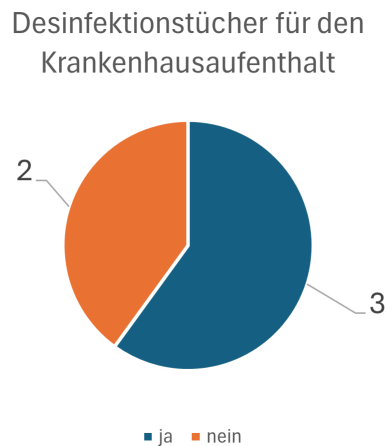


Abbildung 9: Wunsch nach Desinfektionstüchern für Krankenhausaufenthalt (eigene Darstellung)

Betrachtet man die gesamte Auswertung aus den Patienteninterviews mit dem Ergebnis des Usability Tests, so würden sich insgesamt 10 von 16 befragten und getesteten Patienten für den Krankenhausaufenthalt Desinfektionstücher auf dem Patientenzimmer wünschen und an der Flächenhygiene teilnehmen.

Zwischen den Geschlechtern konnten keine Tendenzen oder signifikanten Unterschiede festgestellt werden, da diese gleichmäßig auf der Pro- und Kontra Seite verteilt sind. Gleiches gilt für die Aufteilung auf die Zimmer. Sowohl Patienten auf Einzelzimmern als auch auf Mehrbettzimmern sind gleichmäßig auf beiden Seiten, der Beteiligung an Flächenhygiene und Nichtbeteiligung an Flächenhygiene, vertreten.

6 Persona

Basierend auf den Ergebnissen der Auswertung und der Beobachtungen wurde für die Zielgruppe Patienten eine Persona erstellt. Diese Persona spiegelt aber nur einen Teil dieser Benutzergruppe wider und stellt nur einen primären Benutzer dar. Zur besseren Lesbarkeit und Ansicht wurde diese Persona im Anhang nochmals beigefügt.

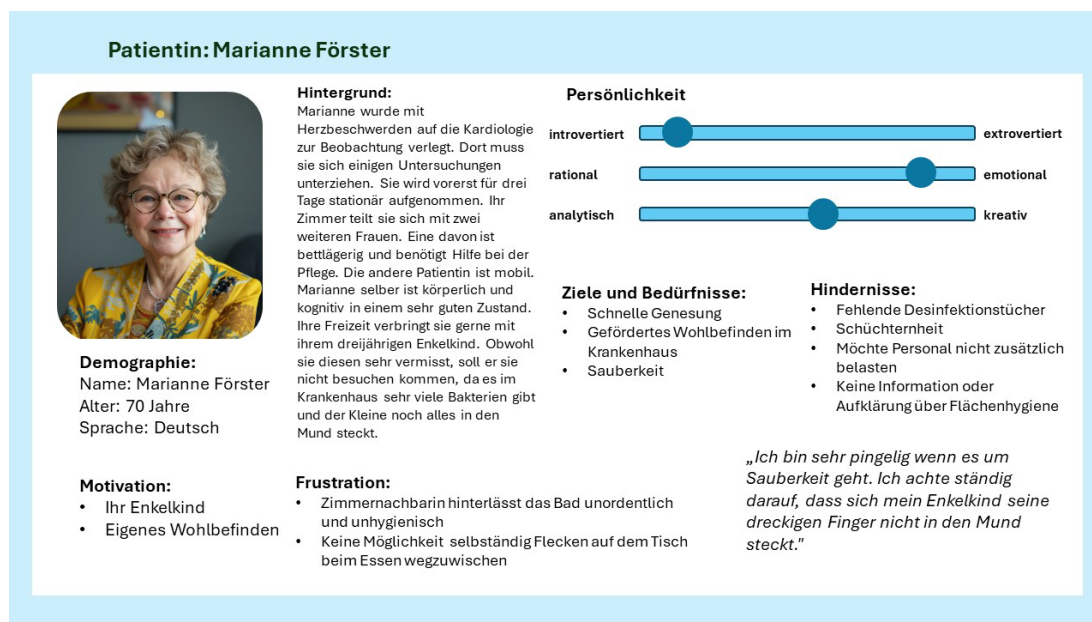


Abbildung 10: Marianne Förster (eigene Darstellung)

Bei dieser Zielgruppe handelt es sich um eine Person, die keine zusätzliche Unterstützung und Hilfe bei der Pflege benötigt, sondern selber agieren kann. Sie ist mobil und kognitiv leistungsfähig. Um das eigene Wohlbefinden zu fördern, achtet die Person auf Ordnung und Sauberkeit. Vor allem im Bad ist ein hygienisches Umfeld wichtig. Jedoch teilt sich die Patientin ein Zimmer mit zwei weiteren Personen, die unter anderem nicht das gleiche Niveau haben und aufrechterhalten, wenn es um Sauberkeit geht. Die Persona würde gerne eigenständig etwas dagegen tun, jedoch fehlen die Mittel. Leider wurde weder der Zimmernachbar noch die Persona über die

Flächenhygiene und die Vorteile davon aufgeklärt. Weil die Persona auch schüchtern ist und das Personal nicht zusätzlich mit Kleinigkeiten und Aufgaben belasten will, werden keine Anmerkungen an das medizinische Personal weitergegeben. Dass sie die Desinfektionstücher, die im Pflegeschrank versteckt gelagert sind, nach eigenem Wunsch und Ermessen mitbenutzen darf, ist ihr nicht bekannt. Weil so viele Bakterien und Keime im Krankenhaus vorhanden sind, sieht sie auch von Besuch ihrer Verwandtschaft ab, damit sie sich nichts einfangen.

7 Handlungsempfehlung

In diesem Kapitel soll anhand der Erkenntnisse aus den gesammelten Daten und Informationen eine Handlungsempfehlung aufgezeigt werden, welche die Beteiligung der Patienten an der Flächenhygiene fördern kann. Die folgenden Empfehlungen wurden auf Grundlage der Zielgruppe entwickelt, die im Forschungsprozess betrachtet wurde. Die Gruppe mit mobilen oder kognitiven Schwierigkeiten konnte hierbei nicht berücksichtigt werden. Daher könnte die Handlungsempfehlung nicht optimal auf ihren Nutzungskontext zugeschnitten sein.

7.1 Informationen und Aufklärung für Patienten

Die Ergebnisse der Forschung zeigen auf, dass Patienten keine ausreichenden und zugänglichen Informationen zur Flächenhygiene bereitgestellt bekommen. In den Patientenzimmern, in denen sie sich am meisten aufhalten, sind keine informativen Aushänge oder Flyer platziert, die den Sinn und Vorteile der Flächenhygiene erklären. Bei der stationären Aufnahme erfolgt keine Aufklärung darüber, welche Maßnahmen durchgeführt werden dürfen und können und es werden auch keine Vorgaben gemacht, an die sich Patienten halten sollten. Wenn Desinfektionstücher im Zimmer oder Bad vorgefunden werden, ist den Patienten nicht bewusst, dass sie diese auch nutzen dürfen.

Aus diesem Grund wird ein einfacher, zugänglicher und informativer Aushang, Flyer oder Plakat in den Patientenzimmern empfohlen, um den Patienten nicht zu überfordern, aber trotzdem die Gründe und die Vorteile von Flächenhygiene aufzuzeigen. Inhalte könnten zum Beispiel die Erläuterung zu Übertragungswegen von Viren und Bakterien beinhalten, die Unterstützung des Genesungsprozesses beschreiben, da die Infektionslast

gesenkt wird und den Schutz anderer Mitmenschen hervorheben. Es sollte aber bewusst werden, dass die Beteiligung nur eine unterstützende Maßnahme ist und die Verantwortung der Reinigung und Desinfektion trotzdem auf dem Klinikum liegt. Als gestalterisches Mittel wäre ein Slogan möglich, der den Menschen im Kopf bleibt und beschreibt, wie einfach es ist, sich ein Tuch herauszunehmen und schnell über eine Verschmutzung oder Fläche zu wischen. Zudem sollte das Pflegepersonal mit einem kurzen Hinweis bei Verlegung des Patienten auf die Hände- und Flächenhygiene, sowie auf Desinfektionsmittelspender und Tücher hinweisen, die zur freien Verfügung stehen.

7.2 Platzierung der Tücher in den Patientenzimmern

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Desinfektionstücher bei selbständigen Patienten erwünscht sind und die Bereitschaft zur Beteiligung an Flächenhygiene vorhanden ist. Durch die Abwesenheit der Tücher auf den Patientenzimmern, können keine proaktiven Maßnahmen ergriffen werden, um sich an der Flächenhygiene zu beteiligen. Am meisten wurde die Sanitäranlage als sinnvoller Nutzungsort genannt. Es wurde als hilfreich angesehen, da die Toilette nach dem Vorgänger vor der Selbstnutzung gesäubert werden kann und hygienische Umstände geschaffen werden.

Aus diesem Grund wird eine Platzierung von Desinfektionstüchern im Bad empfohlen. Die kontaminierte Fläche werden desinfiziert und Schmierinfektionen können damit vermieden werden. Die Platzierung der Tücher sollte gut erreichbar und sichtbar sein. Damit diese nicht mit Feuchtigkeitstüchern für die Hautanwendung verwechselt werden, sollte neben der Verpackung ein klarer Hinweis aushängen, der zum Beispiel

bildlich darstellt, dass die Tücher nur für Oberflächen, wie die Klobrille, verwendet werden dürfen. Zur korrekten Entsorgung sollte es ebenfalls einen Hinweis geben, damit die Tücher nicht fälschlicherweise in die Toilette geschmissen werden. Im Zimmer selbst wäre an der Wand, neben den Handschuhen und dem Desinfektionsmittelspender, ein geeigneter Anlaufort, sowohl für das Personal als auch für die Patienten. Es sollte hierbei aber untersucht werden, wie hygienisch es ist, wenn mehrere Personen darauf Zugriff haben und auch ohne Handschuhe hin fassen. Alternativ wäre eine kleine, persönliche Verpackung mit einem reduzierten Inhalt für Patienten möglich. Somit gäbe es eine verminderte Verschwendung, falls eine große Packung nicht mehr dem Hygienestandard entspricht oder abläuft, und man könnte sie danach mit nach Hause nehmen. Aus Kostengründen wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dies jedem Patienten auszugeben. Für isolierte Patienten mit einer erhöhten Keimlast wäre dies jedoch sinnvoll. Die Bacillol 30 Sensitive Tissues eignen sich hervorragend dafür, da sie eine grundlegende Menge an Viren und Bakterien abdecken und Haut- und Allergikerfreundlich sind. Auch Patienten mit einer langen Aufenthaltsdauer würden von einer eigenen Packung profitieren, da bei langem Aufenthalt das Risiko, sich mit einer Infektion anzustecken, erhöht ist. Da sollte die Flächenhygiene zum Selbstschutz beachtet werden. Der Zugang zu den Tüchern würde zudem die Selbständigkeit und die Eigenverantwortung der Patienten fördern und das Personal entlasten. Damit nicht die Gefahr besteht, dass bei der Verwendung jemand oder etwas zu Schaden kommt, sollte auch hierbei ein Verweis mit Leitlinien zur korrekten Benutzung ausgehängt werden. Darin sollten die Flächen definiert, die Patienten selbständig desinfizieren und reinigen dürfen, die Einwirkzeit,

die beachtet werden sollte, eine Empfohlene Anzahl Tüchern pro Fläche und eine Warnung bei empfindlichen Patienten mit Allergien oder mögliche Hautirritationen drin sein. Diese Leitlinien könnten sichtbar an der Wand neben den positionierten Tüchern aufgehängt werden.

7.3 Förderung von Feedback

Von einigen Patienten wurden die Reinigungsmaßnahmen bemängelt, die sie dazu motiviert haben, selbstständig Maßnahmen zu ergreifen und über Flächen darüberzuwischen. Abgesehen davon, wird nicht viel zu dem Thema geäußert. Möglichkeit zur Kritik in schriftlicher Form wird versteckt und nicht in patientennaher Umgebung platziert und bleibt somit unbemerkt. Das Klinikum strebt es an, die Umgebung für die Patienten zu verbessern und Fehler zu beseitigen. Die Meinungen und Äußerungen mit Verbesserungsvorschlägen zur Reinigung und Desinfektion von Patienten wären insofern eine Beteiligung an der Flächenhygiene, da diese dadurch verbessert werden kann. Es liegt eine Vermutung vor, dass aus gesellschaftlichen Gründen, die Kritik nur als etwas Negatives angesehen wird. Der Patient sollte keine Angst haben, Kritik zu äußern mit der Befürchtung, eine nachteilige Versorgung zu bekommen.

Aus diesem Grund sollte das Einholen von Feedback und Verbesserungsvorschlägen gefördert werden. Die Feedbackbögen könnten hierfür in den Patientenzimmern ausgelegt werden, damit diese erreichbar und zugänglich sind. Das Personal könnte zusätzlich mit einfachen, ungezwungenen Fragen auf die Patienten bei der Visite zugehen und nach Auffälligkeiten oder Problemen fragen. Außerdem wäre eine Bitte um die Meinung zum Krankenhausaufenthalt bei der Entlassung der Patienten

möglich. Hierbei wäre der Einsatz einer Likert Skala mit vorgegebenen Fragen hilfreich, da der Patient nicht gezwungen ist selbständig Antworten und Kriterien zu überlegen. Damit wäre ein breites Spektrum abgedeckt. Für detaillierte Angaben kann ein Freitextfeld ergänzt werden.

8 Fazit

Flächenhygiene ist Teil der Basishygiene und kann dabei helfen nosokomiale Infektionen zu verringern. Die Beteiligung der Patienten an der Flächenhygiene wäre somit vorteilhaft für den Genesungsprozess und zur Verminderung von Übertragungen.

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage „Inwieweit sind Patienten im Krankenhaus dazu bereit die Desinfektionstücher als Mittel zur Flächenhygiene eigenständig zu nutzen?“. Das Ziel war es die Ausgangssituation zu untersuchen und anhand der Ergebnisse soll eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden, wie diese Beteiligung gefördert werden kann. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde der menschenzentrierte Prozess angewendet. Um die Grundlage der Flächenhygiene zu verstehen, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Des Weiteren wurden Interviews mit dem medizinischen Personal geführt, um die Vorteile und möglichen Herausforderungen aufzuzeigen, die durch die Integration der Patienten in die Flächenhygiene auftreten könnten. Zusätzlich dazu wurde mit dem Hersteller der Desinfektionstücher Interviews zur korrekten Verwendung der Tücher gehalten. Durch Gespräche mit den Patienten wurden die Sichtweise zur Flächenhygiene, sowie die Gründe für und gegen die Nutzung von Desinfektionsprodukten aufgedeckt. In einem Usability-Test hatten die Patienten die Möglichkeit die Desinfektionstücher selber zu nutzen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Wunsch nach Desinfektionstücher zur eigenen Verwendung für den Krankenhausaufenthalt bei den Patienten vorhanden ist. Da es in den Patientenzimmern aber keine

Desinfektionstücher gibt, können keine selbständigen proaktiven Schritte eingeleitet werden, um eigenständig Flächen zu desinfizieren. Oft fehlt es den Patienten an Informationen, welche Mittel sie nutzen dürfen und was sie tun können, um ihr Wohlbefinden zu steigern und sich zu schützen. Vor allem in den Badezimmern wäre laut den Patienten der Einsatz von Desinfektionstüchern hilfreich und sinnvoll. Trotz auffallender Mängel in der Reinigung und Hygiene, werden oft keine Bemerkungen gemacht oder Feedback gegeben. Gründe dafür, warum sich die Patienten an der Flächenhygiene beteiligen möchten, sind zum einen die mangelnde Hygiene der Zimmerpartner, eigene Ansprüche an den Hygienestandard, Schutz von Familienmitgliedern und der eigenen Person vor Ansteckung. Somit ist die Fragestellung, inwieweit sie Desinfektionstücher eigenständig nutzen würden, beantwortet. Durch die Handlungsempfehlung kann die Beteiligung der Patienten an Flächenhygiene weiter gefördert werden.

9 Ausblick

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Integration der Patienten in den Prozess der Flächenhygiene erwünscht ist und aus welchen Gründen das Angebot von zugänglichen Desinfektionstüchern genutzt werden würde. Die erhobenen Daten und Ergebnisse repräsentieren jedoch nur einen Teil der Zielgruppe mit einer Altersspanne von 41 bis 82 Jahren und einem Durchschnittsalter von 65 Jahren und können nicht auf alle Patienten projiziert werden. Die Studie beschränkte sich nur auf vier ausgewählte Stationen des Krankenhauses. Für die Zukunft wäre es sinnvoll die Zielgruppe zu erweitern. Zudem konnte der Usability-Test nur verkürzt durchgeführt werden. Die Nutzer sollten die Möglichkeit haben, länger mit dem Produkt interagieren zu können, um mehr Daten zu sammeln. Sollten die Handlungsempfehlungen umgesetzt werden, könnte man die Verhaltensänderungen vor und nach der Umsetzung untersuchen.

Weitere Forschungsfragen, die in Zukunft bearbeitet werden können, sind:

- Wie unterscheidet sich die Einstellung zur Flächenhygiene im Bezug auf das Alter?
- Lassen sich Unterschiede zwischen verschiedenen Stationen feststellen?
- Wie kann sichergestellt werden, dass Patienten mit mobilen oder kognitiven Einschränkungen sich ebenfalls an der Flächenhygiene beteiligen können?
- Gibt es Verhaltensunterschiede zwischen Arztpraxen, Pflegeheimen und Altersheimen?

10 Literaturverzeichnis

Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen :

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (2022). In: *Bundesgesundheitsbl* 65 (10), S. 1074–1115. Online verfügbar unter <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-022-03576-1#change-history>.

Barkhausen, Sybille; Babikir, Regina (2017): Basishygienemaßnahmen im Krankenhaus. In: Markus Dettenkofer, Uwe Frank, Heinz-Michael Just, Sebastian Lemmen und Martin Scherrer (Hg.): *Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz*. Living reference work, continuously updated edition. Berlin, Heidelberg: Springer (Springer eBook Collection), S. 1–12.

Bhalla, Anita; Pultz, Nicole J.; Gries, Delores M.; Ray, Amy J.; Eckstein, Elizabeth C.; Aron, David C.; Donskey, Curtis J. (2004): Acquisition of nosocomial pathogens on hands after contact with environmental surfaces near hospitalized patients. In: *Infection control and hospital epidemiology* 25 (2), S. 164–167. DOI: 10.1086/502369.

DIN EN ISO 9241-210:2020-03, 2020: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 210: Menschzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme.

Flächen desinfizieren: So geht's richtig | MedSolut (2024): Flächen desinfizieren: So geht's richtig | MedSolut. Online verfügbar unter <https://medsolut.com/de/blog/flaechendesinfektion/>, zuletzt aktualisiert am 05.03.2024, zuletzt geprüft am 06.03.2024.

Geis, Thomas; Polkehn, Knut (2018): *Praxiswissen User Requirements*. Nutzungsqualität systematisch, nachhaltig und agil in die

Produktentwicklung integrieren : Aus- und Weiterbildung zum UXQB®
Certified Professional for Usability and User Experience - Advanced
Level "User Requirements Engineering" (CPUX-UR). 1. Auflage.
Heidelberg: dpunkt.verlag. Online verfügbar unter
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlabk&db=nlabk&AN=1885551>.

Geis, Thomas; Tesch, Guido (2019): Basiswissen Usability und User Experience. Aus-
und Weiterbildung zum UXQB® Certified Professional for Usability and
User Experience (CPUX) – Foundation Level (CPUX-F). Heidelberg:
dpunkt.verlag. Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1302151>.

HARTMANN GROUP (2024a): Bacillol® 30 Sensitive – stärker und schonender |
HARTMANN. Online verfügbar unter <https://www.hartmann.info/de-de/loesungen/l/de/kamp/bacillol-30-sensitive>, zuletzt aktualisiert am
07.04.2024, zuletzt geprüft am 07.04.2024.

HARTMANN GROUP (2024b): Bacillol® 30 Sensitive Tissues. Online verfügbar
unter <https://www.hartmann.info/de-de/produkte/desinfektion-und-hygiene/fl%C3%A4che/fl%C3%A4chendesinfektion-vorgetr%C3%A4nkte-t%C3%BCcher/bacillol%C2%AE-30-sensitive-tissues#products>, zuletzt aktualisiert am 09.04.2024, zuletzt geprüft am
09.04.2024.

HARTMANN's Werte und Traditionen (2024). Online verfügbar unter
<https://corporate.hartmann.info/de-de/ueber-uns/werte-und-tradition>,
zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 23.02.2024.

Holtzblatt, Karen (2017): Contextual design. Design for life. Unter Mitarbeit von Hugh Beyer. Second edition. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.
Online verfügbar unter <https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780128011362/?ar>.

Hygieneverordnung & Infektionsschutz (2021), 02.02.2021. Online verfügbar unter <https://www.ppm-online.org/pflegestandards/hygiene-im-pflegewesen/hygienemanagement/hygieneverordnung-infektionsschutz-in-medizinischen-einrichtungen/>, zuletzt geprüft am 28.02.2024.

IfSG - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (2024). Online verfügbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html#BJNR104510000BJNG000500310>, zuletzt aktualisiert am 27.02.2024, zuletzt geprüft am 27.02.2024.

Ihr Einblick in die HARTMANN-DNA (2024). Online verfügbar unter <https://corporate.hartmann.info/de-de/ueber-uns>, zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 23.02.2024.

Institut für Krankenhaushygiene- Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH (2024). Online verfügbar unter https://kliniken-heidenheim.de/klinikum/patienten/kliniken/Institut-fuer-Krankenhaushygiene/#anchor_a22eb9aa_Accordion-Team, zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 23.02.2024.

Kliniken und Fachabteilungen- Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH (2024). Online verfügbar unter <https://kliniken-heidenheim.de/klinikum/patienten/kliniken/kliniken-und-fachabteilungen.php>, zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 23.02.2024.

Krankenhaushygiene (2024). Online verfügbar unter

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhaushygiene>,
zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 23.02.2024.

Pfeiffer, Franziska (2018): Die 7 Formen der Beobachtung für die Bachelorarbeit mit

Beispielen. In: *Scribbr*, 12.07.2018. Online verfügbar unter
<https://www.scribbr.de/methodik/formen-der-beobachtung/>, zuletzt
geprüft am 08.04.2024.

Rheinbaben, F.; Schünemann, S.; Gross, T.; Wolff, M. H. (2000): Transmission of
viruses via contact in a household setting: experiments using
bacteriophage straight phiX174 as a model virus. In: *The Journal of
hospital infection* 46 (1), S. 61–66. DOI: 10.1053/jhin.2000.0794.

RKI - 2019 - Neue Schätzung zur Krankheitslast durch Krankenhaus-Infektionen

(2024). Online verfügbar unter
[https://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2019/
14_2019.html](https://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemitteilungen/2019/14_2019.html), zuletzt aktualisiert am 22.02.2024, zuletzt geprüft am
22.02.2024.

RKI - Krankenhaushygiene Themen A - Z - Hygieneplan (2024). Online verfügbar
unter

[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/ThemenAZ
/H/Hygiene/Hygiene_plan.html](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/ThemenAZ/H/Hygiene/Hygiene_plan.html), zuletzt aktualisiert am 27.02.2024,
zuletzt geprüft am 28.02.2024.

RKI - Nosokomiale Ausbrüche (2024). Online verfügbar unter

[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Ausbrueche/nosokomial/nosoko
miale_Ausbrueche_node.html](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Ausbrueche/nosokomial/nosokomiale_Ausbrueche_node.html), zuletzt aktualisiert am 22.02.2024, zuletzt
geprüft am 22.02.2024.

Schallmo, Daniel; Lang, Klaus (2020): Design Thinking erfolgreich anwenden. So entwickeln Sie in 7 Phasen kundenorientierte Produkte und Dienstleistungen. 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden, Heidelberg: Imprint Springer Gabler (Springer eBook Collection).

sortimentskatalog-desinfektion-hygiene-2023. Online verfügbar unter https://www.hartmann.info/-/media/disinfection/doc/sortimentskatalog-desinfektion-hygiene-2023.pdf?rev=e43502499260474da56d573ff08d95c2&sc_lang=de-de, zuletzt geprüft am 09.04.2024.

www.kliniken.de (2024): Krankenhaus Klinikum Heidenheim. Online verfügbar unter <https://www.kliniken.de/krankenhaus/klinikum-heidenheim-1330K.html>, zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 23.02.2024.

11 Anhang

Persona	82
Interviewleitfäden	83
Medizinisches Personal	83
Patienten im Krankenhaus	88
Vertreter der HARTMANN AG	92
Interview Transkripte	96
Medizinisches Personal	96
Patienteninterviews	166
Hartmann AG	193
Usability-Testskript	208
Usability-Test Transkripte	211
Hygieneplan Klinikum Heidenheim	227
Bilder aus dem Klinikum	231
Excel-Auswertung Aussagen	236
Miro: Affinity Diagram und Card Sorting Auswertung	237

Persona

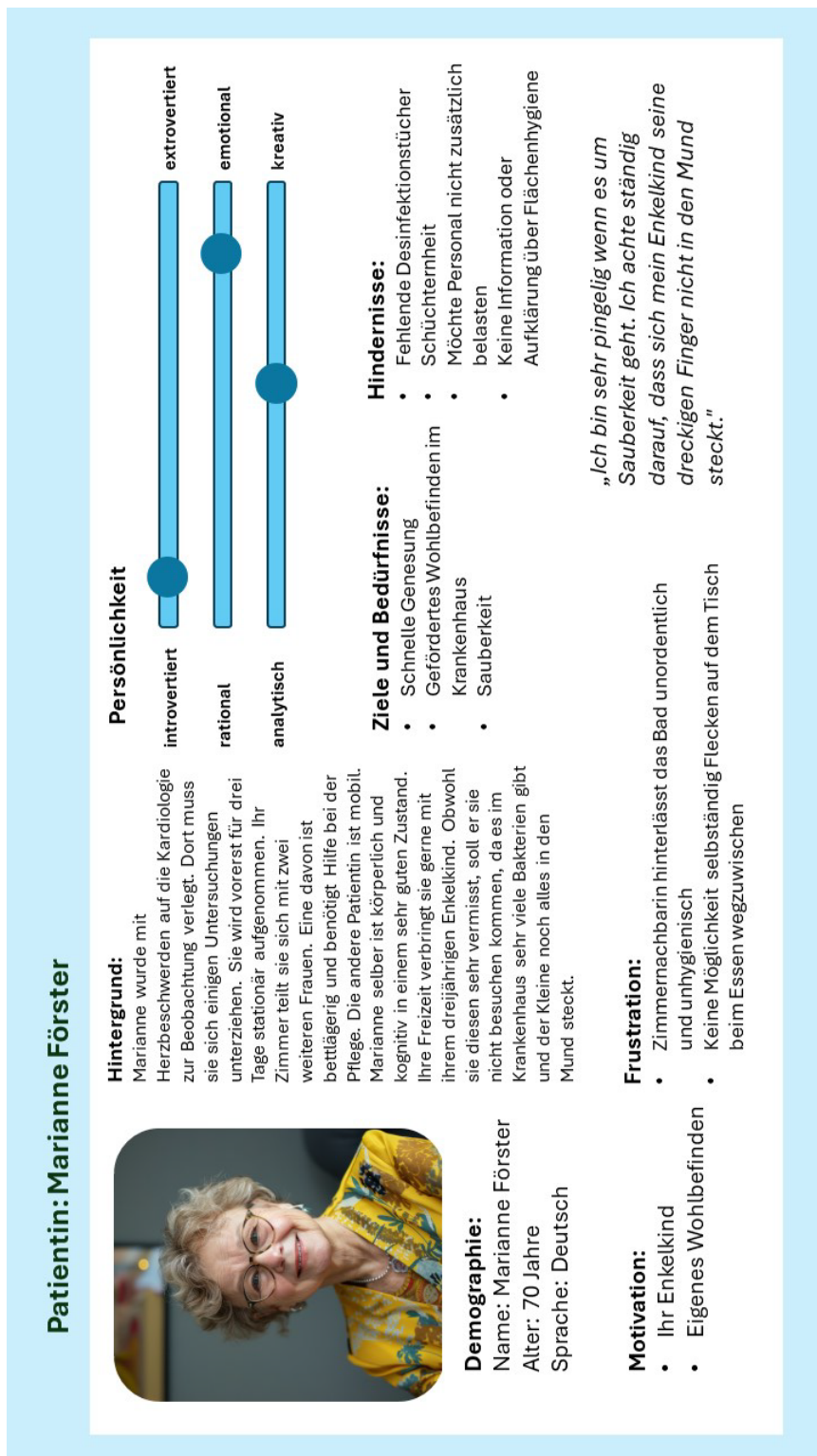


Abbildung 11: Persona Marianne Förster Anhang (eigene Darstellung)

Interviewleitfäden

Medizinisches Personal

Inhalt	Leitfragen	Grund für Frage
Begrüßung	Guten Tag, mein Name ist Kristina Gräfenstein und ich möchte mit diesem Interview mehr über die Flächenhygiene im Krankenhaus, sowie die potentielle Bereitschaft der Patienten bei der Teilnahme an der Flächen Hygiene, im Hinblick auf die Benutzung von Desinfektionstüchern, verstehen und diskutieren.	
Ziel des Interviews	Ich würde gerne in diesem Interview Ihre Meinung und Expertise dazu hören, sowie welche potentiellen Herausforderungen oder Risiken, die Sie damit verbinden.	
Datenschutz	Ich möchte das Interview aufzeichnen, um eine qualitativ hochwertige Auswertung der Ergebnisse zu ermöglichen. Die Aufnahme wird nur im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet und nach der Bearbeitung gelöscht und es werden in der Arbeit keine Namen genannt, die auf die Interviewpartner: innen und Ihre Aussagen zurückgeführt werden können. Haben Sie noch irgendwelche Fragen bevor wir beginnen?	

Vorstellung Interviewpartner	Bitte stellen Sie sich und Ihre Rolle, sowie Aufgaben im Krankenhaus vor.	Metadaten des Gegenübers herausfinden.
Allgemeine Informationen zu den Patienten	1. Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt? 2. Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten? 3. An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf? 4. Wie sieht der Alltag eines Patienten aus? 5. Äußern sich Patienten zu Hygienethemen? → Wenn ja wie wird das Feedback gemessen? 6. Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden? (Seitens des Krankenhauses) Auf welche Art und Weise?	1. Behandlungsbedarf, Raumverfügbarkeit, ähnliche Krankheitserreger = gleiches Zimmer? 2. Relevant für die Planung des Produkt-Testings 3. Mit welchen Flächen kommen Patienten in Kontakt?; Potentielle Orte für Platzierung des Produktes/Integration in den Patientenalltag 4. Ablauf kennenlernen; Relevant für das Testing 5. Gibt es Bereits Äußerungen, Wünsche usw. / Feedback seitens der Patienten das beachtet werden sollte? Wie wird auf das Feedback reagiert? 6. Werden Informationen zur Verfügung gestellt, um die Beteiligung zu fördern? Wird über die Gefahren der Konsequenzen mangelnder Flächenhygiene aufgeklärt?

Aktuelle Hygienemaßnahmen im Krankenhaus	7. Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus? ➔ Wer ist verantwortlich und wer führt es aus? ➔ Wer plant und strukturiert den Prozess? ➔ Welche Mittel werden verwendet? ➔ Wann finden die Reinigung und Desinfektion statt? (täglich; stündlich; je nach Patient?) 8. Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?	Herausfinden wie die Reinigung und Desinfektion der Räume abläuft, mit denen Patienten in Kontakt kommen/ sich aufhalten und ob Patienten/Desinfektionstücher bereits Teil der Routine sind. Welche Mittel/Methoden werden von dem medizinischen Personal und den Grund dafür herausfinden.
Einschätzung und Expertise zur Beteiligung von Patienten	9. Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen? ➔ Steht es im Interesse des medizinischen Personals, dass sie Patienten an der Hygieneerhaltung beteiligen? ➔ Ist das Thema Flächenhygiene überhaupt wichtig? Warum? ➔ Besteht überhaupt eine Notwendigkeit der der Teilnahme an der Flächenhygiene? ➔ Welchen Nutzen und Vorteil hätten die	Meinung der Experten einholen, ob es überhaupt eine Beteiligung der Patienten an der Flächenhygiene braucht.

	Patienten oder das Personal davon? 10. <u>In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?</u>	
Meinung zum Produkt „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ und Nutzung des Produktes Herausforderungen	Meine Bachelorarbeit fokussiert sich auf die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ der Firma Hartmann. 11. Wie schätzen Sie das Produkt ein? ➔ Benutzen Sie es selber in Ihrem Arbeitsalltag oder wird ein anderes Produkt genutzt? ➔ Wie sind die Umgänglichkeit und Benutzung mit dem Produkt? ➔ Wie schätzen Sie die Effektivität ein? ➔ Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern? ➔ Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie in diesem Produkt? 12. Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren? ➔ <u>Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher</u>	Meinung des medizinischen Personals zum Produkt einholen. Einschätzung der UX des Produktes. An welchen Stellen wird Notwendigkeit gesehen die Tücher einzubinden? Expertise über das Krankenhaus Heidenheim und den Alltag herausfinden. Welche Oberflächen von Keimen betroffen? Besteht ein Vorteil bezüglich Schutz des Patientenbesuches?

	<u>„Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?</u> → In welchen Situationen sollten die Tücher genutzt werden? → Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren? 13. Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben? → Wieso sind Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Patientenalltags? 14. Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?	Potentielle Schwierigkeiten erfassen; beim Testing beachten/überprüfen Hypothesen aufstellen; Gründe für Nichtteilnahme an Flächenhygiene Wichtige Schritte bei der Flächendesinfektion, die beachtet werden müssen; Leitfaden für Benutzung erstellen
Sonstige Hygienemaßnahmen	15. Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden sie in den Patientenalltag integrieren und wo?	Gibt es alternative Hygienemaßnahmen für Patienten, die beleuchtet werden könnten?
Relevante Punkte seitens des Interviewpartners	Wir haben nun über viele relevante Punkte der Flächenhygiene gesprochen.	Sonstige Ergänzungen zu dem Thema.

	Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht noch wichtig wären?	
Schluss	Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit! Sollten Sie weitere Anmerkungen oder Fragen für mich haben, dürfen Sie mich natürlich jederzeit aufsuchen. Damit wäre das Interview beendet und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.	

Patienten im Krankenhaus

Inhalt	Leitfragen	Grund für Frage
Begrüßung	Guten Tag, mein Name ist Kristina Gräfenstein. Ich bin Studentin und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Ich möchte mit diesem Interview mehr über die Flächenhygiene im Krankenhaus, sowie die potentielle Bereitschaft der Patienten bei der Teilnahme an der Flächen Hygiene, im Hinblick auf die Benutzung von Desinfektionstüchern, verstehen und diskutieren.	
Ziel des Interviews	Ich würde gerne in diesem Interview Ihre persönliche Meinung zu dem Thema Hygiene und Flächenhygiene verstehen. Ich bitte Sie so offen und ehrlich zu reden wie möglich. Sollte Ihnen eine Frage unverständlich sein, dürfen Sie gerne nachfragen. Wenn Sie das Interview abbrechen wollen, dürfen Sie es gerne jederzeit tun.	

Datenschutz	Die Informationen werden nur im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet und es werden in der Arbeit keine Namen genannt, die auf die Interviewpartner: innen und Ihre Aussagen zurückgeführt werden können. Haben Sie noch irgendwelche Fragen bevor wir beginnen?	
Allgemeine, persönliche Einstellung zur Hygiene	1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten? 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?: Nie, Selten, Manchmal, Häufig oder Immer? ➔ Welche und in welchen Situationen? ➔ In welchen Situationen würden Sie die Desinfektionstücher bevorzugt nutzen? ➔ Aus welchen Gründen benutzen Sie keine Hygieneprodukte? 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?	Einstellung der Patienten zur Hygiene einschätzen. Besteht bereits ein Umgang mit Hygieneprodukten außerhalb des Krankenhauses? Grund für Nutzung/ nicht Nutzung herausfinden? Machen sich Patienten Gedanken zu dem Thema? Existiert eine Meinung? Befolgen Sie die Maßnahmen auch im Krankenhaus?
Aufenthalt im Krankenhaus und die Hygiene-Maßnahmen	4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?	Sorgen und Einschätzung der Patienten zum Thema Hygiene im Krankenhaus herausfinden.

	➔ Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken? ➔ Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden? ➔ Leiten Sie beim Teilen eines gemeinsamen Raumes mit anderen Patienten oder bei Besuch Hygienemaßnahmen ein? ➔ Wie schätzen Sie den Umgang mit Hygiene des Zimmerpartners ein? ➔ Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Umgang mit Hygiene seitens der Mitpatienten vorstellen? 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus? ➔ Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus? ➔ Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus? ➔ Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele? ➔ Auf welche Art und Weise schützen Sie sich? ➔ Welche Faktoren beeinflussen die Eigeninitiative? 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?	Werden bereits seitens der Patienten Maßnahmen eingeleitet, um an Hygiene allgemein teilzunehmen? Ist der Umgang mit ähnlichem Produkt bereits bekannt? Meinung zu den aktuellen Maßnahmen einholen. Besteht eine Schutzvorkehrung oder der Wille nach Sicherheit des Besuches vor Ansteckung?
--	--	--

	7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?: Überhaupt nicht, wenig, neutral, stark, oder sehr stark	
Umgang mit Desinfektionstüchern	8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?: → Wenn keine Bereitschaft zur Nutzung: Warum wollen Sie diese nicht nutzen? → Gibt es gesundheitliche Gründe, warum Nutzung schwierig wäre? 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen? → In welchen Bereichen wäre der Einsatz von → Desinfektionstüchern geeignet?	Ist der Umgang mit ähnlichem Produkt bereits bekannt? Bereitschaft zur Nutzung herausfinden Nutzungsszenario und Wunsch herausfinden
Meinung zur Flächenhygiene	10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreinrichtung die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten? → Haben Sie sich schon Gedanken zur Flächenhygiene gemacht?	Wissensstand nach Flächenhygiene herausfinden
Hartmann Group	11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt? → Haben Sie diese schon mal verwendet?	Kennt der Patient bereits die Firma und hat die Produkte der Firma schon verwendet?

	➔ Wie waren Ihre Erfahrungen?	
Sonstige Anmerkungen vom Interviewpartners	Wir haben nun sehr viel über Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen geredet. Haben Sie noch weitere wichtige Punkte, die Sie ergänzen möchten?	Ergänzungen zu dem Thema
Metadaten	Zum Schluss hätte ich noch gerne gewusst: Welches Geschlecht haben Sie? Wie alt sind Sie?	
Schluss	Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit! Das Interview wäre hiermit beendet. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.	

Vertreter der HARTMANN AG

Inhalt	Leitfragen	Grund für Frage
Begrüßung	Guten Tag, mein Name ist Kristina Gräfenstein und ich möchte mit diesem Interview mehr über die Flächenhygiene im Krankenhaus, sowie die potentielle Bereitschaft der Patienten bei der Teilnahme an der Flächen Hygiene mit Hilfe Ihres Produktes „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ verstehen und diskutieren.	
Ziel des Interviews	Ich würde gerne in diesem Interview Ihre Meinung und Expertise dazu hören, sowie welche potentiellen Herausforderungen oder Risiken, die Sie damit verbinden.	

Datenschutz	Ich möchte das Interview aufzeichnen, um eine qualitativ hochwertige Auswertung der Ergebnisse zu ermöglichen. Die Aufnahme wird nur im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet und es werden in der Arbeit keine Namen genannt, die auf die Interviewpartner: innen und Ihre Aussagen zurückgeführt werden können. Haben Sie noch irgendwelche Fragen bevor wir beginnen?	
Vorstellung Interviewpartner	Bitte stellen Sie sich und Ihre Rolle, sowie Aufgaben vor. Warum sollten sich Patienten an der Flächenhygiene im Krankenhaus beteiligen?	Metadaten des Gegenübers herausfinden.
Einschätzung des Produktes	1. Was zeichnet Ihr Produkt „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ gegenüber konkurrierenden Produkten und Herstellern aus? → Was zeichnet das Produkt bei der Flächenhygiene aus? → Werden mehr Erreger und Bakterien bekämpft? (Noroviren, MRSA, Sporen) → Gibt es Inhaltsstoffe, die Ihr Produkt effektiver machen? Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Frage, ob Patienten bereit wären, sich an der Flächenhygiene zu beteiligen. Dafür kann/ sollen diese Desinfektionstücher eingesetzt werden.	Diese Fragen werden gestellt, um die Meinung zum Produkt und das Profil des Produktes zu verstehen. Eigene Überzeugung vom Produkt im Hinblick auf den primären Nutzer.

	2. Warum sollten Patienten Ihr Produkt benutzen? ➔ Welche Vorteile oder Nutzen hätte der Patient oder Personal? ➔ Gibt es Studien, die die Wirksamkeit des Produktes unterstützen? ➔ Sind die Inhaltsstoffe Hautfreundlicher als andere Produkte? ➔ Ist die Handhabung umgänglicher?	
Umgang mit dem Produkt	3. Was sind Ihre Leitlinien zur korrekten Benutzung des Produktes? ➔ Wie und wann sollte laut Hersteller das Produkt richtig genutzt werden, um den maximalen Nutzen zu beziehen? ➔ Wo und auf welchen Flächen kann/soll das Produkt genutzt werden? 4. Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren? ➔ Wenn ja: Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ in den Alltag eines Patienten integrieren? ➔ Gibt es besondere Empfehlungen in klinischer Umgebung im Krankenhaus? ➔ <u>In welchen Bereichen</u> oder auf welchen Flächen im Krankenhaus <u>könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?</u> ➔ Auf welche Art und Weise könnten die Tücher den	Sichtweise des korrekten Umgangs und korrekte Leitlinien zur Benutzung erfassen. Was denkt/will der Hersteller? Wünscht der Hersteller, dass Patienten diese Tücher nutzen? Schwierigkeiten seitens des Herstellers erfassen.

	Patienten zur Verfügung gestellt werden? 5. Welche Herausforderungen oder Risiken vermuten Sie könnten bei der Benutzung der Tücher durch Patienten auftreten?	
Allgemeine Frage	6. Haben Sie bei Ihrem letzten Krankenhausbesuch oder Aufenthalt an der Flächenhygiene teilgenommen? ➔ Gab es spezifische Momente oder Bereiche die besonders Aufmerksamkeit erregt haben?	
Relevante Punkte seitens des Interviewpartners	Wir haben nun über viele relevante Punkte der Flächenhygiene besprochen. Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht, die noch wichtig wären?	Sonstige Ergänzungen zu dem Thema.
Schluss	Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit! Sollten Sie weitere Anmerkungen oder Fragen für mich haben, dürfen Sie mich natürlich jederzeit aufsuchen. Damit wäre das Interview beendet und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.	

Interview Transkripte

Medizinisches Personal

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K01

Am 09.01.2024

1.1: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K01: Ja, also das ist so wir sind von der Bettenzahl her limitiert, wir haben maximal 16 Betten auf der Infektionsstation. Und jetzt kommt es natürlich immer drauf an, was ich dort isoliere. Jetzt zum Beispiel in der Corona Pandemie, wo man sagt, alle Corona Fälle kommen auf die Infektiologie, dann war die natürlich sehr schnell voll und dann mussten die anderen infektiösen Erkrankungen auf Normalstation gelegt werden, was natürlich relativ schwierig ist. Und da es immer wieder so Phasen gibt, eine Häufung der Grippe oder Norovirenwelle, also sprich Brechdurchfallerkrankungen und so weiter, hat man sich vor vielen Jahren darauf verständigt, auf eine sogenannte Positivliste. Das heißt diese 16 Betten werden definiert über diese Positivlisten und die Positivliste beinhaltet eben als High Risk zum Beispiel Patienten mit einer offenen Tuberkulose, also die halt eben sehr ansteckend ist und auch vom Krankheitswert sehr bedeutend ist, oder Patienten, die einen hochwertigen antibiotikaresistenten Keim haben. Auch die werden bei uns auf der Infektionsstation isoliert. Und dann eben solche Dinge wie Atemwegsinfektionen, eben wie die Grippe, also sprich Influenza, wie Corona und so weiter und die Noroviren, die darf ich nicht vergessen, weil die einfach so hoch ansteckend sind, das eskaliert sehr, sehr schnell, auch die werden zunächst bei uns isoliert. Alle anderen niederschwelligen, es gibt ja zum Beispiel so sporenbildende Durchfallerkrankungen, die zwar auch ansteckend sind, die sogenannten Clostridien, aber die können auf Normal Station ,wenn das Personal geschult ist, sehr wohl auch dort geführt und beherrscht werden. Oder zum Beispiel MRSA, als einer der gängigen antibiotikaresistenten Keime, schon seit 20 und noch mehr Jahren, ist mittlerweile so implementiert im Alltag, dass die auf Normal Station verlegt werden und eben die anderen, die High-Risk, auf die Infektionsstation verlegt werden. Dann ist es noch so, wenn irgend möglich, werden die schon vom Fachgebiet her zugeordnet, also wenn jemand mit einer kardialen Problematik kommt und hat ein MRSA, der wird dann nach Möglichkeit schon auf die Kardiologie verlegt, also dass gleich der Schwerpunkt der Erkrankung und die Infektiologie schon klar ist. So in etwa muss man sich das vorstellen. Was es vielleicht noch zu sagen gibt, wenn es ausufert, dann benötigen wir ja sozusagen eine Art Plan B, eine Filiale sozusagen von der Infektionsstationen wo man eben sagt, nein, das muss weitergehen mit definierten Isolierungen, die nicht querbeet im Haus verteilt werden können. Da wird dann eine Station definiert, die ist zum Beispiel die Station C 7 bei uns, als

Verlängerung sag ich mal der Infektiologie, aber wenn irgend möglich wird praktisch nur auf der Infektiologie die High Risk Geschichten isoliert und alles andere kann auf Normal Station isoliert werden.

2.I: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K01: Also die normalen Geschichten, das ist ganz arg schwierig zu sagen, also zum Beispiel eine kardiologische Station oder so, die kommen ja häufig rein zu irgendeiner Intervention, werden durchgecheckt und gehen wegen mir schon am nächsten Tag oder nach 2 Tagen. Da ist die Verweildauer sicher bei 3 oder 4 Tagen. Jetzt zum Beispiel bei uns in den konservativen Fächern, wo auch die betagten Herrschaften da sind, da ist sicher im Schnitt 5 Tage in etwa und die, die was infektiöses haben, also was ansteckendes, da würde ich mal sagen, sprechen wir mal wahrscheinlich von einer Woche, mal mehr weil weniger. Aber im Normalfall würde ich sagen, sind die, die zu isolierend sind, eine Woche da. Wobei ein wichtiger Zusatz ist wenn ich jetzt zum Beispiel ein MRSA auf der Kardiologie habe, dann wird der stationäre Aufenthalt nicht länger sein, weil der den MRSA hat. Das heißt, wenn die kardiologische Intervention vorbei ist, wird er entlassen, auch mit seinem MRSA. Die ISO Patienten im Schnitt, die sind sicher so eine Woche etwa stationär. Gibt natürlich auch andere. Tuberkulose, die sind 3-5 Wochen da, aber das sind Ausnahmen.

3.I: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K01: Also der überwiegende Teil ist natürlich im Patientenzimmer, ganz klar. Dann ist es so, es gibt Nischen bei uns im Haus, früher war das praktisch pro Station eine Ecke, eine Nische, wo die Patienten sich aufhalten konnten. Das ist jetzt durch die neuen Umbaumaßnahmen und so weiter anders. Es gibt schon noch Aufenthaltsräume, sage ich jetzt mal, aber die meisten, wenn sie zum Beispiel noch fußläufig sind, die gehen dann raus, an die frische Luft oder unten bei uns im Eingang, die sogenannte Vorhalle, und bewegen sich dort. Das sind dann eben diejenigen, wo nicht isoliert sind, die sind ja sozusagen Freigänger, sag ich jetzt mal. Und die, die isoliert sind, aber unbedingt raus möchten, bei denen wird klar definiert, wie das Ganze zu gehen hat, aber die dürfen natürlich sich nicht überall aufhalten. Also nicht zum Beispiel in Besucherecken. Die Besucherecken sind immer im Normalfall am Ende eines langen Flurs.

4.I: Wie sieht der Alltag eines Patienten aus?

K01: Natürlich sehr stark abhängig von der Erkrankung und von den Begleiterkrankungen. Also normalerweise ist es so, dass der Patient morgens irgendwann, zwischen 06:30 Uhr und 07:00 Uhr findet der erste Kontakt mit der Pflege statt, wo es darum geht, ob man zum Beispiel jemand behilflich sein muss beim Waschen, oder das Bett machen, oder wird zum

Beispiel die Körperpflege ganz übernommen oder es gibt zum Beispiel erste Injektionen gegen Thrombose, irgendwelche Spritzen und so weiter das ist so das erste.

Und dann gibt es irgendwann, ganz grob so um 08:30 Uhr etwa, das Frühstück und nach dem Frühstück so ab 09:00 Uhr geht eigentlich der eigentliche Tag los. Das heißt, dann kommt die Visite, das heißt, da werden, wenn jemand eine Wunde hat, Verbandswechsel gemacht, Infusionstherapie, Antibiotika Gabe, wenn sie in Infusionsform gegeben werden. Aber auch zum Beispiel die Physiotherapie kommt zu der Zeit. Die Diagnostik läuft in dieser Phase und so geht der Vormittag dahin, bis etwa so um 11:30 Uhr, 12:00 Uhr und dann gibt es das Mittagessen. Der Nachmittag ist eigentlich dann relativ trist. Da gibt es vielleicht noch ein paar Untersuchungen, aber die laufen normalerweise alle am Vormittag, am Nachmittag. Ja, ist eigentlich nicht mehr viel geboten. Natürlich, immer wieder der Kontakt von der Pflege, dass zum Beispiel wie Vitalzeichen gemessen werden, Temperatur, Blutdruck, Puls. Man schaut sowieso ins Zimmer rein, wie geht es den Patienten? Vielleicht muss beim Gang zur Toilette geholfen werden und so weiter aber das ist im Prinzip da so, dass das eigentliche Programm, sag ich mal läuft bis um 12 Uhr bei einem Patienten und nachmittags eben nur noch gelegentlich Untersuchungen, ein paar Infusionen und so Geschichten.

5.I: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K01: Also das ist ganz arg abhängig. Fast keine, fast niemand, sag ich jetzt mal. Das ist für mich sehr erstaunlich, selbst durch die Corona Pandemie, die jetzt ja 3-4 Jahre geht, hätte ich gedacht oder erwartet dass das schon einen größeren Effekt ein Lerneffekt gibt. Selbst beim Klinikpersonal ist es so, die von Anfang an schon ein gewisses Hygiene Verständnis haben, die betreiben das weiter, aber die, die sozusagen neu gelernt haben, sehr wenig und bei den Patienten ist es eben auch so. Es ist sicher auffallend, dass die Patienten die sehr krank sind häufig zum Beispiel Krebspatienten, die eine Chemotherapie bekommen oder so, die achten natürlich auf ihre Gesundheit wesentlich mehr und sind drauf bedacht, dass sie die Hände desinfizieren, dass sie nicht jedem die Hand schütteln, dass sie auch jetzt zum Beispiel mit den Atemwegsinfektionen, die zirkulieren, eine Maske tragen, dass sie nicht jeden Besuch empfangen. Das Hauptklientel achtet bisher wenig auf Hygiene, wir werden wahrscheinlich im Verlauf von dem Interview noch dazu kommen, aber das liegt auch viel an uns, weil wir eben wirklich nicht so darauf hinweisen, wie es sich eigentlich gehört.

6.I: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K01: So gut wie nicht, sag ich jetzt mal. Also es gibt immer wieder mal so Themen bei uns. Ist ja auch im Klinikum, wie in vielen anderen Betrieben auch, durch so viele Themen überlagert. Man sollte sich auch um solche Themen kümmern und irgendwie fällt es dann doch am Ende des Tages runter, man hat es sporadisch schon mal begonnen, Patienten darauf hinzuweisen, mit einzubeziehen. Wir hatten vorhin gesagt, wieviel Infektionsbetten gibt es und da sind wir ja sehr stark limitiert und weil man eben nicht so viele Leute einzeln

isolieren kann, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, weil mit Infektiologie kannst du kein Geld verdienen, was natürlich heutzutage auch ein Riesenthema ist, versucht man auch bestimmte Patienten mit dementsprechenden Erregern normal in ein Mehrbettzimmer unterzubringen, aber bestimmte Auflagen im Personal zu geben. Die Klinikhygiene spricht von Basishygiene und wir in der Pflege sprechen von Barrierepflege. Barrierepflege deshalb, weil einem das mehr sagt. Also es gibt eine Barriere, sozusagen. Man hat Dreibettzimmer, der in der Mitte sozusagen, der hat einen nicht ganz unproblematischen Keim. Das heißt alles um den sein Bett herum, das ist sozusagen die Barriere. Man spricht immer ein Meter vom Patientenbit entfernt, das ist das Umfeld, wo der eigentliche Hotspot ist, wo das abgeht. Da in dem Setting, wenn die Patienten entsprechend untergebracht werden, müssen die auch, wenn sie gemeinsam die Toilette, das Bad, Handwaschbeckenarmaturen und so weiter benutzen, die Flächen dementsprechend desinfizieren. In dem Zusammenhang hat man das Mal aufgenommen. Man hat gesagt, Oh ja, das wäre doch genial, wenn die Patienten, natürlich muss die Compliance vorhanden sein, das limitiert sich das schon sehr stark, die es von der Sprache her verstehen, wo es vom Intellekt her verstehen, wo es körperlich machen können ohne Behinderungen, dass die sozusagen, wenn sie jetzt zum Beispiel auf der Toilette waren, wenn sie einen Stuhlgang hatten, dass sie, nachdem sie die Hände gewaschen haben und so weiter, dass sie dann auch die Klobrille mit einem Desinfektionsmittel getränkten Tuch desinfizieren und das dann abwerfen in den Mülleimer. In dem Rahmen kam das tatsächlich auf, aber das hat man einstampfen müssen, die Patienten nicht hingebacht, dass sie das in die Mülltonne werfen müssen. Sie haben es die Klospülung runtergespült, die dann regelmäßig verstopft ist das war das Problem. Wirklich das einzige, wo man bisher das angegangen hat und sonst eigentlich nicht.

7.1: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K01: Also das ist ganz klar definiert, wer was zu machen hat. Es gibt ja die sogenannten Hygienepläne, das sind praktisch Standards hinterlegt, wo immer ganz klar ist, was zu tun ist. Also ich nehme jetzt zum Beispiel, wenn ein Patient Noroviren hat, dann kann ich nicht das übliche Desinfektionsmittel nehmen, sondern ich muss ein bestimmtes Desinfektionsmittel nehmen, weil das eben die Noroviren kaputt macht und das andere nicht wirkt. Und so muss man das sehen bei viele andere Erkrankungen auch, zum Beispiel diese Sporen, die da gebildet werden, da muss ich natürlich ein Desinfektionsmittel für die Fläche nehmen wo auch die Sporen kaputt macht. Das heißt, es gibt ein Hygieneplan und da sind die Hygiene Standards drin und da ist praktisch hinter jeder möglichen Infektion hinterlegt was ich zu tun habe beim Betreten des Zimmers, Stichwort Schutzausrüstung, welche Desinfektionsmittel habe ich zu verwenden, für die Haut für die Hände, welche für die Fläche, und das ganze geht wird auch geschult mit den Reinigungskräften. Die Reinigungskräfte müssen wissen für die Flächen, sowohl was Inventar betrifft als auch den Boden, was da zu verwenden ist. Also das ist alles im Hygieneplan in Standards hinterlegt.

→ **7a.I: Die Reinigungskräfte sind im Großteil für die Desinfektion und Reinigung im Krankenhaus zuständig oder gibt es da auch noch andere Leute?**

K01: Für die Fläche ist das Reinigungspersonal zuständig und wir, das ist das was ich vorher sagte mit dem der Patient das Bett und ein Meter Umfeld sozusagen, das sind die patientennahen Flächen und die desinfizieren auch wir, die Pflege. Das heißt wir sprechen jetzt vom Nachtkästchen, wir sprechen von dem Bett, da gibt es auch diesen Galgen, wo man sich aufrichten kann, so hochziehen kann, das wird desinfiziert. Das Bettende, das Fußende und weiter die Dinge, wo praktisch immer wieder angefasst wird. Oder zum Beispiel das Frühstücks Tablett kommt weg und man möchte ein Set hinstellen, wo dann nachher das ganze Zeug für einen Verbandswechsel oder für eine Infusionsanlage und so weiter, das Ganze wird dann vor und nachher desinfiziert. Das macht das Pflegepersonal. Aber alles andere, die Schränke, wo die Leute ihr Equipment drin haben, der Boden, die Dusche, die Armaturen, das Bad und die ganzen sanitären Einrichtungen macht das Reinigungspersonal.

→ **7b.I: Wer genau definiert und strukturiert den Prozess oder gibt es dafür das Krankenhaus Heidenheim, eine eigenen Hygieneplan**

K01: Ja, es ist so, es gibt ja das RKI, das Robert Koch Institut, und es gibt diese KRINKO, die zwei sind die großen Player, sag ich jetzt mal. Die geben Empfehlungen raus, aber es wird geraten, sich an die Empfehlungen und Regelungen von RKI und KRINKO zu halten. Wenn irgendwas schief, wird jeder Richter danach schauen „was sagt denn das RKI?“ und wenn du dich da nicht dran gehalten hast, dann hast du ein Problem. Im Prinzip ist das fast schon Gesetz was die sagen, man spricht von Empfehlungen, aber eigentlich ist das Gesetz. Aber diese Empfehlungen lassen immer noch Wege offen, also was mache ich, welches Desinfektionsmittel nehme ich, in welcher Konzentration, wie lange Einwirkzeit und so weiter. Also ich kann zum Beispiel mit einer Atombombe herkommen, Desinfektionsmittel und relativ in kurzer Zeit mit einem Wahnsinnsmittel alles desinfizieren und neutralisieren aber das ist die Frage, ob das nicht für denjenigen, der das Macht, gesundheitsschädlich ist, beziehungsweise die Patienten, die im Anschluss dann in das Zimmer reinkommen. Das heißt, man muss dann schon sehr genau schauen, wer macht was mit welchen Mitteln und natürlich heutzutage mehr denn je auch der ökologische Gedanke. Wie ist die Bioverträglichkeit? Immer mehr auf solche Produkte zu kommen, die auch sozusagen die Umwelt möglichst nicht schädigen, also weder das Personal noch die Luft, noch die Umwelt. Aus diesem Grund legt jedes Haus letztendlich die Hygienepläne fest. Bei uns ist es der Klinikhygieniker, der ist auch zuständig für Umweltmedizin und dann ist der ja auch im Vorstand von der deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, da werden solche Dinge natürlich auch besprochen. Oder ich gehe eine Kooperation ein mit anderen Kliniken. Ich brauche irgendeinen Klinik Hygiene. Dann gibt es ja die Hygiene-Fachkräfte wie bei uns auch, die arbeiten diese Hygienestandards aus und die werden dann im Hygieneteam sozusagen final besprochen. Dann kommt das Ganze in die Hygienekommission. Dort werden Leute offiziell berufen, von der Geschäftsleitung, das sind eben Mediziner aus allen möglichen Ebenen, aber auch zum Beispiel Pflegekräfte und so weiter. Dann werden diese Standards in der Hygienekommission eben besprochen, diskutiert, da wird darüber

abgestimmt, wenn die Hygienekommission den freigibt, dann geht das Ganze an die Geschäftsleitung und die gibt es dann frei und es wird offiziell verabschiedet. Dieser Standard wird alle etwa 3 Jahre angeschaut, ob er noch aktuell ist.

➔ **Nachfrage 7c.I: Die Hygienefachkräfte arbeiten die Standards aus, dann kommt es in die Kommission und letztendlich kommt. Dann an die Reinigungskräfte und Pflege die das dann alles umsetzen?**

K01: Genauso ist es. Die Geschäftsleitung wird sozusagen als finaler Partner gefragt. Wenn es durch die Hygiene Kommission gegangen ist, winkt es die Geschäftsleitung ab und dann ist es ein offizieller Standard und dann wird es praktisch wieder runtergebrochen. Bei uns die Reinigungskräfte, die die ganze Mannschaft, das ist die Servicio das ist eine Untergruppe von unserem Klinikum. Die Leitungen sind da angehalten, dass ihre Reinigungskräfte Kenntnis haben über diese Standards und die natürlich auch einhalten.

➔ **7d.I: Wann findet die Reinigung und Desinfektion statt? (täglich; stündlich; je nach Patient?)**

K01: Ja, also was die Pflege betrifft, das mit den patientennahen Flächen, was ich jetzt ja vorhin gesagt hab, das ist sozusagen immer in der Situation. Situationsabhängig, was ich gerade eben da mache und was die Reinigungskräfte betrifft, die kommen morgens, ich glaube um 06:00 Uhr ins Haus und dann geht es im Prinzip los. Das meiste wird täglich gereinigt, wo man jetzt auch halt durch Personalmangel nicht so auf das tägliche schaut, sind mehr so die Büros und so weiter aber alles was Patienten betrifft, was Flure betrifft und so, die werden eigentlich täglich gereinigt. Es gibt so eine abgespeckte Version an Wochenende, Feiertage oder wenn jemand krank ist. Aber im Großen und Ganzen wird eigentlich jeden Tag Flächen gereinigt.

➔ **Nachfrage 7e.I: Auch wenn die Patienten noch da sind. Also wenn der Aufenthalt 5 Tage ist, wird trotzdem jeden Tag in dem Patientenzimmer auch von den Reinigungskräften das Zimmer gereinigt?**

K01: Genau das ist ja mitunter der große Vorteil, wo ich ja davon träume. Zum Beispiel, dass die Patienten, die Interesse haben, die es verstehen, die intellektuell auf der Schiene fahren, dass man die zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt in der Studie als Korrektiv mit einbaut, also die sollen das ruhig mit beobachten und beurteilen und ein Feedback geben. Zwar auch anonymisiert, aber die haben sowieso eine Menge an Zeit und wissen nicht was sie tun sollen und die beäugen natürlich so eine Reinigungskraft ganz genau. Wird das Nachkästchen zur Reinigung weggefahren oder wische ich halt um das Nachkästchen herum, die Fläche am Boden. Oder wenn Schuhe vorm Bett stehen, wird auch drum rum gewaschen oder wirklich alles. Aber das läuft auch, während der Patient da ist, ja.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K01: Ja, wer es verstanden hat passt natürlich auf. Ein ganz großes Problem, auch bei den Reinigungskräften ist, dass die aus Eigenschutz Schutzhandschuhe anziehen und die zu selten wechseln. Also die fassen kontaminierte Flächen an, dann gehen sie praktisch wieder an ihren Reinigungswagen, nehmen saubere Tücher heraus und so weiter mit diesen kontaminierten Handschuhen. Bei uns im Büro, da kommt die Reinigungskraft, die auf der Station den Flur reinigt, die Patientenzimmer und auch das Büro bei mir. Wenn ich weiß, dass die Reinigungskraft da war, wische ich die Türklinke innen und außen, die Lichtschalter, das Waschbecken, wo ich mir die Hände wasche, die Armaturen reinige ich dann sehr wohl. Im begrenzten Umfang ja, nur da, wo es praktisch sinnvoll ist.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach an Flächenhygiene beteiligen?

K01: Das Problem ist es an die Patienten hinzubekommen. Patienten werden bisher meines Erachtens viel zu stark da außen vor gelassen. Wenn 100% der Hygiene und in dem Fall jetzt der Flächenhygiene, würd ich mal tippen das was wir machen, das sind vielleicht 70%, aber die 30% können nur über Patienten gehen, weil das eben enorm wichtig ist. Wir agieren ja immer auch vom Denken her, ah das ist klar, ich lege jetzt da eine Infusion bei dem Patienten, jetzt schaue ich mal erst, dass das Nachtkästchen gereinigt ist, stelle das Ganze dann ab, lege die Infusion und so weiter dann wird das alles wieder verworfen und dann wieder praktisch nachher gesäubert. Wenn der Patient auf die Toilette geht, wir wollen es gar nicht wissen, wieviel Patienten sich vielleicht gar nicht die Hände waschen und so weiter. Wenn er Besuch empfangen hat, wenn die Hände geschüttelt werden, wenn er jemand besuchen war. Es gibt sicher Komponenten, wo es eben wichtig ist, wo auch der Patient einen Part übernimmt. Vielleicht noch größer ist das Problem bei den Händen, aber du sprichst ja jetzt von den Flächen.

→ 9a.I: Welchen Nutzen und Vorteil hätten die Patienten oder das Personal davon?

K01: Ich würde es mal so sagen. Bei der Händehygiene geht man davon aus, wenn die Compliance vom Personal bei 70% ist, bei der Handyhygiene, dann ist statistisch bewiesen sozusagen dann gehen die nosokomialen Infektionen, die Übertragungen, die gehen signifikant runter. Und wenn sozusagen jetzt wirklich das Zusammenspiel da ist, alle sozusagen, die ins Klinikum reinkommen, halten sich an bestimmte hygienische Aktionen, sowohl als Personal als auch die Patienten, erst dann wird es sozusagen rund und gibt ein Ganzes, erst dann können wir sagen, wir können wirklich eine bestmögliche Infektionsprävention machen, so ist halt immer nur punktuell Ärzte, Pflege, sonstiges medizinisches Personal und so weiter. Es fehlt immer dieses kleine Stück und das sind eben die Patienten und die Angehörigen.

→ 9b.I: Wäre es weniger Arbeit für das für das medizinische Personal deiner Meinung nach?

K01: Genau es wäre weniger Arbeit. Es ist eine deutliche Verbesserung generell, der Hygiene und damit sozusagen auch, dass halt die Keimlast, die Viruslast dementsprechend sinkt. Ganz klar, es ist eine Entlastung vom Personal und es ist gleichzeitig, sage ich jetzt mal

großspurig, es ist auch eine gesundheitsfördernde Maßnahme. Wenn natürlich ein Patient mit dementsprechenden Keimen und so weiter belastet ist, das natürlich auch immer negativ für seine Genesung. Wenn man von diesen Kreuzkontaminationen spricht, wenn ich jetzt in dem einen Zimmer bin als Pflegekraft bei der Visite und ich kontaminiere mich an der einen Fläche des Patienten und ich gehe ins nächste Zimmer, dann trage ich die ja immer weiter. Bei 20-25 Zimmer auf der Station, das heißt, ich trage natürlich diese Keime weiter, oder ich habe ja dann auch zum Schluss auch ein Cocktail an Keimen. Ja, bei dem einen hole ich mir die Sporen, bei dem nächsten hole ich mir einen antibiotikaresistenten Keim entweder auf die Hände oder an die Kleidung. Und dann geht man damit in das nächste Zimmer und kommt mit der Kleidung an das Leinentuch oder das Bett. So finden auch Übertragungen statt.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K01: Also wo es auf jeden Fall sinnvoll ist, ist ihre alles, was ihr persönliches Equipment betrifft. Vor allem natürlich das Nachtkästchen, sowohl die Ablageflächen als auch eben die Griffe, wo man immer hat und dann natürlich vor allen Dingen im Sanitärbereich. Soweit würde ich nicht gehen, dass man sagt der Patient wird die Türklinke vom Patientenzimmer desinfizieren und so weiter das ist wirklich der Job von uns im Krankenhaus, aber alles was seins ist, sozusagen plus die sanitären Einrichtungen eben gerade da. Bei einem nicht unproblematischen Keim, da wäre es natürlich toll, wenn jetzt gerade zum Beispiel natürlich immer wieder genannt, die Klobrille oder zum Beispiel der Druckknopf oder die flache Fläche eben, wo ich die Klospülung betätige, solche Dinge.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K01: Also wir kommen ja von ganz anderen Tüchern her, die wirklich viel aggressiver waren. Wenn du die Fläche zum Beispiel dann desinfiziert hast, neben dem Geruch, gab es immer so ein Schmierfilm auf der Fläche, und man hat sowohl an der Haut als auch nachher, also man ist ja eigentlich gehalten die Schutzhandschuhe zu tragen, wenn man, wenn man solche Tücher benutzt. Aber nachher zum Beispiel wenn du eine Fläche desinfiziert hast und du fasst an, wie Tastaturen oder die Maus vom PC hat man nachher einfach gemerkt das war einfach stumpf.

Diese neue Generation jetzt eben, die gehen in die richtige Richtung, sowohl was der Geruch betrifft als auch weitem nicht mehr so aggressiv für die Haut. Es ist bei weitem nicht mehr so aggressiv für Equipment, auch zum Beispiel Handys oder Laptops oder was auch immer. Und das Ziel wäre eben das Ganze noch hautverträglicher und von der Instrumente her, von dem ganzen Equipment verträglicher zu machen. Dann natürlich auch, dass sie biologisch abbaubar wären, wäre natürlich super und das Fernziel, die ich eben

bedenkenlos auch in die Toilette werfen kann und sich auflösen. Aber die Generation die du jetzt hast ist schon ein deutlicher Fortschritt, die sind gut.

➔ **11a.I: Benutzen Sie diese Tücher in Ihrem Alltag?**

K01: Ja. Vor allen Dingen dieses Produkt. Es ist aber nicht sporentauglich. Also ich benutze keine anderen, aber auf der Station bei den Patienten wird dann schon in Abhängigkeit dessen, was der Patient hat, eben dementsprechend Tücher verwendet, wo es halt eben auf das Desinfektionsmittel ankommt, weil es halt ein Unterschied ist. Hat der Patient einen antibiotikaresistenten Keim oder hat er zum Beispiel ein Sporenbild?

➔ **11b.I: Wie ist die Umgänglichkeit und Benutzung mit dem Produkt?**

K01: Ja also Schmierfilm. Es ist besser, es war viel übler, sag ich jetzt mal. Auch was die Reinigung betrifft von den Böden zum Beispiel bei solche Dinge oder andere Flächen. Wenn man es positiv sehen will, wenn ich jetzt zum Beispiel das Nachtkästchen abreibe und ich sehe den Schmierfilm, die sagen, wenn man es positiv ausdrücken will, dann sehe ich wenigstens, dass es gereinigt ist. Also sprich, überall da, wo kein Schmierfilm drauf ist, ist es nicht richtig gereinigt. Aber um es ernsthaft zu sagen, da ist sicher noch Luft nach oben. Das ist sehr schwierig, auch für die Industrie, auch was die Menge betrifft, dass ich weiß, dass manche sagen, dass diese Tücher zu trocken sind. Es kommt halt immer drauf an, wieviel Fläche will ich reinigen, wenn ich natürlich nur einen Türgriff habe oder ein Handy, Laptop oder eine kleinere Fläche dann reicht mir das aus. Bei größeren Flächen wäre es sicher nicht schlecht wenn sie feuchter wären, aber wenn man mich fragt, ich sage das ist ausreichend.

➔ **11c.I: Wie schätzen Sie die Effektivität ein?**

K01: Also schlussendlich der größte Effekt ist ja praktisch dadurch zu erkennen ob die Leute, Patienten oder Personal irgendwie selbst was aufschnappen und erkranken, also sprich hab ich nosokomiale Infektionen. Und wenn ich unsere Station, dann meine ich vor allen Dingen das Team als Paradebeispiel hernehme, auf der Infektiologie, bei uns gibt es praktisch keine Infektionen, also das sind nur Dinge, wo sozusagen Schicksal sind, wo du dann wirklich nicht beeinflussen kannst. Keine Ahnung, dass zum Beispiel jemand durch Angehörige Noroviren reingeschleppt bekommt und der erbricht dann der Mitpatient bekommt es dann auch oder so. Solche Dinge halt eben. Also die Effektivität meines Erachtens ist sehr groß, weil sonst müsste es mehr schaden geben und den Schaden gibt es nicht. Also auf den Stationen die das richtig handhaben und durchziehen gibt es die nicht.

➔ **11d.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?**

K01: Genau. Also mein Ding ist halt vor allen Dingen, dass es halt biologisch abbaubar wären, noch weniger Alkohol ist, wo halt nicht hautschädlich oder auch sonst schädlich sind. Auch von der Entsorgung, weil es ist tatsächlich so im Moment auch noch wenn du jetzt zum Beispiel viele Tücher in so einem Müllbeutel hast, ist das schon auch eine Geruchsbelästigung. Dann musst du wirklich sagen, du machst die Mülltüte zusammen, knotest sie zu und wirfst sie weg. Aber das kann man bei nur zwei Tüchern in der Mülltüte nicht machen, das wäre vom Umwelt Aspekt her nicht gut. Was die Flüssigkeitsmenge betrifft ist es meines Erachtens völlig okay. Meine Schwerpunkte wären wirklich mehr auf

biologische Produkte, biologisch abbaubar, ganz normal wegzuwerfen in den Kanal ohne, dass es verstopft.

➔ **Nachfrage 11e.I: Benutzen Sie die Tücher mit oder ohne Handschuhe?**

K01: Also ich persönlich, ich weiß, dass man sie ohne benutzen kann. Wenn ich jetzt Patient wäre und ich würde mir keine Ahnung am Tag 3 oder 5 so Teile rausziehen, würde ich keine nehmen, da hätte ich keine Bedenken. Ich persönlich nehme welche, aber das hat nur aufgrund der Häufigkeit praktisch zu tun.

➔ **11f.I: Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie in diesem Produkt?**

K01: Also der Vorteil ist natürlich ganz einfach: Früher gab es die Werbung von Zewa, Küchentücher Zewa, Wisch und weg und so ist im Prinzip ja auch. Ich zieh so ein Tuch raus und wenn ich die Fläche richtig desinfiziere dann ist halt der Effekt sehr groß, weil ich halt damit eben die Keimlast enorm senken kann.

Also ich, ich glaube die größten Dinge, die einen wirklich stören, ist so ein Stück weit der Geruch, je nach Menge. Wenn man dann anschließend so das Equipment anfasst ist es dann so stumpf, nicht angenehm zu arbeiten mit der mit der blanken Haut.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

➔ **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K01: Ja. Also ich, ich würde es halt vor allen Dingen, bei den Patienten sehen, die die einen nicht ganz unproblematischen Keim habe. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn man genügend Räume hätte, genügend Betten hätte und so weiter, die man eigentlich isolieren würde, dass die Leute vor allen Dingen da hergeführt, weil dann eben von ihnen aus, von ihrem Equipment aus keine große Gefährdung ausgeht.

➔ **12a.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?**

K01: Das das ist ein ganz toller Gedanke gegangen, da habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich ein super Punkt, weil es ist sicher, so die Packungsgröße, die wir jetzt haben, die ist sicher nicht günstig, wenn das jeder Patient kriegt. Ich weiß gar nicht, wieviel Tücher das da drin sind, müsste ich mal nachschauen. Also da ist die Größe wahrscheinlich, echt jedem das so hinzustellen zu groß.

Was natürlich immer so toll ist bei solchen Dingen, wäre natürlich, wenn ich irgendwelche Spender hätte, also jetzt praktisch so wie ich natürlich die Flüssigkeit habe, sprich Händemittel, wenn ich jetzt einen Spender hätte, wo sozusagen das rausgezogen werden könnte. Wenn er hygienisch sicher ist und wenn jetzt praktisch der nächste Patient kommt, dann könnte ich sagen, OK, zwei von diesen Blättchen werden nach dem einen Patienten verworfen und dann kommt der nächste praktisch rein. So eine Art Spender oder so wäre

natürlich toll, aber das kann nicht gehen, weil die Trocknen ja aus durch das Zimmertemperatur und so weiter.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K01: Es gibt Patienten, wo der Bettnachbar zum Beispiel, der nimmt sich eine Tube, die eigentlich gedacht ist für das Einreiben der Brust, damit die Bronchien etwas freier werden, der nimmt sie und schmiert sie sich auf das Brot. Da gibt es im Prinzip alles. Es gibt halt Leute, die sind wirklich verwirrt, aufgrund von Erkrankungen oder wenn sie dement sind. Das ist schon ein großes Problem, oder ältere Herrschaften das auch heikel. Also es gibt sicher Patienten, die auch das missbrauchen sozusagen durch Erkrankung, durch Demenz. Früher zum Beispiel durften Patienten Desinfektionsmittel gar nicht im Patientenzimmer haben, weil zum Beispiel Alkoholiker, die haben es getrunken oder demente Patienten haben es getrunken. Es war ein riesen Prozess, dass man irgendwann gesagt hat, ja gut, man macht es jetzt trotzdem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da jemand dieses Ding nimmt und dran rumlutscht oder was auch immer, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, es gibt sicher Patienten, wo man sagt. Die würden es nicht verstehen. Und dann macht es auch keinen Sinn und würden vielleicht sogar irgendwie ja Fehler damit machen. Bei der Flächendesinfektion hätte ich da keine großen Bedenken, außer dass es halt vielleicht nicht funktioniert, ja weil es nicht richtig gehandhabt wird. Sonst hätte ich keine großen Bedenken.

➔ 13a.I: Wären es die Gründe, warum die Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Patientenalltags sind?

K01: Das ist ganz sicher so. Zum anderen ist es sehr komplex, das sieht man ja an deiner Arbeit. Ja, man muss sich wirklich viel Gedanken machen. Schlussendlich gibt es wenige die sich damit befassen. Manche werden auch sagen, die Patienten sind zu alt und verstehen das nicht. Mein Paradebeispiel ist meine Verwandte, die auch im hohen Alter in der Klinik adäquat reagiert hat. Es hat nicht unbedingt immer mit dem Alter zu tun sondern mit der Compliance.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K01: Es muss ihnen klar sein, also warum sollen sie es machen? Wo sollen sie jetzt machen? Sie sollen ja sozusagen nicht das ganze Zimmer durchwischen. Wie gesagt, weshalb sollen sie es machen, weil was sind die die Hotspots für sie und dann halt eben wie entsorgen Sie das, das adäquat entsorgen und dass man dann zum Beispiel sagt, OK, und dann werden doch die Hände mit Seife gewaschen und gut ist es.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden Sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K01: Also das sind ganz sicher die Schwerpunkte. Die Händedesinfektion ist das A und O. Die Fläche wäre absolut genial, wenn man das noch in Kombination zusammenbringt. Das wären im Prinzip die Highlights vom Personal aus gesehen. Dann natürlich auch noch mit Masken durchaus, dass man den Patienten sagt, wenn sie eben eine Maske tragen, also jetzt zum Beispiel auch welche, die dann zwar isoliert sind, aber sie dürfen unter bestimmten Auflagen raus, eben mit Maske und so weiter. Zum Personal noch ganz kurz mit Kreuzkontamination das von Zimmer zu Zimmer tragen und so weiter, das ist ja mit dem Grund, weshalb wir diese Einmalschutzkittel tragen. Um Kleidung zu schützen, habe ich einen Einmalschutzkittel, dass ich nicht das von Bett zu Bett trage. Bei der Desinfektion habe ich vorhin noch vergessen, gibt es natürlich nach diesen infektiösen Patienten eine sogenannte Schlussdesinfektion, da wird wirklich das ganze Zimmer dann gereinigt, adäquat. Was Patient betrifft, wie gesagt Hände und Flächen, das ist das sind die absoluten Big Points.

Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht noch wichtig wären?

K01: Erstens natürlich, dass uns das wirklich gelingt, dass man mal so eine Studie machen und es hoffentlich Effekte gibt. Ein weiteres Teilziel wäre, dass die Angehörigen mit einbezogen werden. Am Ende des Tages ist es auch eine Bevölkerungsaufklärung.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K02

Am 17.01.2024

1.I: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K02: Im Prinzip versuche ich eigentlich immer, alle infektiösen Patienten erst mal alleine zu legen. Dann gibt es bei uns im Haus ja so eine Positivliste, wo eigentlich feststeht, dass zum Beispiel sowas wie Noroviren, irgendwelche Durchfälle, die sollten eigentlich überhaupt nicht auf einer peripheren Station liegen, sondern die sollen immer auf unsere Infektionsstation. VRE, 4 MRGN und MRSA Patienten, das sind jetzt Patienten die man auch auf Station isoliert. Wenn die Möglichkeit besteht, kann man die natürlich auch auf die Infektionsstation verlegen. Aber vor allem jetzt halt im Winter ist es natürlich schwierig. Covid Patienten sind bei uns auch auf Normalstation. Durchfallerkrankungen und Infektionen, die werden prinzipiell schon auf der Infektionsstation behandelt, weil die halt

viel bessere Möglichkeiten haben mit Schleuse. Am Wochenende kam eine Patientin die auf der Stroke lag auf einmal mit Erbrechen und Durchfall. Die hat man natürlich dann gleich isoliert, also in ein Einzelzimmer. Die Mitpatienten wurden Schutzisoliert, weil wir die Möglichkeit haben. Das ISO Stroke Zimmer wo halt wirklich weniger Material drin ist, nur das Nötigste wenn man weiß OK der Patient ist Covid positiv und muss auf die Stroke, dann kommt der nicht auf einen von den 6 Plätzen sondern kommt separat auf ein Zimmer.

2.I: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K02: Also ich würd jetzt mal sagen zwischen 3 und 5 Tagen ist so der Durchschnitt. Wir haben Langlieger, die sind teilweise 8 Wochen da und sprengen den Rahmen. Dann haben wir Rückenschmerzpatienten, die eigentlich dann nur auf ihr Bildgebung warten, das heißt das kann sein, der Patient kommt heute, wenn es ganz gut läuft, kriegt er heute Mittag ein MRT oder spätestens morgen, wenn da nichts rauskommt und mit Schmerzmedikamente es besser ist, dann geht der auch morgen schon wieder nach Hause. Unter Schlaganfall sage ich jetzt mal, der typische neurologische sage ich, die sind ja schon auch mal eine Woche oder zwei, weil halt immer dann das Problem ist, wie entwickelt sich der Patient, wird er Reha-Fähig. Wie lang dauert es bis zur Reha kann der Patient vorher zu Hause versorgt werden, braucht er ein Kurzzeitpflegeplatz, wenn er kurzzeitpflegeplatz braucht, wird es natürlich dementsprechend schwierig und die Leute bleiben teilweise auch mal 3 Wochen, weil es halt einfach keinen Kurzzeitpflegeplatz gibt. Das wird mit den Angehörigen abgesprochen.

3.I: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K02: Also ich sage jetzt mal, die meisten tatsächlich im Zimmer. Teilweise. Wir haben hinten so einen Aufenthaltsbereich mit so einer großen Glasfront, da stehen Tische und Stühle, da sitzen sie vor allem, wenn sie halt Besuch bekommen und möchten halt dann nicht im Zimmer mit dem Mitpatienten sein, dann sitzen sie dahinter. Je nachdem, wie mobil sie sind, gehen sie auch mal in irgendwie Verteilerhalle oder setzen sich ins Café und. Ansonsten gibt es jetzt hier gar nicht so viel Möglichkeiten, wo man noch so sein kann. Aber ich sag jetzt schon überwiegend eigentlich im Zimmer.

4.I: Wie sieht der Alltag eines Patienten aus?

K02: Also im Prinzip ist morgens fängt die Frühschicht an, dann gehen wir durch, hängen unsere Infusionen hin, eigentlich alle Patienten. Dann werden Vitalwerte gemessen, gegebenenfalls bekommt der Patient eine Antibiose oder, wenn er Schluckstörungen hat und wenig trinkt, dann kann sein, er kriegt halt einfach normale Infusion zur Flüssigkeit. Der Blutzucker wird gemessen. Dann muss er warten, bis es ungefähr 8 Uhr ist. Dann bekommt er sein Frühstück, dann frühstückt er. Das ist dann die Zeit, wo dann das Personal auch meistens Pause macht, dann wird so gegen Dreiviertel Neune wird wieder eingesammelt. Der Patient wird je nachdem, also wir haben Pflegeassistenten auch auf Station, wenn die Auszubildende da sind, je nachdem wie es ist, wieviel Leute da sind, wird der vorm

Frühstück versorgt mit der Körperpflege oder vielleicht auch erst nach dem Frühstück. Dann kommen morgens die Therapeuten, also ob das jetzt Ergotherapeutin, Physiotherapeutin, Logopädie, das läuft in der Regel vormittags, Logopäden, die machen das dann bei Patienten, die mit Schluckstörungen oder Schwierigkeiten beim Schlucken haben, die kann dann auch sein, dass die schon zum Frühstück kommt, die meldet sich dann vorher bei uns und sagt „Bitte Frühstück stehen lassen“, sie kommt und guckt, macht es dann entweder zwischendurch und bei manchen macht es dann so, dass sie sagt, sie kommt zum Mittagessen um zu gucken, wie funktioniert es beim Schlucken.

Dann Untersuchungen natürlich laufen morgens und mittags, da ist die Schwierigkeit, dass oft Patienten fragen, ja, was steht denn heute an und ich kann dann sagen, gut, das und das, und das ist angemeldet, aber ob das heute läuft, wann das heute läuft, da ist bei uns die Terminvergabe völlig unsicher. Das steht zwar eine Uhrzeit 09:00 Uhr, aber das kann sein, das kommt schon um 8, das kann sein, das ist erst um 12 es kann sein, dass es um 16:00 Uhr, also. Völlig offen. Deswegen ist es manchmal schwierig, den Patienten klar zu machen, ich kann ihn dir nicht sagen, wann sie dran kommen. Somit warten die halt in ihrem Zimmer bis die abgeholt werden zur Untersuchungen. Wie gesagt, Therapeuten kommen nebenher noch morgens auch mittags teilweise Physio- und Ergotherapeutin. Dann 17:00 Uhr, also 12:00 Uhr Mittagessen, dann ist 17:00 Uhr das Abendessen. Da dann wieder das Gleiche. Das Essen wird halt ausgeteilt, je nachdem ob der Patient Hilfe benötigt bekommt er Hilfe. Das ist dann in der Regel auch so eine Dreiviertelstunde Stunde, dann wird wieder eingesammelt und dann gehen wir da abends so zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr noch mal durch. Messen noch mal Vitalwerte, spritzen, noch mal eventuell Antibiosen, die es dann mittags zwischen 12 und 17:00 Uhr gibt es dann um 15:00 Uhr auch noch mal Antibiosen, wenn sie dreimal am Tag welche bekommen. Manche gingen nur zweimal am Tag, das ist dann halt morgens und abends. Genau dann werden sie fertig gemacht zum um Schlafen. Noch mal vielleicht zur Toilette oder ins Bad Zähneputzen. Und dann werden sie ins Bett gebracht. Dann verabschieden wir uns sozusagen, und dann ist Übergabe zur Nacht. Die Tagschicht vorbei.

5.1: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K02: Ich sage jetzt eigentlich eher selten. Es kommt vielleicht mal von dem ein oder anderen hier und sagen „ Ah, da am Boden, da müsste man auch mal wieder wischen“. Also die Pflege, die Reinigungskräfte kommen ja jeden Tag, wobei man da schon manchmal auch sagen muss, ob die wirklich in jede Ecke kommen? Ich mein klar ist es ja dann auch schwierig für die, dann steht das Bett, dann das Nachtkästchen, dann hat der Patient eine Tasche irgendwo. Und manche, die dann tatsächlich länger sind, sieht dann schon ein bisschen aus, wieso eigene Wohnung, da ist ja dann alles mögliche, manche haben sogar ein zweites Nachtkästchen und da ist es dann, glaube ich, auch schwierig, überall hinzukommen. Aber das ist eigentlich was, was den wenigsten Patienten auffällt. Das sind dann auch eher, sag ich jetzt mal, die Patienten, die so mit Rückenschmerzen kommen, die dann auch eher mobiler sind. Weil die Schlaganfallpatienten, die mit einer Hemiparese und

alleine nicht aus dem Bett kommen, die sehen ja im Prinzip, wenn sie im Bett liegen, außer die Decke nicht viel, aber wie gesagt, die, die mobiler sind, da kommt vielleicht mal das ein oder andere, aber ich sage jetzt mal eher selten.

6.I: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K02: Nein. Ich wüsste jetzt nichts.

7.I: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K02: Also wir haben ja jetzt sozusagen ein bisschen umgestellt. Das Interview haben Sie mit dem Kollegen auch schon geführt, der hat es bestimmt auch schon berichtet, dass die Bettenaufbereitung jetzt seit ich glaube November ist, Dezember ist das angelaufen mit so einem neuen Logistiksystem. Früher haben wir ja die Betten sozusagen mit einer Folie abgedeckt, mussten das Nachtkästchen abräumen, haben das in die Verteilerhalle gefahren, dort wurde es abgeholt. Und dann wurde in der Bettenzentrale aufbereitet. Jetzt wenn wir sozusagen Patient entlassen dann haben wir so große Smartphones, dann können wir das Bett absキャンen, müssen sagen, in welchem Zimmer das Bett steht, wie es verunreinigt ist, Iso da gibt es dann Punkte wie normal verschmutzt, stark verschmutzt, infektiöses Bett und da können wir dann auswählen, wenn jetzt der Patient, sage ich jetzt mal 3 Tage da war oder 4 Tage da war, scanne ich ab als normal verschmutzt. Meine Aufgabe ist dann das Nachtkästchen, das muss ich sozusagen abräumen, dass da nichts mehr drauf steht. Und die Reinigungskräfte kommen dann und beziehen das Bett frisch und reinigen das Bett, das Nachtkästchen im Patientenzimmer, den Patientenschrank und die Ablagefläche im Bad, was vorher unsere Aufgabe war. Was sie nicht reinigen, ist die Patientenklingsel. Das ist unsere Aufgabe, die zu putzen. Und ich sag jetzt mal alles, was um den Patienten so rum ist, ist dann eigentlich unsere Aufgabe. Der Tisch der neben dran steht die Flächen abzuwischen ist unsere Aufgabe. Es ist jetzt weniger geworden weil wir halt diesen Patientenschrank, den wir früher ausputzen mussten, den müssen wir jetzt nicht mehr ausputzen das macht die Reinigung. Das Bett, wie gesagt, putzt die Reinigungskraft und die haben da so einen Algorithmus dahinter, die wissen, welches Bett wie oft gereinigt wurde und ich könnte ihnen jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaub spätestens nach jeder 10. Aufbereitung im Zimmer bekommen die eine Meldung und müssen dann das Bett mitnehmen und bringen sozusagen ein frisches Bett mit, weil das dann in der Bettenzentrale durch die Waschanlage muss.

➔ 7a.I: Die Reinigungskräfte planen und strukturieren Sie diesen Prozess und führen ihn dann aus oder wer ist da dafür zuständig?

K02: Da ist die Servizio eine eigenständige Abteilung. Die hat man auch vor Jahren gegründet und das ist sozusagen ein eigenständiges Unternehmen im Unternehmen. Das ist die Servizio, und die sind sozusagen für ganze Küche und Reinigungskräfte zuständig. Früher hatten wir eine externe Firma, das war die Firma Kiefer aus Steinheim und. Und das hat man jetzt sozusagen alles selber in die Hand genommen, hat diese Servizio gegründet und

da gibt's dann eine Leitung wo man sich auch hinwenden kann, wenn es Probleme gibt. Dann kann ich sozusagen anrufen, wenn ich sage, jetzt will ich das Bett hier absキャンen, das funktioniert irgendwas nicht, dann muss ich die anrufen. Oder ich hab Beschwerden und sag „Wurde nicht richtig geputzt. Das sieht immer noch aus, als ob es gerade vom Patienten benutzt wurde“, dann muss ich mich an sie wenden.

➔ **7b.I: Welche Mittel werden bei der Reinigung und Desinfektion verwendet?**

K02: Bisher hatten wir von Ecolab Desinfektionstücher. Wir haben so einen Spender, den wir auffüllen mit Tüchern. Man ist gerade am Umstellen, weil man diese Tücher abschafft und austauscht. Und wie gesagt, diese Spender sind ja auch von der gleichen Firma, die möchte man jetzt auch austauschen, weil irgendwas mit der Einwirkzeit, ich glaube, die müssten eigentlich 10 Minuten einwirken, hat man jetzt herausgefunden, und deswegen stellt man gerade alles um. Und bisher haben wir eigentlich diese Tücher benutzt in diesen Eimern, und damit haben wir die Flächen desinfiziert. Unterschiedlich noch auf das Stroke, da werden diese Bacillol 30 Tücher verwendet, weil die sozusagen extra für medizinische Geräte gedacht sind und weil wir ja da Monitore haben zum Abwischen. Das sind die anderen nicht geeignet dafür, da waren dann nur die geeignet, deswegen haben wir auch die Bacillol Tücher nicht nur auf der Station, sondern auch draußen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich benutze die [Baccillol] auch lieber, weil wenn ich mit denen putze, dann ist es halt sauber, wenn es getrocknet ist. Die anderen machen immer so Flecken, wie Wasserflecken. Und es sieht dann natürlich nicht so schön aus. Ist wahrscheinlich vielleicht genauso sauber, aber es sieht halt rein optisch nicht so schön aus.

➔ **7c.I: Wann findet die Reinigung und Desinfektion statt? (täglich; stündlich; je nach Patient?)**

K02: Also die anderen Flächen sag ich jetzt mal, wenn zu den zu nach den Mahlzeiten, wenn da jetzt, wenn man sieht, dass es da irgendwie schmutzig ist, dann reinigt man da sage ich jetzt mal nach Bedarf und die Tische genauso, aber wir haben jetzt muss ich sagen, auf der Station keinen so wirklichen Plan, wo man sagt, immer da und da und da wird geputzt, das ist alles eher so. Ich sag mal nach Bedarf.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K02: Also im Büro gucke ich eigentlich schon regelmäßig, dass ich hier alles wegräume und auch mal Putz. Oben ist tatsächlich so, das ist wahrscheinlich wie auf jeder Station, sie haben immer irgendwelche. Mitarbeiter, die da mehr drauf achten und die, die weniger drauf achten. Und ich sage immer die, die dann mehr drauf achten, die kompensieren die, die weniger drauf achten, die dann auch im Nachtdienst oft, da wird dann das sehen sie wenn Sie am nächsten Morgen kommen, da ist dann alles aufgeräumt, da ist alles geputzt, da wird halt auch mal irgendwo wo was rumsteht, es wird weggeräumt, wird gewischt und wieder hin geräumt aber ist jetzt auch nicht so wo es einen Plan gibt wie man es regelmäßig macht. Das ist so individuell, wenn viel rumsteht und viel rumliegt, dann fängt da eine an zu

putzen. Manche stört es überhaupt nicht. Und auf der Station sag ich jetzt mal so, Türklinke oder sowas, da verlassen sich halt alle auf die Reinigungskräfte, die die Flure putzen und die Zimmer putzen.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K02: Na, weil sie es wahrscheinlich zu Hause auch tun würden. Manchmal ist es ja so, sie kommen hier zur Pforte rein und dann wird manchmal das Gehirn abgegeben, also wo ich mir auch denke, auch was, was hier liegen bleibt und was vergessen wird, weil irgendwie alle meinen, ja die Pflege kümmert sich ja dann drum. Für uns wäre es natürlich ja auch eine Erleichterung, wenn der Patient sagt, OK, ich habe jetzt hier gegessen und jetzt habe ich hier ein Fleck, ich kann mir irgendwo Tücher nehmen und kann die selber putzen. Ich glaube, dass wenn das es ein bisschen publik gemacht werden würde und sagt, gucken sie, da hat es Tücher, dann würden das bestimmt auch einige tun. Aber irgendwie kommt man glaub ich nicht auf die Idee und macht es entweder dann selber oder man lässt es tatsächlich teilweise dann schon auch mal dreckig.

→ 9a.I: Steht es im Interesse des Personals, dass die Patienten sich an der Flächenhygiene beteiligen?

K02: Bestimmt. Also ich glaub da wären viele dafür. Ich glaub nur, dass bei uns teilweise halt auch ein Klientel ist, dass die sich gar nicht beteiligen können. Wie gesagt, wenn sie jetzt jemanden haben mit einer Hemi, der noch nicht mal alleine aus dem Bett kommt, der kann sich natürlich schwieriger an der Flächendesinfektion beteiligen, wie jetzt ein Rückenschmerzpatient, wobei es da auch dann manchmal schon schwierig ist, wenn die schwer aus dem Bett kommen. Sicherlich gibt es Patienten die selbstständig sind. Wo man sich bestimmt auch vorstellen könnte, dass so ein fitter Patient, wenn der jetzt zwei Mitpatienten in dem Zimmer hat, die vielleicht nicht so sind, dass er sagt, OK, dann fahre ich halt einmal am Tag mit so einem Tuch über den Tisch und reinige das.

→ 9b.I: Welchen Nutzen und Vorteil hätten die Patienten oder das Personal davon?

K02: Sauberkeit.

→ 9c.I: Würden Sie das als eine unterstützende Maßnahme sehen oder sollten Patienten die Flächenhygiene komplett übernehmen können?

K02: Also wenn sie es können, dann ist eine Unterstützung. Aber ja. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es eine Unterstützung wäre. Die Frage ist natürlich dann auch immer, wie man den Patienten das verkauft. Es gibt welche die sagen, jetzt bin ich im Krankenhaus, jetzt muss ich auch noch selber putzen. Das wird bestimmt auch kommen. Wir haben ja teilweise Patienten, die dann zum Beispiel ja auch bei verschiedenen Infektionen, denen man die Tücher gibt, wenn die sagt, sie müssen auf Toilette und danach müssen sie sie auch abwischen, aber das funktioniert halt nur bei denen, die wo die Compliance da ist und die

es an dem Alter verstehen und können. MRGN Patienten die bei uns ja sozusagen mit Basishygiene, vielleicht mit 2 anderen im Zimmer ist sind? Denen müssen wir das ja auch sozusagen beibringen, dass sie eigentlich ihre eigene Toilette benutzen sollten oder halt dann tatsächlich desinfizieren, nachdem sie auf der Toilette waren.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K02: Toilette. Also ich denke man könnte das Waschbecken ohne Probleme könnte man als Patient putzen, man könnte sein Nachtkästchen, den Teil den ich ausklappe, das Tablett drauf sein Nachtkästchen, die Fläche, den Tisch, der im Zimmer steht. Ja, ich glaub das wär so das sinnvollste, weil ich glaub sein schrankputzen macht jetzt keinen Sinn, wenn da alles drin ist. Das macht man ja dann, wenn der Patient wieder geht.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K02: Gut, also ich komm gut damit zurecht. Wie gesagt, die hinterlassen keine Flecken. Sind von der Anwendung her ist es natürlich sehr einfach, Deckelchen auf Tücher rausnehmen, Deckelchen zu. Problem ist, wenn einer das Deckelchen nicht zumacht und die dann austrocknen, ja. Aber das liegt ja dann am Anwender und nicht am Produkt.

→ 11a.I: Wie schätzen Sie die Effektivität ein?

K02: Ich hoff, dass das auch sauber ist, also dass das sämtliche Bakterien und Viren sozusagen abtötet. Wobei ich das ja nicht überprüfen kann. Also ich mein, das ist ja dann sozusagen die Klinikhygiene, die dann sowas überprüft und Abstriche oder abklatsche macht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir die Tücher haben, dass sie auch Nutzen bringen.

→ 11b.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?

K02: Also teilweise würde ich mir wünschen, dass Sie vielleicht ein bisschen größer wären. Wobei man sich da ja auch abhelfen kann und sagt, dann nehm ich halt zwei und tu die halt. Übereinander nehmen oder ein bisschen versetzt, dann habe ich es auch größer, aber manchmal würde ich mir größere Tücher, das ist sozusagen bei denen von diesen Ecolab, die sind ein bisschen größer, wenn man die abreißt.

→ 11c.I: Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie in diesem Produkt?

K02: Jetzt so auf die Schnelle eigentlich nicht.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

➔ **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K02: Könnte ich mir vorstellen. Ja. Flächendesinfektion, wie gesagt jetzt diese Nachtkästchen abwischen oder den Tisch putzen. Toilette damit putzen. Also ich würd dann mit dem alles putzen glaub ich.

➔ **12a.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?**

K02: Wenn wir ins Zimmer reingehen, gleich links, haben wir sozusagen so einen Pflegeschrank. Der hat unten und oben in Türen, also die obere Türe, da sind so Sachen drin zum VVK verbinden, zum Abstöpseln und im unteren Fach ist ein bisschen Wäsche, also frische Spann Tücher, frische Deckenbezüge, sodass, wenn sie halt einen Patienten haben, der jetzt irgendwas schmutzig gemacht hat, nicht immer gleich raus müssen, ein Bettenwagen holen, sondern man hat dann vor Ort ein paar Sachen, so Kissenbezüge, und da ist sozusagen ein offenes Fach, da stehen immer Sprudel Flaschen, also gibt es ein stilles Wasser und Sprudel, und da ist zwischen den eine Lücke und da liegen tatsächlich auch in jedem Zimmer schon diese Bacillol Tücher. Die Patienten hätten Zugriff, wenn sie, wenn Sie es wollen würden. Ich habe jetzt noch niemanden gesehen, aber dass sich der ein oder andere da bestimmt auch schon mal ein Tuch genommen hat und was geputzt hat, wenn was dreckig war, weil die holen sich ja sozusagen ihr Wasser von dort, die mobilen Patienten und die sehen ja dann auch diese Tücher da liegen. Bei uns auf der Station ist es in jedem Zimmer. Bisher war das ja immer so, dass die Tücher nur für die Stroke und die intensiv mit elektrischen Geräten genutzt werden, aber wie gesagt, wir benutzen sie tatsächlich inzwischen auch so für die Flächendesinfektion.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K02: Also wir hatten tatsächlich auch schon demente Patienten, die dann gemeint hätten, das wären Feuchttücher. Das ist natürlich dann nicht so gut. Oder zum zur Hygiene, sie meinen, ich kann da meine Hände damit oder kann mich waschen damit. Das ist natürlich die Gefahr, dass das einer benutzt, wobei das jetzt höchst selten vorkommt. Aber das sehe ich so ein bisschen als Gefahr.

Wie gesagt, die Akzeptanz sage ich jetzt mal, dass sie selber auch was putzen müssen. Wobei ich mir denke, wenn man die Leute aufklärt, sie wollen ja auch, dass es sauber ist und sie wissen, Sie sind im Krankenhaus. Hier gibt es viele Keime und sie sorgen dann auch dafür, dass hier alles sauber ist. Ich glaube, dann kann man die meisten schon davon überzeugen. Und vom vom Alter her würde ich jetzt sagen, vielleicht ist das jetzt auch Klischee, aber ich sag, ich glaub die Damen könnte man eher davon überzeugen wie die Herren.

➔ **13a.I: Wären es die Gründe, warum die Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Patientenalltags sind?**

K02: Ich glaube, weil man sich da zu wenig Gedanken gemacht hat bisher. Ich glaub, die Resonanz auf den Stationen wär glaub ich überall positiv. Wenn das jemand einfach mal vorschlagen würde und sagt das wär doch eine Idee und so machen wir das jetzt. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das auf anderen Stationen gehandhabt wird, ob auf manchen Stationen vielleicht auch schon Patienten mit eingebunden werden. Das weiß ich jetzt nicht.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K02: Sie dürfen die Tücher benutzen und Flächen damit wischen, aber ich würde da jetzt nichts Besonderes sagen. Also ich wie gesagt, ich hab mich jetzt auch nicht so damit beschäftigt, kann jetzt nicht sagen ob das die Hände austrocknen und ich sag ich müsste eigentlich Handschuhe benutzen. Ich benutze sie ohne Handschuhe. Und hab jetzt aber keine Schwierigkeiten irgendwie, dass ich sag, sie greifen jetzt meine Hände an. Von dem her würde ich sagen, das ist einfach ein normales Reinigungstuch, so wie sie zu Hause auch und ein Lappen in die Hand nehmen und putzen.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden Sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K02: Also weil sie jetzt sagen, Händedesinfektion sozusagen. Würde ich jetzt, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht die Patienten auch mehr integriert werden, weil es ja eigentlich hauptsächlich das Personal benutzt und mir aber im Zimmer ja eigentlich genug Spender haben, das auch der Patient sieht. Er kann das benutzen. Das wird eigentlich wenig benutzt oder wenig drauf hingewiesen, dass man sagt, Patient darf auch seine Hände dort desinfizieren. Ansonsten. Wird mir jetzt aus auf Anhieb nichts Besonderes noch einfallen. Wie gesagt, wie sie sagen mit Maske, wenn jemand erkältet ist oder so drauf hinweist, dass er auch eine Maske tragen darf und vielleicht das auch sinnvoll ist um seine Mitpatienten zu schützen. Wobei mir das auch auffällt, dass das jetzt nach Corona schwieriger ist, manche zu überzeugen, eine Maske zu tragen, weil sie, glaube ich, etwas maskenmüde geworden sind. Also ich sehe das jetzt nicht nur bei Patienten, sondern auch beim Personal. Da es gab halt die Maskenpflicht, da war das dann halt so. Dann hat man natürlich geschimpft und wie schrecklich und alles, dann hatte man sich irgendwie ein bisschen dran gewöhnt und dann war natürlich jeder froh, dass man sagt Okay Maskenpflicht ist weg und wir haben jetzt aber seit auch schon wieder im November von der Geschäftsleitung wird halt die Maske empfohlen. Aber sie sehen natürlich hier nicht so viele mit Maske rumlaufen, weil die alle froh sind, dass sie keine mehr tragen müssen. Und so, glaube ich, geht es auch vielen Patienten, die seit jetzt im Alltag, wenn sie beim Einkaufen waren, immer Maske, Maske, Maske tragen mussten. Ich glaub noch vor 3 Jahren, wenn ich jemanden gesagt hätte, tragen sie doch eine Maske, sie sind ein bisschen erkältet, dann hätte er gesagt, ja OK mach

ich und jetzt sagt er wieso, jetzt ist doch keine Maskenpflicht mehr, ich glaub da ist ein Patient en bisschen Maskenmüde, sag ich jetzt mal.

I: Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht noch wichtig wären?

K02: So speziell nicht.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K03

Am 15.01.2024

1.I: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K03: Patienten werden je nach Erreger, wenn es übertragbar Erreger sind oder ansteckend, in der Regel auf der Isolierstation untergebracht, mit einer eigenen Schleuse, dem eigenen Vorraum, wo man sich umziehen kann, mit einer speziellen Lüftung. Patienten also je nach Schweregrad des Erregers, werden aber auch, weil natürlich nur begrenzt Platz ist, mit 10 Zimmern werden Patienten auch auf Normalstation isoliert, also sprich die liegen alleine haben dort ihr eigenes Bad, eigene Toilette.

2.I: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K03: Normal 3 bis 5 Tage, wobei das schon stark abgebaut hat im Vergleich zu früher. Also damals kann ich mich erinnern, war das schon so 5 bis 7 Tage und mittlerweile durch diese Verweildauern, die man ja bezahlt bekomme mit dem mit dem System sind die deutlich gesunken und ich würde mal sagen in der Regel sind es vielleicht 3 Tage.

3.I: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K03: Es gibt Nischen, also Aufenthaltsbereiche zum Teil, wobei die seit Corona, muss man sagen, glaub ich nicht mehr so arg genutzt werden. Meistens sind die schon in ihrem Zimmer oder gehen mal kurz spazieren. Aber hauptsächlich in den Patientenzimmern.

4.I: Wie sieht der Alltag eines Patienten aus?

K03: Ja es geht in der Regel morgens los, dass man die Patienten so 06:30 Uhr 7 weckt. In der Regel gehen die dann ins Bad oder denen wird geholfen je nachdem wie fit die sind bei der Körperpflege. Eventuell wird das Bett gemacht je nachdem wie es aussieht wie lange der Patient geplant da ist wann er kam. Danach liegt der Patient ein bisschen im Bett, dann kommt das Frühstück gegen 08:00 Uhr. Da danach gibt es eine Runde von der Pflege wo man durchgeht und wo die Vitalzeichen gemessen werden es folgt dann nur im Laufe des Vormittags die Visite je nachdem bei einem chirurgischen Patient Verbandsvisite. Ja, dann ist wahrscheinlich auch schon wieder Mittagszeit. In der Regel laufen Untersuchungen also, wo der Patient abgeholt wird, beispielsweise Röntgen, EKG wurde dann hingbracht, da laufen viele vormittags. Kommt dann wieder, kriegt um 12 Uhr rum, gibt es die runde Mittagessen, wo die Pflege durchgeht und das Essen austellt. Dann gibt es meistens noch mal eine Runde, wo die Pflege durchgeht, wenn sie das Essen wieder einsammelt um eventuell noch mal messen muss, manche kriegen noch Infusionen, kriegen Antibiotika, dann haben sie ein bisschen Ruhe, weil die Pflegeübergabezeit hat und mittags geht meistens dann die Mittagsschicht noch mal durch und guckt ob alles okay ist, teilt Getränke aus, das heißt der Patient hat da auferstehen Untersuchungen an eigentlich nicht mehr so viel. Und dann gibt es irgendwann noch mal eine Runde gegen Abend, wo die Pflege noch mal durchgeht und wo meistens noch mal Vitalzeichen gemessen werden. Je nachdem, wie der Patient drauf ist, eventuell noch Medikamente ausgeteilt werden. Also je nachdem, was noch anliegt. Und dann hat der Patient eigentlich seine Abendruhe.

5.1: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K03: Hat in den letzten Jahren eher zugenommen, also schon so, dass sie auch beobachten, dass die Desinfektion zwischen dem Patienten gefehlt hat, also dass ein Blutdruckmanschette zum Beispiel nicht desinfiziert wurde oder dass die Hände nicht desinfiziert werden oder was oft beobachtet wird, ist, dass die Reinigung vielleicht nicht so sorgfältig war vom Zimmer oder dass da irgendwas nicht so gepasst hat. Also das muss man sagen, schon vor Corona hat es zugenommen, weil Desinfektion immer mehr so ein Thema war oder Hygiene, weil mit den Medien auch immer mehr publik war, aber durch Corona hat man deutlich schon gemerkt, dass es angezogen hat.

➔ 5a.I: Und würden Sie sagen, dass es eher mehr Patienten sind, die sich dazu äußern oder ist es eher so nur ein kleiner Teil?

K03: Also wenn man es vom gesamten sieht, ist schon ein kleiner Teil, aber der kleine Teil hat zugenommen. Also früher war es ein ganz ganz kleiner Teil, da war das eigentlich eher nie Thema. Mittlerweile ist schon ein vermehrt immer mal wieder was, wo mir auch Anfragen kriegen oder wo mal auch Bewertungen vom Patienten geschrieben werden, wo das mit dem Thema ist. Also das steigt schon, aber es ist trotzdem immer noch ein kleiner Teil.

➔ 5b.I: Wie wird dieses gesammelt und gemessen?

K03: Ja, die die Patienten können praktisch was schreiben, wenn Sie sagen, Ihnen passt irgendwas nicht, die haben irgendwelche Mängel oder Ihnen fällt was auf oder auch wenn sie was loben möchten, da haben Sie die Möglichkeit was zu schreiben. Je nachdem wird es entsprechend weitergeleitet, um was es geht oder was aber meistens gemacht wurde, ist, dass es mündlich entweder an der Stationspersonal getragen wird, die das an die Hygiene melden und wird dann eventuell mal das Gespräch suchen oder je nachdem um was es halt geht, aber meistens eher mündlich.

6.I: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K03: Nicht direkt. Die Reinigung kommt sicher und wird dann sagen, dass sie jetzt das Zimmer reinigt oder desinfiziert. Aber so, dass der Patient jetzt explizit in irgendeinem Schreiben oder wie auch immer Bescheid bekommt, was genau getan wird, ist er nicht.

7.I: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K03: Also wir haben auf den Stationen Dosiergeräte. Als es ist immer so, dass die Hygiene ja letztendlich was vorschlägt, dass ein bestimmtes Konzept gibt. Also es gibt ja die Reinigungsfirma, die mit ihrem Dreifarbensystem bestimmte Lappen haben für den Boden, für die Oberflächen. Dann gibt es ein Mittel, das die da verwenden. Das wird praktisch empfohlen, in der Hygienekommission besprochen. Jene Kommission trifft sich viermal im Jahr, das ist sind Vertreter aus allen Bereichen, mit Chefärzten, mit Geschäftsleitung, da wird dann in einem Hygieneplan vorgestellt für die Desinfektion eben wie das Schema ablaufen soll. Dann wird dort zugestimmt, sonst wird eben besprochen, was man ändern soll. Dann geht das Ganze an die Geschäftsleitung, die das dann absegnen muss. Und dann ist so ein Plan letztendlich verbindlich. Es wird dann geschult und die Reinigungsfirma zum Teil von uns, zum Teil selber eben. Dann gibt es Ablaufschemas in der Reinigung, wie das stattfinden soll, also welche, was soll im Zimmer zuerst gemacht werden, mit welcher Lappenfarbe letztendlich also für die Oberflächen, wann kommt das Bad dran, wann kommt die Toilette dran, da gibt es dann einen Ablaufschema.

➔ 7a.I: Und wer ist denn dafür verantwortlich, dass es ausgeführt wird oder beziehungsweise wer führt das aus? Macht das nur das Reinigungsteam oder gibt es auch noch weitere Parteien?

K03: Die Desinfektion macht die Reinigungsfirma also bei uns ist das eine integrierte Firma, oft sind es auch externe Firmen, die dann kommen, also die im Haus dann integriert sind, da gibt es eine Vorarbeiterin, eine Leiterin, die müssen das Ganze mitkontrollieren, dass das eben auch so durchgeführt wird, die machen letztendlich auch eine Einweisung und eine Schulung. Und dann gibt es noch patientennahe Flächen, die zum Teil eben auch von der Pflege gemacht werden. Das Bettgestell oder elektronische Geräte zum Beispiel oder so, wo zum Beispiel die Reinigungsfirma nicht ran darf oder Monitore, je nachdem.

➔ 7b.I: Welche Mittel werden dabei verwendet?

K03: Es ist so, dass man eine tägliche Unterhaltsreinigung macht. Da haben wir das Insidin Rapid von der Firma Ecolab derzeit noch da, wobei man da gerade am Umstellen sind, weil das nicht mehr zulässig ist. Und dann muss man noch unterscheiden, gibt es Gegenstände, die eben eine Schnelldesinfektion brauchen, also zum Beispiel ein Tisch, wo ich Infusionen herrichte, wo ich die Einwirkzeit nicht so lange abwarten kann, also keine halbe Stunde warten kann. Da brauche ich dann ein alkoholisches Mittel, das Bacillol zum Beispiel haben wir da. Und dann kommt es noch drauf an, hat ein Patient einen gewissen Erreger, wo ich eben noch mal ein spezielles Mittel brauche, ein viruzides Mittel, ein sporizides Mittel, und dann muss man dementsprechend eben diese Mittel verwenden.

➔ **7c.I: Wann findet die Reinigung und Desinfektion statt? (täglich; stündlich; je nach Patient?)**

K03: Ja, wir haben einmal täglich eine Unterhaltsreinigung, also es heißt, der Raum, der Bereich, der Boden wird einmal am Tag desinfiziert. Auch einmal die Toilette und die Flächen eben in dem Zimmer und dann kann es sein, dass die patientennahen Flächen eben vom Personal, also von der Pflege, dass die mehrmals am Tag gemacht werden, also wenn die im Zimmer irgendwas machen, wie Nachtkästchen Verbandswechsel oder ähnliches, dann sollten die ihre Flächen, die sie benutzen, dann dementsprechend wieder desinfizieren und abwischen.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K03: Da wir nicht mit Patienten direkt in Kontakt sind, werden in der Regel Büros nicht desinfiziert, sondern werden nur gereinigt. Wir selber gucken eben auf Handyhygiene. Das heißt, wenn wir im Bereich im Krankenhaus unterwegs waren oder bei Patienten oder auf Stationen was gemacht haben, werden wir danach eine Händedesinfektion tätigen, sodass wir davon ausgehen, dass wir hier in unseren Büros jetzt nicht haben, was eine Desinfektion benötigt.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K03: Der Patient geht am Tag öfters mal auf die Toilette das heißt er wird dort ein bestimmtes Keimspektrum vorfinden. Er wird seins verlassen oder verteilen von daher macht es schon Sinn die Toilettenbrille einmal abzuwischen bevor ich mich drauf setze und dass ich danach vielleicht auch meine Hände desinfiziere oder wenn ich das Zimmer verlasse. Im Krankenhaus habe ich eine Ansammlung von schwerkranken Menschen, von vielen verschiedenen Erregern die zusammenkommen und von daher macht es schon Sinn. Die Reinigung macht es einmal am Tag aber man kann sich vorstellen im Laufe des Tages wie oft ein Griff von der Tür zum Beispiel angefasst wird, wie oft ein Schalter in einem Aufzug betätigt wird. Ich habe letztendlich relativ schnell wieder eine Ansammlung von verschiedenen Erregern und um sich selber eben zu schützen in der Situation im Krankenhaus wo sein Immunsystem vielleicht nicht mehr so gut funktioniert oder eben ein

bisschen gestresster ist macht schon Sinn sich dann gegen Keime die da noch rumschwirren ein bisschen zu wehren und das kann der Patient natürlich sehr gut.

➔ **9a.I: Würden Sie meinen, dass es im Interesse des medizinischen Personals, der Pflege der Ärzte besteht, dass sich Patienten an der Hygieneerhaltung beteiligen?**

K03: Ja, bestimmt. Ich denke, das erleichtert es uns ja und schützt uns und schützt wiederum andere Patienten. Also denke ich schon, dass das jeder auch als jeder befürworten würde.

➔ **9b.I: Welchen Nutzen und Vorteil hätten die Patienten oder das Personal davon?**

K03: Generell geht es ja nur eigentlich um die Übertragung von bestimmten Erregern. Also das heißt, es hat schon eine prophylaktische Wirkung, also den Schutz. Klar das Bilden von Resistenzen auf Dauer, also das heißt umso mehr Erreger ich habe wo sie sich irgendwo ansammeln, die dann vor allem auch Richtung Abwasser gehen, habe ich vielleicht auf Dauer, oder helfe ich mit sowas eventuell zu verhindern. Aber ich glaube im Krankenhaus direkt geht es schon um die Prophylaxe, also den Schutz vor allem der Schwerkranken.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K03: Also im Endeffekt sind es immer hauptsächlich Kontaktflächen, die man hat, also Griffe von Türen, von Aufzügen.. Am Patientenbett hab ich ein Telefon, eine Fernsehanlage, die dann auch wieder der nächste hat und umso besser die täglich auch mal abgewischt wird oder gereinigt wird, umso so weniger wird letztendlich verschleppt für den für den nächsten und ganz entscheidend wäre halt eine Händedesinfektion. Wenn ein Patient das Zimmer verlässt oder wenn er wieder ins Zimmer kommt wäre sowas ganz mitentscheidend.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K03: Sehr gut, also wir nutzen das ja auch. Ich habe hier eine alkoholische Schnelldesinfektion, was angenehm ist was den Geruch angeht. Was Umgang angeht, brauche ich keine Handschuhe anziehen was immer ganz wegen Müllvermeidung. Wird gut genutzt. Wir haben da auch noch keine Klagen, also von daher eigentlich ein ganz gutes Produkt.

➔ **11a.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?**

K03: Also wir immer schauen ist die Qualität der Tücher. Also wie groß ist ein Tuch, wie gut ist das Mittel verteilt in dem Tuch, wie Reißfest sind die also da finde ich es eigentlich ein sehr gelungenes Produkt, ein sehr gutes Tuch. Dann Nachhaltigkeit, also kann ich diese Tücher kompostieren und wieviel Rest Plastik letztendlich bleibt übrig. Sowas, denke ich,

kann man immer verbessern auf Dauer. Aber es geht immer um die Prozesse, das sind immer so die Dinge auf die wir schauen.

➔ **11b.I: Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie in diesem Produkt?**

K03: Also wenn ich weiß, für welchen Druckbereich ich das einsetzen kann, eigentlich nicht. Also das das blöde in so einem Krankenhaus ist halt immer, ich brauch einiges an Produkten damit ich alles abdecke, aber das wird nicht anders möglich sein, weil ansonsten habe ich längere Einwirkzeit und von daher denke ich passt es beim Bacilloll für das Wirkspektrum. Ich habe eine kurze Einwirkzeit. Es fällt mir da eigentlich kein großer Nachteil ein wo ich jetzt sagen könnte, das müssten wir unbedingt verbessern.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

➔ **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K03: Ja, es wird schon Sinn machen, wenn er das immer wieder auch mal nutzt, um seine Flächen, die er hat bei sich mal desinfizierend abzuwischen. Wobei man, glaub ich immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man es nicht übertreibt. Also unser Job ist immer zu gucken, dass das, was getan werden soll, getan wird, aber das eben auch nicht zu viel. Weil das ganz oft oder öfters ein Problem ist. Vor allem seit Corona, dass eben jeder meint er muss überall und alles desinfizieren. Aber das, was zumindest soweit integriert, dass man, dass man eben sagt, Ja Sanitärbereich oder dort, wo sich eben Keime ansammeln, vor allem auf dem Toilettenbereich, wird schon Sinn machen, dann auch mal mit so einem Tuch drüber zu wischen. Aber ich glaube, was das ganze Entscheidende ist, ist halt auch die Händedesinfektion.

➔ **12a.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?**

K03: Gut, man müsste es ja letztendlich im Zimmer irgendwie auslegen. Das heißt, er braucht ja Zugang dazu, dann bräuchte er ein Informationsschreiben, dass er weiß warum, wieso und wann. Dann eben wie gesagt Toilettengang oder dass man sagt, er soll morgens einmal sein Bett, also seine Kontaktflächen am Bett, vielleicht damit abwischen, das, was eventuell die Pflege sonst übernehmen würde. Da könnte er ja selber ein bisschen mitintegriert werden. Oft ist denen auch ein bisschen langweilig, das heißt, es schadet manchmal gar nicht, wenn man die so ein bisschen integriert und die was tun haben, wenn sie es können. Aber das wären so die Punkte, glaube ich.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K03: Beim Bacillol ist nicht so viel schadhaftes drin, aber klar im Kinderbereich müsste man aufpassen, dass die Kinder das nicht einatmen oder damit spielen. Oder, dass die Tücher nicht in die Toilette geworfen werden und verstopfen.

➔ **13a.I: Wären es die Gründe, warum die Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Patientenalltags sind?**

K03: Ja, sicher. Also das eine ist, man müsste es natürlich in die Hand nehmen und müsste das ganze Mal integrieren und machen, da muss sich jemand zuständig fühlen, das ist immer schwierig. Die Reinigung kann es zum Teil oft nicht, weil oft auch ein sprachliches Problem zum Beispiel dahinter steckt. Es müsste dann schon eigentlich jemand übergeordnet organisieren und müsste so eine Struktur aufbauen, dass das dann schon hinterlegt wäre. Ich glaube, das ist so ein Mittelgrund. Und dann gibt es halt die Reihe, wie gesagt, die Psychiatrie, Kinderbereiche, wo es halt wahrscheinlich nicht funktioniert.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K03: Dass es eine gewisse Einwirkzeit gibt. Dass, wie gesagt, nicht übertreiben sollen, also dass eben dran steht, ein Tuch für diese Flächen und dass man halt nicht 5 Tücher verwendet. Und natürlich, dass sie es nicht die ganze Zeit machen. Es gibt ängstliche Patienten, bei denen sicher ist, wenn man es denen eine Packung anbietet, dann kann es sein, die würden an einem Tag so ein Pack verbrauchen und jede Stunde darüberwischen. Da ist so die Gefahr dabei.

➔ **14a.I: Können Sie sich vorstellen, dass Patienten als unterstützende Maßnahme sich daran beteiligen oder sollen sie die Arbeit komplett übernehmen? Wie schätzen Sie das ein?**

K03: Ich glaub das komplette würde nicht funktionieren. Unterstützend, ja. Man sagt, ihr habt an eurem Bett zum Beispiel die Flächen oder die Toilette nach Benutzung zu machen. Mehr wird wahrscheinlich nicht funktioniert.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden Sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K03: So im Krankenhaus ist eigentlich das Entscheidende die Händedesinfektion. Klar können wir sagen, das Händewaschen kommt noch mit dazu, wobei das in dem in dem Krankenhaus, wo sie sich eigentlich nicht optisch jetzt schmutzig machen, eigentlich gar keine so große Rolle spielt, da wäre das Desinfizieren entscheidender. Die Alltagshygiene, also sprich regelmäßig auch duschen, eben der der Körperpflege widmen schon mal ganz wichtig, wobei es immer die Frage ist, wie gut können Sie das im Krankenhaus alleine je nachdem wie mobil sie sind. Aber jetzt wenn wir rein die Desinfektion anschauen glaube

ich, würde es reichen, die Händedesinfektion und gelegentlich eben die Flächendesinfektion durchzuführen.

Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht noch wichtig wären?

K03: Nee, also generell geht es immer drum, dass man nicht zu viel desinfiziert, sondern dass man da desinfiziert, wo es Sinn macht. Dass man auch ein bisschen drauf schaut, wieviel Müll produziert man. Deswegen ja, gucken was macht Sinn, wo macht es Sinn, mit welchem Mittel. Aber ich glaub, dass sie die Vorgaben gibt es ja, und da muss man eben gucken, was passt am besten. Wo kann man sparen und wo kann man sich zurückhalten.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K04

Am 12.01.2024

1.I: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K04: Es ist so, dass die Patienten eigentlich hauptsächlich über die Notaufnahme kommen und dann wird natürlich erst mal geschaut, was sind seine Beschwerden, was hat der Patient und je nachdem wird in diesem Rahmen dann auch in Bezug auf Erreger dann gescreent, also in Bezug auf MRSA, jetzt zum Beispiel wird dann geschaut oder 4 MAGN, also halt resistente Erreger, ob der ein Risiko hat und der wird dann gescreent und je nachdem was dabei dann rauskommt, würde dann halt isoliert oder nicht und je nachdem ob was seine Beschwerden sind. Wenn er jetzt auch zum Beispiel ankommt mit Fieber und hat Husten, dass wir da natürlich auch gleich einen Corona oder Influenza Abstrich machen und schauen bevor er dann unser Haus sozusagen offiziell auf den Stationen betritt, dass wir dann auch eine Infektion ausschließen können. Wenn er infektiös ist, auch irgendwas mit der Galle hat, wegen Bauchschmerzen kommt oder so, dann kann er ganz normal auf Station und ganz normal in ein anderes Patientenzimmer, wo mehrere Patienten drin liegen. Muss aber nicht zwingend sein, dass die dann alle was mit der Galle haben, sondern die haben dann halt einfach ein internistisches Problem. Also die Stationen sind ja in Internistisch oder neurologisch, wenn irgendwas mit dem Gehirn ist, eingeteilt.

2.I: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K04: Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es ist sehr stark abhängig ist von der Erkrankung. Es ist durchaus so, dass zum Beispiel eine Schwangere, die ein Kaiserschnitt bekommen hat, nur 2 bis 3 Tage im Krankenhaus ist. Manche werden auch schon direkt in der Notaufnahme wieder entlassen, weil man gemerkt hat, dass es jetzt kein stationäres Problem das kann der Patient durchaus auch ambulant abklären lassen beim Hausarzt oder wenn jemand mit einem Herzinfarkt reinkommt, der eventuell sogar intensivpflichtig wird, kann das natürlich über Wochen oder Monate gehen. Das ist ganz, ganz individuell.

3.1: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K04: Also wenn Sie bei uns im Krankenhaus aufgenommen werden, dann natürlich in den Patientenzimmer oder je nachdem, wenn die mobil sind, wenn sie laufen können, sind sie auch oft auf den Fluren von den Stationen oder dann in den Untersuchungsabteilungen, wie zum Beispiel im Röntgen oder beim CT oder in der Physiotherapie haben wir auch eine Abteilung, wo die Leute, die laufen können oder mit dem Rollstuhl fahren können. Wir haben auch ein paar internen Patienten Transport Dienst, der dann auch die Patienten rumfährt, wenn man zum Beispiel jetzt nicht selber laufen kann. Ja oder halt natürlich, wenn Angehörige kommen und die Patienten sind mobil, dann halt auch im Haupteingang, also ja in der Cafeteria oder so denke ich mal. Aber so hauptsächlich natürlich in den Patientenzimmern.

4.1: Wie sieht der Alltag eines Patienten aus?

K04: Also im Endeffekt ist es so, dass morgens der Patient schläft. Dann morgens wird der geweckt von dem ersten Rundgang der Pflegekraft, das heißt, die Pflegekraft geht mit ihrem Pflegewagen durch. Sie misst Blutdruck und verteilt die Medikamente, das Frühstück wird ausgeteilt. Danach kann der Patient essen, wenn er darf. Ja, manche müssen ja auch nüchtern bleiben, weil sie eine bestimmte Untersuchung bekommen und dann geht es eigentlich los, schon so ab 8 Uhr, wo halt das Telefon klingelt und dann die ganzen Abteilungen anrufen und sagen, der Herr Müller muss zum Beispiel ins Röntgen, weil die verschiedene Untersuchungen bekommen. In der in der Zeit, wo Patienten auf Station sind, wird natürlich angeboten, ob die Hilfe bei der Körperpflege brauchen oder sogar teilweise wird die Körperpflege komplett übernommen. Es wird gegebenenfalls Infusion noch angehängen. Dann fängt so um 10 Uhr ,11 Uhr herum die Visite an, da kommt dann ein Arzt, also im Idealfall natürlich. Und dann geht man durch jedes Patientenzimmer und fragt natürlich nach seinem Befinden, wie es weitergeht. Das wird dann mit dem Arzt besprochen. Und dann macht der Arzt auch Anordnungen, die man ausarbeiten muss, bevor der Spätdienst kommt. Das heißt vielleicht Medikamente umstellen, neues Medikament bekommen, irgendwie vielleicht Physiotherapie anmelden oder so. Dann ist eigentlich schichtende, dann fängt Spätschicht an. Für den Patient ist eigentlich immer was los, dass der mal jetzt stundenlang im Zimmer liegt, ist eher untypisch. Vielleicht dann gegen Abend beim letzten Durchgang, wenn er dann seine Spritze bekommen hat. Es wird ja natürlich schon auch geschaut, dass der Patient, ich sag jetzt mal schnellstmöglich wieder gesund wird oder man weiß, was ihm los ist, so dass er auch wieder entlassen werden kann.

5.1: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K04: Das ist auch sehr unterschiedlich, also je nachdem wie adäquat, also kognitiv in der Lage ein Patient ist, kommt es schon vor. Also die Patienten fragen dann schon mal ab und zu. „Wie sieht es denn aus mit der Nadel?“ unter anderem, also Infusionsnadel, „brauche ich die denn noch oder kann man die dann auch ziehen?“ Was in Heidenheim auch typisch ist, dass morgens die Schränke geputzt werden teilweise von der Pflege. Die Nachttische, die bekommen dann neuen Müllbeutel. Das wird dann auch oft kommentiert. Oh, das ist aber super, dass sie das wechseln. Ja, so und sonst ist es schwierig zu sagen. Also es kommt halt auch sehr individuell auf die einzelne Person an. Da werden schon Fragen gestellt, aber ich würde sagen eher weniger.

6.1: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K04: Nein.

7.1: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K04: Also wir haben bei uns vorgeschrieben Hygienepläne oder Reinigungs- und Desinfektionspläne und die haben wir für jede Station, also ganz individuell angepasst oder für jede Abteilung. Auch für Abteilungen, wo jetzt kein Patient ist, weil da ja natürlich auch gewischt und desinfiziert werden muss. Und da haben wir auch alles aufgelistet von Medizingeräte, über die Bodenreinigung, über die patientennahen Flächen, patientenfernen Flächen. Es ist eigentlich fast alles definiert und wenn neue Geräte reinkommen müssen wir halt dann auch abklären, ist es mit unserem Mittel desinfizierbar und es wird dann auch in den Reinigungsplan oder Desinfektionsplan aufgenommen.

→ 7a.1: Wer ist denn verantwortlich oder wer führt denn die Desinfektion und Reinigung aus?

K04: Ah ja, der Reinigungsdienst. Und tatsächlich auch teilweise die Ärzte, also die haben schon auch die Aufgabe zu schauen, dass ihre Ultraschallgeräte sauber sind und ihre Blutentnahmetabletts. Das ist ein ganz großes Streitthema in einem Krankenhaus.

→ 7b.1: Von wem werden die Hygienepläne festgelegt? Sind die individuell für das Krankenhaus oder gleich wie in anderen Krankenhäusern?

K04: Es ist tatsächlich vom RKI vorgeschrieben, dass jedes Krankenhaus Hygienepläne haben muss aber wie der gestaltet ist, ist dann natürlich individuell aufs Haus angepasst. Es gibt da schon mal Vorlagen im Intranet weil die Hygienepläne ja oft in Tabellenform sind. Da gibt es vielleicht Vorlagen wo man sich daran orientieren kann. Aber ausfüllen muss es dann schon jedes Haus für sich, weil jedes Haus natürlich andere Geräte, andere Betten, andere

Nachttische hat von verschiedenen Firmen. Auch andere Desinfektionstücher, die natürlich dann auch ganz individuell nur bei bestimmten Dingen eingesetzt werden dürfen. Andere Desinfektionstücher dürfen halt dann nur bei Medizinprodukten eingesetzt werden. Man wird Hygienepläne überall finden, aber nicht mit dem gleichen Inhalt.

➔ **7c.I: Welche Mittel werden für die Reinigung verwendet?**

K04: Es ist schon überwiegend eine desinfizierende Reinigung, also schon Desinfektionstücher, das auf jeden Fall ja.

➔ **7d.I: Wann findet die Reinigung und Desinfektion statt? (täglich; stündlich; je nach Patient?)**

K04: Also es ist eigentlich bei patientennahen Flächen immer ein täglicher Prozess, also einmal täglich, so steht es dann auch in den Plänen drinnen. Je nachdem wenn es patientenferne Flächen sind, dann kann man das schon auch definieren, das wird dann immer unter Hygienefachkräfte oder mit unserem Krankenhaushygieniker besprochen, in welchen Intervallen das aufbereitet werden soll. Das Allerwichtigste ist nach Herstellerangaben in dem Sinne, dass der Hersteller halt dann sagt, ja sie sollen das jetzt nicht 50 mal am Tag reinigen, weil sonst geht es irgendwann kaputt, machen wir das natürlich nicht so.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K04: Ja, da betreibe ich auch Flächenhygiene. Aber auch tatsächlich ist es auch bei den Stationen so, dass die Tastaturen und so weiter auch mit in dem Desinfektionsplan mit drin sind und dann auch mit desinfizierenden Tüchern geputzt werden oder mit Desinfektionsmittel je nachdem. Und dass das dann bei uns jetzt auch nicht anders, also ich Putz aber allerdings nicht meinen Platz jeden Tag. Natürlich ist immer zu schauen dass es optisch sauber ist und Staubablagerung vermieden werden und je nachdem guckt man dann halt, putzt man oder halt nicht.

➔ **Nachfrage 8a.I: Machen Sie das selber, oder übernimmt das auch die Reinigungskraft?**

K04: Nee, das machen wir selber. Also vor allem, wenn es um elektronische Geräte geht oder Medizingeräte, das dürfen die leider nicht machen. Also im Büro bei uns putzen die eigentlich nur den Boden, ja.

➔ **8b.I: Benutzen Sie die Bacillol Tücher, wenn Sie selber Flächenhygiene betreiben?**

K04: Ja doch kann man schon sagen. Je nachdem was wir halt gerade im Büro haben. Wir haben auch so ein Bacillol Schaum, aber das liegt auch daran dass wir so extrem viele Mitarbeiter da haben an verschiedenen Firmen, dass die dann auch oft Probeprodukte mitbringen, die wir dann halt auch manchmal verwenden, weil es natürlich auch schade ist, das wegzuschmeißen. So an sich kann man schon sagen die Bacillol Tücher.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K04: Also das Ziel ist es immer, dem Patient ohne Infektion wieder aus dem Krankenhaus zu entlassen. Das ist das Interesse von allen, sowohl vom Patient als auch von Mitarbeitern von Ärzten, also von allen, und ich denke, umso mehr Leute in der Hygiene involviert sind, umso besser ist es natürlich dann auch für den Patient, aber natürlich auch für den Mitarbeiter, weil gerade wenn jetzt ein infektiöser Patient irgendwo liegt, und der würde sich daran auch beteiligen, wenn die Kollegin vergisst Handschuhe anzuziehen, ist das natürlich toll, wenn sie den Erreger nicht abbekommt, wenn sie irgendwo hinlangt, also von dem her, ist es im Interesse von allen eigentlich.

→ 9a.I: Würden Sie die Teilnahme an Flächenhygiene als unterstützende Maßnahme sehen, oder sollen Patienten es komplett übernehmen?

K04: Also ich würde es als unterstützende Maßnahme empfehlen und gut finden, weil im Endeffekt denke ich mir, es ist schon auch ein bisschen was, darauf zu achten bei der Desinfektion, wie zum Beispiel, dass halt auch alles benetzt sein soll. Ich könnt mir auch vorstellen, dass der Patient unter anderem dann vielleicht denkt, wenn seine Aufgabe ist dann auch die falschen Tücher nimmt. Er ist nicht so aufgeklärt wie wir jetzt als Fachpersonal. Was ich toll fände, wenn der Patient natürlich gesagt bekommt, er kann da gerne mitwischen, bekommt Tücher irgendwie zur Verfügung, die er benutzen kann, dann ist es denke ich schon ist mal viel gewonnen.

→ 9b.I: Welchen Nutzen und Vorteil hätten die Patienten oder das Personal davon?

K04: Ja, natürlich auch für den Patient, weil es ist halt extrem viel Haut und Handkontakt in der patientennahen Umgebung. Das heißt, wenn der Patient mit dem Bett umhergeschoben wird, ist ja das Bett dauerhaft irgendwie in Kontakt, der Patient selber fummelt ja auch am Bett rum, um das zu verstellen oder im Nachttisch sind ja seine Utensilien oder im Bad ist er ja und geht aufs Klo und Duschen oder vor allem auch Türklinken. Da denke ich, ist das schon sinnvoll, dass man sagt, bei patientennahen Flächen kann er dann auf jeden Fall mitdesinfizieren.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K04: Ja. Patientennahen Bereiche, also eigentlich in seinem Patientenzimmer, wenn man es so will.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K04: Gut, sonst würden wir es nicht im Krankenhaus haben. Also was ich immer gut finde sind diese Flowpacks. Ja, das hat aber jetzt nichts unbedingt mit Bacillol an sich zu tun. Jede Firma hat ja Flowpacks, weil das ist halt wie eine Tempobox, da kann man dann halt immer

was rausziehen und immer nur eins. Das finde ich super. Ich finde die von der Benetzung her eigentlich gut. Ich hab die auch schon ohne Handschuhe verwendet. Mir reizen Sie jetzt nicht, ich finde sie sind gut verträglich. Ja genau und stinken auch nicht bestialisch. Von dem her sind wir mit denen eigentlich schon relativ zufrieden, würde ich sagen.

➔ **11a.I: Wie schätzen Sie die Effektivität ein?**

K04: Gut, also jedes Produkt hat ja ein Wirkungsspektrum und die Bacillo! Sensitivtücher haben genau das Wirkungsspektrum was wir halt jetzt erwarten. Also, dass die halt auch begrenzt viruzid, also Noroviren, und so weiter abtöten. Das ist eigentlich halt auch das Ziel und vor allem halt auch Bakterien und Pilze abtöten was halt überwiegend überall gibt. Für den Patient jetzt gar nicht schlecht.

➔ **11b.I: Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie in diesem Produkt?**

K04: Also Nachteile auf jeden Fall der Bezug Nachhaltigkeit, das ist so ein Ding was wo ich sehr viel Wert drauflege, aber da ist ja Hartmann gerade auch am neue Produkte herstellen und die Nachhaltigkeit etabliert sich jetzt im allgemeinen überall ziemlich schnell und stark, was ich toll finde, aber sonst Vorteile. Vorteil ist eigentlich ja eigentlich die Benetzung, die gute Verträglichkeit. So, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

➔ **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillo! 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K04: Ja, in dem Sinne schon, weil es ein Standardprodukt ist. Es hat jetzt halt kein Wirkspektrum mit Sporizidi wo jetzt aber auch in patientennahen Flächen jetzt nicht unbedingt notwendig wär. Wenn der Patient jetzt keine Durchfallerreger oder sowas hat. Auf jeden Fall hat es das Wirkspektrum, was für den Patienten selber völlig ausreicht. Die Handhabung mit dem Flowpack und dass man das Tuch ganz einfach rausziehen kann, dass eigentlich nichts passieren kann bezüglich Haut. Ich denke das ist schon ein gutes Produkt.

Also tatsächlich kommt es auf die Station drauf an. Wir haben das schon integriert, unter anderem in der Gynäkologie im Patientenbad, weil die Frauen halt oft mit Binden zu tun haben und da halt oft auch mal was daneben geht und die aber natürlich meistens auch jung sind und selbstständig sind und dann halt einfach darüberwischen. Und dann halt auch im Patientenzimmer, einfach auf dem Nachttisch. Also wir tun auch teilweise Hände Desinfektionsmittel, kleine Taschenflaschen den Patienten geben und fordern die auch schon teilweise zu vermehrter Handyhygiene auf. Das kommt auch immer ganz gut an, also von dem her denke ich das wird es mit der Flächendesinfektion gleich sein.

➔ **12a.I: Ist es auch auf den anderen Stationen so verbreitet?**

K04: Also momentan eigentlich nur auf der Gynäkologie, Auf den anderen wüsste ich jetzt nicht, dass wir das eingeführt haben und habe ich auch noch nicht gesehen.

➔ **12b.I: Wie sieht es mit den Sanitäreinlagen aus, würden sie die Tücher auch in den Patientenzimmern auf den Sanitäranlagen benutzen lassen, also auch wenn das Wirkungsspektrum vielleicht nicht ganz so groß ist?**

K04: Ja, doch, kann man definitiv schon auch machen. Auf jeden Fall, vor allem den Toilettenrand desinfizieren. Natürlich immer mit Absprache, ob des Desinfektionsmittel freigelassen ist für diese Materialien, das ist immer so eine Sache, aber auf jeden Fall, oder ich würde es halt natürlich immer dann im Patientenbad legen, wo es halt nicht direkt am Klo ist, weil es natürlich auch eine Aerosol und Spritzgefahr ist. Also ich würde da natürlich was eine Ablage oder sowas einführen, wo dann gezielt immer in dieser Ablage, in diesem Regal dann halt Desinfektionsmitteltücher drin sind, das kann ich mir dann schon gut vorstellen.

➔ **12c.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?**

K04: Also es gibt ja Flowpacks, die sind wirklich teilweise dick, mit sehr vielen Tüchern, diese hätte ich auch so wie Handschuhhalter an die Wand angebracht und dann da ein großes Flowpack rein und man könnte ja auch zum Beispiel sagen, das kommt halt drauf an, ich weiß nicht wie das dann ist wie es sich umsetzen kann oder halt dann wirklich so kleine es gibt auch so kleine Probe-Packungen wo vielleicht 20 Tücher oder so drin sind. Die könnte man ja theoretisch auch dem Patienten dann halt direkt auf den Nachttisch hinlegen. Ja, aber wie sinnvoll das dann ist, auf dem Nachttisch zu haben und an der Wand, das kann ich jetzt so nicht sagen.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K04: Ja, da denke ich sofort an Verwirrte, weil im Endeffekt, wenn die halt die Desinfektionstücher essen das ist zwar echt komisch, aber es gibt leider sind Patienten vor allem halt auch demente Patienten, manchmal nicht in der Lage, ja da stellt man dann halt einfach alles weg, auch Wasser und so weiter da sehe ich ein Risiko, dass man halt solchen Leuten das nicht gibt. Ich weiß halt nicht wie es ist, von der Verträglichkeit der Haut, das ist auch immer ein großes Thema bei uns in der Hygiene bezüglich Hautschutz. Wenn die da wischen wie sie wollen, dass es halt dann im Endeffekt Hautirritationen bekommen. Das müsste man dann halt natürlich abklären. Im Endeffekt gibt es sonst keine. Umso mehr desinfiziert wird, ist es umso besser. Ich sehe darin sogar eher Vorteile, weil man könnte ja auch sagen, das würde ja auch eine Entlastung der Reinigungskräfte führen, dass oder halt auch von der Pflege, dass man halt sagt, der Patient macht sein Nachtkästchen oder so selbst.

➔ **13a.I: Wären es die Gründe, warum die Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Patientenalltags sind?**

K04: Das kann sein. Warum haben wir das nicht eingeführt, ist eine gute Frage. Eigentlich spricht nichts dagegen, vielleicht eher, weil man erstens vielleicht noch nicht dran gedacht

hat und zweitens auch, weil man halt dann schon strikt trennt zwischen der Aufgabe des Patienten und der Aufgabe der der Mitarbeitenden. Der Patient ist halt, das ist halt nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es halt, im Bett zu liegen und halt Untersuchungen mitzunehmen, sage ich jetzt mal ganz blöd aber. Vielleicht so aus meinem Gedankengut heraus. Ich denke, man hat da einfach noch nicht sich großartig drüber Gedanken gemacht.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K04: Ja gut, so wie man es halt denen ja auch dann sagt. Also wenn man denen die Desinfektionstücher austeilen würde, dann würde ich halt zu denen sagen, dass sie halt einfach schauen, wenn irgendetwas optisch unrein ist, dass sie halt dann mit dem Tuch drüber gehen. Aber halt das jetzt auch nicht. überstrapazieren, wenn sie wissen, was ich meine, also halt, dass man die halt anleitet und sagt, die Tücher sind jetzt auch nur gedacht für ihre Umgebung beziehungsweise halt für die und die Materialien, weil nachher kann er aufgrund von chemischer Reaktion vielleicht sogar auch Sachen kaputt machen. So in der in der Richtung dann halt aufklären. Für was die Tücher geeignet sind und wie oft er sie verwenden kann und vielleicht dann auch mit Handschuhe oder nicht.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden Sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K04: Also es gibt sehr, sehr viele Hygienemaßnahmen, aber jetzt explizit, wo man den Patienten integrieren könnte, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele in Bezug auf uns, was wir halt achten müssen mit persönlicher Schutzausrüstung und so weiter, wie man mit Lebensmittel umgeht, solche Dinge. Aber im Endeffekt denke soll der Patient auch nicht zu viel integriert werden in solchen Dingen, weil er sich ja natürlich einerseits auch auf die Genesung konzentrieren muss. Die Händedesinfektion ist halt das, woran wir immer sehr appellieren, weil das halt einfach das allerwichtigste ist, das mit der Fläche ist auch ist auch sehr wichtig, aber, die Hände sind halt die Überträger und deswegen denke ich, ist das eigentlich schon ausreichend, wenn die Hände und gerne auch dann die Flächen mit ins Boot genommen werden beim Patient und das war es ja.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K05

Am 11.01.2024

1.I: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K05: Es ist ein bunt gemischtes Bild. Wir haben wenige Vierbettzimmer, wir haben 3 und Zweibettzimmer, wir haben auch Einbettzimmer, wo teilweise Patienten eben isoliert werden, alleine untergebracht werden, ansonsten werden Patienten, auch abhängig von ihrem Versicherungsstatus, in der Regel eigentlich immer in Zweibettzimmern und Dreibettzimmer bei uns untergebracht. Teilweise je nach Versicherungsstatus auch im Einzelzimmer.

2.I: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K05: Es pendelt immer um die 2-7 Tagen herum. Sowas ja.

3.I: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K05: Ich würde sagen vor allem in ihren Patientenzimmern natürlich. Da sind sie hauptsächlich anzutreffen. Wenn sie mobil sind, werden sie auf dem Flur, im ganzen Krankenhaus, in den öffentliche Bereiche vom Krankenhaus anzutreffen sein und wahrscheinlich auch im Café, um sich mal einen Kaffee zu genehmigen, wenn sie dürfen, und natürlich in den Untersuchungs- und Behandlungsräumen.

4.I: Wie sieht der Alltag eines Patienten aus?

K05: Das hängt jetzt wahrscheinlich auch vom Krankheitsbild letztendlich mit ab. Das wird sicher schon mal mit einem internistischen Patient anders aussehen als wie zum Beispiel operativen, sprich chirurgischen Patienten. In der Regel wird es wahrscheinlich so aussehen, dass nach einer hoffentlich gut durchschlafen Nacht, er morgens in der Regel vom Pflegepersonal aufgeweckt wird. Der Patient wird wahrscheinlich eine gewisse Körperpflege vornehmen, während erste Vitalzeichenkontrolle gemacht werden. Es wird Frühstück geben für die, die frühstücken dürfen, manche dürfen ja auch nicht frühstücken, die bleiben dann nüchtern. Im Verlauf des Vormittags werden dann entweder Therapien oder Untersuchungen laufen bei den Patienten. Es wird, wenn es gut geht, auch eine Visite vorbeikommen, bestehend aus Ärzte und Pflegepersonal. Dann kommen wir zum Mittagessen. Dann wird hoffentlich eine gewisse Mittagsruhe eingehalten. Am Nachmittag gibt es eventuell auch noch Untersuchungen oder Therapieformen. Allerdings findet da schon deutlich weniger statt. Zum Abend hin gibt es Abendessen, was für die meisten Patienten ein bisschen früh kommt. Nach dem Abendessen passiert meistens nicht mehr arg viel. Meistens nur nochmal ein Kontakt mit Pflegepersonal, das dann nochmal durchgeht für die Nacht. Und dann beginnt die Nachtruhe, wobei die Nachtschwester dann auch regelmäßig normalerweise im Patientenzimmer vorbeischaut.

5.I: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K05: Gute Frage, das wird meistens nicht an uns herangetragen. Das erfahren wir tatsächlich relativ wenig. Also teilweise bekommen wir dann mal eine Rückmeldung, meistens in Form von Kritik. Dass da einfach Rückmeldebogen vom Krankenhaus ausgefüllt werden, wenn bestimmte Hygienemängel quasi angeprangert werden. Ist aber recht selten, da müsste man den Klinikhygieniker nochmal dazu Fragen, weil das oftmals an ihn dann herangetragen wird. Ansonsten bekommen wir es wenig mit.

➔ **5a.I: Diese Kritik, die sie dann bekommen, wie wird das ausgewertet? Wird das dann auch sofort umgesetzt? Gibt es Verbesserungen oder wird das erst mal gesammelt und dann erst nach einer bestimmten Zeit angegangen?**

K05: Nein, das wurde in der Regel dann eigentlich gleich umgesetzt, beziehungsweise wir schauen es uns dann an. Man muss sehen, ist es berechtigt, ist es nicht berechtigt, kann man was ändern, kann man nichts ändern. Wir müssen individuell beurteilen, aber wir versuchen schon auf die Vorschläge dann einzugehen, eigentlich, und wenn möglich entsprechend umzusetzen.

➔ **5b.I: Hätten sie auch ein Beispiel für solche Vorschläge, die von den Patienten kommen, oder für Kritik?**

K05: Wenn jetzt, zum Beispiel, der Patient sagt: „Mensch, mir ist aufgefallen, dass die Reinigungskraft, zum Beispiel, nie die Toilette putzt.“ Solchen Sachen würden wir natürlich hinterher gehen. Dann wird geschaut, auf welcher Station ist der Patient gelegen, wenn man diese Information hat, wenn das quasi eine anonyme Meldung ist ohne Hinweis auf Station oder Patientenzimmer oder irgendwas, dann tun wir uns oft mal schwer, aber wenn man dann eben einen Hinweis haben, welche Station es ist, dann würde man entweder selber da gewisse Beobachtungen vornehmen, um zu sehen stimmt das, können wir das verifizieren oder dann auch mit der Leitung von der Reinigungskräfte mal sprechen und sagen: „Uns ist da immer was zu Ohren gekommen. Können wir da was verbessern? Stimmt das so, oder war das eventuell eine Gegebenheit, dass zu wenig Personal da war und nicht nur die Toilette nicht geputzt wurde, sondern alles nicht geputzt wurde?“ Aus Krankheitsausfall oder sonst irgendwie was. Also wir würden es einfach individuell beleuchten und beurteilen und dann Rückschlüsse ziehen und eventuell Verbesserungen vorschlagen.

6.I: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K05: Puh, da müsste man tatsächlich in unseren Flyer schauen. Wir haben eine gewisse Information für den Patienten, teilweise auf der Toilette ein Hinweis eben, dass jeder, der die Toilette benutzt, letztendlich die Toilettenbrille selber mit einem Desinfektionsmittel abwischen soll. Von daher haben wir ein Hinweis bei unserem Flyer für Patienten, wenn jetzt nicht ganz sicher ist, ob da Flächenhygiene mit erwähnt ist oder ob wir es da nicht mit drin haben.

➔ **6a.I: Wird es auch noch mündlich weitergegeben?**

K05: Das war es eigentlich. Also wenn es gut läuft, geben wir das teilweise jetzt gerade bei Patienten, eben mit speziellen Erregern, an die Pflegekräfte der Station weiter, dass sie eben die Patienten informieren sollen, dass sie eben Hände Desinfektion und, wenn möglich, Flächendesinfektion auf der Toilette vornehmen sollen bei speziellen Erreger. Ob das dann weitergegeben wird, das kann ich nicht sagen.

7.I: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K05: Also in der Regel ist es so, dass eben über unsere hundertprozentige Tochterfirma Servicio die Reinigungskräfte das Krankenhaus, die Räume reinigen plus eventuell desinfizieren. Das ist dann je nach Nutzungsart von den Räume abhängig. Ob eine Reinigung oder Desinfektion stattfindet oder beides eben und auch wie häufig dieser Raum daneben gereinigt oder desinfiziert wird, hängt auch vom Nutzungsgrad dann. Ja. Darüber hinaus wird aber Flächendesinfektion auch noch vom Anwender vorgenommen. Vornehmlich vom Pflegepersonal. Gerade so patientennahe Flächen werden vom Pflegepersonal desinfiziert dann aber teilweise auch noch Flächendesinfektion von Anwendern. Jetzt, wie zum Beispiel Ärzte oder so, die einfach bestimmte Flächen benutzen wollen oder benutzt haben und da dann eine Flächendesinfektion noch vornehmen.

→ 7a.I: Wann findet die Reinigung und Desinfektion statt? (täglich; stündlich; je nach Patient?)

K05: Ja, also dieser Prozess ist ja immer abhängig von der Nutzung der Räume. In der Regel ist es so, dass zum Beispiel jetzt die Patientenzimmer, was ja eine große Anzahl an Räumen jetzt hier im Krankenhaus ist, wird in der Regel einmal täglich gewischt und desinfiziert. Unter Umständen aber auch zweimal täglich. Die patientennahe Flächendesinfektion findet vom Pflegepersonal in der Regel auch einmal täglich statt. Je nach Zustand muss man sauber machen, eventuell auch öfters, also das wird dann individuell teilweise noch. Aber ich würde sagen, jetzt mal in der Regel einmal täglich.

→ 7b.I: Welche Mittel werden verwendet?

K05: Wir haben Incident Rapid als standartmäßiges Flächendesinfektionsmittel. Wir haben. natürlich Bacillol, da haben wir zum einen das Bacillol AF, Bacillol Sensitiv, ebenfalls Desinfektionsmittel. Wir haben das Ultrasol Active zur Flächendesinfektion. Dann Insidin noch zur Flächendesinfektion. Was haben wir sonst noch? Es wird anscheinend auch ein Reiniger für die Fußböden hergenommen. Ob wir jetzt noch was vergessen? Ich glaub das müsste es ungefähr gewesen sein.

→ Nachfrage 7c.I: Bacillol Sensitive wird öfters angewendet?

K05: Ja, also wir haben das quasi in unserem Desinfektionsplan, wo auch zu den Hygieneplänen mit dazu gehört und letztendlich verbindlich für das Haus ist. Da haben wir das festgehalten, welche Fläche mit welchem Mittel eben desinfiziert wird. Bacillol Sensitive ist berücksichtigt, was wir überwiegend quasi für empfindliche Oberflächen hernehmen. Nimmt man viel für medizinische Geräte her. Ja, vor allem für medizinische Geräte wird es vor allem empfohlen. Genau.

➔ **Nachfrage 7d.I: Wer legt fest, welche Mittel wie verwendet werden müssen?**

K05: Das liegt in der Regel der Hersteller eigentlich fest. Also jetzt gerade von Medizingeräten. Da liegt es der Hersteller fest, der muss Desinfektionsmittel freigeben, wo er sagt, ihr könnt dieses Produkt anwenden, um mein Medizinprodukt zu desinfizieren und es wird kein Schaden dann dran nehmen. Da müssen wir uns dran orientieren. Letztendlich hier für das Haus den Desinfektionsplan haben wir Hygienefachkräfte, die das einfach alles zusammengetragen haben, quasi sämtliche Flächen die im Krankenhaus vorkommen sind da definiert mit was es desinfiziert werden darf.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K05: Wenig, wenig. Flächenhygiene im Sinne der Desinfektion habe ich nicht als Routine in meinem Alltag. Reinigung, ja natürlich, sowohl zu Hause, wie in der Arbeit, eben möglichst in regelmäßigem Turnus, meistens nach Sicht Prüfung. Nachdem ich aber viel quasi im Büro arbeite, meine Arbeitsmittel von sonst niemand verwendet werden, sehe ich jetzt nicht so den Bedarf da drinnen. Da wo sich natürlich mehrere Leute ihren Arbeitsplatz teilen oder auch Telefone, oder Türklinken, Lichtschalter, so wie Sie sagen, wo mehrere Menschen, dann unterschiedliche Menschen dann berühren, da sollte man natürlich dann schon drauf achten, dass man regelmäßige Flächendesinfektion macht. Wir sagen, gut wäre es, mindestens einmal täglich, öfters wäre natürlich noch besser, in der Praxis wird man es aber wohlmöglich weniger häufig sehen.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K05: Gut, weil es eine Möglichkeit wäre, Übertragungswege von Krankheitserregern zu unterbrechen. Von daher wäre es gut und sinnvoll. Allerdings stelle ich in Frage, ob das so arg viel Patienten tatsächlich differenziert durchführen können. Also von daher stehe ich immer ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber.

➔ **9a.I: Haben sie auch Vermutungen oder Gründe, warum Patienten es nicht durchführen wollen?**

K05: Ja gut, das ist schon mal krankheitsbedingt eventuell, dass manche zum Beispiel nicht aus dem Bett rauskommen. Manche sind kognitiv nicht in der Lage, solche Aufforderungen umzusetzen. Bei manchen, den meisten Flächendesinfektionsmittel, da haben wir jetzt mit Bacillol sensitiv eben die Ausnahme, ist im Prinzip auch vorgeschrieben, dass man Handschuhe anziehen muss zur Flächendesinfektion, wo ich schon Probleme mit dem Bereitstellen der Handschuhe sehe.

➔ **9b.I: Steht es im Interesse des medizinischen Personals, dass sie Patienten an der Hygieneerhaltung beteiligen?**

K05: Ja, wäre sicher nicht schlecht, aber das sehe ich jetzt als nicht die vordringliche Aufgabe von den Patienten im Krankenhaus. Ziel 1 ist Genesung. Und wenn es der

Genesungsprozess quasi behindern würde, wenn sie sich an der Flächendesinfektion beteiligen, dann würde ich sagen, dann lieber nicht. Aber wenn sie es im Rahmen vom Genesungsprozesse durchführen können, dann denke ich, spricht eigentlich nichts dagegen.

➔ **9c.I: Besteht überhaupt eine Notwendigkeit der der Teilnahme an der Flächenhygiene?**

K05: Also ich würd sagen, für Patienten steht das an zweiter Stelle. Flächendesinfektion ist für uns ein großes und wichtiges Thema im Klinikum. Es ist für uns auch wichtig, dass es regelmäßig durchgeführt wird, diese Flächendesinfektion, aber es sei ja mal dahingestellt, von wem es eben durchgeführt wird. Wenn wir genügend Personal zur Verfügung haben und dieses Personal genügend Zeit zur Verfügung hat, dann würde ich es präferieren, dass es eben vom speziell dafür angestellten Personal durchgeführt wird, weil die dann auch das fachliche Know-how hat und da entsprechend der Hintergrund und entsprechend sorgfältig machen. Die man schulen und anweisen kann, da weiß ich dann wie es läuft. Dass Patienten damit dran teilnehmen, kann entweder ergänzend sein oder eben, dass man sagt, wir können es jetzt von der Personalsituation her nicht mehr stemmen, dass wir alles tatsächlich im notwendigen Umfang vornehmen und dann kann es natürlich gut sein, wenn zum Beispiel Patienten in die Bresche springen und zumindest einen kleinen Teil in ihrer Umgebung machen können.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K05: Also ich denke, das sind auf jeden Fall die patientennahe Flächen, also da, wo der Patient eben selber seine Sachen abstellt oder wo er selber berührt. Also ich denke jetzt vor allem an den Nachttisch, an sein Bett zum Beispiel, an den Tisch, den Stuhl, wo er vielleicht drauf sitzt und natürlich auch die Sanitäreinrichtungen, speziell Toilette.

11.I: Meine Bachelorarbeit fokussiert sich auf die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ der Firma Hartmann. Wie schätzen Sie das Produkt ein?

K05: Also ich finde es im Prinzip als sehr gutes Produkt. Ich wende es nicht regelmäßig an, aber ich finde es ein sehr gutes. Von der Wirksamkeit her, von der Verträglichkeit her, dass empfindliche Oberfläche, da eben tatsächlich desinfiziert werden können und auch ohne Handschuhe anwenden kann. Und von daher finde es eine klasse Geschichte, was vielleicht nicht ganz so toll ist, aber was ich wahrscheinlich nicht verhindern lässt ist, dass es einfach gewisse Rückstände gibt, weil dem Alkohol dann noch andere Mittel eben mit beigesetzt sind. Deswegen gibt es so gewisse Rückstände, die nicht dramatisch sind aber manche Anwender stören sich dran.

➔ **11a.I: Wie schätzen Sie das Produkt im Vergleich zu anderen ein?**

K05: Ja gut, Bacillol 30 als Niedrigprozentiger Alkohol zur Desinfektion kann von der Wirksamkeit her natürlich nicht so gut wie andere Produkte sein, die wo dann aber eventuell schwächen eben in der Verträglichkeit, sei es Material Verträglichkeit oder eben Verträglichkeit gegenüber Mensch. Da muss man gewisse Kompromisse finden und deswegen denke ich auch, dass wir verschiedene Produkte im Krankenhaus einsetzen, einfach weil manche Produkte irgendwo Lücken haben, die, wo man mit anderen Produkte daneben abfangen kann.

➔ **11b.I: Wie ist die Umgänglichkeit und Benutzung mit dem Produkt?**

K05: Gut, also ich glaube, es wird berichtet, mein Geruchssinn ist jetzt so arg ausgeprägt, dass es einigermaßen angenehm riechen tut. Es ist sehr schnell wirksam und das wird von den Anwendern auch natürlich sehr gern gesehen. Trocknet schnell und weitgehend rückstandsfrei ab. Und die Packungen sind einigermaßen anwenderfreundlich, wie man es entnehmen kann.

➔ **11c.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?**

K05: Da hab ich es momentan tatsächlich zu wenig vor Augen, ob die Tuchgröße wirklich ausreichend ist und eventuell die Dicke vom Tuch. Da müsste tatsächlich das zuerst einmal anschauen, aber das können zwei Punkte sein, wo man eventuell verbessern könnte.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

K05: Also wenn Desinfektion, dann finde ich für die Patienten das Bacillol Sensitiv auf jeden Fall das geeignetste Produkt. Eigentlich, was man momentan jetzt hier bei uns im Krankenhaus zur Verfügung haben. Eben aus dem vorhergenannten Vorteilen. Schon zum einen, dass sie es ohne Handschuhe anwenden können, dass keine große Gesundheitsgefahren von diesem Produkt ausgehen, dass es relativ schnell abtrocknet, dann in ihrer Umgebung. Also von daher würde ich sagen, wenn Flächendesinfektion, dann mit diesem Produkt.

➔ **12a.I: Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K05: Ja, also gerade Nachttische und Bett finde ich auf jeden Fall gut. Auch der Tisch und der Stuhl, wo sie ihr Essen einnehmen, das auf jeden Fall. Für die Toilette, da müsste man tatsächlich noch mal vom Spektrum schauen, ob es ausreichend ist. Das ist sicher besser als wie gar nichts hernehmen, aber das könnte sein, dass das Wirkspektrum für Toilettenbereich schmal ist. Also ich würde den Patientenschrank, wo der Patient eben seine Sachen unterbringt eventuell noch mit dazunehmen. Wobei der nicht ganz so wichtig ist. Vielleicht an zweiter Stelle. Ja, nee, eigentlich war es das dann.

➔ **12b.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?**

K05: Ich denke, dass wir es wahrscheinlich so machen müsste wie mit den Spendern, dass man da Halterung irgendwo anbringt, wo man diese Flowpacks dann fest integrieren kann,

wo die Patienten sich dann Tücher entnehmen können. Ich würde jetzt nicht jedem Patienten einzelne Packs geben, das wird einfach zu kostenintensiv, die würde dann auch verschwinden, sondern ich denke ein Flowpack pro Zimmer, irgendwo in zentraler Lage untergebracht, so dass die Patienten sich dort bedienen können, was natürlich dann auch schon wieder voraussetzt, dass dieser Patient auch entsprechend mobil ist und sich das dort selber abholen kann. Eventuell zur zusätzlichen Namenmöglichkeit auf der Toilette dann.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K05: Ja gut, wir wollen natürlich jetzt nicht, dass die Patienten anfangen diese Produkte zu verzerren, zum Beispiel, also gerade bei Patienten, die wo im Durchgang sind, halte ich das nicht für ausgeschlossen. Und da muss man natürlich schon auch vorsichtig sein. Weiteres großes Problem, das wir tatsächlich auch kennen ist, wenn diese Produkte eben in Toilette geworfen werden, vor allem vermehrt in Toilette geworfen werden, dass wir Verstopfungen haben von unseren Abwasserleitungen. Deswegen ist die Verwendung da eben im Toilettenbereich ja auch mit Vorsicht zu genießen. Weil viele Patienten es eben nicht umsetzen können, dass sie dieses Produkt tatsächlich in den Abfalleimer werfen müssen und nicht in die Toilette reinwerfen. Ich glaub im Patientenzimmer, wo sie ihre patientennahe Umgebung dann desinfizieren, ist das viel leichter, dass sie das danach dann in den Abfalleimer entsorgen.

➔ 13a.I: Sind das die Gründe, warum Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Alltags sind?

K05: Ich denke, das kommt ja erst jetzt in neuerer Zeit auf, dass die Patienten immer mehr in solchem Maßnahmen mit einbezogen werden. Ich glaube tatsächlich auch aus dem Grund, dass man in der Zwischenzeit in sämtliche Berufssparten, in der Medizin, Personalmangel haben. Ich glaube, deswegen kommen solche Ideen tatsächlich auf. Und momentan fehlt sicher auch noch die Möglichkeit personalbedingt das entsprechend umzusetzen und auf die Patienten dann auch zugehen, weil jeder einzelne Patient ist so individuell, dass man da gar keine Verpflichtung ja draus machen können, sondern im Prinzip müsste jeder Patient bei Aufnahme ins Krankenhaus individuell beraten werden, was er mit dazu beisteuern kann. Das wäre schön und wünschenswert natürlich. Aber momentan sehe ich nicht, dass irgendeine Berufsgruppe diese Zeit hätte, ebenso detailliert auf den Patienten einzugehen.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K05: Gute Frage. Letztendlich bräuchte man Handlungsanweisung für die Patienten, dass man denen zeigt, wie sie eben ein Tuch entnehmen können, dass sie am besten nur ein Tuch entnehmen, dass sie da damit eben Flächendesinfektion vornehmen können. Wahrscheinlich muss man ihnen ja auch noch die Vorteile daneben schildern, die man

dadurch hat. Dass sie eventuell auch ihre Gesundheit davon profitieren kann. Man muss ihnen aber auch die Grenze aufzeigen, dass sie nachher nicht anfangen, ihre Brille, ihre Schuhe und sonst alles zu desinfizieren, in welcher Reihenfolge, sei mal dahingestellt. Und wenn wir danach irgendwelche Schäden damit produzieren, kann es sein, dass es sonst zu Regress führt. Man muss Patienten dann gezielt einweisen, welche Flächen dann dafür geeignet sind, wie sie das Tuch dann entsprechend entsorgen und, dass sie das Tuch auch nur einmal hernehmen, nicht dass sie es dann aufbewahren und jeden Tag wieder neu hernehmen.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K05: Gut, teilweise bringen Patienten ja selber Medizinprodukte mit ins Krankenhaus, die sie normalerweise in ihrem täglichen Alltag verwenden, sei es jetzt das Heim-Beatmungsgerät, sei es das Blutzuckermessgeräte, oder auch Insulinpumpen. Solche Geschichten. Und eben die korrekte hygienische Versorgung von diesen Geräten, wäre sicher auch gut und sinnvoll, wenn im Krankenhaus dann entsprechend durchgeführt werden würde, weil wir sehen, dass diese Patienten oftmals zu Hause entweder nicht in der Lage sind oder einfach das Wissen nicht haben, hygienisch entsprechend korrekt damit umgehen zu können. Deswegen denke ich, das wäre sicher noch ein Feld was man weiterbearbeiten könnte. Grad in der Erkältungssaison kommen natürlich auch Umgang mit Masken. Da eventuell noch mal schulen, um die Patienten zu sensibilisieren, dass sie entsprechende Mund-Nasen-Schutzmasken selbständig aufsetzen und absetzen und so versuchen weitere Umgebungskontamination zu vermeiden.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K06

Am 11.01.2024

1.I: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K06: Prinzipiell spielt zunächst die Diagnose eine Rolle. Dort gibt es die Wunschzieleinheit und dann muss man abklären, kann der Patient in ein Dreibettzimmer, Einbettzimmer, wie auch immer. Das hängt natürlich vom Assessment ab. Geht es dem Patienten ganz arg schlecht, braucht er Einzelzimmer oder hat er eben eine infektiöse Erkrankung und da werden initial bei der Aufnahme verschiedene Abstriche gemacht, auf multiresistente Erreger oder Corona oder so Geschichten. Haben wir ein Patient auf der Station und es wird

dann gesehen, dass er eben doch infektiös ist, haben wir ja im Haus, Gott sei Dank, so eine Infektiologie und er wird dann dorthin verlegt.

2.I: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K06: Zwischen 5 und 6 Tage.

3.I: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K06: Ja, die überwiegende Anzahl verlässt das Patientenzimmer nur dann, wenn es zur Diagnostik geht.

4.I: Wie sieht der Alltag eines Patienten aus?

K06: Trist. Der Patient wird morgens irgendwann zwischen 06:30 Uhr und 7 Uhr geweckt. Damit er gegen 07:30 Uhr sein Frühstück hat. Dann kommt das nächste Highlight, irgendwann zwischen 9 Uhr und 12 Uhr findet die Visite durch Stationsarzt oder Oberarzt statt. Um 11:30 Uhr hat er dann wieder sein Mittagessen, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ist so die erste große Welle an Diagnostik. Von der Diagnostik her gibt es da eine kurze Pause, so eine Stunde bis um 13 Uhr und dann geht Diagnostik weiter so bis 15:00 Uhr. Der Patient wird regelmäßig von der Pflege, also ich sag jetzt mal so alle 2-3 Stunden wird er regelmäßig von der Pflege kontaktiert, pflegeintensive Patienten natürlich öfters. Und am Nachmittag findet dann noch mal, gegebenenfalls Besuche durch Angehörige und Arztgespräche im Rahmen von Patient Angehörige und Arzt statt. Um 17:00 Uhr Abendessen und dann geht es schon wieder ins Bett. Also trister Alltag, ja. Um 19:00 Uhr sind ja dann die meisten bei uns so. Letzter Durchgang noch mal stattfindet zwischen 19 Uhr und 20:00 Uhr. Grad, die pflegebedürftigen Patienten werden dann bettfertig gemacht. Ja, und dann ist der Tag vom Patienten schon wieder vorbei.

5.I: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K06: Differenzierter Patient, ja. Dem differenzierten Patient fällt es zum Beispiel sofort auf, wenn jetzt Sanitäranlagen, nicht in Ordnung, ja nicht seinem persönlichen Standard entsprechend aufbereitet sind. Patienten fällt es auch auf, wenn Händedesinfektionsmittel in den Zimmer leer sind. Also das finde ich immer ganz interessant, dass Patienten im Krankenhaus doch dazu verleitet werden, was ja positiv ist, sich die Hände zu desinfizieren. Das fällt dem Patienten schon auf, auch wenn es irgendwelche Staubablagerungen oder so gibt. Ja, Patienten äußern sich. Definitiv.

➔ **5a.I: Ist es eher der größere Teil der sich dazu äußert oder eher einzelne, wenige Fälle?**

K06: Also bei mir [auf der Station] mit einem relativ hohen Altersdurchschnitt von Patienten ist es eher der kleinere Teil. Das sind wirklich die, die ja die differenzierten Patienten, der ältere Patient, den juckt es salopp gesagt nicht mehr. Aber die Jüngeren, da wächst eine ganz andere Generation an Patienten ran, die das anders wahrnehmen wie der ältere Patient.

➔ **5b.I: Wie wird das Feedback gemessen oder aufgenommen? Kommt es dann zu Verbesserungen?**

K06: Ja, klar, klar, natürlich wird es weitergeleitet. Also gerade was Sanitäranlagen etc. betrifft. Da hat man ja immer eine Reinigungskraft, zumindest am Vormittag von unserer Firma Servicio auf der Station und dann wird natürlich nachgebessert und wenn irgendwelche Desinfektionsmittelspender leer sind oder so wird es ja alles umgehend ausgewechselt. Ganz klar ja, auf das reagieren wir auf jeden Fall. Ja, manche Patienten haben auch den Wunsch, dass sie gerade für die Toilette, die Situation ist ja, dass drei Patienten in einem Zimmer [sind] und manche Patienten haben jetzt auch den Wunsch, dass sie Desinfektionsmitteltücher für die Toilette bekommen, um vorher einfach auch einen Toilettensitz abzureiben, bevor sie drauf sitzen und dem Wunsch kommen wir natürlich nach, ganz klar.

6.I: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K06: Nur wenn ich jetzt ein Patient mit im Zimmer habe, den wir mit der sogenannten Barrierepflege betreuen müssen. Also spricht er hat ein MRGM zum Beispiel, dann werden die beiden anderen Patienten mit aufgeklärt, was sie zu beachten haben, zum Beispiel im Sanitärbereich. Ansonsten findet keine größere Aufklärung statt.

➔ **6a.I: Findet diese Aufklärung nur mündlich statt oder gibt es irgendwelche Informationsbroschüren oder Plakate?**

K06: Die findet leider nur mündlich statt, zumindest bei uns auf der Einheit, ja.

7.I: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K06: Also zum einen Mal haben wir ja die regelmäßige Reinigung von Flächen, also Fußböden oder Pflegearbeitsräume. Das obliegt der Firma Servicio, die haben da ihre Hygienepläne, was sie tagtäglich abzarbeiten haben und auch für die Pflege gibt's ein Reinigungsplan. Was desinfiziert werden muss, mit welchem Produkt desinfiziert werden muss, in welcher Häufigkeit desinfiziert werden muss, das ist schriftlich fixiert und hängt zum Beispiel in der Pflegearbeitsräume, also im unreinen Arbeitsraum hängt das zum Beispiel gut sichtbar für jeden aus.

➔ **Nachfrage 7a.I: Das heißt, es sind vor allem die Reinigungskräfte und die Pflege dafür die Flächenhygiene verantwortlich?**

K06: Definitiv, ja. Also im näheren Patientenumfeld ist die Pflege, wie zum Beispiel jetzt einfach mal typischerweise das Nachtkästchen her, dass das täglich desinfizierend gereinigt wird, das macht die Pflege. Geht es um Sanitäranlagen oder Fußböden, das ist dann die Reinigungskraft genau.

➔ **7b.I: Wer plant und strukturiert den Prozess?**

K06: Genau, also wir haben in der Klinik eine Kommission und die Hygienekommission bestehend aus Mitarbeiter aus dem Pflegedienst aus dem ärztlichen Dienst und aus dem Institut für Krankenhaushygiene, die entwerfen diese Hygienepläne und da wird es dann kaskadenartig eben nach unten weitergeben. Durch Pflegedienstmitarbeiterinnen, die in der Hygienekommission mit drin sitzt wird dann eben vermittelt was gibt es für uns neues, was muss man anders machen, wenn ein Produkt wechselt, was passiert dann. Die Informationen bekommen wir auch von der Klinikhygiene. Und die Schnittstelle zu Servizio geht über Krankenhausdirektion.

➔ **7c.I: Welche Mittel werden verwendet?**

K06: Also im Moment ist so, dass wir das Incidin Rapid in 0,25 % Wirkstärke für die Böden und auch Sanitäranlagen, glaub ich. Für die Flächendesinfektion haben wir auch entweder dieses Incidin Rapid 0,25% oder diese, bis vor kurzem Incidenoxy wapes, die sind ja jetzt raus und die wurden ja vom Hersteller zurückgerufen und jetzt gibt es diese ultrasol Tücher oder die Bacillol Tücher. Gerade für technische Geräte, ja.

➔ **7d.I: Wann findet die Reinigung und Desinfektion statt?**

K06: Na gut, da gibt es ja verschiedene Umfelder. Also wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel den Blutdruckapparat, da habe ich natürlich einen stetigen Reinigungsprozess bei Patientenwechsel. Nachtkästchen zum Beispiel, das ist eine tägliche Aufgabe, die sind jeden Vormittag oder beim morgendlichen Durchgang, machen wir das jeden Vormittag zum Reinigen, zum Beispiel. Das nähere Patientenumfeld in den Patientenzimmern im Regelfall nach Entlassung. Also es sind verschiedene, vom zeitlichen Ablauf her sind es verschiedene Zeitspannen, wann man Aufbereiten muss und etc. Da kommen wir ja auch noch so Dinge mit dazu wie Stationstresen. Auch da zum Beispiel die Tastaturen und sowas muss man ja putzen. Das sind so Dinge, ja, da gibt es im Moment meines Wissens gar keine explizite Vorgaben, aber an die muss man immer wieder denken und, dass man die zum Beispiel im Nachtdienst, so ist das bei uns geregelt, dass man die im Nachtdienst einfach mal mit einem Bacillol Tuch dann zum Beispiel reinigt, ja.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K06: Mein Betätigungsumfeld ist am Vormittag in der Regel, man nennt das Kurzliegerbereich, da nehme ich ganz arg viele Patienten auf. also Das heißt ich habe dann

einen Raum wo ich halt alle 10 Minuten einen neuen Patient drin habe und da habe ich Flächen, wo ich zum Beispiel einen venösen Zugang anlege und da ist zum Beispiel Flächendesinfektion natürlich nach jedem Patient, bevor der neue sich hinaussetzt, kurz drüber wischen einwirken lassen und der nächste nimmt Platz. Das wäre jetzt die Flächendesinfektion und natürlich Händedesinfektionen, klar, und aseptische Tätigkeiten situationsangepasst und bevor ich natürlich ins Büro gehe und nachdem ich vom Büro wieder komme. Logisch.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K06: Man hat es ja bei Corona gesehen. Ich muss anders anfangen... Also Hygiene, Hygiene im Krankenhaus oder Hygiene oder Flächenhygiene in Deutschland ist das so ein stiefmütterliches Thema. Man denkt ja, das ist alles gut, das sieht man ja auch an irgendwelchen Einkaufswägen finde ich ganz toll, wenn ich jetzt daran in den Einzelhandel gehe, manche bieten es ja tatsächlich noch an, dass man sich diese wägen da kurz desinfizieren kann, und manche Patienten tun das ja auch. Nach Corona oder manche Bürger tun das dann auch, wenn sie jetzt im Krankenhaus sind, ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, bei einem Anteil der Bevölkerung so, ein gewisses Umdenken stattgefunden hat, dass eben Flächen doch behaftet sein können und man sich anstecken kann. Diese Geschichte haben wir jetzt ja nicht. Bis Corona haben wir ja zum Beispiel Noroviren, eine Welle auf der Station, wo uns gar nicht klar war, wie es zustande kommt, diese Welle. Aber das ist ja gerade in dem Fall Kontaktflächen, Schmierinfektionen ein Riesenthema und die Patienten, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass keiner sich nach dem Toilettengang die Hände wäscht, aber sicherlich ein großer Anteil nicht, und die Flächen, die sind ja dann wirklich Problem. Zum Beispiel dieser Tisch, wo dann 2 bis 3 Leute sitzen und ja, nach dem Toilettengang dort sitzen und dort aber auch Mahlzeiten einnehmen. Also natürlich wäre es sinnvoll, wenn Patienten in Flächendesinfektion, weil das kann die Pflege dann irgendwo auch nicht mehr leisten, dass sie dann regelmäßig auch noch stündlich durchgeht und irgendwie Flächen desinfiziert, dass Patienten da miteinbezogen werden, sinnvoll wäre das absolut. Zurverfügungstellung von Material wäre ja kein Problem, durch diese Bacillol Tücher durch, durch die Gebinde ist das ja wirklich kein Akt mehr, entsprechendes Material zur Verfügung zu stellen, in die einzelne Zimmer.

➔ 9a.I: Steht es im Interesse des medizinischen Personals, dass sie Patienten an der Hygieneerhaltung beteiligen?

K06: Definitiv aus meiner Sicht. Ja.

➔ 9b.I: Welchen Nutzen und Vorteil hätten die Patienten oder das Personal davon?

K06: Ist ja klar, nosokomiale Infektionen werden damit sicherlich nicht alle vermieden, aber ein Teil davon, was zumindest mal die Schmierinfektion anbetrifft, kann man sicherlich damit teilweise vermeiden.

➔ 9c.I: Wäre es weniger Arbeit für das für das medizinische Personal deiner Meinung nach?

K06: Oh, ich sag mal, wenn ich morgens die 30 Nachtkästchen nicht abwischen müsste, wären wir schon entlastet. Ja.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K06: Im Prinzip alle Flächen, wo sie regelmäßig Kontakt mit haben. Und das ist ja der kleine Bereich für Patienten, [sie] halten [sich] sicher, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die meiste Zeit ja wirklich im Patientenzimmer auf. Das heißt Nachtkästchen, Tisch und nach Nutzung der Sanitäranlagen, der Sanitärbereichs. Und das wäre auch nicht viel. Das wäre die Toilettenbrille und das Waschbecken vielleicht. Ja, da könnten sie aktiv mithelfen definitiv. Und es wäre nicht viel, der Aufwand ist überschaubar und die Zeit hätten sie ja im Prinzip, die Patienten. Es würde glaube ich an der Compliance der Patienten einfach fehlen. Die wird jetzt schlicht nicht machen, der Großteil.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K06: Inzwischen sehr gut. Davor hatten wir andere Bacillol Tücher, da hatte ich immer den Eindruck, dass der Wirkstoffgehalt aus meiner Sicht nicht feucht genug ist. Diesen neuen da, die haben ja so ein eher gelben Touch irgendwie, also es hat sich ja was geändert. Ich habe es nicht im Detail mitverfolgt. Sehr gut, die benutze ich vor allem für technische Geräte, also elektronische Geräte. Hab da inzwischen gute benetzte Oberfläche drauf und die Tücher an sich die die Reißen nicht. Also ja. Passt. Gutes Produkt.

→ 11a.I: Benutzen Sie diese Tücher in Ihrem Alltag?

K06: Wie gesagt, wir nehmen zur täglichen Desinfektionen im patientennahen Bereich, wahrscheinlich aus Kostengründen, im Moment noch das Produkt Incidin Rapid. Da haben wir in der Pflege in Arbeitsräumen so Dosieranlagen, wo ich das dann eben habe. Also da kommt das Konzentrat rein, in die Dosieranlage, dann kriege ich das 0,25 prozentige Mischungsverhältnis, quasi in meinen Behälter rein, wo es dann Tücher drin hat, die dann in der Lösung drin liegen und aus dem Eimer kann ich sie dann rausnehmen. Wahrscheinlich ist das günstiger. Deshalb haben wir verschiedene Produkte, glaub ich, im Haus vorrätig. Wobei ich diese Bacillol Tücher oder auch das andere Produkt, was wir hatten und jetzt vom Markt genommen wurde, diese Incidin oxyvapes, da mag ich diese Verpackungseinheiten, weil ich eben diese Verpackungen, da kann ich auch mal Verpackung geschickt in ein Zimmer reinlegen, gerade bei so einem Dreierzimmer. Gerade bei einem MRGR Patient mit Barrierepflege, wo sich dann die Patienten draus bedienen können aus diesem Behältnis und wenn die Patienten heimgehen und da 5 drin sind, dann schmeiße ich halt die 5 von uns weg. Vom Verpackungssystem her sind die sehr, sehr gut und auch von der Entnahme her sind sie gut, weil tatsächlich grad bei dem Produkt was wir hatten, das waren teilweise so endlose Tücher, die da rauskommen. Da hatte ich gleich 10 Stück in der Hand, was ja völliger Unsinn ist und bei den Bcillol kann ich tatsächlich, so der Eindruck, kann ich die

einzelnen wirklich rausnehmen, ohne dass die jetzt aneinander haften und ich 10 in der Hand hab. Das gibt es eigentlich nicht, von daher gut gemacht.

➔ **11b.I: Wie ist die Umgänglichkeit und Benutzung mit dem Produkt? Sehen Sie Nachteile?**

K06: Nee, weil, wie ich schon gesagt habe, nachdem die jetzt, das Vorgänger Produkt von Bacillol, da hatte ich immer den Eindruck, es ist einfach zu wenig Wirkstoff im einzelnen Tuch drin, und jetzt bei diesen Tüchern habe ich so meinen Eindruck, mein ganz persönlicher Eindruck, mehr Wirkstoff in den Tüchern drin, habe eine gescheite Flächenbenetzung, die ich auch sehe. Ist ja ganz wichtig, wenn ich so etwas auftrage, dass ich visuell nachvollziehen kann: „Jawohl, hier habe ich Oberfläche, die jetzt feucht ist.“ Passt, ist gut.

➔ **11c.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?**

K06: Nee, die Verpackung ist gut und wie ich schon gesagt hab, ich kann sie halt wirklich einzeln rausnehmen, ohne dass ich jetzt gleich mehrere Tücher dann rausziehe. Auch der Verschluss, wenn ich dann quasi die Verpackung wieder zu mache. Der Verschluss scheint dicht zu sein, weil ich jetzt nicht den Eindruck habe, die Verpackung dann jetzt mal einen Tag unbenutzt rumliegt, könnte man ja annehmen, dass der Verschluss nicht richtig dicht ist und das erste Tuch trocknet aus. Das habe ich jetzt bei dem Bacillol den Eindruck nicht. Von daher Verpackung ist ok und das ist natürlich Kunststoffmüll, das lässt sich, glaube ich, in den nächsten 50 Jahre auch nicht vermeiden.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

➔ **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K06: Ja. In den Patientenzimmern. Also wir haben ja so Pflegeschränke in den Zimmern, das heißt, ich hätte da auch einen Platz, wo ich es hinlegen könnte, wo der Patient sich dann Tücher holen könnte, gar kein Problem. Wir haben auch Ablageflächen im Sanitärbereich, wo man dieses Produkt bereitlegen könnte, das wär schon gar kein Problem. Und in denen Bereichen jetzt zur Flächendesinfektion Nachtkästchen, Tisch und eben Sanitärbereich, da würde ich es so ein paar Patienten da zur Verfügung stellen wollen. Würde natürlich Kosten verursachen, weil die Tücher bestimmt aber beim ein oder anderen dann im Koffer landen, weil die haben ja auch sehr gute, sehr gute Reinigungskraft, muss man ja sagen. Typisches Ding, ich schreibe hier auf dem Tisch einem Patienten was auf, hab kein Kuli dabei, nimm einen Eding, mach das auf dem Blatt Papier, Edding drückt durch. Mit dem Bacillol Tuch krieg ich das sowas von gut wieder weg, das sind tolle Tücher.

➔ **12a.I: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie die Tücher auch gern mal in das Patientenzimmer mitnehmen und denen auch hinstellen. Ist es ein standardisierter Prozess, oder ist es einfach nur so, im Ausnahmefall, wenn sie mal vorbeilaufen?**

K06: Genau das passiert auf Nachfrage des Patienten. „Kann ich so Tücher haben?“ oder eben im Rahmen der Barrierepflege.

→ **12b.I: Und kommt es öfters vor, dass Patienten so Tücher verlangen oder eher weniger?**

K06: Eher weniger.

→ **12c.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?**

K06: Also wenn, dann würde ich es tatsächlich über einen Spender machen, also im Patientenzimmer irgendwo zentral. Ich meine im Regelfall hat man ja mindestens zwei Händedesinfektionsmittelspender in der Nähe, neben der Türe, wo wir auf jeden Fall immer Händedesinfektionsmittelspender haben, da würde ich auch einen Spender für diese Tücher hintun mit einem entsprechenden Hinweisschild für den Patient. Man muss ja auch diesen die Aufklärung, was der Patient wo mitwirken kann, muss man ja auch, sag ich mal, zeitlich so gestalten, dass wir jetzt nicht, wir müssen so viele Assessments machen, nur was drauf toppen, weil das wird nicht funktionieren. Das heißt dann ein Spender, mit entsprechenden Großgeschriebenen Hinweisschildern und das kurz und prägnant gehalten.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K06: Also was mich erschrocken hat ist, nachdem wir jetzt bei uns die Incidin Tücher, wenn wir sie alle zurückschicken und herausgenommen hat und ausgetauscht gegen andere Tücher und ich mir als allererstes mal durchlese: „Sie benötigen persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille, bla bla bla...“ Natürlich kann im Umgang mit allen Desinfektionsmitteln ja immer irgendwas schiefgehen. Wischt sich der Patient damit die Augen aus, weil er denkt, das ist eine Serviette, haben auch ein Problem. Ja, sensibles Thema fällt mir jetzt auch akut eigentlich nichts ein, wie man das... Wie könnte man das in den Griff kriegen? Also ich denk vor allem der kognitiv eingeschränkte Patient, da hat man natürlich so die ein oder andere Gefahr, dass so Desinfektionstuch gegebenenfalls dann als Taschentuch oder sonst irgendwie zweckentfremdet werden kann. In dem Fall müsste man tatsächlich die Sachen eigentlich raus tun aus den Zimmern dann. Aber bei der Desinfektionsmittel hatten wir da jetzt auch nie ein Problem. Also. Ich bin ja schon wirklich eine Weile mit dabei.[In der Zeit] habe ich es jetzt noch nie erlebt, dass ein Patient ein Desinfektionsmittel, zum Beispiel, trinkt. Rum. Ja, könnt ja theoretisch vorkommen, aber habe ich persönlich noch nie erlebt. Also ich glaub die Gefahr, dass mit den Desinfektionsmittel Tüchern dann irgendeine Zweckentfremdung stattfindet und ein Patient Schaden nehmen könnte, weiß ich nicht, wie hoch die ist, kann ich nicht einschätzen.

→ **Nachfrage 13a.I: Tragen Sie bei den Bacillol Tüchern auch Handschuhe wie beim anderen Produkt?**

K06: Ja, Handschuhe, Handschuhe, auf jeden Fall. In der Pflege haben Sie ja tagtäglich so oft Kontakt zu irgendwelchen alkoholischen oder sonstigen Desinfektionsmitteln, wenn sie da jetzt diese, auch die Bacillol Tücher, wenn sie jetzt tagtäglich nur Hände machen würden, irgendwann ist die Haut kaputt. Also Pflege trägt immer Handschuhe und es wäre natürlich auch Patienten ratsam, da Handschuhe anzuziehen, aber das wäre ja kein Problem, wir haben natürlich in jedem Zimmer unsere Handschuhspender. Die Frage ist nur, Kosten von den Handschuhen und natürlich extremer Müll, der dann anfällt. Also noch mehr Müll. Das sind so die Dinge, aber das ist ein anderes Thema, das möchte ich gar nicht beleuchten, ja.

➔ **13b.I: Fallen Ihnen weitere Gründe ein, warum die Tücher nicht bereits Teil des Patientenalltags sind?**

K06: Nein.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K06: Handhabungshinweis, ziehe ich Handschuhe an oder nicht und ganz wichtig glaube ich die Anwendungsfrequenz gerade. Nach dem Toilettengang oder vorm Toilettengang. Jetzt am Mittag, wenn die Patienten bei Mittagessen waren, dass halt einer dann in dem Zimmer, dann der Tisch danach abwischt, also Frequenz und Nutzungshinweis, wie gehe ich mit dem Produkt um. Die zwei Sachen glaub aus meiner Sicht. Also die Hinführung zur Nutzung, die Schwellen ganz arg niedrig setzen, damit es überhaupt durchgeführt wird. Wenn man da jetzt 1000 Vorgaben macht, wann, was, wie wo, macht es dann keiner wieder. Patienten einfach sagen, zieh Handschuhe an, wenn du auf Toilette warst, bitte einmal abwischen. Das wär so jetzt im Sanitärbereich sag ich jetzt, sagen wir mal so ad hoc das, was mir einfallen würde.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden Sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K06: Dass sich die Patienten endlich mal, also ich mein, das ist ja so das Phänomen irgendwo, also ich bin ja immer nur der Meinung, dass regelmäßiges Händewaschen das A und o eigentlich ist, und ich erlebe leider im Alltag genau dieses nicht, ja und selbst im Krankenhaus nicht, und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Patienten von der Toilette zurückbegleite, dass ich dem Großteil Patienten immer nur sagen muss, jetzt erst mal ans Waschbecken bitte und Händewaschen. Also da haben wir einfach schon so grundlegende Dinge, die einfach nicht funktionieren, und die müssen wir, glaube ich, erst einmal in den Griff bekommen und dann, dann kann man sich Gedanken für weiteres machen, ja. Grundlegende Dinge wie, ich wasche meine Hände und ich tue meine Toilettenbrille noch

mal kurz abwischen. Das sind aus meiner Sicht das A und O. Zweitens, das meiste wird ja dort übertragen, wenn ich an die Gastroenteritis Tiden, denke die so vor allem zu der Jahreszeit hier bei uns immer aufschlagen, die werden halt da übertragen. Das ist mit des A und o ja.

➔ **Nachfrage 15a.I: Warum waschen sich die Patienten nicht die Hände?**

K06: Da es oftmals alte Patienten sind, ich denke, das ist eine andere Generation, die ist anders großgeworden. Corona hat es ja gezeigt, dass wir umgeben sind eben von Krankheitserregern, und die eben immer mehr Probleme machen werden, auch in Zukunft. Also vor 20 Jahre oder so hat man ehemaliger Chefarzt gesagt, irgendwann kommt der Virus, wir waren gestresst, 2 Jahre lang mit Corona, der Virus hat es Gott sei Dank nicht geschafft, aber das ist in der älteren Bevölkerung ist es nicht so drin, die sind immer nur davon überzeugt, dass ein Antibiotikum gegen alles hilft. Sensibilisieren, sensibilisieren, das findet nicht statt. Also ich bin ein begeisterter Italienurlauber und da war es schon immer so, dass sie zum Beispiel Obst, Gemüse nur mit Einmalhandschuhe hier aus dem Behältnis rausnehmen dürfen. Das finde ich in Deutschland kaum. Also das ist so ein bisschen ein deutsches Problem, dass wir da schlampig sind, ich sag jetzt einfach mal schlampig sind.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K07

Am 15.01.2024

1.I: Nach welchen Kriterien werden Patienten verlegt?

K07: Bei uns spielt es eine relativ große Rolle, weil wir immer relativ voll sind auf Station. Das kommt aber immer darauf an, wie unsere anderen Stationen natürlich auch besetzt sind. Wenn wir eine interne Verlegung haben, also wenn praktisch ein Patient von der einen Einheit, einer gesundheitlichen Fachrichtung, auf eine andere Wechselwelle auf einmal internistisch ist und chirurgisch zu Ende behandelt ist, dann sind die Kriterien relativ einfach, weil dann geht es um die, sag jetzt mal, Untersuchungseinheit, also die Fachrichtung. Also wenn er internistisch wird, dann müssen wir natürlich eine Internistisch passende Station für ihn suchen, dass wir uns am Klinikum Heidenheim aufgeteilt ist, die geschlechtliche Trennung, klar, das spielt eine Rolle mit und bei uns wird auch ab und zu, nicht immer, aber ab und zu drauf geachtet, wie fit der Patient ist. Wenn eine Station heute schon, ich weiß nicht ob Ihnen die A und S Einstufungen was sagen, ob Sie das kennen, allgemein und speziell wo die Patienten gruppiert werden, wenn die zum Beispiel ein Vollpflegefall sind, sind die A 3, da gibt es immer 1 bis 3, dann sind die A 3 eingruppiert. Das heißt, wenn eine Station heute schon 3 á Dreier bekommen hat, dann guckt man, dass man die nächste

Verlegung nicht auch noch auf diese Station packt, weil dann haben die schon einen sehr hohen Pflegeaufwand. Und man koordiniert das dann ein bisschen anders. Aber wir haben ein Belegungsmanagement hier bei uns im Haus, die sich um solche Dinge kümmern, also die sich, wenn ich jetzt eine oder wenn unsere Station, weil sie so voll war, einen Fremdlieger auf einer anderen Station hat, sagt man mal keine Ahnung, auf der Urologie liegen von uns manchmal welche, dann weiß das Belegungsmanagement, es geht morgens durchs Haus über alle Stationen, die wissen, welche Zugänge kommen am Tag auf Station, also welche kommen geplant, von außerhalb zur OP, und welche Zugänge sind noch im Haus, die verteilt werden müssen. Die ACH in dem Fall hat einen Fremdlieger auf der urologischen Station, den müssen wir heute unterbringen, weil die Urologie kriegt selber ihre, das sind so Kriterien, muss er verlegt werden oder kann er noch bleiben? Ja genau. Aber wie gesagt, wir haben ein Management da dafür, ich glaube mit 4 Personen mittlerweile, die sich ausschließlich um das kümmern, auch wenn Patienten über die Notaufnahme kommen und verlegt werden müssen, aus der Notaufnahme, suchen die einen Platz dafür. Und bei uns gibt es eine ganz klare Regel: die Intensivstation hat Vorrang. Also wenn Patienten von der Intensivstation auf die Normalstation zurück verlegt werden sollen, weil einfach der Zustand des Patienten wieder so gut ist, dass er zurückverlegt werden kann, dann hat das Vorrang vor allen anderen Patienten, weil die Intensivstation muss ihre Betten generieren für das was nachkommt. Genau.

2.1: Wie lange dauert ein Aufenthalt eines Patienten?

K07: Also ja, das ist bei uns relativ breit gefächert. Wenn ich jetzt ein Schnitt ziehen müsste, wäre es fast unfair, weil der Schnitt wären ungefähr 5 Tage. Aber das wäre fast unfair, weil wir haben unter anderem aufgrund der Ambulantisierung, die Krankenkassen oder halt ja der Bund verabschiedet hat, ist es jetzt so, dass ganz viele Operationen jetzt ambulantisiert worden sind. Der Katalog umfasst glaub 2000 Diagnosen, die 2023 ambulantisiert worden sind. Wir haben hier ein neues ambulantes OP Zentrum, deshalb einfach auch aufgebaut wegen den Zahlen und das sind so Sachen wie Leistenhernien, zum Beispiel, die eigentlich jetzt ambulant laufen müssen. Die Klinik bekommt dann kein Geld mehr wenn sie es nicht ambulant laufen lassen. So, und jetzt ist es die Aufgabe der Klinik die Kontextfaktoren dazu rauszufinden, das bedeutet die Klinik muss Faktoren finden, was dagegen spricht, dass die Ambulantisierung werden. Das heißt zum Beispiel, die Tragen dann ein Versorgungsproblem, weil der Patient zum Beispiel 83 Jahre alt ist und zu Hause nicht versorgt werden kann, wenn er ambulant operiert wird. Das bedeutet, wir kriegen auch Kurzlieger. Diese Kurzlieger sind eine Nacht dann nur da. Wir haben aber im Gegenzug auch Patienten, die zum Beispiel nach Operationen, im Schnitt sag ich jetzt mal, 6-7 Tage da sind. Und dann gibt es die Patienten, die nach Operation, nach ihren 6-7 Tagen Fieber entwickeln und wegen mir, ich sag jetzt mal übertrieben, einen Platz brauchen, die sind 3 Wochen da. Ja, deswegen wäre es jetzt unfair. Also ich sage jetzt mal im Schnitt zwischen 4-5 Tagen, wenn alles normal läuft. Das sind aber sowohl die, die eine Nacht da sind, als auch unsere Gefäßpatienten, die PTA, die kann man noch nicht ambulant operieren, wird aber auch kommen und diese PTA liegt eine Nacht da.

3.I: An welchen Orten halten sich Patienten meistens auf?

K07: In ihren Zimmern. Bei uns ist es so, die also jetzt spreche ich mal für unsere Stationen getrennt. Wir haben den gefäßchirurgischen Bereich, die gefäßchirurgischen Patienten haben AVK, ich weiß nicht ob ihnen das was sagt, arterielle Verschlusskrankheit. Die Gefäße sind verkalkt und zu, und das findet ja nicht nur in den Extremitäten statt, wo sie dann diese Wunden haben, sondern das ist ja im ganzen Körper so, also auch im Kopf. Diese Patienten sind relativ beratungsresistent, die sind oft beim Rauchen, die findet man am meisten draußen. Und dann haben wir unsere Patienten hier auf Station, die Kurzlieger, die sind in ihren Zimmern, weil die gehen ja morgen schon wieder. Und dann haben wir Patienten, die länger da sind, die durch die KG, durch die Mobilisation der KG immer wieder auf unser, wir nennen es Panoramazimmer, am Ende des Flures einen Aufenthaltsraum mit einer großen Fensterfront, wo Kaffee, Tee und alles Mögliche steht, wo sich die Patienten mit Ihren Besuchen bedienen dürfen. Das ist ein Raum, da halten sich unsere Patienten auf. Auf dem Flur halten Sie unsere Patienten mit der KG auf, in den Zimmern und natürlich in den Bädern.

5.I: Äußern sich Patienten zu Hygienethemen?

K07: Jein. Wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Ich würde es jetzt mal, eher auf die weibliche runterbrechen, den Frauen, denen das mehr auffällt. Die sagen, die Putzfrau war heute noch gar nicht da. Die Frauen, die sagen, die Putzfrau war zwar da, aber es ist nicht sauber. Die Frauen, die sagen, Mensch, die Frau, die Bettnachbarin, hat heute Nacht so erbrochen, die Kollegin hat zwar das Bett frisch gemacht, aber meinen sie nicht, das Bettgestellen muss man machen? Also das ist bei der weiblichen Spezies würde ich jetzt mal sagen, häufiger, wie bei der männlichen Spezies. Bei uns kommt es überhaupt gar nicht vor, wenn ich jetzt auch noch unsere zweite Station denke. Kommt es überhaupt nicht vor. Wo der Schwerpunkt ist, ist im Bad, also alles, was im Hygienebereich ist. Bei uns in den Zimmern fällt es dem Patienten eher auf wenn was nicht stimmt, vor allem in der Toilette. Ja, also da liegt glaub ein größeres Augenmerk auf der sanitäre Bereich. Und dort im sanitären Bereich auf die Toilette, würd ich jetzt mal speziell sagen. Das sind unsere, oder würd ich jetzt von mir aus als Schwester ausgehen, die die meisten Rückmeldungen wahrscheinlich.

→ 5a.I: Ist es eher ein großer Teil der sich äußert oder ein kleiner Teil?

K07: Wenn ich es in Prozent einteilen müsste, würde ich vielleicht sagen 35% bis 40%, wenn überhaupt.

6.I: Ist eine Aufklärung bezüglich der Flächenhygiene vorhanden?

K07: Nein. Wie soll ich sagen? Bei uns übernehmen wir [Pflege] die Fläche, Flächendesinfektion. Also wir und die Reinigungskräfte. Wir im Sinne von, wenn ich mein Zimmer oder wenn ich, jeder hat bei uns im Schnitt drei Zimmer am Tag, á drei Patienten. Wenn ich meine Betten gemacht habe und wenn ich alles fertig habe, bin ich diejenige, die der Fenstersims und den Tisch abputzt. Die anderen Flächen was den sanitären Bereich betrifft, macht unsere Reinigungskraft.

7.I: Wie sieht das aktuelle Desinfektions- und Reinigungskonzept im Krankenhaus aus?

K07: Wir haben [eine Kollegin] bei uns im Haus, die Servicio die Leitung der Servicio Kollegen. Und diese Serviociokollegen fällt unter anderem auch die Wäscherei und die Bettenaufbereitung bei uns und die Hygienefachkräfte, also die Reinigungskräfte. Da gab es jetzt vor kurzem eine Umstrukturierung, nämlich dass unsere Betten in dem Zimmer aufbereitet werden. Also unsere Betten wurden früher Zentralaufbereitet in der Waschmaschine, in einer großen unten im Keller, die wurde aber abgerissen, dann wurde es weiterhin so ein bisschen Betrieben im Keller und jetzt wird dezentral aufbereitet, das bedeutet, die kommen jetzt auf Station. Unsere Betten haben einen NFC Tag, die kommen auf Station, lesen diesen NFC Tag aus, nachdem wir eine Anforderung übers Telefon geschickt haben für dieses Bett, und dann sehen die wenn das 10 mal aufbereitet worden ist, dann muss es zentral aufbereitet werden. Dann nehmen die das praktisch mit den Keller, aber bis zu 10 mal dürfen sie es oben aufbereiten auf Station, das heißt, die kommen und haben einen ganzen Pulk an Material dabei, nämlich vom Spannbettuch über den Durchzug, frisches Kissen, frische Decke und das ist alles schon, früher hätten wir gesagt, im geschnürten Päckle, also die haben vorbereitete Pakete, und das bringen sie mit, tauschen das aus und putzen da dabei das komplette Bettgestell ab. Wenn ein Patient entlassen wird und das Bett geht, dann reinigen die das Nachtkästchen, die Ablage im Bad und nehmen das Bett mit oder bereiten es auf. Je nachdem wie oft es dann schon aufbereitet ist. Aber, da ist jetzt mein Struggle ein bisschen, den Patientenruf, also die die Glocke praktisch, die wird da nicht mit gereinigt. Das müssen wir separat machen und dann kriegen die, wenn man die Disco geht, kriegt man doch solche Bündel um den Arm, und so ein Bündel kommt praktisch an das gereinigte Nachtkästchen. Da steht drauf, clean, dass wir wissen, dass das fertig ist und vorbereitet. Dann bestätigen die den Auftrag und sind weg. Die Reinigungskraft hat ganz klar zugewiesene Aufgaben über deren Arbeitsabläufe. Und die macht Boden und Bad, genau Müll leeren, solche Sachen. Wir machen den Rest. Das klingt jetzt blöd. Aber ja, wir machen den Rest. Ich als Schwester putze die Nachtkästchen von vorhandenen Patienten ab, weil das ist einfach eklig. Da ist von dreimal essen praktisch Zeug drauf und ich fahr, also das ist meine Intuition und ich weiß, unsere älteren Schwestern machen das auf jeden Fall auch, ich reinige mit einem weiteren Tuch den Tisch, den Fenstersims und ich mach eine frische Mülltüte dran, weil niemand möchte neben einer 2 Tage alten Bananenschale schlafen. Also niedergeschrieben sind ganz sicher die Abläufe von der Bettenzentrale und niedergeschrieben sind ganz sicher auch die Abläufe von der Reinigungskraft. Das ist hinterlegt.

➔ 7a.I: Welche Mittel werden verwendet?

K07: Wir nehmen die Incidin Wipes, das sind diese 99 Tücher auf der Rolle, die man durch diesen Eimer, den man dann auffrischt und wieder beschriftet. Und auf unseren Wägen, auf unseren Bettenwägen, sind jeweils so ein Eimer. Und die Kollegen haben auch diese Bacillol Tücher dabei, ja, wobei diese Bacillol Tücher meines Wissens nach zwar Flächendesinfektionsmitteltücher sind, wir aber eigentlich ursprünglich, glaube ich, für alles was Monitor und Display hat angeschafft haben. Wir haben unter anderem auch viele Geräte an den Betten hängen, unsere Thoraxdrainagen oder unsere Vakuumpumpen, die wir genau mit diesen Tüchern reinigen, weil der Patient die überall mit rum trägt, oder da auch mal was drauf tropft am Sekret und die dann damit gereinigt werden müssen.

8.I: Wie betreiben Sie persönlich Flächenhygiene in Ihrem Arbeitsalltag?

K07: Also in meinem Schreibtisch, was ich gar nicht mag, ich habe eine helle Tastatur, weil ich es widerlich finde, wenn da solche unerkannten Fingerabdrücke drauf sind, kennen Sie das? Wenn so eine weiße Tastatur schon bei ASDF aufweist, die Fingerränder, dieses braune, und ich habe mit Absicht eine helle Tastatur. Ich bin jemand, die einmal in der Woche ihre Tastatur reinigt, mit aber auch unter anderem einem Bacillol Tuch, weil die [anderen] Tücher zu nass sind. Die Tücher kommen ja aus diesem Eimer und die sind zu feucht für eine Tastatur. Mit Bacillol. Und wir haben vor kurzem mal was ausgetestet hier, wir haben uns Stüllpas über die Arme gezogen, weil wir mit unseren Unterarmen auf der Tischkante sind und wenn sie immer mit ihren Unterarmen auf der Tischkante sind, werden sie irgendwann sehen, wir haben helle Schreibtische, das genau an diesen Stellen relativ viel Schmutz sich anhaftet und wir haben das getestet über eine Woche mal. Also ich hatte solche Stüllpas auf den Unterarmen, wie schmutzig diese Stüllpass sind. Einfach nur, um zu sehen, was da. Schwitz, da kann ja keiner was für, was da an Schwitzen am Tisch hängen bleibt. Und seitdem ist es ganz witzig, nehmen meine Kollegen häufig mal ein Bacillol Tuch und wischen die Tische vorne rum immer wieder ab, also unsere Arbeitsplätze und ich mache es einmal in der Woche meistens. Freitag, lupf ich meine ganzen Unterlagen an und ziehe da auch meine Maus, weil meine Maus gerne mal an der vergriffenen Stelle einfach schmutzig ist. Und es ist erstaunlich was da vorkommt manchmal. Aber trotzdem, auch wenn man die Hände gewaschen hat, und ich geh eigentlich morgens, wenn ich hier reinkomme zum Händewaschen, einfach weil ich die Tür angefasst hab und mein Schlüsselbund und alles Mögliche, ist es eigentlich immer der erste Weg. Guten Morgen sagen zu meinen Kollegen und da dabei auf dem Weg zum Waschbecken. Trotzdem, wenn ich jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen das nicht machen würde mit meiner Tastatur, hätte ich da ebenso so braune Ränder dran und ich mag es einfach nicht, ich bin da den ganzen Tag dran, ich möchte das nicht. Aber Bacillol ist das Heilmittel, das hilft.

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K07: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube zur eigenen Sicherheit. Oder zur eigenen Absicherung. Vielleicht nennen wir es eher so. Das klingt jetzt bisschen schwäbisch,

vielleicht auch einfach, dass man es noch besser weg bekommt. Weil wenn ich diese Essensreste, wenn jemand, wenn ein Patient sieht, dass er ihm jetzt gerade keine Ahnung, da der Joghurt verschütt gegangen ist und er gar kein Essenstablett mit runter hatte, weil er der Joghurt erst um 15 Uhr nachmittags gegessen hat und klebt an das Nachtkästchen, an das ausgezogene Board dran, wäre es vielleicht einfacher, er könnte sich beteiligen, wenn er so kognitiv fit ist, dass er sagt: „Kein Problem, ich wisch das mal kurz weg.“ Ja, das wäre für mich was oder wenn er sieht, Mensch die haben vergessen, das kommt natürlich auch vor, die haben vergessen hier den Tisch abzuwischen, ich möchte mich so nicht dran setzen, ist verständlich, dann sollte es ihm offen stehen, dass er ein Tuch nimmt und es einfach kurz drüber wischt, wenn er sich da einfach auch wohler fühlt. Also ich mein, er ist schon in einer fremden Umgebung und wenn er sich da dafür dann wohler fühlen würde, wäre das für mich in Ordnung. Natürlich auch, um die Keimverschleppung zu reduzieren. Dass wir Verteilung von, keine Ahnung, also wir haben jetzt unsere Patienten eigentlich isoliert, also es ist jetzt nicht so, dass einer etwas verteilen könnte im Zimmer, weil derjenige ist ja isoliert, der liegt ja separat für sich, aber dennoch. Keine Ahnung, Influenza oder Corona. Der eine hat gar keine Auswirkungen, der merkt es gar nicht, der nächste, den legt es aber voll dafür rein. Also diese Sachen, diese Keimverschleppung zu reduzieren wäre natürlich mit einer der Hauptpunkte auf jeden Fall.

➔ **9a.I: Steht es im Interesse des medizinischen Personals, dass sie Patienten an der Hygieneerhaltung beteiligen?**

K07: Puh, unsere Ärzte weiß nicht, gibt vielleicht 2-3, die sich für dieses Thema interessiert. Unsere Ärzte sind relativ wenig präsent hier bei uns. Unsere Ärzte kommen morgens zur Visite, hauen das Ganze in 20 Minuten durch, weil die müssen in den OP, und die müssen ihre Stationen abarbeiten. Das ist ein bisschen anders, wie zum Beispiel auf einer inneren Abteilung, wo man 2 Stunden Zeit hat, sich mit einer Visite auseinanderzusetzen und mit den Patienten. Das würde bei uns nicht geschehen und ich glaube auch wenn ein Patient bei uns sagen würde, Mensch, Herr Doktor, gestern ist mir auch aufgefallen, hier ist aber schmutzig, dann würde mein Arzt rauskommen und würde sagen, da hat er das gesagt, kümmer dich drum. Es wäre jetzt nicht so, dass unsere Ärzte da dafür groß angesprochen sind, aber unsere Schwestern, würde ich jetzt schon sagen, würden sich dafür interessieren. Aber ob jetzt jede Schwester das durchboxen würde, weil da würden die Kontras kommen und die Kontras wären so Sachen: „Mensch, dann haben wir aber einen nicht kognitiven Fitten, dann muss ich es ja eh machen, also mache ich es doch gleich selber.“ Dann haben wir einen, der provoziert, weil er sagt: „Hey, so sehe ich die Schwester zweimal am Tag mehr. Dann kipp ich meinen Joghurt halt um. Ja, und dann klinge ich und sag ihr, ich hab gar keine Tücher. Ja und dann kommt sie und macht das für mich.“ Also ich glaube, da würden wir allerhand erleben. Und wir würden von unseren Schwestern oder ich würde für meine Schwestern auch allerhand Rückmeldungen bekommen, weil man schon auch Pro und Contra sehen muss. Die würden die Verschwendung sehen. Also ganz sicher würden unsere Kollegen oder meine Kollegen die Verschwendung sehen im Sinne von, die Patienten verbrauchen diese teuren Tücher unnötig und der Schwabe steckt gerne auch ein Päckchen ein. Das wäre glaub das Kontra was meine Kollegen sehen. Im Gegenzug, zum Pro, natürlich wäre es toll, es würde den Kollegen Arbeit abnehmen. Aber ich weiß nicht, wie man es

kommunizieren würde. Würde ich zu einem Patienten sagen: „Herr Meier, willkommen, ich wollte Ihnen nur sagen, hier putzen Sie selber.“ Wenn ich ihn ins Zimmer bringe: Herr Meier, hier ist ihr Schrank, hier liegen Tücher, wenn sie sich irgendwo nicht wohl fühlen oder wenn sie Bedenken haben, an diesem Tisch zu essen, dann dürfen Sie noch mal drüber wischen, dann würde ich jetzt als Patient denken: „Hey, was ist mit denen los, das hier ist eine Hygiene Einrichtung, warum soll ich denn jetzt hier was reinigen?“ Oder wie verkaufe ich den Patienten, oder wie erkläre ich es dem Patienten, dass es für ihn nicht rüberkommt, als hätte das Klinikum Heidenheim hier in dem Fall ein Defizit?

➔ **9b.I: Wie würden sie es als unterstützende Maßnahme sehen?**

K07: Also wir haben in jedem Zimmer einen sogenannten Pflegeschrank, da sind Pflegeartikel drin und Artikel für uns, die wir nutzen können, wenn jemand sich, so ein Beispiel, komplett eingestuhlt hat, dann schauen wir oder sowas. Am Anfang haben wir das kommuniziert, weil der unter anderem auch das Trinken drin steht. Also, dass die Patienten sich Nachschub an Trinken holen können und nicht jedes Mal raus auf den Fluch oder in die Küche müssen, weil die Küche war am Anfang offen für alle, für alle frei zugänglich und die haben wir gesperrt, die Küche. Da wurde einfach auch Schabernack, hygienischer Schabernack getrieben. Diese Küche, diese Gemeinschaftsküche wurde wieder gesperrt. Und in diesem Schrank, da sind also sowohl Pflegeartikel, als auch Trinkflaschen. Am Anfang hat man das kommuniziert und hat gesagt, Mensch, hier ist ihr Zimmer, hier ist ihr Schrank, hier ist ein Pflegeschrank. Sollten Sie etwas benötigen an Wasser oder eine Kompresse für irgendwo, zum Beispiel am Zugang oder sowas, dürfen Sie sich hier bedienen. Unsere Schränke waren gut und gerne mal relativ schnell leer, weil die dann die Inkontinenzmaterialien mitgenommen haben. Die Patienten, die haben Unterlagen, Saugunterlagen mitgenommen, dann haben wir das Ganze wieder gelassen und jetzt ist es besser für uns. Natürlich sieht der Patient, wenn wir im Zimmer sind und holen Trinken für ihn, dass wir an diesen Schrank rangehen. Aber jetzt Frage: Lege ich dieses Päckchen Tücher, zum Beispiel, auf den Fenstersims sieht es für mich immer auf den ersten Blick, wenn ich mich in die Besucherlage versetzt, gruschtig aus. Packe ich sie in den Schrank, dann kam die Frau Müller mit ihrem kaputten Fuß vielleicht nicht aufstehen und die holen, würde aber gerne. Die wäre kognitiv so fit, weil sie noch jung ist. Würde aber gerne ihr Nachtkästchen abwischen. Händige ich jedem Patient eins aus, ein Päckchen, dann haben wir einen sehr hohen Verbrauch. Definitiv, würde ich jetzt behaupten, 50% der Patienten nehmen das mit nach Hause. Ja, also ich bin grundsätzlich nicht dagegen und es wäre toll, als unterstützende Maßnahme das zu sehen, aber ich sehe mehr Kontra wie Pro, weil die unterstützende Maßnahme die würde vielleicht darin enden, dass der Patient klingelt, um uns zu sagen, dass wir ihm bitte ein Reinigungstuch bringen oder in die Hand geben. Wenn wir eine Lösung finden, wäre ich da gerne bereit, das auch mit dem Patienten zu kommunizieren. Würde sagen: Schauen Sie, Herr Meier, Sie haben hier im Zimmer die Möglichkeit, dass wenn was wäre, hier die Tücher für Sie bereit liegen und sie dann einfach drüber wischen, das ist gar kein Problem für uns.“ Ja, also ihm ist als Positives zu verkaufen.

➔ **9c.I: Wie würden Sie denn die Tücher in den Patientenalltag integrieren, so dass es für alle zufriedenstellend wäre, dass es nicht wekommt oder, dass kein hoher Verbrauch zustande kommen würde?**

K07: Und in den neueren Bau in den Patientenzimmern sind Handschuhhalter, und die sehen, wenn man sie legen würde, aus wie Feuchttücherspender von Kindern. Und in diesem Handschuhhalter müsste, meines Erachtens, dann einfach ein Feld mehr sein, dass ich diese Feuchttücher dort positionieren kann. Also ich kann die ja austauschen, so wie die Handschuhpakete auch. Es würde nicht im Zimmer rumliegen, aber es wäre für die Patienten frei zugänglich. Das wäre für mich eine Anlaufstelle. An diesem Handschuhspender ist nebendran auch der Desinfektionsmittelspender, das wäre für mich die Anlaufstelle, wo ich es, wo ich es sehen würde, wo es hingehören würde. Wo ich es am ehesten suchen würde und wo es in jedem Zimmer seinen festen Platz hätte.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K07: Also, ich würde sagen, Nachtkästchen definitiv. Also ganz klar, am gemeinsamen Tisch könnten sie genauso mitwirken oder zum Beispiel nach dem Essen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, zu Hause wisse ich doch auch meinen Tisch ab, wenn ich fertig bin, fahre ich doch auch mit dem feuchten Tuch über meinen Tisch und mach den sauber. Also praktisch, wenn die mobilen Patienten bei uns am gemeinsamen Tisch sitzen, könnten sie den doch nach dem Essen abwischen. Dann wäre der eigentlich immer sauber. Die Patienten, die nicht mobil sind, sitzen ja an ihrem Bettrand oder im Bett oder mit dem Nachtstuhl am Nachtkästchen, die müssten einfach dann, oder könnten einfach dann über Nachtkästchen fahren. Wo sie mithelfen könnten, ich aber nicht weiß, ob die Tücher da dafür das Richtige sind, wäre, wenn sie im Bad waren und die Reinigungskraft schon durch ist. Weil sie ja irgendwie nicht immer in jedem Zimmer warten kann, bis jeder gewaschen ist, dass er das Waschbecken, nachdem sie fertig sind, vorne am Berührungsrand, am Wasserhahn und in der Fläche innen einfach ausreiben. Ich meine, ich mache das zu Hause auch, wenn ich fertig bin, mache ich mein Waschbecken sauber und reib es trocken. Aber ob man das mit einem Desinfektionsmitteltuch zum Beispiel, oder, keine Ahnung, eine Idee wäre, vor dem Toilettengang die Klobrille. Ja, dass jeder für sich da safe wäre, bei drei Leuten im Zimmer ist, man das nicht, oder? Ich würd jetzt nicht sagen, wir haben drüber diskutiert, wer morgens bei der Visite alles unten das Bett anfasst,. Da halten sich morgens unsere Ärzte dran fest, wenn sie mit den Patienten sprechen. Ja, die KG, der Patient hält sich fest, ob das was wäre, aber das sehe ich eigentlich jetzt nicht im Bereich vom Patienten, sondern das sehe ich eigentlich im Bereich der Reinigungskraft, die da morgens drüber fahren sollte.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K07: Also wir kommen gut mit dem Produkt zurecht. Wie gesagt, wir nutzen das vor allen Dingen für unsere ganzen Gerätschaften, die wir haben und natürlich für die schnelle

Nummer, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt nicht gerade den Bettenwagen dabei habe, sondern nur ein Verbandswagen in Anführungszeichen, dann habe ich dort in Anführungszeichen nur Tücher draufliegen und benutzen die für eine Flächendesinfektion. Wir kommen gut damit zurecht. Die sind relativ reißfest, also wenn man mal probiert, die irgendwie auseinander zu ziehen. Wir haben die mal gespannt, über was drüber gespannt, haben versucht das praktisch kaputt zu kriegen. Das geht relativ schwer, also die sind stabil im Tuch. Die sind nicht zu nass, das war für uns ganz wichtig, weil unsere Incidenttücher, die wir im Eimer haben, wenn man die trinkt, wenn man das richtig macht, so wie die Vorgabe ist, dann sind die meistens gut nass. Die werden durch so einen Stern gezogen, die insidintücher, ich weiß ob sie das kennen, der Deckel ist so ein Stern und dann wird es durchgezogen und dann wird noch ein bisschen den Rest nach innen gestreift, trotzdem sind die noch sehr satt an Flüssigkeit. Das haben wir bei den Bacillol Tüchern nicht. Wir nutzen gerne die Bacillol Tücher, die klauen die immer bei uns, um ihre Büros sauber zu machen. Also die machen da die komplette Fläche mit. Die Reinigen ihren kompletten Schreibtischmonitor, alles dann damit und wie gesagt, sie sind ja auch für Monitore und solche Sachen alles was Display hat gut geeignet.

➔ **11a.I: Wie schätzen Sie die Effektivität ein?**

K07: Ich sag jetzt mal, ja. Wir haben hier auf Station bislang noch keine große Keimverschleppung irgendwie gehabt. Also könnte jetzt nichts dagegen sagen. Aber allerdings habe ich jetzt auch noch einen Abklatsch gemacht, ob das alles dem entspricht wie es sein sollte. Also wir haben Hygieniker, die bei uns hier regelmäßig durchs Haus gehen und sich um alles Mögliche, was das betrifft, kümmern. Und deswegen sag ich Ihnen mal ganz ehrlich, wir sind da auf relativ großer Vertrauensbasis. Wenn die morgen kommen und sagen, bei euch stimmt was nicht, ihr müsst gucken, mit was habt ihr hier gewischt, dann wird natürlich ein größeres Augenmerk draufgelegt. Wir reinigen mit denen Tücher und ich sag's ihnen ganz ehrlich, wir verlassen uns drauf, dass das sauber ist. Aber wir hatten auch jetzt keine Keimverschleppung dadurch oder irgendwas, wo ich sagen könnte: „Mensch da könnte ich jetzt vielleicht drauf zurückführen, dass die Tücher gar nicht sauber reinigen.“

➔ **11b.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?**

K07: Die Öffnung. Die Öffnung des Pakets würde ich vielleicht ein bisschen verändern. Ich meine, alle Feuchttücher Päckchen sind ja irgendwie gleich aufgebaut. Wenn dann aber da nur noch 3-4 Tücher drin sind, wird das eine ganz schön [nervige] Angelegenheit und man zieht meistens alle drei restlichen Tücher auf einmal raus. Also das ist so ein bisschen ein Nachteil. Ich bin jetzt nicht für mehr Müll und ich die Verpackung ist ja schon aus Kunststoff und ich verstehe auch, dass man sie nicht anders machen kann, aufgrund der Feuchtigkeit, alles OK, aber, ich würde sagen, da kommt mir bei Incidin die Anordnung der Tücher besser vor, wie jetzt bei Bacillol. Incidin ist rund um, man zieht von innen nach außen und hat dann so eine Sollbruchstelle, wo man es abreißen kann. Klar bei Bacillol sind die ja gefächert gelegt, wie die normalen Papierhandtücher auch, das macht schon auch Sinn im Umkehrschluss zieht man dann die letzten voll raus. Also wir haben Kollegen, jetzt erst vielleicht vor weiß nicht zwei gehabt, da kam sie und sagte: „Super, jetzt habe ich die Ganze

das ganze Paket in der Hand und Krieg es eigentlich gar nicht mehr rein.“ Wenn vielleicht das Bacillol nicht rund wäre sondern länglicher, der Auslass, wo es wirklich dann immer das nächste einfach abstreift. Ich weiß nicht ob sowas geht, keine Ahnung.

➔ **11c.I: Welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie in diesem Produkt?**

K07: Also für uns ist ein Alltagsprodukt, mit dem wir sehr gut zurechtkommen, was wir gerne nutzen. Aber Nachteile wie gesagt, ich will jetzt sagen, dass es verschwenderisch ist, aber einfach ungut für uns, gerade mit diesem rausziehen und es wird so locker. Ich bin jetzt aber auch nicht dafür, dass man alles in Hartplastik irgendwie verpackt, nur damit es für mich von der Haptik besser ist, sondern das sind Sachen, die kann ich akzeptieren. Der Umgang mit den Tücher ist gut, sie hinterlassen nicht viele Spuren, also wenn ich mit Bacillol meinen Monitor abwische, sieht es nicht aus als wäre ich mit einem feuchten Tuch drüber gefahren, diese tropfenähnliche Dinger Geschichte, sondern das ist echt insofern ein gutes Produkt. Wir sind damit zufrieden. Wir kommen damit sehr gut zurecht. Wir nutzen es auch gerne.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

➔ **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?**

K07: Ja, würd ich machen. Ja würd ich machen. Entweder müsste aber vielleicht die Verpackungseinheit kleiner sein, dass wenn der Patient es einsteckt wir da nicht immer Massen an Tücher Verlust haben. Weil wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn der Herr Meier kommt und er hatte Glück und in dem Zimmer habe ich gerade ein frisches Päckchen reingelegt weil das andere leer war, dann hat Herr Meier Glück und ich es Nachsehen wenn der Herr Meier nach 2 Tagen geht und das Päckchen mitnimmt, aber eigentlich erst 5 Tücher draußen sind. Das ist so ein bisschen mein Denken und wir sind hier einfach im Schwabenland und die Leute machen das. Wir sehen es an, denen Sachen, die schon das Haus verlassen haben. Die Leute machen das und ich möchte da niemand was Böses unterstellen, sondern sie machen es einfach deswegen. Entweder müsste es dann für Patientenzimmer, keine Ahnung, eine kleine, die hälft an Verpackungseinheit geben, das wird dann aber schon wieder teurer für uns in der Anschaffung. Weil alles, was kleinere Einheiten sind, ist meistens teuer. Das spiegelt sich bei uns oft in der Apotheke wieder. Und ins Zimmer, wie gesagt, dann bräuchten wir einen festen Platz, dafür. Eine feste Anlaufstelle wäre dann aber so, dass Frau Müller, die vielleicht jetzt gerade mit dem Fuß oder nicht aufstehen darf, wir haben Patienten, die dürfen gar nicht aufstehen, nicht hinkommen könnte also, wenn das ein fester Platz wird. Unter dem Handschuhhalter hätte sie keine Chance dran zu kommen.

➔ **12a.I: Wie wäre eine Halterung am Bett?**

K07: Das ist für uns keine gangbare Lösung, weil bei unserem Patientenbett, also unsere Dreibettzimmer sind schon relativ eng. Am Patientenbett findet relativ viel statt. Wir haben Drainagen, sowohl in Hartschalen -Form, also unsere Thoraxdrainagen und unsere

Unterdrucktherapie-Geräte, die hängen schon am Bett. Dann haben wir Blasenkatheter, die hängen am Bett. Also ich finde das unhygienisch am Bett, den Urin hängen haben und parallel eine Halterung mit sauberen Tüchern. Frage, darf ich diese Tücher dann nachher wieder überhaupt an ein anderes Bett hängen? Ja, wenn die schon mal an diesem Bett waren. Dann haben wir solche Sachen wie Drainagen, die aus dem Bauchraum kommen. Die hängen auch außen am Bett. Unsere Magensonden Beutel mit dem Ablauf hängen außen am Bett, dann haben wir Patienten, die operiert sind am Darm, die in künstlichen Darmausgang haben, das hängt alles außen am Bett. Ich würde es da eher nicht sehen. Jetzt könnte man sagen, Mensch am Fußende, da kommen ja keine Drainagen links und rechts vom Bett raus. Ja, am Fußende hält sich aber jeder gefühlt fest und wir passen da damit schon eh schon nicht mehr in den Aufzügen, das bedeutet, ich muss diese Haltung immer weg bauen, wenn ich irgendwo hinfahr zu jeder Untersuchung. Wenn ich in den OP fahre, muss ich immer diese Halterungen am Bett selber weg bauen. Es wäre fraglich, ob man am Nachtkästchen zum Beispiel , was anschrauben könnte. Aber dann ist es auch so, dann ist da dieses Päckchen drin und der Herr Müller hat sich dran bedient während er lag auf diesem Bett dann kommt die Wäscherei oder halt die Bettenaufbereitung, die bereitet dieses Nachtkästchen auf, macht dann wieder ihren Zettel „clean“ dran, aber der Herr Müller war mit seinen Fingern in diesem Päckchen drin. Ist es dann noch hygienisch richtig? Das gleiche Problem hab ich auch wenn sie im Zimmer auf Fenstersims liegt. Oder in der Handschuhbox- Das natürlich immer das gleiche Problem. Da wäre der Appell natürlich an unsere Patienten dass sie nicht mit den stuhlverschmierten Fingern da dran fassen.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K07: Besucher. Also Besucher, die, das muss ja gar nicht mal der eigene Patient sein, sondern Besucher, die von draußen reinkommen. Ist die Frage natürlich, das wäre aber eine Frage an unsere Hygiene, wie gut kann ein Bacilloltuch sowas ab? Weil eigentlich soll ja Bacillol uns durch die Flächendesinfektion bewahren vor Keimverschleppung und vor Keimen an sich. Ja, also wenn ich jetzt praktisch in ein Paket Bacilloltücher reinfasse, das unter einer Handschuhhalterung hängt, ich als Schwester, weil ich ein Nachtkästchen abputzen möchte oder sauber halten möchte, hab aber vorher beim Bettnachbar, weiß nicht, das mache ich ja alles mit Handschuhen, und hab dem über die Schulter gestreichelt weil es ihm heute nicht so gut geht, verschleppe ich dann was, wenn ich dann in ein Desinfektionsmittelpaket von Bacillol fasse? Oder ist die Lösung da drin so stark, dass das Tuch das schon ab kann? Also wissen Sie, was ich mein? Passiert vielleicht gar nichts, weil ich fass ja in ein Desinfektionsmittelprodukt. Ja, natürlich nicht die stuhlverschmierten Finger, aber wenn von draußen meine Tanne Trude kommt, und die hat eigentlich ein bisschen Influenza, wirkt sich bei ihr aber nur durch eine Rotznase aus, die kommt aber auf Besuch, fast in dieses Bacillol Päckchen und möchte bei ihrer Schwester das Nachtkästchen abputzen, weil sie da gerade einen Fleck gesehen hat. Dann steht es ihr ja frei, da hinzugehen, weil sonst würden wir es ja nicht öffentlich aushängen. Schafft die Lösung des

Barcelotuches, das das Abzukönnen, wenn sie da reinfasst? Oder, schaffst das nicht? Also das wäre erstmal eine Frage glaube ich, was man hygienisch klären müsste, ob das möglich wäre, wenn das draußen frei liegt, dann fassen alle rein. Von der Schwester über den Besuch, der Patient, vielleicht sogar unser Arzt, keine Ahnung, ich weiß es nicht.

➔ **13a.I: Wären es die Gründe, warum die Desinfektionstücher nicht bereits Teil des Patientenalltags sind?**

K07: Ich glaub ja. Also wir haben je nachdem, wenn wir einen Patienten haben, der durch zum Beispiel einen Apoplex schlecht essen kann, aber bei uns operiert werden muss, dann werden die bei uns so gut es geht mobilisiert. Das heißt, wir wissen vorher, kann der aufsitzen, kann der selbständig nur an der Bettkerne sitzen oder sitzt der im Bett. Wenn der zum Beispiel zwar noch selbstständig an der Bettkante sitzen kann, mit Hilfe oder mit Unterstützung durch so ein Mobilisationswürfel oder in wir haben so Mobilisationsstühle und kann sogar selber Essen, aber hat so einen Tremor, also so ein schütteln in der Hand, so ein wackeln in der Hand, dann weiß ich, dass er sich jedes Mal komplett einsaut. Das ist nicht schlimm, man nimmt ihm diese Selbständigkeit, diese Mobilität ja nicht, sondern, da bin ich jemand, dann liegt bei ihm am Bett am Fenstersims nebendran Päckchen Bacillol Tücher. Dann kann ich ihm auch mit diesen feuchten Tüchern, dass ich denen die Hände damit nachher abwische, also nicht im Gesicht, also nicht im Gesicht auf der Haut, aber dieses feuchte Tuch, das hat bei Kindern schon immer geholfen, dieses feuchte Desinfektionsmitteltuch nehme ich da dafür. Ich kann das Tuch wegschmeißen, nehme nochmal ein Tuch raus, mach meinen Mobilstuhl wieder sauber und trag sein Essen weg und bring ihn wieder ins Bett. Dann hab ich wieder eine saubere Ding, aber ich muss nicht rausspringen und muss 3-4 Tücher holen. Bei solchen Patienten hab ich es schon am Bett, bei anderen Patienten ist es in der Tat noch nicht am Bett, weil wir das bislang übernehmen.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K07: Da können wir anfangen, es mag jetzt witzig, mag sich jetzt witzig anhören, ist aber eigentlich wirklich der Fall, das würde anfangen bei: Bitte nicht essen, bitte nicht draus trinken bitte nur für Flächen benutzen. Dann nicht rauchen, nicht anzünden, nicht auskochen. Also wir haben hier echt spezielle Fälle. Wir haben auch Patienten, die sich die Schmerzpflaster von anderen Patienten auskochen, weil sie solche Junkies sind. Und sich daraus praktisch den Wirkstoff, den restlichen Wirkstoff ziehen, um sich den zu spritzen. Deswegen sage ich, das ist jetzt relativ breit gefächert und für meine Patienten lege ich da keine Hand ins Feuer, dass die das verstehen würden, sondern die würden das für alles Mögliche nehmen, die würden das zum Po abwischen nehmen, weil sie denken „Wow super Feuchttücher“, die würden das für alles nehmen. Das müsste wirklich jetzt mal nur für unseren Bereich bis ins Detail ausgehängt werden. Die Benutzung der Tücher, das heißt mal angenommen man würde das in so einen Handschuhspender mit reinpacken, als vierte Instanz, dann müsste da ganz klar dabei stehen, wie die zu handhaben sind, für

verschiedene Möbelstücke ein separates Tuch. Also nicht mit dem Tuch, was ich ein Tisch abgewischt hab, auch das Nachtkästchen abwischen. Nicht zum Verzehr geeignet, müsst ihr auf jeden Fall bei uns mit drauf stehen, nicht für die Körperhygiene müsste mit drauf stehen. Also all diese Dinge müssten ganz genau beschrieben sein. Ich spreche jetzt aber wirklich ganz speziell für unsere Station. Natürlich macht man keine fünf Zettel, sondern guckt dann, dass bei allen das Gleiche draufsteht.

→ 14a.I: Würden Sie es bei allen anderen Patienten auch einführen wollen oder nur bei denen, die keine Risiken hätten?

K07: Ich würde es dann bei allen einführen. Aber lediglich drauf hinweisen. Ich denk mit einem Hinweis, das ist unsere einzige Absicherung, die wir haben. Ich würde das den anderen Patienten nicht vorenthalten deswegen. Es sind nicht alle Patienten so, aber wir haben ja schon die buntesten Dinge erlebt. Deswegen, rein zur Absicherung unserer Klinik, würde ich es mit einem Hinweis versehen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel: Wir haben hier große Privatzimmer, das sind ganz neue Privatzimmer und der Standard an privat wird immer höher. Das bedeutet, jetzt kriegen die Snacks und Getränke in ihre Kühlschränke. Das mag ja ganz nett sein, aber Patienten, die bei uns auf der Allgemeinchirurgie operiert werden, befinden sich im Kostaufbau. Die dürfen gar nicht alles essen. Ja, das heißt, jetzt stelle ich das denen ins Zimmer, weil die Kassen das verlangen, ja, also die Kassen schreiben das vor, das muss der Standard sein, jetzt [sind wir in] der Beweisspflicht, dass ich meine Patienten alle darüber informiert habe, dass die daraus nichts essen dürfen aus diesen Kühlschränken. Die dürfen keine Cola trinken, die dürfen keinen Orangensaft trinken, weil das ätzt denen alles an dem OP Weg. Aber die Kassen schreiben es vor, weil sonst kriegt die Klinik ihre Gelder nicht. Ja, das bedeutet, ich bin in der Nachweispflicht zu sagen: „Mensch, wir haben euch da drüber informiert, dass ihr das nicht dürft, das heißt, wir haben uns jetzt extra Schilder machen lassen müssen für diese Kühlschränke, wo ganz genau draufsteht, dass sie nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt oder einer Pflegekraft sich an diesem Kühlschrank bedienen dürfen.“ Ja, und so müsste das dort auch sein. Es müsste so sein, dass ganz klar für alle gleich. Man kann auch einen verwirrten, aber fitten Dreiundsiebzigjährigen haben. Ja, es muss einfach beschrieben sein. Bitte nur für Flächen benutzen, bitte nicht für Körperhygiene. Solche Sachen müssen glaube ich zur Absicherung der Klinik ganz genau beschrieben sein. Man muss einfach gucken, dass man so viel wie möglich in eins packt. Eine Hinweis beziehungsweise einfach, das klingt jetzt blöd, eine Bedienungsanleitung für die Tücher gibt, wo genau diese Hinweise drauf stehen, für was die sind und wie sie zu handhaben sind. Dann würde ich natürlich auch bei unseren Patienten einführen, weil ich hätte eine Absicherung durch diesen Hinweis.

15.I: Welche sonstigen Hygienemaßnahmen neben Desinfektionsmittel für die Hände und Masken würden Sie in den Patientenalltag integrieren und wo?

K07: Also ich wäre dafür, dass die 3 mal am Tag Hände waschen müssen gehen, weil die einfach auch draußen sind. Aber das ist nicht kompatibel. Ich kann ja niemand meine

Meinung aufzwingen, weil unsere, zum Beispiel gerne beim Rauchen sind, wir viele Ableitungen am Körper haben, unsere Patienten, die hier zum Beispiel einen AP, also einen künstlichen Darmausgang kriegen, die angelernt werden, das selber zu handhaben, also selber da damit umzugehen die Platte zu erneuern und sowas. Ich glaub schon, dass unsere Kollegin, die die anleitet in diesen Fragen sie darauf hinweist, immer wieder. Aber manchmal denke ich, Mensch, wenn ihr 2-3 mal mehr am Tag Hände waschen gehen würdet, würde euch das nicht schaden. Aber was ich jetzt speziell an Hygienemaßnahmen.. ich würde eine Duschpflicht glaub aufrufen, aber das geht auch nicht, weil unsere Patienten gar nicht duschen dürfen zeitweise aufgrund der Operation. Ich muss wieder auf unsere [Patienten] kommen. Unsere [Patienten] halten nix von Körperpflege, also die wenigsten halten was von Körperpflege. Das ist mittlerweile so, da weisen die Schwestern darauf hin, und da gibt es wenig Diskussionsspielraum für uns, wenn die bei uns sind. Die dürfen sich zu Hause gerne verhalten, wie sie wollen, aber hier sind Sie im Zimmer mit Mitpatienten und der Mitpatient muss in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal den Gestank ertragen. Das geht nicht, also gegen das Rauchen können wir nichts machen, wenn die dann hochkommen und ihre Klamotten riechen nach Rauch, da können wir nichts dagegen tun, aber gegen Körperhygiene können wir was tun, und zwar wir scheuchen die morgens raus und wir haben Pflegeassistentinnen bei uns auf Station, die sich darum kümmern und die gehen rein und sagen: „Hey Herr Müller, jetzt wird aufgestanden, wir waschen sie jetzt oder sie waschen sich jetzt“ Vielleicht kann man ja auch manche duschen, aber die wenigsten. Aber flächenhygienisch oder keine Ahnung, da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, ob man jedem so eine kleine Flasche Händedesinfektionsmittel austeilt. Ja, da wäre vielleicht auch schon ein kleiner Fortschritt dabei. Dass jeder Patient, was sind denn das glaub 100 Milliliter, diese kleine Fläschchen von Hartmann von Sterilium, dass jeder Patient irgendwie, was weiß ich sowas kriegen würde. Sprengt natürlich auch den preislichen Rahmen und so viel zum Thema bei Noro schon gar nicht. Also bei Noro geht nur [ein anderes Produkt]. Das sind so Sachen, aber eine richtige Lösung jetzt, was ich wohl sagen würde, Mensch, das wäre toll, wenn man das hier einführen könnten, dass jeder Patient dreimal am Tag Hände waschen muss. Wir können niemand die Meinung aufzwingen und wir können niemand sagen, du musst jetzt, du bist jetzt im Klinikum Heidenheim und hier wird dreimal am Tag gewaschen. Können wir nicht machen.

Mitarbeiter im Klinikum Heidenheim Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Interviewpartner Klinikum (K): K08

Am 19.03.2024

9.I: Warum sollten sich Patienten Ihrer Meinung nach sich an Flächenhygiene beteiligen?

K08: Also im Grunde gibt es natürlich so eine Ebene, wo ich denke: Patientin war krank, aber sollten natürlich trotzdem weiterhin sich für sich selbst verantwortlich fühlen. Das Krankenhaussystem in Deutschland arbeitet oft damit, dass den Patienten alles abgenommen wird, auch die Verantwortung. Aber das ist meiner Ansicht nach nicht richtig. Sondern im Prinzip sollten Menschen immer, auch kranke Menschen verdienen, für sich selber verantwortlich sein. Dazu gehört natürlich auch, dass es sich um die Problematik von Hygiene, Umgebungshygiene Gedanken machen. Deshalb finde ich es gut, dass dir zum Beispiel in der Klinik auch angeleitet werden, um dann bestimmte Dinge halt im häuslichen Alltag auch weitermachen zu können. Also ich denke, das ist einfach gut so. Das zweite ist natürlich, dass im Grunde Patientin auch so ein bisschen aufpassen, spüren können, weil natürlich viele Teams um den Patienten rum sind, Pflege Teams und so weiter und im Druck des Alltagsgeschehens manchmal Hygiene-Fragen so ein bisschen nach hinten rutschen und zwar jeder weiß, dass man hygienisch arbeiten sollte, das aber oft aus vermeintlichen Zeitgründen nicht so gemacht wird und, dass der Patient auch so ein bisschen mit drauf gucken kann. Ist das denn eigentlich überhaupt in Ordnung, wie ich hier versorgt werde?

→ **9a.I: Steht es auch im Interesse des medizinischen Personals, dass sich Patienten an der Hygieneerhaltung beteiligen?**

K08: Unbedingt, aus ähnlichen Gründen. Ich glaub Medizin, gesund werden, gesund bleiben ist immer Teamaufgabe. Es kann nicht nur die Pflege, nicht nur der Patient alleine gucken, sondern im Grunde würden die besten Erfolge eben dann erzielt, wenn man es gemeinsam macht.

→ **9b.I: Sie haben vorhin gemeint, Patienten werden angeleitet. Wie sieht es hier im Klinikum Heidenheim aus, werden die Patienten aufgeklärt, wie sie zu handeln haben, was sie tun müssen, was sie beachten müssen?**

K08: Also da muss ich tatsächlich ein Stück weit passen. Es ist zumindest in den ärztlichen Aufgaben, glaube ich, nicht drin oder zumindest sehr unterrepräsentiert. Sondern ich glaube tatsächlich, so die Anleitung wie bediene ich mein Nachtschränkchen? Worauf muss ich beim Toilettengang und beim Waschbecken achten? Das ist doch sehr in der Hand der Pflege, wo wir natürlich schon gucken, und das ist, glaube ich, schon auch so ein kleiner, aber wichtiger Part ist natürlich Vorbildfunktion. Dass natürlich vor und nach Kontakt mit dem Patienten schon auch. demonstrativ eben, zumindest auf Händehygiene, geachtet wird. Aber eine direkte Anleitung durch Ärzte, so nicht bekannt.

→ **9c.I: Welchen Nutzen und Vorteil hätten die Patienten oder das Personal davon?**

K08: Es gibt erstmal aus Patientensicht den direkten Nutzen. Wenn natürlich meine Umgebung mit weniger Keim besiedelt ist, dann hab ich vielleicht ein geringeres Risiko, dass ich natürlich an mir eine Infektion zuziehe. Der indirekte Nutzen ist natürlich, dass eine Klinik insgesamt ein Hort ist für viele und für multiresistente Keime. Und je mehr eben alle Beteiligten an Krankenhausbehandlungen darauf achten, dass eben hygienisch gearbeitet wird, desto geringere ist die Keimlast im Krankenhaus, sodass ich natürlich auch für

nachfolgende Patienten eigentlich etwas Gutes tue, wenn ich im Prinzip auf Umgebungshygiene achte.

10.I: In welchen Bereichen oder auf welchen Flächen im Krankenhaus könnten Patienten am effektivsten und hygienisch sinnvollsten aktiv an der Flächenhygiene teilnehmen?

K08: Also das eine ist natürlich der Klassiker, das ist so der Bereich Körperhygiene, Toilette, dass man da einfach guckt, dass vor allem nach dem Toilettengang die Toilette sauber hinterlassen wird und das natürlich beim Verlassen des Toilettenbereichs natürlich auch die Hände noch mal auf jeden Fall gründlich behandelt werden. Das zweite sind natürlich häufig genutzte Oberflächen wie Türklinken. Wenn ich natürlich im Grunde durch ein Krankenhaus durchziehe, immer mal wieder Klinken benutze, sollte ich gucken, dass wenn ich sag mal was in meinem eigenen Bereich zurückkomme, also mein eigenes Bett, dass ich dann auf jeden Fall meine Hände desinfiziere. Andersrum sollte natürlich auch von den Putzdiensten danach geguckt werden, dass Handläufe im Treppenhaus, Türklinken, also diese Flächen, die häufig einfach berührt werden, dass die auch regelmäßig halt gereinigt werden. Ich glaube ansonsten, wenn tatsächlich so konkrete Maßnahmen, wie jetzt irgendwie Verbands Wechsel, Katheter Wechsel und so weiter, da ist glaube ich, die Awareness relativ hoch und, dass ich denke, da ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es sind eher so die Alltags Flächen. Geschirr, Essenswagen, Toiletten, öffentliche Bereiche, Handlauf, Türklinken, wo tatsächlich glaub ich irgendwie ein hohes Potential wäre, dass man da drauf guckt.

→ 10a.I: Wäre dann die Beteiligung der Patienten eher eine zusätzliche Maßnahme oder wäre damit die Reinigung und die Pflege auch entlastet?

K08: Also im Prinzip sind ja Patienten im Krankenhaus nicht durchgängig dafür verantwortlich. Wir haben viele ältere, vergessliche Menschen, zum Teil demente Patienten, wo man solche Tätigkeit natürlich nicht gut delegieren kann, wenn man sich Menschen, die vielleicht auch von ihrem biografischen Hintergrund her bei Hygiene eben als nachrangig einordnen und nur weil ich die Ermuntere wird sich da jetzt nicht sofort alles dran ändern, sondern die würden deshalb vielleicht nur kurz oder nur unvollständig oder oberflächlich machen. Sodass ich denke, ich würde schon meinen, dass es sinnvoll ist, den Patienten einzubeziehen, aber sich darauf zu verlassen, dass Patienten wirklich bestimmte Bereiche verantwortlich übernehmen, das ging immer zu weit.

→ 10b.I: Welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten hätten Patienten, sich daran zu beteiligen?

K08: Na gut, das ist ja ähnlich so wie beim Rauchen. Du weißt, dass Rauchen nicht gesund ist. Trotzdem rauchen viele. So wissen eigentlich auch im Grunde alle, dass eben gewisse Hygiene einfach natürlich wichtig ist zur Gesunderhaltung, nicht nur von einem selbst, sondern auch von seiner Umgebung. Und obwohl das eben alle wissen, wird es eben doch sehr inkonsequent gemacht. Im Prinzip die Überzeugung zu erreichen, nur, weil jemand im Krankenhaus ist, dann zuvor nicht ging, das Verhalten durchzuführen. Sehr, sehr schwierig. Das funktioniert vielleicht dann, wenn natürlich im Prinzip einzelne Menschen sehen, dass

alle anderen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und das ist vielleicht ein positiver Drücker, positiver Stimulanz, dass dann halt auch so machen. Aber tatsächlich habe ich natürlich auch wenig Handhabe und Menschen dort zu zwingen, was zu tun, wo keine Einsicht da ist. Also ich denke die Einsicht zu erreichen, ist tatsächlich gar nicht so einfach.

11.I: Wie schätzen Sie das Produkt Bacillol 30 Sensitive Tissue ein?

K08: Also ich habe es benutzt, natürlich unterschiedlich häufig. Wie wir alle, habe ich natürlich während der Corona Zeit bestimmte Dinge häufiger getan. Wie schätze ich es ein? Also es war damals relativ praktisch irgendwie, man konnte tatsächlich, da habe ich es so wieder angesetzt, eben in der Ambulanzsprechstunde dann halt zwischen den Patienten mal Oberflächen, wie eben die Tischplatte bei einem Patient, der da sitzt und spricht, ist natürlich die Tischplatte im Kopf, wo dann auch Tröpfchen eben Land am Tisch waren, Tischklappen, aber auch Stuhllehnen oder so Griffe von Stühlen und so weiter wurden regelmäßig abgewischt. Das hat ganz gut funktioniert.

→ 11a.I: Was würden Sie an dem Produkt ändern oder verbessern?

K08: Wo grundsätzlichen der Fokus drauf liegt, das hat jetzt mit Hartmann speziell nichts zu tun, ist das wirklich die, das die Krankenhausmedizin und Hygiene natürlich Müllberge ohne Ende eben produziert. Ein Produkt, welches ich sag mal, möglichst wenig umweltbelastend wäre vom Herstellungsprozess bis hin zum Entsorgungsprozess wäre für mich ein wichtiges Kriterium. Also neben der Wirksamkeit, wäre eben halt die Umweltbelastung für mich der entscheidende Faktor.

12.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

K08: Wie gesagt, wie ganz eingangs, wenn schon jemand, der schon sehr dran glaubt, dass der Prozess, das man gesund wird viel damit zu tun hat, dass der Patient Möglichkeiten hat, sich selbst zu beteiligen, sich selbst als Teil eben eines Behandlungsteams, eines Behandlungsprozesses sieht. Zumindest auf Angebotsebene sagen, mit weiteren Informationen, dass es die Möglichkeit gibt, eine Anleitung was er tun könnte, fände ich wichtig. Ich glaube, da Zwang und Druck auszuüben, das wäre tatsächlich nicht erfolgt.

→ 12a.I :Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissue“ in den Alltag des Patienten integrieren?

K08: Das ist schwierig, weil ich da einfach im Prinzip keine so ganz detaillierte Kenntnisse drüber habe. Also ich denke schon, dass es vor allem, sagen wir mal der wirklich unmittelbare Bezug, also wenn der Mensch eben am Waschbecken steht oder die Toilette benutzt oder verlässt oder eben das Nachtschränkchen, wo ja alles Mögliche drauf steht, aber auch eben Essen angerichtet wird. Das sind so die Bereiche, die mir vor allem einfallen würden.

13.I: Welche Herausforderungen oder Risiken könnten Patienten bei der Benutzung dieses Produktes haben?

K08: Gut, man muss natürlich drauf achten, dass die Hautverträglichkeit gegeben ist, ob Menschen vielleicht krankheitsbedingt auch Läsionen haben, wo dann im Prinzip auch das nicht zuträglich wäre, dass es halt reizend wäre auf bestellte Hautveränderungen. Man muss bei Menschen, die eben halt dement sind drauf achten, dass es nicht missbräuchlich eingesetzt wird, dass sie das eben nicht verwechseln. Und eben schon ein bisschen auf die Umwelt natürlich darauf achten, dass es eben, sagen wir mal, gezielt und nicht eben zum häufiger eingesetzt wird. Dass nicht irgendwie quasi, alle Viertelstunde irgendwie im Bereich irgendwie abgewischt wird, so mal extrem zu sagen, sondern dass es wirklich bei gezielten und auch sinnvollen Maßnahmen bleibt.

14.I: Welche Anweisungen sollten Patienten bei der Benutzung des Desinfektionstücher beachten?

K08: Ich glaub schon, man muss es einfach erklären wofür es gut ist und wozu auch nicht. Das es jetzt was weiß ich nicht, zum Beispiel benutzt wird um den Intimbereich zu säubern. Da könnte man draufgehen, es gibt ja im Prinzip so Intimreinigungstücher, die auch ganz ähnlich aussehen. Also da muss man natürlich klar darauf hinweisen, dafür ist es gut, aber dafür ist es auch nicht gut. Man muss auch klären irgendwie, wie es benutzt wird, dass es halt im Prinzip nicht aus der Originalverpackung rausgenommen wird und dann erstmal 2 Stunden irgendwie an der Luft trocknet, sondern dass es quasi nur direkt vor Benutzung eben entnommen wird und das ist halt im Prinzip danach auch korrekt entsorgt wird. Also das muss glaub ich schon da erklärt werden, weil die wenigsten Menschen in ihrem heutigen Alltag üblicherweise mit solchen Desinfektionstüchern arbeiten. Das glaube ich schon ein kleiner Aufwand oder ein kleiner Flyer mit irgendwelchen Piktogramme, aber da muss schon ein klarer Hinweis: Was ist gewollt und was ist nicht möglich.

➔ 14a.I: Auf welche Art und Weise würden Sie die Tücher integrieren?

K08: Ist ja immer das Problem, dass ich keine Kontrolle drüber hab, wie die Menschen den Spender anfassen. Und da gibt's ja im Prinzip auch, sagen wir mal, ganz gute Beispiele, dass man das im Prinzip sag mal diese ganzen Dinge, wo dann hygienische Flüssigkeiten rauskommen selber halt kontaminiert sind, weil sie mit sehr verschmutzten oder kontaminierten Händen berührt werden. Insofern wäre für mich da, glaube ich, schon der Punkt, dass ich sage, OK, man müsse sich überlegen, was wäre eine geeignete Packungsgröße für einen typischen Klinikaufenthaltsdauer und dann wäre aber schon meine Idee, dass tatsächlich die Patienten selber so eine Box personalisiert für sich vor Ort hätten. Genau, also ich würde das schon eher personalisieren und ist im Prinzip natürlich die Idee, dass ich dann mein kleines Päckchen mitnehme und wieder mit Zurücknehme, dass das quasi, sagen wir mal, ein Begleiter wird. Aber das ist schon schwierig, weil öffentliche Dinge,

die sind häufig oben im Eingriffsbereich, wo ich halt berühre, kontaminiert. Man hat wirklich keine Kontrolle drüber, wer da was reinsteckt oder rausnimmt oder wie denn im Prinzip die Packung an sich kontaminiert ist. Und deshalb fände ich das tatsächlich nicht gut.

15.I: Vielen Dank. Dann war es das eigentlich auch schon mit meinen Fragen. Gibt es von ihnen aus weitere wichtige Punkte, die Sie gerne ansprechen würden, hinzufügen möchten?

K08: Ich glaube, dass natürlich, wenn die Idee sich festsetzt, dass tatsächlich eine Anleitung ein Stück weit eine Ermächtigung von Patienten zu hygienischen Verhalten gelingt, dass man natürlich dann tatsächlich auch überlegen müsste, wie könnte denn ein Patient in einer angemessenen Form hygienische Mangelzustände in den Bereich zurückmelden. Also wenn zum Beispiel beobachtet wird, dass der Boden nicht richtig gewischt wird, wenn man feststellt, dass Schränke eben im Prinzip beim Bezug des Zimmers eben nicht, wie soll ich sagen, hygienisch erscheinen. Wenn man feststellt, dass eben der Nassbereich in der Toilette halt irgendwo nicht korrekt sind gereinigt erscheint, dass da halt im Prinzip, sagen wir mal das Menschen auch zurückmelden können, ohne dass sie das Gefühl haben, sie verraten oder diffamieren jemand, weil das ist immer so der Hemmschwelle, man will ja niemand weiß Böses und trotzdem wäre es eben gut, wenn Hygieneverstöße im weiteren Sinn auch in den Systemen rückgemeldet werden können. Weil natürlich aus Fehlern und Fehlverhalten man im Grunde, glaube ich, relativ viel auch lernen kann, wie man es besser machen kann. Wenn es gelingt, tatsächlich, sagen wir mal, Patienten ebenso ein Bewusstsein zu schaffen, dann würde ich sagen, mein nächster Schritt, wie können die im Prinzip Hygienefehler tatsächlich auch Rückmelden, ohne jetzt Angst zu haben: „ich bin eine Petzte, ich würde danach von der Schwester nicht mehr behandelt“. Das sind reale Ängste. Also viele Patienten bemerken tatsächlich einiges in ihrem Alltag und melden es nicht, weil sie dann für sich eben Behandlungsnachteile fürchten. Also das ist tatsächlich nicht banal, sondern das müsste dann tatsächlich mehr oder weniger über irgendwie so eine Art anonymisierte Meldeportal oder oder oder geschehen. Aber von einem Patient zu erwarten, dass er praktisch ein Hygieneverstöß von der Pflegekraft meldet, das wird nicht funktionieren, das werden die wenigsten tun.

→ Nachfrage I: Werden Patienten dazu ermuntert auf die Feedbackmöglichkeit zuzugreifen?

K08: Also das ist Teil des Problems. In Deutschland gibt es, glaube ich, eine nicht sehr günstige Kritikkultur. Ich hab zum Beispiel [im Ausland] gearbeitet, das ist ganz anders. Da wird Kritik immer als etwas verstanden, was dabei hilft, zukünftige Fehler zu vermeiden und sein Tun zu verbessern. In Deutschland ist es leider so, dass Kritik ja fast immer als was wahrgenommen wird, was die kritisierte Person eigentlich, sagen wir mal in der Wertschätzung verringert, und das ist ja aber immer nicht so, aber das ist tatsächlich so, dass Kritik in Deutschland relativ negativ konnotiert ist und schon daran deshalb selten geäußert wird. Und wenn natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis Patient-Pflege oder Patient-Arzt ist total schwierig Kritik zu äußern. Dieses Rückmeldesystem ist tatsächlich ein Stück weit unterentwickelt, die

Idealvorstellung ist natürlich schon, dass im Prinzip der Patient diese Kritikbögen nicht holen muss, sondern proaktiv ausgeteilt bekommt. So ist es eigentlich gedacht, auch mit einer kleinen Erklärung, wie damit umzugehen ist und natürlich auch mit dem Hinweis, dass natürlich, weil eben anonymisiert diese Kritik geäußert wird, da muss man ja nicht unterschreiben, wer man ist, da eigentlich auch keine Scheu davor bestehen sollte, wirklich Kritik zu üben. Die Erfahrung aus dem Alltag ist aber tatsächlich so, wie ihn von ihnen auch antizipiert, dass das extrem wenig genutzt wird und ganz, ganz viele Punkte in der Kritik seit vielen Jahren sich eigentlich immer über zwei Dinge drehen. Das ist einmal der Zimmerkomfort und das andere ist das Essen. Das Essen ist ein Dauerbrenner. Da gibt es ganz viel Rückmeldung und deshalb kommen wir noch mal an einen Punkt zurück. Ich glaube, bevor wir nicht eine gewisse Awareness bezüglich Hygiene geschaffen haben, bevor der Patient auch nicht zumindest eine grobe Vorstellung davon hat, was hier der Standard ist, kann er zu dem Bereich auch gar nicht kritisieren. Das ist sehr individuell. Der eine ist sehr reinlich, dem fällt alles auf, der andere ist zu Hause eine alte Sau, Entschuldigung, und der denkt natürlich, hier ist alles übertrieben. Das heißt bevor ich nicht irgendwo ein gewissen Standard habe, der heißt irgendwie dieses Zimmer wird täglich einmal gereinigt und danach sollte es so und so aussehen, kann ich natürlich auch im Grunde gar nicht irgendwelche Kritiken vernünftig äußern. Also da muss erstmal der Standard, die Awareness und dann vielleicht auch der Punkt, das wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, dass man so einen Fragebogen Hygiene auch nicht nur allgemein unterbringt, sondern an einem definierten Punkt auch abfragt.

Patienteninterviews

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C4_01

Weiblich, 54 Jahre, teilt sich Zimmer mit anderen Patienten

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P C4_01: neutral bis wichtig; Naja, ich finde halt dass jeder darauf achten sollte, dass man die Umwelt sauber hält, auch für die andern Mitmenschen...mit Erkrankungen oder Viren, dass man sich möglich nicht ansteckt und die Sachen sauber hält.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P C4_01: Selten, höchstens wenn ich ins Pflegeheim gehe zu meiner Mutter, da desinfiziere ich mir die Hände

➔ I: Aus welchen Gründen benutzen Sie es nur im Pflegeheim?

P C4_01: Naja weil Zuhause eigentlich alles sauber ist und nicht mit Viren in kontakt kommt. Vielleicht noch wenn ich zum einkaufen gehe und nach Hause komme, also nach dem Einkaufswagen.

- ➔ I: Und im Pflegeheim benutzen Sie da Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?
- ➔ P C4_01: Desinfektionsmittelspender

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P C4_01: Wichtig. Es gibt ja Viren und Menschen, die mit Krankheiten in Berührung sind, Erkältung, Schnupfen Corona und was es noch so alles gibt. Dass man sich dann selber sicher fühlen kann und alles sauber ist, z.B. Gläser.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P C4_01: Ich habe da wenig Bedenken.

- ➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?
P C4_01: Also wenn da jetzt einer reinkommen würde, der die ganze Zeit nießt, dann hätte ich Bedenken, aber momentan kann ich mich nicht beschweren.
- ➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?
P C4_01: Nein, mir ist nichts aufgefallen. Es ist alles sauber und es wird alles geputzt.
- ➔ I: Sie teilen sich im Moment den Raum. Leiten Sie beim Teilen eines gemeinsamen Raumes mit anderen Patienten oder bei Besuch Hygienemaßnahmen ein?
P C4_01: Wir machen halt öfters die Tür auf zum Lüften. Sonst, wenn halt einer kommt, dass er sich die Hände desinfiziert. Ich hatte aber jetzt wenig Besuch.
- ➔ I: Wie schätzen Sie den Umgang mit Hygiene des Zimmerpartners ein?
P C4_01: Es ist alles ok mit den Damen. Mir ist da nichts aufgefallen.
- ➔ I: Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Umgang mit Hygiene seitens der Mitpatienten vorstellen?
P C4_01: Naja, dass er das Bad sauber hält und sich ab und zu die Hände desinfiziert.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C4_01: Sehr wichtig. Ich finde schon, dass man es einhalten sollte, vor allem bei sterilen Sachen bei irgendwelchen Eingriffen wie Nadeln, da muss man schon sicher sein, dass es steril gemacht wird.

➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P C4_01: Nein, es gab keine Vorgaben.

➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C4_01: Wenn ich von draußen komme, dass ich mir mal die Hände desinfiziere aber jetzt auch nicht stündlich.

➔ I: Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus?

P C4_01: Beruht auf Eigeninitiative

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C4_01: Zufrieden – Sehr zufrieden. Mir gefällt es, dass es hier all diese Desinfektionsmöglichkeiten gibt. Die Handschuhe sind da. So ist alles sauber würde ich sagen.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C4_01: Nein, eigentlich nicht. Ich gehe davon aus, dass die [Besucher] selber drauf schauen, dass sie sich die Hände desinfizieren, wenn sie unten reinlaufen oder wenn sie Schnupfen hätten, dass Sie sich eine Maske aufsetzen, das wäre auf jeden Fall klar. War aber bis jetzt nicht der Fall.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C4_01: Ich wüsste jetzt nicht für was. Zum Beispiel (schaut sich im Raum um), hmm was könnte ich desinfizieren.

➔ I: Was wäre mit den Flächen in Ihrer Nähe? Ihr Tisch, Ihr Bett, die Sanitäreanlage oder der Griff der über Ihnen hängt?

P C4_01: Vielleicht das Licht? Aber die [Mitarbeiter] machen ja eigentlich jeden Tag sauber. Sie putzen einmal am Tag den Tisch ab und das ganze Bad. Alles andere ist ja schon desinfiziert. Vielleicht den Bildschirm?

➔ I: Sie teilen sich ja ein Zimmer mit anderen Patienten. Wie ist Ihre Meinung zur Sanitäreanlage? Meistens ist ja nicht bekannt, welche Erreger oder Krankheiten der Mitpatient hat und man teilt sich dabei das Bad.

P C4_01: Also als einzige was mir einfallen würde, wäre die Klobrille ab und zu zu putzen. Dass man da ein paar Mal rumfährt oder am Waschbecken vielleicht. Aber Klobrille wäre am wichtigsten.

➔ I: Das heißt, wenn Desinfektionstücher in den Sanitäranlagen ausliegen würden, würden Sie auf dieses Angebot zurückgreifen?

P C4_01: Ja, ich denke schon.

➔ **Frage 9 somit auch beantwortet**

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäranlage die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C4_01: Ja klar, das ist nicht auszuschließen. Ich meine, auch an öffentlichen Orten weiß man nicht wer vorher dran war. Aber da finde ich es hier [im Krankenhaus] hygienischer.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C4_01: Ja schon. Pflaster, Verbände oder was man halt so braucht. Auch Desinfektionsmittel. Ich war damit auch immer zufrieden.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher z.B. im Badezimmer zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C4_01: Also ich würde sagen im Bad wäre es sinnvoll, dass man Desinfektionstücher auslegt, dass man da kurz rumputzen kann wenn andere drin waren. Klar, es wird einmal am Tag geputzt, aber ich glaube es wäre sinnvoll.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C4_02

Männlich, 64 Jahre, teilt sich das Zimmer mit anderen Patienten

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P C4_02: Sehr wichtig. Im Krankenhaus, wegen Krankheitsverbreitung. Ordnung gehört zum Mensch ist und wichtig. Man muss nicht übertreiben, aber im Krankenhaus ist es sehr, sehr wichtig.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P C4_02: Selten. Ich benutze sie oft, wenn ich etwas berühre von dem ich denke, das es Bakterien hat. Ich benutze ein Desinfektionsspray, das habe ich im Auto.

- ➔ I: In welchen Situationen würden Sie die Desinfektionstücher bevorzugt nutzen?
P C4_02: Vielleicht für das Lenkrad im Auto.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P C4_02: Sehr wichtig (Antwort bereits bei Frage 1 gegeben)

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P C4_02: Ich habe da wenig Bedenken. Ich mache mir keine Sorgen und habe keine Angst. Aus meiner Sicht ist alles tip top.

- ➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?
P C4_02: Nein.
- ➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?
P C4_02: Nein, es ist alles bestens.
- ➔ I: Wie schätzen Sie den Umgang mit Hygiene des Zimmerpartners ein?
P C4_02: Das ist eine schwere Frage. Das weiß ich nicht.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C4_02: 5 Sehr wichtig Logisch, sehr wichtig.

- ➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?
P C4_02: Ich gehe oft raus aus dem Zimmer.
- ➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?
P C4_02: Nein, keine.
- ➔ I: Auf welche Art und Weise schützen Sie sich?
P C4_02: Vor dem Essen, wasche und desinfiziere ich meine Hände.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C4_02: Sehr zufrieden. Ich habe zwar meine eigene Sachen, aber es gibt hier auch alles im Krankenhaus.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C4_02: Wenn ich weiß, dass sie momentan keine ansteckenden Krankheiten haben und ich auch nicht ansteckend bin dann mache ich nichts zusätzliches.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C4_02: Keine Ahnung. Für mich persönlich bräuchte ich es nicht.

➔ Nachfrage I: Stellen Sie sich vor Ihr Mitpatient benutzt die Sanitäranlage. Wie würden Sie es finden wenn zusätzlich Desinfektionstücher ausliegen würden, damit man noch selber darüberwischen kann.

P C4_02: Das ist eine gute Frage und schwere Frage. Ich weiß nicht wie es die anderen machen. Ich persönlich mache es immer vor der Nutzung und nach der Nutzung. Dann fände ich Desinfektionstücher nicht schlecht.

Frage 9 beantwortet.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäranlage die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C4_02: Also hier im Zimmer habe ich keine Angst.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C4_02: Ja, ich habe schon mal Verbände gekauft.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher z.B. im Badezimmer zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C4_02: Warum nicht. Wenn es sie gibt könnte ich sie benutzen. Aber ich habe mir noch nie Gedanken gemacht.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C4_03

Weiblich, 55 Jahre, teilt sich Zimmer mit anderen Patienten

I: 1. **Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?**

P C4_03: Sehr wichtig: Sehr wichtig, weil ich persönlich sehr viel Wert darauf lege. Mein Ekelfaktor ist da nicht sehr tolerant. Ich habe immer Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel, z.B. wenn ich eine öffentliche Toilette nutzen muss, damit ich mich selber wohl fühle.

I: 2. **Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?**

P C4_03: Häufig. Auf Öffentliche Toiletten, oder in Hotels. Ich benutze gerne Desinfektionsmittel und Tücher.

I: 3. **Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?**

P C4_03: Sehr wichtig. Wegen dem Gesundheitsfaktor, Wohlfühlfaktor, einfach dass man Gesund werden kann ohne das Keime entstehen und da ist Hygiene sehr wichtig.

I: 4. **Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?**

P C4_03: Da habe ich wenig Bedenken.

➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?

P C4_03: Nein eigentlich nicht.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?

P C4_03: Seit zwei Tagen zum Beispiel, liegt eine Tablette auf dem Boden und keiner fegt die weg. Ich habe es aber nicht angemerkt, weil ich wissen will wie lange die noch liegen bleibt. Und im Bad der Lüfter. Ich weiß nicht was da dran hängt aber es ist voll mit irgendwas.

➔ I: Wie schätzen Sie den Umgang mit Hygiene des Zimmerpartners ein?

P C4_03: Nicht so hoch wie meine. Sie betreiben Körperhygiene, aber sie waschen sich nicht die Hände nach dem Toilettengang, das hört man einfach, wenn man spült und sofort rausgeht.

- ➔ I: Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Umgang mit Hygiene seitens der Mitpatienten vorstellen?

P C4_03: Darauf achten, wenn etwas runterfällt es aufhebt, nach dem Toilettengang sich die Hände waschen. Selber mal ein Desinfektionstuch nehmen, die liegen ja aus, und selber seinen Tisch abwischen wenn man kleckert. Die Desinfektionstücher lagen schon im Patientenzimmer aus.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C4_03: Sehr wichtig

- ➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C4_03: Viel lüften, Hände waschen und desinfizieren, Flächen desinfizieren, den Tisch abwischen nach dem Essen, meine Nachtschränken abwischen. Alles was in meinen Möglichkeiten steht.

- ➔ I: Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus?

P C4_03: Es beruht alles auf Eigeninitiative.

- ➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P C4_03: Nein, keine.

- ➔ I: Welche Faktoren beeinflussen die Eigeninitiative?

P C4_03: Mein persönlicher Anspruch

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C4_03: Zufrieden, weil alles ausliegt, weil die Desinfektionsmittel aufgefüllt werden und dort hängen. Ansonsten muss jeder selber mitarbeiten.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C4_03: Desinfizieren ganz normal. Ich nehme meinen Besuch nicht mit ins Zimmer. Wenn ich wüsste, dass jemand eine Erkältung hat, dann würde ich sagen man trifft sich im Foyer. Ich mit Mundschutz, die Person mit Mundschutz. Aber das ist momentan nicht der Fall.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden? (Es wurde genannt, dass Desinfektionstücher im Patientenzimmer bereits ausliegen.)

P C4_03: Ich benutze die Tücher für das Nachtschränken, Esstisch und die Toilettenbrille. Im Bad nur bevor ich mich draufsetze.

I: 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen?

P C4_03: Ich glaube, es ist im Patientenzimmer ausreichend.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreinrichtung die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C4_03: Ja es ist mir bewusst.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C4_03: Im großen und ganzen ja, aber nicht alle. Als die Kinder klein waren hatte ich ihre Windeln ansonsten nichts mehr.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C4_03: Ja ich würde mich beteiligen.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C6_04

Männlich, 73 Jahre, teilt sich Zimmer mit anderen Patienten

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P C6_04: Sehr wichtig. In Heidenheim ist es zu wenig. Man weiß nicht wo man hingehen soll. Da ist alles verschmutzt. Da liegen überall Leute rum. Es liegt überall Abfall, obwohl ein Papierkorb da ist.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P C6_04: 4 Häufig. Hauptsächlich für die Hände.

➔ I: Welche und in welchen Situationen?

P C6_04: Wenn ich vom Klo komme, oder wenn ich zum Essen gehe, eventuell nach dem Hände waschen noch oder vorher je nachdem.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P C6_04: Sehr wichtig. Im Krankenhaus gibt es so viele Keime. Das man sich nicht anstecken kann oder die Ansteckung verbreiten kann.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P C6_04: Keine Bedenken. Aber ich war vor zwei Jahren auch hier während der Coronazeit mit anderen Beschwerden, da wurde nichts gemacht. Ich habe mir eine Infektion eingeholt. Jetzt ist aber alles in Ordnung.

➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?

P C6_04: Kann alles sein, ist alles möglich. Ich habe mir im Krankenhaus Keime abgeholt. Ich musste Arzneien abnehmen und hat dann lang gedauert. Ist aber wahrscheinlich zu vermeiden.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?

P C6_04: Hier ist überall Personal da die reinigen und so. Da wird jeden Tag das Zimmer geputzt. WC und alles in Ordnung gebracht.

➔ I: Leiten Sie beim Teilen eines gemeinsamen Raumes mit anderen Patienten oder bei Besuch Hygienemaßnahmen ein?

P C6_04: Andere Leute, da will ich nicht reinreden und keine Schwierigkeiten bekommen. Ich mische mich da nicht ein. Aber ich selber desinfiziere mir die Hände.

➔ I: Wie schätzen Sie den Umgang mit Hygiene des Zimmerpartners ein?

P C6_04: Ich sag das so: Mich geht das eigentlich nichts an.

➔ I: Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Umgang mit Hygiene seitens der Mitpatienten vorstellen?

P C6_04: Das sie das einhalten, was Vorschrift ist oder was man machen sollte.
[Keine Spezifikation]

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_04: Wichtig.

➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_04: Ich achte persönlich auf Hygiene und Hände desinfiziere ich auch.

➔ I: Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus?

P C6_04: Das wird vom Krankenhaus gesagt. Es hängen ja die ganzen Apparate aus, die ganze Flüssigkeiten sind vorhanden, wenn man zur Tür raus ist. Aber die machen keine Vorschriften.

➔ I: Welche Faktoren beeinflussen die Eigeninitiative?

P C6_04: Es ist eigentlich normal und selbstverständlich.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C6_04: Zufrieden Ja schon zufrieden.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C6_04: Maske tragen verlange ich nicht, aber die meisten Besucher desinfizieren sich die Hände. Was soll ich da machen? Ich kann da keine Antwort geben.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C6_04: Das habe ich noch nie getan, außer zu Hause. Das habe ich hier wenig gesehen hier sind überall Spender. Ich mache zuhause z.B. den Computer mit einem Tuch sauber. Ich bin heute aufs WC gegangen und da sind mir Tropfen aufgefallen. Da habe ich gleich ein Tuch genommen und es aufgewischt. Man weiß ja nie was kommt. Ich setz mich da nicht hin. Man muss etwas mit dem WC machen, dass es gereinigt wird bevor jemand drauf sitzt. Vor einem sitzt einer drauf und man weiß nicht was er hat und dann komm ich. Ich war früher viel unterwegs. Ich bin nie auf dem Klo gesessen auf der Raststätte. Nie aufs Klo gesessen.

➔ Nachfrage I: Wenn auf der Sanitäreinrichtung Tücher ausliegen würden, würden sie diese benutzen?

P C6_04: Ja, auf jeden Fall. Bevor ich wo draufsitze auf den WC. Außer zuhause halt.

➔ I: Gibt es weitere Flächen die sie gerne reinigen würden?

P C6_04: Ich sehe es jeden Tag, wenn das Personal kommt zum Reinigen. Die wischen sogar die Türen ab und ich mache das zuhause auch. Aber ich vertraue darauf, man sieht ja wie sie arbeiten ob sie gut sind oder schlampig arbeiten.

I: 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen?

P C6_04: Ja die Sanitäreinrichtung, unten am Krankenhauseingang vielleicht oder wenn man ins Kaffee reingeht.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreinrichtung die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C6_04: Es ist mir bewusst. Es ist so eine Sache, wenn der Bettnachbar sieht, was denkt er, wenn ich hinterhergehe und Möbel abputze und den Tisch. Wenn der Tisch verkleckert ist, aber die Möbel danach das mache ich nicht, die Türklinke auch nicht. Das mache ich nur daheim. Das ist kein schönes Bild wenn man nachputzt und derjenige sieht es vielleicht.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C6_04: Ja, Verbandzeug und Desinfektionsmittel. Ich war immer zufrieden. Alles hygienisch verpackt.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C6_04: Also für die Hände würde ich es benutzen. Das mache ich sowieso. Aber nicht Möbel.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C6_05

Weiblich, 57 Jahre, teilt sich Zimmer mit anderen Patienten

I: 1.: Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P C6_05: Sehr wichtig. Weil an öffentlichen Orten kommen verschiedene Leute und heutzutage bei den vielen Viren, sollte man schon darauf achten.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P C6_05: Selten. Ich selber war eine Zeit lang allergisch, jetzt nicht mehr, aber ich glaube wenn man auch zu viel desinfiziert wird der Körper auch schwächer oder so empfindlich.

➔ **I: In welchen Situationen würden Sie die Desinfektionstücher bevorzugt nutzen?**

P C6_05: Als wir Corona hatten im Haus, da haben wir es öfter benutzt. Ich selber bin empfindlich.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P C6_05: Sehr wichtig. Auch wegen den vielen Krankheiten und viele kranke, empfindliche Leute.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P C6_05: Keine Bedenken.

➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?

P C6_05: Nein keine.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?

P C6_05: Nein ich habe keine Beschwerden. Es ist sauber.

➔ I: Leiten Sie beim Teilen eines gemeinsamen Raumes mit anderen Patienten oder bei Besuch Hygienemaßnahmen ein?

P C6_05: nein.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_05: Sehr wichtig.

➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_05: Nicht viel anfassen, viel Hände waschen.

➔ I: Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus?

P C6_05: Es ist Eigeninitiative.

➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P C6_05: Es gibt keine.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C6_05: Zufrieden. Es gibt Desinfektionsmittel aber man fasst ja eigentlich nichts an.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C6_05: Nein.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C6_05: Nein. Weil ich es unnötig finde. Die Pfleger putzen ja nach und desinfizieren. Ich finde, je mehr Desinfektion im Zimmer ist, desto empfindlicher wird der Mensch. Man soll nicht übertreiben.

➔ Nachfrage I: Wie würden Sie den Fall finden wenn man mit anderen Patienten die Sanitäreanlage teilt. Würden Sie da Desinfektionstücher benutzen?

P C6_05: Ja da würde ich es schon benutzen, aber ich weiß, dass meine Bettnachbarn nicht aufs Klo gehen. Dann bin ich ja die einzige, die das Bad nutzt. Ich bin die einzige hier und es wird ja jeden Tag sauber gemacht.

I: 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen?

P C6_05: Nein.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreanlage die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C6_05: Ja, das ist mir schon bekannt.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C6_05: Ja meine Schwiegermutter hat dort gearbeitet. Windeln hatten wir.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C6_05: Nein. Ich hatte früher so viele Allergien auf Desinfektionsmittel und während Corona hab ich es auch nicht benutzt.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C6_06

Männlich , 59 Jahre, teilt sich das Zimmer mit anderen Patienten

I: 1. **Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?**

P C6_06: Sehr wichtig. Man weiß ja nicht was Vorgänger getätigt haben, was sie an den Händen haben, wie sie sich benehmen. Wenn ich etwas anfassen oder benutzen muss, da hätte ich es gerne schon so, dass ich mir keine Keime und Bakterien einhole.

I: 2. **Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?**

P C6_06: Sehr häufig, Immer.

➔ I: Welche und in welchen Situationen?

P C6_07: Also, nach dem Toilettengang werden Hände gewaschen und desinfiziert. Dann schaue ich auch, dass Griffe und sonstige Sachen, wo andere Leute öfters bei mir im privat Bereich in die Hand nehmen bei mir täglich gereinigt sind. Auch der Tisch. Ich muss auch sagen ich bin Patient, ich kriege Pflegedienst und da muss man sehr hoch auf die Hygiene achten. Auch hier [im Krankenhaus] beim Toilettengang. Da ich eine medizinische Beschwerde habe, kann ich mir schnell etwas einholen. Wenn hier Fremde reinkommen, achte ich darauf, dass alles desinfiziert ist. Auch privat ist das gang und gäbe bei uns.

➔ I: In welchen Situationen würden Sie die Desinfektionstücher bevorzugt nutzen?

P C6_07: Desinfektionstücher benutze ich um den Toilettenrand zu reinigen oder Türgriffe natürlich. Flächen werden mit Desinfektion-Spray behandelt und mit Tüchern abgewischt. Wir haben auch Tücher im Kraftfahrzeug, wenn meine Frau einkaufen geht, vor allen bei den Einkaufswägen, vorher und nachher.

I: 3. **Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?**

P C6_06: Sehr wichtig. Ganz arg wichtig! Es ist sehr heikel. Wie gesagt, wegen meiner medizinischen Beschwerde.

I: 4. **Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?**

P C6_06: Die Gefahr besteht immer. Auch bei Hygieneeinhaltung. Und im Krankenhaus kann man wahrscheinlich nicht die top Hygienestufe erreichen. Es gibt immer Schmutz, es kommt Besuch ins Zimmer. Aber seit ich hier bin, bin ich zufrieden mit der Station. Es sieht alles ordentlich aus. Das einzige was ich witzig finde, wenn die Reinigung kommt, mit einem

Lumpen mit irgendetwas drauf. Da werden die Galgen abgeputzt und der Tisch abgeputzt, da wird noch was abgeputzt. Man kann nicht die Toilette und das Waschbecken putzen, mit dem gleichen Lumpen rauskommen und hier [im Zimmer weiterputzen]. Ich habe bisher nichts weitergegeben. Bis auf die Kleinigkeit hier im Raum ist mir nichts aufgefallen. Wenn es eine Katastrophe wird, zum Beispiel wenn sie aus dem Bad kommt und bei mir was putzen möchte... das darf sie nicht. Ich beobachte es von A bis Z, solange es mein Gesundheitszustand zulässt. Standards muss man haben, sollte was passieren wäre es schlecht. Aber im Krankenhaus kann immer was passieren. Aber ich bin zufrieden hier. Schmutzige Sachen habe ich nicht gesehen. Beklagen kann ich mich nicht.

➔ Nachfrage I: Was würden Sie denn bezüglich der Hygiene verbessern?

P C6_06: wenn ich den Tisch abputze, dann putz ich Tische und fertig. Da hocken Leute zum Essen. Und ob ich die Türgriffe und die Rollen am Bett und die Griffe... das sollte man getrennt halten. Wie Ihre Vorschriften sind weiß ich nicht ob es gewechselt wird, aber ich habe es noch nicht gesehen.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_06: Sehr wichtig

➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_06: Also wenn ich aus dem Bett gehe und etwas mache und etwas angefasst habe: Hände waschen mit Seife und danach desinfiziere. Auch wenn ich aus der Toilette gehe, weil es viele Menschen nicht gelernt haben, die Hände zu waschen und ich möchte das nicht anfassen und dann gehe ich in mein Bett.

➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P C6_06: Nein es gibt keine.

➔ Auf welche Art und Weise schützen Sie sich?

P C6_06: Mundschutz und wie gesagt, Hände waschen. Das ist wichtig.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C6_06: Zufrieden. Es gibt Desinfektionsmittel und Wasser.

➔ Nachfrage I: Gibt es etwas was sie sich wünschen?

P C6_06: Grad so Hygienetücher, damit man selber etwas wegputzen und abwischen kann.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C6_06: Die Hände werden immer desinfiziert. Man braucht nicht zu übertreiben.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C6_06: Auf jeden Fall! Grad für meine persönliche Oberflächen, alles was ich selber anlange. Man kontaminiert ja selber etwas. Wenn sie ausliegen würden, dann würde ich den Toilettendeckel und nach der Benutzung die Brille abwischen. Das wäre eine Idee.

I: 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen?

P C6_06: Nichts mehr. [Alles wurde bereits genannt]

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreinrichtung die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C6_06: Ja klar.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C6_06: Ja natürlich. Ich verwende die Produkte jeden Tag. Pflaster, Mull, Blutdruckmessgerät. Solche Sachen halt. Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C6_06: Selbstverständlich.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C6_07

Männlich , 75 Jahre, ist alleine im Zimmer

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P C6_07: Wichtig. Sauberkeit ist ganz wichtig. Wir haben es ja jetzt mit Corona erlebt, mit was man sich alles anstecken kann. Jeden Schnupfen holt man sich ja irgendwo.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P C6_07: Immer, Täglich. Händedesinfektion.

➔ I: Welche und in welchen Situationen?

P C6_07: Immer wenn ich nach Hause komme. Nach dem Toilettengang. Das sind die wichtigsten.

➔ I: In welchen Situationen würden Sie die Desinfektionstücher bevorzugt nutzen?

P C6_07: Unterwegs. Nach dem tanken. Wenn man in einer Gruppe unterwegs war, nach dem Hände schütteln.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P C6_07: Sehr wichtig. Wegen Ansteckungsgefahr.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P C6_07: Ja natürlich. Man kommt selber angeschlagen ins Krankenhaus. Und wenn da Erreger einem begegnet ist die Ansteckungsgefahr umso größer.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?

P C6_07: Es ist alles top.

➔ I: Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Umgang mit Hygiene seitens der Mitpatienten vorstellen?

P C6_07: Vorsichtig. Hand vor dem Mund beim Husten, Händedesinfektion nach Toilettengang. Oder wenn er die Türklinke anfasst, dass er diese desinfiziert.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_07: Sehr wichtig.

➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C6_07: Hände desinfiziert. Sonst eigentlich nichts.

➔ I: Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus?

P C6_07: Ja ich mache es von mir selber aus.

I: 6.: Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C6_07: Zufrieden. Die Toilette war desinfiziert. Die Tür wird täglich rausgewischt. Es gibt Handschuhe.

Frage 7 wurde übersprungen weil Patient am gleichen Tag eingeliefert und entlassen wird. Kein Besuch.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C6_07: Gelegentlich ja. Einmal um Hände zu desinfizieren und Gegenstände, die ich anfassen muss.

I: 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen?

P C6_07: Keine weiteren Angaben.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreinrichtung die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C6_07: Ja.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C6_07: Ja. Ich habe selber aktiv Mullbinden, Pflaster, Verbandskasten für das Auto benutzt. Auch Desinfektionsmittel und Tücher.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C6_07: Ich denke ja.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): C8_08

Männlich , 41 Jahre, alleine im Zimmer

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P C8_08: Sehr wichtig . Als Krebspatient bin ich darauf angewiesen, dass ich keine 1000 Bakterien und Bazillen um mich herum habe. Vor allem auf dem Behinderten-WC. Auch wegen Ansteckungsgefahr und der allgemeine Ekel.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P C8_08: Täglich. (Immer).

➔ I: Welche und in welchen Situationen?

P C8_08: Desinfektionsmittel beim Bad Putz. Hausputz allgemein. Nach dem einkaufen. Im häuslichen Bereich hauptsächlich.

➔ I: In welchen Situationen würden Sie die Desinfektionstücher bevorzugt nutzen?

P C8_08: Beim Reinigen von mobiler Oberflächen. Zum Beispiel Tische, Türklinken. Allgemein Flächen.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P C8_08: Sehr wichtig. Es ist gesundheitliche Voraussetzung, dass man hygienisch arbeitet, um Patienten nicht kränker zu machen, als sie schon sind. Man arbeitet ja auch intim.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P C8_08: Während der Coronazeit hatte man schon Bedenken. Aktuell eher weniger.

➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?

P C8_08: Ja. Oder vom Personal.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen? Beschwerden?

P C8_08: Ich habe keine Beschwerden.

➔ I: Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Umgang mit Hygiene seitens der Mitpatienten vorstellen?

P C8_08: Man würde das WC sauber hinterlassen. Einfach das Bad sauber hinterlassen. Den Müll aufräumen. Den Tisch beim Essen abwischen. Das Mobiliar, welches gemeinsam genutzt wird, sauber hinterlassen.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P C8_08: Sehr wichtig.

➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P: Bei Symptomen eine Maske tragen. Der Krankenhauskeim wird abgenommen, da wird ein Abstrich gemacht. Hände waschen nach dem Toilettengang, aber das ist eine Voraussetzung. Der Abstrich ist Pflicht, aber Maske tragen ist keine Pflicht. Es können Leute reinkommen, die Husten, aber die sehen es nicht ein eine Maske aufzusetzen.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P C8_08: Sehr zufrieden. Es gibt die Spender im Zimmer und im Bad. Aber die Desinfektionstücher fände ich nicht schlecht. Das man den eigenen Tisch noch abwischt. Das machen die Mitarbeiter morgens immer oder die Putzkraft. Aber wenn man mir Tücher hinstellen würde, würde ich es auch selber machen. Da hätte ich kein Problem.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P C8_08: Es kommt auf die Situation an, wie es gerade um meine Abwehr steht. Die Besucher sollen sich möglichst auf Corona testen und wir schütteln nicht die Hand und im Sommer gehen wir an die frische Luft. Aber ansonsten gibt es keine Maßnahmen.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P C8_08: Ja, ich würde sie benutzen. Für meinen Tisch, den Wagen neben dem Bett, das Mobiliar das sonst noch hier steht. In erster Linie damit es schön aussieht und natürlich schützt man dabei seinen Besuch.

I: 9. Wo würden Sie sich Desinfektionstücher wünschen?

P C8_08: Auf dem WC. Beim Zähneputzen spuckt man und da wären Desinfektionstücher gar nicht so schlecht. Es gibt normale Tücher aber keine Desinfektionstücher.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäranlage die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P C8_08: Ja das ist mir bekannt. Auch über einen längeren Zeitraum.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P C8_08: Ja, Verbandkasten, Wundspray. Wir haben zuhause auch ein Pflegeset, da ist ein Desinfektionsmittel dabei. Ich bin zufrieden damit.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P C8_08: Ja.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): K4_09

Männlich, 82 Jahre, alleine im Zimmer

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P K4_09: Sehr wichtig. (Bei Nachfrage wurde nicht erläutert warum.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P K4_09: Die Pflegekraft verwendet es viel. Ich verwende es aber nicht.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P K4_09: Wichtig. Es ist in Ordnung.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P K4_09: Nein. Sowas gibt es gar nicht.

➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?

P K4_09: Nein ich habe keinen Kontakt.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen?

P K4_09: Es ist alles 100% in Ordnung.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P K4_09: Gibt es sowas überhaupt? Aber ja, ich halte es für selbstverständlich mir die Hände zu waschen.

➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P: Nein.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P K4_09: Sehr zufrieden. Es ist alles in Ordnung.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P K4_09: Nein, nicht wirklich.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P K4_09: Wofür soll ich sie benutzen? Die Putzkraft kümmert sich um alles. Es wird alles gemacht.

Frage 9 übersprungen.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäranlage die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P K4_09: Nö. Ich mache mir keine Gedanken. Das macht das Krankenhaus sauber.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P K4_09: Meine Frau holt sich was sie braucht. Es ist alles in Ordnung.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P K4_09: Nein

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): K4_10

Weiblich, 57 Jahre, alleine im Zimmer

I: 1. Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P K4_10: Sehr wichtig. An den öffentlichen Toiletten zu Coronazeiten und Grippezeiten wenn sich die Leute nicht die Hände waschen, schon an der Türklinke, überträgt man es wieder nach innen in den Raum. Wenn dann zum Beispiel schwangere Frauen reingehen wird es übertragen, das ist schlimmer und der Kreis wird immer größer.

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P K4_10: 4 Häufig. Wenn ich nieße oder genießt habe, desinfiziere ich meine Hände mit den Tüchern. Bei der Toilette, an den Türklinken.

➔ I: Welche und in welchen Situationen?

P K4_10: Auf der öffentlichen Toilette nehme ich gerne das Spray, sprüh es drauf und Wisch mit einem Tuch rum.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P K4_10: Sehr wichtig. Aus den besagten Gründen, mit Corona. Ich hatte eine Bekannte, die hatte Krankenhauskeime im Knie bekommen und von meinem Mann der Bekannte ist sogar daran gestorben. Es gibt auch so viele Leute. Aber das Krankenhaus kann da meistens nichts dafür.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P K4_10: Ich bin da neutral, ich tu was ich kann für mich, aber man kann sich ja nicht komplett abkapseln.

➔ I: Haben Sie die Befürchtung, dass Sie sich mit den Erregern anderer Patienten oder Ihre Besucher anstecken?

P K4_10: Es kann überall sein. Es kann passieren wenn ich einkaufen gehe.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen?

P K4_10: Nein, ich finde alles in Ordnung.

Nachfrage I: Bitte beschreiben Sie bitte nochmal genau, was die genau für sich tun.

P K4_10: Wenn ich auf der Toilette war, Hände waschen. Wenn meine schwangere Tochter vorbeikommt, gebe ich ihr Tücher. Ich überlasse es ihr. Sie schimpft mich so. Man soll nicht übertreiben. Man soll ja auch Abwehrkräfte aufbauen.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P K4_10: Sehr wichtig.

Nachfrage I: Sie meinten, sie übertreiben gerne. Würden Sie bitte darauf eingehen?

P K4_10: Hier [im Krankenhaus] nicht so, weil ich nicht die Möglichkeiten habe. Aber zuhause, putze ich viel, wasche viel Wäsche und füge Sagrotan hinzu. Ich bin auch wegen meinem kleinen Enkel vorsichtig, ich sage ihm öfters er soll nichts anfassen.

Nachfrage I: Was fehlt den Ihnen hier im Krankenhaus?

P K4_10: Nein, ich finde es hier sehr sauber. Die Putzkraft die kommt hält hier alles sehr sauber.

➔ I: Welche Vorgaben vom Krankenhaus gibt es? Beispiele?

P K4_10: Nein. Aber ich finde es selbstverständlich. Es gibt ja überall die Spender. Unten gibt es das Schild, dass ein begrenzte Zahl an Besucher erlaubt sind zum Beispiel.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P K4_10: Sehr zufrieden. Wenn man unten reinkommt gibt es schon viele Spender und ich finde es toll, dass die Pfleger auch sehr darauf achten und sich selber die Hände desinfizieren. Die Putzkraft putzt auch das ganze Zimmer.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P K4_10: Ja schon. (Frage hat sich bereits erübrigt)

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P K4_10: Nur im Patientenzimmer. Wenn Sie draußen rumliegen, kann es sein, dass Kinder es anfassen und aus Umweltgründen sind die Desinfektionstücher auch nicht ganz ohne. Im

Zimmer würde ich es schon benutzen. Wenn ich weiß, dass meine Tochter kommt, dann würde ich es für die Türklinke und den Toilettendeckel benutzen. Und wenn man sich die Hände desinfiziert, reicht es ja. Und der Umwelt zuliebe, weiß ich nicht wie umweltfreundlich es ist wenn jeder Patient im Zimmer sowas hat. Ich habe privat zwar eine kleine Packung Desinfektionstücher in der Tasche, aber gebraucht habe ich es nicht. Die putzen hier sehr gut.

Frage 9 übersprungen.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäreinrichtung die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P K4_10: Ja, das ist mir bekannt.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P K4_10: Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht schon.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P K4_10: Ich schon.

Patienteninterviews Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Patient (P): K4_11

Weiblich, 79 Jahre, alleine im Zimmer

I: 1.: Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Hygiene an öffentlichen Orten?

P K4_11: Sehr wichtig. [Wurde nicht erläutert warum genau]

I: 2. Wie oft benutzen Sie in Ihrem privaten Umfeld Hygieneprodukte z.B. Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher?

P K4_11: Nie. Ich wasche meine Hände. Die sind sauber. Aber ich verwende keine Mittel, weil ich keine Chemie mag.

I: 3. Wie wichtig ist für Sie persönlich die Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus?

P K4_11: Sehr wichtig. Ich möchte keine Erreger

.

I: 4. Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Krankenhaus Bedenken oder Sorgen bezüglich der Verbreitung von Bakterien und Erregern?

P K4_11: Nein, keine Bedenken.

➔ I: Wie schätzen Sie die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus ein? Sorgen?

P K4_11: Nein.

➔ I: Wie schätzen Sie den Umgang mit Hygiene des Zimmerpartners (in der Vergangenheit) ein?

P K4_11: Da habe ich nicht darauf geachtet.

I: 5. Wie wichtig ist Ihnen der Schutz vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P K4_11: Eigentlich sehr wichtig. Aber ich glaube, das Personal weiß, was es tut.

➔ I: Wie schützen Sie sich vor Krankheitserregern im Krankenhaus?

P K4_11: Ich finde Hände waschen ausreichend. Ich benutze keine Desinfektionsmittel.

➔ Beruht das Handeln auf Ihrer Eigeninitiative oder sind es Vorgaben von dem Krankenhaus?

P K4_11: Ich mache das selber.

I: 6. Sind Sie mit dem Angebot an Hygienemaßnahmen im Krankenhaus zufrieden?

P K4_11: Ja ich bin zufrieden.

I: 7. Schützen Sie Ihre Besucher vor der Ansteckung mit Erregern?

P K4_11: Nein. Ich mache da nichts Besonderes.

I: 8. Würden Sie Desinfektionstücher benutzen, wenn Sie frei ausliegen würden?

P K4_11: Nein.

➔ Nachfrage I: Warum?

P K4_11: Weil ich denke, dass die normale Hygiene mit Hände waschen ausreichend ist. Man ist ja kein kleines Kind, man fasst ja nicht alles an.

Frage 9 übersprungen.

I: 10. Ist Ihnen bewusst, dass Sie bei Kontakt mit Flächen wie z.B. Möbeln oder der Sanitäranlage die Gefahr besteht, dass Sie in Kontakt mit Erregern kommen oder sie weitergeben könnten?

P K4_11: Ach Gottchen, wenn man über alles nachdenken würde löst man sich in Luft auf.

I: 11. Sind Ihnen die Paul Hartmann Group und ihre Produkte bekannt?

P K4_11: Nein.

Abschließende Frage:

I: Wenn man Desinfektionstücher zur Verfügung stellen würde, könnten Sie sich vorstellen sich an der Flächenhygiene zu beteiligen?

P K4_11: Wenn es Pflicht wäre, würde ich es machen, aber ansonsten nein.

Hartmann AG

Hartmann AG Vertreter Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Hartmann (H): H01

0.I: Warum sollten sich Patienten an der Flächenhygiene im Krankenhaus beteiligen?

H01: Weil gerade jetzt, wo wir den Personalnotstand haben und Pfleger oder allgemein alle Beteiligten im Krankenhaus, alle Angestellten Krankenhaus stark überlastet sind. Es ist aus

meiner Sicht hilfreich, wenn Patienten, so lange sie in der Lage dazu sind und nicht bettlägerig sind, nahe Flächen mitaufbereiten oder desinfizieren, um einfach das Infektionsrisiko für die Angestellten und andere Patienten zu minimieren und auch um Personal zu entlasten.

Außerdem finde ich, schafft das auch ein Bewusstsein beim Patienten. Wie wichtig Hygiene sein kann und wie einfach Hygiene auch teilweise sein kann. Vielleicht breitet sich das dann auch aus Richtung Händehygiene, wenn Patienten wissen, dass Flächenhygiene wichtig ist und sie Flächen anfangen, eigenständig zu desinfizieren, fangen sie vielleicht auch an, sich die Hände zu desinfizieren, wenn sie andere Patienten besuchen, wenn sie das Zimmer verlassen, ins Zimmer kommen und so kann auch noch mal vielleicht Infektionsrisiko ein bisschen verringert werden.

1.I: Was zeichnet Ihr Produkt „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ gegenüber konkurrierenden Produkten und Herstellern aus?

H01: Es ist sehr verträglich und löst auch keine Allergien aus. Also es hat ein EKA Siegel ECARF Siegel, das ist einzigartig bisher in dem Bereich gewesen. Also es gab vorher keine Flächendesinfektionsmittel, die auf Allergiker Freundlichkeit geprüft sind und wir haben es auch Dermatologisch testen lassen. Selbst bei ausgiebiger Nutzung traten bei den Probanden keine Hautprobleme auf. Rein theoretisch könnte man es ohne Handschuhe benutzen, wenn Arbeitsschutz und Infektionsschutz und die Vorgabe des Krankenhauses dies zulassen. Aus Anwenderfreundlichkeitssicht wäre es auch ohne Handschuhe anwendbar. Das ist etwas, was andere Produkte nicht zwangsläufig so haben.

➔ 1a.I: Was zeichnet das Produkt bei der Flächenhygiene aus?

H01: Bei der Wirksamkeit gibt es meistens 2 Gruppen. Es gibt einmal die Basiswirksamkeit und dann die erweiterte Wirksamkeit. Zu Basiswirksamkeit gehören Bakterien und Hefepilze und auch manche Viren, also Grippeviren, Coronaviren oder SARS cov. Da ist das 30 sensitive voll wirksam. Und da hat es auch nichts, was Wettbewerbsprodukte da nicht hätten. Also das ist so ein Must-Have von Desinfektionsmitteln Und dann gibt es noch die erweiterte Wirksamkeit mit speziellen Erregern, aber da braucht man spezielle Mittel, die dann auch ein bisschen harscher sind, weil es dann um Erreger geht, die besonders schwer abzutöten sind. Da kann man jetzt 30 Sensitive nicht anwenden. Aber das ist auch gar nicht das Ziel. Es ist ein Produkt für die Basishygiene, für den alltäglichen Gebrauch, für die Routine und Desinfektion.

2.I: Warum sollten Patienten Ihr Produkt benutzen?

H01: Explizit unser Produkt gegenüber Wettbewerbsprodukten mit gleicher Wirksamkeit, weil Patienten im ersten Moment nicht so viel falsch machen können. Das Produkt ist sehr

materialverträglich, also sie können damit auch über Flächen wischen, ohne, dass jetzt Gefahr besteht, dass irgendeine Fläche oder ein Medizinprodukt Schaden nimmt. Es gibt andere Produkte, die haben zum Beispiel mehr Alkohol, da wird es dann schwieriger bei Acrylglas oder Plexiglas. Da gibt es so Material und Wirkstoff Unstimmigkeiten. Es gibt nur sehr wenig Materialien die etwas sensitiver sind oder ein bisschen empfindlicher sind. Da kann also der Patient erstmal nichts falsch machen, wenn er pauschal die Flächen in der Umgebung mitabwischt. Dadurch, dass das Produkt auch so Hautfreundlich ist, ist es auch nicht schlimm, wenn es ohne Handschuhe verwendet wird. Man sich jetzt nicht zwingend danach die Hände sofort waschen, weil da irgendwelche komischen Inhaltsstoffe drin sind. Das würde auch theoretisch so funktionieren, das zeichnet das Produkt aus im Vergleich zueinander.

➔ **2a.I: Welche Vorteile oder Nutzen hätte der Patient oder Personal?**

H01: Direkt vielleicht weniger. Also das Personal wäre trotzdem noch angehalten, die Flächen nach Hygieneplan zu desinfizieren, weil ja nicht sichergestellt werden kann, dass der Patient das ordnungsgemäß macht und richtig macht und immer dann macht, wenn es notwendig ist. Also da ist das Personal vielleicht in der Routine nicht weniger entlastet. Das würde gleich bleiben. Es geht dann eher darum, falls eine akute Situation besteht, dass der Patient drüber wischt. Der Patient kann es selber machen ist nicht darauf angewiesen, dass jetzt Personal kommt.

Jede Desinfektion vermindert das Infektionsrisiko. Es ist schwer vorherzusagen, wie oft eine Fläche in der Patientennähe so im Alltag desinfiziert wird. Das ist eher seltener, weil das Personal wichtigeres zu tun hat. Und wenn dann der Patient da noch miteingreift und ab und zu mitdesinfiziert, weil etwas viel angefasst wird, das Bettgestell, was auch immer, dann unterbindet das Infektionsketten und kann dann indirekt Vorteile bringen.

➔ **2b.I: Gibt es Studien, die die Wirksamkeit des Produktes unterstützen?**

H01: Nein. Also Studien im Sinne von wissenschaftlichen Publikationen gibt es nicht. Desinfektionsmittel werden aber bevor der sie zugelassen werden, nach verschiedenen Normen getestet, es gibt die EN-Norm, also europäische Normen, es gibt Normen, die von deutschen Verbänden, aufgestellt werden. Es gibt Prüfmethode, die zum Beispiel das Robert Koch Institut aufstellt. Und die Produkte werden dann nach diesen, meistens nach diesen 3 Systemen EN Normen, RKI und VAH getestet. Und das wird dann in unabhängigen Instituten gemacht in so mikrobiologischen Instituten in Deutschland meistens Österreich, in der Dach Region und dann kriegt man da seine Prüfsertifikate. Das wird nicht publiziert, das bleibt sozusagen bei uns intern. Wir schreiben dann auf das Produkt drauf „Produkt geprüft nach Norm 13 727“ und Wirksam nach x Minuten. Die Zulassung muss gemacht werden, weil es nach strikten Normen von unabhängigen Laboren durchgeführt wird. Der Kunde oder der Nutzer, kann sich drauf verlassen, dass das Produkt wirksam ist, wenn es nach Norm XY getestet wurde.

➔ **2c.I: Ist die Handhabung umgänglicher?**

H01: Also es ist zum einen die hohe Materialfreundlichkeit. Das ist nur sehr, sehr wenige. bestimmte Kunststoffe gibt, die so ein bisschen empfindlicher sind. Bei 30 Sensitive funktioniert das allerdings sehr gut mit den meisten Kunststoffen. Auch ist eine große Reichweite vorhanden, also mit einem Tuch kann man auch sehr viel wischen, bevor es trocken wird. Die Gefahr von Benetzungslücken, also wenn man wischt und es bleiben trockene Stellen übrig wo Infektionsrisiko bestehen bleibt, ist geringer, dadurch, dass das Tuch an sich eine hohe Reichweite hat. Also ist schon eine ordentliche Fläche, bevor es problematisch wird und Lücken entstehen. Was vielleicht für den Patienten auch wichtig ist, ist, dass wir eine gute Reinigungsleistung haben, also da sind nicht nur die Alkohole drin, sondern da ist auch ein Tensid drin, ein seifenähnlicher Stoff. Auf manchen Oberflächen schäumt das Produkt auch so ganz leicht, wenn die Oberfläche ein bisschen rauer ist. Zum Beispiel ist ein Kaffeefleck eingetrocknet über Nacht und dann am nächsten Tag kann der Patient rüber wischen und dann hat das Produkt nicht nur die Desinfektionsleistung, sondern auch eine Reinigungsleistung. Der Patient fände es auch einfach nett, wenn er seine eigene Umgebung so ein bisschen sauber halten kann, weil ja mal schnell passiert, dass man beim Kaffee, Mittagessen, was auch immer kleckert, sag ich jetzt mal. Es muss ja nicht immer Blut und andere Flüssigkeiten sein.

➔ **2d.I: Und wie schätzen Sie das Produkt ein bezüglich der Verpackung?**

H01: Also klar, wenn die Packung offen bleibt, dieser Clip Verschluss, dann trocknen sie aus. Recht schnell sogar, weil es Alkohol ist und Alkohol verdunstet sehr schnell, also schneller als Wasser. Das ist ein Problem, da muss man dran denken. Den Deckel zu machen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist aber mit jedem Produkt so. Trocknet es aus, ist die Wirksamkeit nicht gegeben. Gerade bei den alkoholbasierten Produkten, wenn der Alkohol verdunstet ist, weil darin der Wirkstoff ist. Bei wasserbasierten Produkten verdunstet das Wasser, aber der Wirkstoff wird ja auf dem Tuch bleiben. Deswegen ist es wichtig bei Alkoholprodukte, dass sie saftig bleiben oder feucht bleiben und das muss auch der Patient leider selber daran denken. Aufmachen, Tuch nehmen, zu machen. Ist aber auch bei den Feuchttüchern zu Hause so. Das kennt man, wenn man mit Feuchttüchern vielleicht zu Hause auch zu tun hat. Die Packung selbst ist dafür designt, das Produkt zu schützen, also wenn die Packung zu ist, dann ist das Produkt auch fein und kann nach Anbruch mindestens einen Monat verwendet werden. Vielleicht sogar länger das. Es sind ja auch nur 80 Tücher drin. Und wenn man dann jeden Tag ein oder 2 benutzt, ist das auch aufgebraucht. Gerade wenn man sie in Reichweite hat, ist die Hemmschwelle ja auch geringer und dann wird öfter gewischt. Von daher ist das eigentlich nie ein Problem, dass sie zu lange angebrochen rumstehen.

➔ **2e.I: Wie sieht die Entsorgung aus? Auch bezüglich Geruch und wie wird es mit der Umwelt vereinbart?**

H01: Klar ist es Alkohol drin, aber es ist nicht viel Alkohol. Es riecht ein bisschen alkoholisch, aber nicht, dass es in der Nase brennt, wie wenn man jetzt zum Beispiel Essig riechen würde oder so.. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben ist, dass es eigentlich gerne gesehen wird oder gerne gerochen wird, weil das ein Gefühl von Sauberkeit und Desinfektion vermittelt. Selbst für einen Patienten, der nicht täglich mit Desinfektion zu tun hat, der fühlt

sich dadurch ein bisschen wohler. Das ist dieser typische Krankenhausgeruch, den man eigentlich unbewusst gerne hat. Wir haben auch Produkte auf Wasserbasis, die riechen ganz anders, die riechen dann eher so ein bisschen erdig. Bei den 30 Sensitive Sachen war das aber bisher nie ein Problem.

Man kann die Tücher ganz normal entsorgen. Wenn sie kontaminiert sind, müssen sie gesondert entsorgt werden. Aber das ist im Krankenhaus üblich, da gibt es dann immer extra Sammelbehälter für kontaminierte Abfälle, das muss dann gesondert sterilisiert werden von der Entsorgung, damit sich niemand anders daran infiziert. Momentan bestehen die Tücher aus Plastik und Kunststoff. Wir bewegen uns immer mehr Richtung Nachhaltigkeit und es werden auch grüne Tücher kommen. Wir haben jetzt auch schon ein Produkt was wir aus Naturfasern hergestellt haben. Das wird auch bei 30 sensitive irgendwann mal passieren, das wird auch bei allen Wettbewerbern früher oder später passieren. Trotzdem bleibt das Problem, dass wenn es kontaminiert sein könnte, muss es gesondert entsorgt werden. Also an Recycling können wir da leider nicht denken, weil es sich aus Infektionsschutzgründen nicht geht. Das werden wir auch in Zukunft leider nicht so leicht ändern können, denk ich mal. Da muss das Krankenhaus das ganze Abfallmanagement erweitern und besser sortieren, besser trennen und das ist halt ein Mehraufwand, den sich heute noch keiner so vorstellen kann. Wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie Flächen zu desinfizieren und man nicht davon ausgeht, dass das Tuch jetzt stark kontaminiert ist, weil der Patient, das im Rahmen seiner Routine macht und kurz über den Bettrahmen wischt, kann das Tuch auch einfach in den Restmüll neben dem Bett entsorgt werden, sage ich mal. Man riecht das jetzt nicht stark, dass es alkoholisch ist oder so. Man riecht das, wenn man es in der Hand hat und nah an der Nase aber nicht im Mülleimer zwei Meter weiter.

➔ 2f.I: Inwiefern unterscheiden sich wasserbasierte zu den alkoholbasierten Tüchern? Wenn die wasserbasierten zum Beispiel austrocknen, könnte man die dann einfach nicht noch mal nass machen, separat und dann die auch weiter benutzen?

H01: Nein. Wir jetzt zum Beispiel haben Säuren drin, organische Säuren, Fruchtsäuren. Rein theoretisch, könnte man das Tuch wieder anfeuchten, weil der Wirkstoff bleibt auf dem Tuch, also die Säuren verdunsten ja nicht wie das Wasser verdunsten würde. Allerdings wird bei der Herstellung ganz genau geschaut, wieviel Feuchtigkeit pro Tuch benötigt wird, damit es feucht genug ist aber nicht zu feucht ist und die Feuchtigkeit auch gut abgegeben werden kann. Wenn ich jetzt so ein trockenes Tuch wieder nass mache, ist einfach die Gefahr sehr groß, dass ich den Wirkstoff abwasche. Wenn ich es einfach unter den Wasserhahn halte, läuft der Wirkstoff mit dem Wasser mit in das Spülbecken. Ich kann das jetzt auch nicht irgendwie in ein Gefäß tun, weil ich genau eine definierte Wassermenge brauche. Ist zu viel Wasser, ist der Wirkstoff zu stark verdünnt, ist es zu wenig Wasser, dann komm ich ja auch nicht weit mit dem Tuch. Deshalb auf keinen Fall ein trockenes Tuch wieder befeuchten! Wenn man merkt das Tuch oder das ganze Flowpack stand über Nacht auf, ist es nicht mehr sichergestellt, dass die Feuchtigkeitsmenge stimmt. Entweder entsorgen oder zum Säubern verwenden, wo keine desinfizierende Leistung mehr erforderlich ist, weil die

ist nicht mehr gegeben, wenn es anfängt einmal auszutrocknen. Aber man merkt es mit der Hand recht gut. Wenn es jetzt offen stehen würde, ob es jetzt Ethanol basiert, also alkoholbasierte oder wasserbasiert ist und das erste Tuch ist trocken, da nimmt man halt so 3-5 weg, schmeißt sie weg und dann fängt es auch wieder an feucht zu werden. Also es dauert schon sehr lange bis der ganze Stapel durchtrocknet, weil die Öffnung auch zu gering oder zu klein ist.

3.1: Was sind Ihre Leitlinien zur korrekten Benutzung des Produktes?

H01: Man muss ein bisschen gucken, dass das Produkt oder die Wirkstoff oder die Wirksamkeit des Produktes auch dem, was sich gerade auf der Fläche befindet, angemessen ist. Bei einer Durchfallerkrankung mit einem bestimmten Erreger, mit Sporen, muss ich auch sicherstellen, dass das Produkt dazu passt und das Produkt notfalls wechseln. Je nachdem was der Patient hat, das Produkt dementsprechend auch die Wirksamkeit hat. Bestimmte Viren zum Beispiel würden mit 30 sensitive nicht inaktiviert werden können. Das ist bei der leitliniengerechten Verwendung ebenfalls wichtig. Flächen, die stark verschmutzt sind erst einmal desinfizierend reinigt und dann noch mal desinfiziert, wenn es erforderlich ist. Gerade wenn man viel Kontamination mit Blut, Stuhl, Urin oder so hat, dann ist es wichtig, erstmal die ganze organische Belastung loszuwerden. Zuerst eine desinfizierende Reinigung und dann in einem zweiten Schritt mit einem frischen Tuch noch mal desinfiziert. Beim Wischen ein Tuch, für eine Fläche. Man nimmt nicht ein Tuch für mehrere Flächen. Beim Wischen, dass man auch wirklich guckt dass keine Benetzungslücken entstehen. Dass man den Schmutz nicht noch mehr verteilt also da muss man ein bisschen darauf achten. Wenn ich jetzt daran denke, dass der Patient unterstützen soll bei der Desinfektion, bin ich immer noch der Ansicht, jede Art von Desinfektion, die der Patient macht, kann nur positiv sein und unterstützen, auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig richtig ausgeführt ist. Wenn vielleicht doch eine Lücke entsteht, dann ist es immer noch besser als wenn gar nicht gewischt werden würde. Also so würde ich das jetzt sehen.

➔ 3a.1: Wo und auf welchen Flächen kann/soll das Produkt genutzt werden?

H01: Also man unterscheidet immer zwischen patientennahen und patientenfernen Flächen und sogenannten High Touch und Low Touch. So oft berührt Flächen sind diese 2 Gruppen. Patientennahe, irgendein Tisch oder so ein kleiner bewegliche Tisch, den man da immer hat, oder das Bettgestell ist eine klassische High Touch patientennahe Fläche. Gerade das Bettgestell fasst so ziemlich jeder an, der das Zimmer betritt, meistens unbewusst. Ärzte bei der Visite, der Besuchte fast früher oder später das Bettgestell an. Und das sind so klassische Flächen, wo ich denke, da könnte der Patient eigenverantwortlich auch einmal drüber wischen. Sowas wie Fußboden ist nicht notwendig und Medizin Geräte also würde ich auch nicht empfehlen, einfach weil die Gefahr zu groß ist, dass da Fehler gemacht werden und das Gerät darunter leidet. Gerade bei teuren oder aufwendigen Medizin Geräten ist das Problem der Material Verträglichkeit gravierender als jetzt bei so einer gewöhnlichen Tischfläche oder Bettgestell. Vielleicht einmal kurz, wenn der Patient das möchte, über die Sanitäreinrichtungen wischen, ist ja alles dann Metallkeramik und Glas, da kann eigentlich nichts

passieren. Und das gibt dem Patienten dann vielleicht ein sicheres Gefühl. Gerade wenn man sich zu zweit die Sanitäranlagen teilt oder die Nasszelle teilt, im Mehrbettzimmer oder so. Medizinprodukten und Geräte, da würde ich auch eher von abraten. Aber sowas steht auch nicht oft im Patientenzimmer einfach so rum. Wenn wir jetzt nicht gerade Intensivstationen haben, wo der Patient eh nicht wischen sollte. Ultraschallgerät oder so bleibt ja nicht einfach stehen, sag ich mal. Aber klar, auch andere elektrische Geräte würd ich immer aufpassen.

4.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

→ Wenn ja: **Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ in den Alltag eines Patienten integrieren?**

H01: Ich würde es ausprobieren wollen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Bauchgefühl würde ich sagen, ist eine klasse Idee das mal zu testen. Ich weiß nicht ob es langfristig was bringt. Das ist schwer zu sagen. Es wäre eine sehr umfangreiche Studie, langfristig festzustellen, ob das irgendwie die Rate, die Anzahl an Krankenhausinfektionen verringern würde oder nicht, da müsste man sehr viele Patienten beobachten. Zum Testen fände ich das erstmal eine gute Idee und ich könnte mir das auch vorstellen, dass man das in einer Art Halterung in der Nähe des Patienten anbringt. Halterung deswegen, damit es nicht verschwindet oder eingesteckt wird. Das war in der Hochphase der Pandemie schlimmer, das Desinfektionsmittel eingesteckt wurde von Besuchern und Patienten gerade Hände Desinfektionsmittel, aber deswegen vielleicht einfach in der Halterung, dann hat es auch immer seinen Platz. Ich würde mir wünschen, dass da auch ein bisschen Schulung oder Training beim Patienten stattfindet, dass der Patient genau weiß, was das ist und genau weiß, dass es zum Beispiel kein Tuch ist, um sich die Hände regelmäßig zu desinfizieren oder zu reinigen, oder dass es kein Feuchttuch ist, wie man es aus dem Hygienebereich, dem Privathygienebereich, kennt. Sonst sehe ich da erst mal eine schöne Idee, um Infektionsketten zu unterbrechen, ja.

→ **4a.I: Sie würden es also als unterstützende Maßnahme sehen?**

H01: Ja, man muss sicher und es klar sein, dass das, was der Patient macht, nicht das ersetzt, was momentan passiert. Es ist nur ein Add-on, ein Zusatz sozusagen. Wenn man das jetzt wirklich messen wollen würde, wie effektiv das ist, müsste man anfangen irgendwie 2 Stationen miteinander zu vergleichen. Die einen benutzen das Tuch, die anderen benutzen das nicht, dann müsste man über einen längeren Zeitraum schauen wie hoch die Infektionsrate ist. Mutmaßen, dass es was bringt oder nicht bringt, wenn sich die Zahlen ändern. Aber das ist ein bisschen umfangreicher. Also man müsste auch Stationen erst mal finden, die sonst komplett gleich sind, dass man da nicht mehrere Faktoren oder Freiheitsgrade beeinflusst. Also es geht schon, aber es ist halt ein 2 Jahres Projekt würde ich jetzt grob schätzen.

5.1: Welche Herausforderungen oder Risiken vermuten Sie könnten bei der Benutzung der Tücher durch Patienten auftreten?

H01: Also einmal muss der Patient selber geschützt werden, dass er es nicht falsch anwendet, für sich selber, wie sie sagten, jetzt Make-up Entfernung. Es muss auch geguckt werden, dass das Krankenhausinventar nicht beschädigt wird also im Rahmen von teuren Geräten oder Flächen, wo klar ist, dass die nicht desinfiziert werden dürfen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man das klar kennzeichnet, was genutzt werden darf für diese Flächen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn es Richtung Psychiatrie geht, weil alles alkoholische dort schnell zweckentfremdet und getrunken wird. Also auf solchen Stationen sind Händedesinfektionsmittelspender besonderen Herausforderungen gestellt, das man sie nicht öffnen und trinken kann, sowas muss auch sichergestellt sein. Das ist ein sehr besonderer Spezialfall, sage ich mal. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand ein Flowpack aufreißt und auswringt, weil da kommt schon ein halber Liter Flüssigkeit raus oder so am Ende. Dass man da guckt, was für einen Patienten man da hat, also in der Normalstation ist das eigentlich kein Problem, das sehe ich eher so bei der Psychiatrie. Gerade weil 30 sensitive so freundlich für Material und Anwender ist, sehe ich gar nicht so super viele Risiken. Außer bei besonderen Geräten oder pauschal immer, wenn es wieder am Körper angewandt wird.

→ 5a.I: Wie ist es mit Sanitäranlagen? Wenn es nach der Benutzung hineingeworfen wird.

H01: Das ist nicht gut. Die sind nicht Flashable. Auf Englisch. Also nicht Sanitäranlagen gerecht oder Abspülbar. Das funktioniert nicht, die lösen sich nicht auf und verstopfen. Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das muss auf jeden Fall verhindert werden irgendwann verstopft uns das WC.

→ 5b.I: Auf welche Art und Weise könnten die Tücher den Patienten zur Verfügung gestellt werden?

H01: Also es gibt, soweit ich weiß, noch kein gescheites Berührungsfreies Spendersystem für Tücher. Man kennt das vielleicht von öffentlichen Toiletten oder WCS. Da gibt es sowas, da hält man die Hand runter, dann kommt ein Tuch raus, zum Hände trocknen. Solche Apparate gibt es, glaube ich, auch für Desinfektionstücher, aber das ist superselten und auch ein sehr großes Gerät, welches vielleicht übers Ziel hinausschießt. Das Problem bei den Tüchern ist, dass man sie da wirklich momentan, berühren muss, den Deckel aufmachen, man muss ein Tuch rausnehmen, wenn man das zu enthusiastisch macht, kommen mehrere Tücher raus, man stopft vielleicht unbewusst das oberste wieder zurück, was man eigentlich nicht machen sollte, dadurch ist es ja schon wieder kontaminiert oder potenziell kontaminiert. Man macht den Deckel wieder zu. Sowas auf einer Hygiene Station, sage ich mal, dem Flur aufzustellen und jeder geht dahin, wenn er es braucht und ist vielleicht natürlich ein bisschen kritischer als mit einem Hände Desinfektionsmittel. Ich könnte es mir eher vorstellen, dass man das in einer Halterung ans Bett macht, dann ist es auch immer dabei, wenn der Patient sich bewegt. Es ist irgendwo in die Einrichtung integriert, also es gibt auch schon Krankenhäuser, die haben dann so kleine Fächer, so im Schranksystem so ein kleines

Loch, das man aufmachen kann, da kommt das Flowpack, also die Packung dann rein, und man macht es zu und da ist ein Loch, sodass man die Öffnung aufmachen und benutzen kann.

Wir vertreiben auch so eine Metallhalterung. Ein Flowpack-Halter. Das sind dann so Metalldreizangen und hier kommt dann das Flowpack rein und dann kann man das über ein Schraubsystem auch überall festmachen. Ansonsten sehe ich eher, dass jeder Patient eine individuelle, ein eigenes Paket bekommt, ein eigenes Flowpack bekommt, statt es jetzt irgendwo zentral zu lagern. Und es muss ja auch kein großes Paket mit vielen Tüchern sein. Es gibt ja auch kleinere Varianten mit nur weniger Tüchern, dann ist die Gefahr auch nicht so gegeben, dass da jetzt so ein halb angebrochenes Paket irgendwie übrig bleibt. Wenn der Patient es jetzt nicht leer macht, weil er nicht so lange da ist oder weil er das nicht so viel benutzt, dann steht man ja am Ende mit einem angebrochenen Paket da, was man nur ungern anderswo verwenden würde. Also ich würde es ungern woanders verwenden, von einer richtigen pflegenden Person, weil nicht sichergestellt ist, wie der Patient mit dem Paket umgegangen ist, ob es vielleicht doch über Nacht aufstand oder nicht. Deswegen vielleicht für Patienten eher kleinere Packungen mit weniger Tüchern. Dass es nicht so dramatisch ist, wenn man die Reste entsorgt.

6.I:Haben Sie bei Ihrem letzten Krankenhausbesuch oder Aufenthalt an der Flächenhygiene teilgenommen?

H01: Ich achte da drauf, wenn ich bei Ärzten oder so bin. Ich achte auf Hygiene, mehr als ich vorher drauf geachtet hab. Aber in Arztpraxen ist Flächenhygiene nicht so im Fokus. Ich habe auch keine gravierenden Verstöße oder so festgestellt. Also mein Rucksack ist immer voll mit Desinfektionsmittel, und wenn ich dann beim Arzt bin oder in der Bahn oder in dem Bus und dann verlasse ich den Bus und dann habe ich auch immer irgendwo ein Desinfektionsmittel parat und desinfizier mir die Hände oder beim Arzt. Dann nehme ich lieber mein eigenes als das, was an der Rezeption steht. Einfach weil ich auch unsere Produkte besser finde als die, die irgendwo angeboten werden. Meistens. Das sind dann die riechen manchmal anders, schlechter. Oder ist die Frage, wie lange stehen sie da schon und wie alt sind sie? Irgendwann laufen die ja auch ab und so weiter also das ist schon, aber das ist jetzt einfach nur weil ich so viel davon im Rucksack habe.

I:So, wir haben jetzt sehr viele relevante Punkte zur Flächenhygiene besprochen und diskutiert. Haben sie noch weitere Punkte, die für Sie wichtig wären, die Sie noch hinzufügen möchten?

H01: Nein, es wurde alles angesprochen.

Hartmann AG Vertreter Transkript:

Interviewer (I): Kristina Gräfenstein

Hartmann (H): H02

0.I: Warum sollten sich Patienten an der Flächenhygiene im Krankenhaus beteiligen?

H02: Grundsätzlich, die Patienten sind ja, sag jetzt mal, gefährdeten Patienten, vor allem die, die natürlich auch mit irgendwelchen immunsupprimierten oder einfach geschwächten Immunsystemen im Krankenhaus liegen. Und die Fläche ist ein Übertragungsweg für Keime. Also die erste Fläche sind die Hände, aber die zweite sind Oberflächen, dann in die Hände. Deshalb sollten auch Patienten wissen, wie Oberflächen bekeimt sein können und wie man sie natürlich. Keimfrei halten kann.

1.I: Was zeichnet Ihr Produkt „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ gegenüber konkurrierenden Produkten und Herstellern aus?

H02: In ganz einfacher Art und Weise. Technisch werden ihnen andere erklären, was alles drin ist. Aber grundsätzlich, was das Produkt auszeichnet, es ist Wirksam gegen die üblichen pathogenen Keime, also Bakterien und Viren, die in so einem Krankenhaus in der Routine vorkommen und Wirksam natürlich auch in der Zeit, also innerhalb von einer Minute muss es wirken, also schnell wirksam. Und das ist das hervorragende, es ist eben so schonend, dass man es eben auch ohne Handschuhe anwenden kann. Also das ist eben nicht nur einfach ein Desinfektionsmittel. Da sind Biozide, relativ aggressive Mittel, die natürlich etwas abtöten müssen, und da hat man oft Hautreizungen. Das kennt man auch aus der Küche oder aus dem aus dem Bad, wenn man mit aggressiveren Putzmitteln arbeitet. Da ist es im Prinzip nicht angebracht, ohne Handschuhe zu putzen und deshalb, wenn man das häufig tut, ist die Handschuhgeschichte natürlich ganz wichtig. Und das ist genau das Baciollol 30 sensitiv, das erlaubt es in der Routine sogar ohne Handschuhe zu arbeiten. Das ist jetzt vielleicht für Profis nicht angedacht, aber soeben, wenn Patienten oder wenn man es zu Hause anwenden will, muss man nicht immer einen Handschuh mit anziehen, man kann es auch unbedenklich in die Hand nehmen und anwenden.

2.I: Warum sollten Patienten Ihr Produkt benutzen?

H02: Also wie gesagt, also unser Produkt ist, ich meine, die Patienten wissen ja nicht, wie ein Produkt hergestellt ist und was für Gefahren dieses Produkt hat. Natürlich, wie auch im Haushalt, gibt es die Gefahrenhinweisen, es gibt Anwendungshinweise, aber das macht niemand, das liest niemand. Das machen wir nicht mal bei uns. Gibt schon viele Leute, die das machen, aber die meisten kaufen etwas und wenden es an, außer es ist wirklich explizit hervorgehoben und das ist eben genau unser Produkt. Ich sage jetzt mal unbedenklich in der Anwendung, das heißt also, man kann es sowohl bei Menschen anwenden, also nicht, um die Hände zu desinfizieren, aber die Menschen können es unbedingt sich anwenden und

die Flächen, die damit desinfiziert werden, werden auch nicht zu stark beschädigt oder geschädigt, weil sie halt einfach dieses schonende Desinfektionsmittel drin haben, das auch trotzdem wirkt. Und warum sollen sie unseres nehmen? Na gut, die Patienten, idealerweise wissen Sie von unserem Produkt. Dann fordern sie es auch im Spital an oder im Krankenhaus. Deshalb ist es natürlich auch ein bisschen eine Markenpositionierung. Im Endeffekt ist es natürlich auch so, wenn sie es im Krankenhaus kennenlernen, können Sie es natürlich später auch in der Apotheke kaufen. Und das ist natürlich für uns auch ein bisschen ein Produktplacement.

➔ **2a.I: Welche Vorteile oder Nutzen hätten der Patient oder Personal?**

H02: Gut also das ist am Schluss ganz klar, dass im Prinzip das Risiko einer möglichen Kontamination von gefährlicheren Keimen in der Nähe von Patienten, die dann eben damit Mühe haben, reduziert sind. Also, ganz salopp gesagt Norovirus, der zu kleinen Durchfall führt, das kennt man ja oft bei Kindern, wenn die Mal in ein Lager gehen, das reduziert sich. Das heißt also, wenn die Patienten ihre Flächendesinfektion, zum Beispiel auf der Toilette, aber auch bei gewissen Flächen, die sie teilen, selber vornehmen, dann ist im Prinzip die Übertragung, das Übertragungsrisiko minimiert. Das ist der Benefit, den sowohl der Patient direkt hat, aber natürlich auch das Pflegepersonal, weil die müssen nicht regelmäßig reinigen und desinfizieren. Das ist ja etwas das sie nicht tun können, indem sie einfach routinemäßig, wenn jemand auf die Toilette gegangen ist, nachreinigen und desinfizieren. Das müsste man aber tun wenn zwei Personen in einem Raum sind, die potenziell sich gegenseitig gefährden können. Und das macht ja niemand. Das Offensichtliche ist jetzt die Toilette. Aber so ganz salopp gesagt, banal zum Beispiel, Ist immer seltener, aber das Teilen von gemeinsamen Flächen. Das heißt also irgendwo ein Tisch, den man gemeinsam benutzt oder man spielt vielleicht zusammen Karten oder man hat Besuch. Wenn ich als Patient ja weiß, dass ich ein Risiko habe, vielleicht eine Infektion zu kriegen, weil ich eine offene Wunde habe, weil ich ein schwaches Immun[system habe], dann schau ich, dass ich meine Flächen, wo ich mich auch immer wieder bewege, regelmäßig desinfiziere, so wie ich auch Hände regelmäßig [desinfiziere]. Ich als Patient kann mich besser sensibilisieren, kann selber dazu beitragen, dass mein Risiko reduziert wird und bin nicht davon abhängig, dass mir irgendjemand wie eine [Reinigungskraft] oder eben auch das Pflegepersonal mein Schutz gibt. Die werden sowieso machen, aber die sind halt beschränkt in der Zeit und in der Möglichkeit, wann sie es machen.

➔ **2b.I: Ist das Produkt damit umgänglicher für die Patienten als konkurrierende Produkte?**

H02: Ja, wie gesagt, also wenn ich keinen Handschuh tragen muss, nehme ich es auch in die Hand. Das heißt also, ich kann es nutzen. Das ist schon mal das erste. Wenn ich einen Handschuh tragen muss, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder muss ich dann als Hygienefachkraft die Patienten anleiten, Handschuhe zu tragen und natürlich als Anwender wie Hygiene muss ich es sowieso machen. Also schon nur das die Handschuhanwendung ist schon mal ein Nachteil. Wobei bei der bei der Reinigung, bei der Hygiene, die das wahrscheinlich schon machen, unabhängig welches Produkt sie nehmen, sie wissen das ist

ein Risiko, aber der Patient denkt nicht daran Handschuhe zu nehmen. Also müssen sie immer daran erinnert werden, Handschuhe zu tragen. Zweitens müssen Sie Handschuhe auch in der Nähe haben, also ist das auch eine Frage, wo sind die Produkte. Stellen Sie sich vor, sie sind auf der Toilette und Sie müssen es sich noch Handschuhe anziehen, um dann das Klo zu desinfizieren, bevor sie Klo gehen, das macht niemand. Also es ist schon schwierig, aber genau das ist der Vorteil, also die Praktikabilität des Produktes. Es ist umgänglicher, üblicher und braucht keine große Anleitung. Man kann es einfach sagen: Da ist was, nutzt es.

3.I: Was sind Ihre Leitlinien zur korrekten Benutzung des Produktes?

H02: Gut, wie gesagt, genauso wie angedeutet. Also das Produkt muss natürlich korrekt in dem Sinne angewendet werden, das wenn man die Wirkung haben möchte, muss man die sogenannte Einwirkzeit einhalten. Auf jedem Produkt steht dann für welche Art von Bakterien und Viren braucht es wie viele Minuten oder Sekunden, um das Produkt wirksam zu haben. Und das ist so im Schnitt, bei Flächendesinfektion eine Minute für so Routine Desinfektion und 2 bis 5 Minuten, wenn man ein bisschen schwierigere Keime hat. Jetzt weiß ich bei dem Produkt nicht auswendig, ob es eine zwei- und fünfminütige Anwendungszeit gibt für ein spezifischer Time, aber so für die Routine, für das alltägliche Norovirus, die normalen Bakterien, hat man eine Minute und innerhalb von dieser Minute muss es wirken. Aber das muss man einhalten. Also das ist wichtig, also das Einhalten der Anwendungszeit ist wichtig, weil sonst nützt es nichts, also sonst hat man den Effekt nicht. Und das zweite ist natürlich, und das ist natürlich immer so, das sind keine Produkte, die man in die Toilette werfen kann. Man darf sie nicht in die Toilette werfen, das heißt, die korrekte Entsorgung ist wichtiger.

➔ 3a.I: Wo und auf welchen Flächen kann/soll das Produkt genutzt werden?

H02: Genau, also genau also können, kann das Produkt, weil es ein sensitives Produkt ist, eigentlich auf allen Oberflächen benutzt werden. Das Produkt hat einen leichten Alkohol Bestandteil drin. Bei Produkten, die Hochsensitiv sind für Alkohole, darf man es nicht anwenden, aber das sind eigentlich in dem Umfeld, wo wir jetzt sprechen, Patientenzimmer und so weiter, eher selten. Also man kann es zum Beispiel auch benutzen, um so ein Handy oder ein Tablet oder einen Bildschirm zu desinfizieren. Sehen sie eben so dosiert, dass es eben auch auf solche Oberflächen, wie Computer, Tastaturen und so weiter benutzt werden kann. Alle diese Flächen, die man benutzt, also wo man Hände drauf legt. Telefone, Tastaturen, Tische, Bettkanten, Bett. Wo man die Hände hinhält, Türklinken und so weiter. Natürlich Toilettendeckel, Toiletten, Waschbecken und so weiter. Wobei, also auch hier muss man aufpassen, man muss nicht den Waschbecken desinfizieren, wenn man es nicht anfasst. Also im Waschbecken, wird ja nur am Rande vielleicht angefasst oder nur der Griff. Dort, wo man eigentlich immer wieder mal mit den Händen rankommt oder wo man mit einer großen Hautfläche sich hinsetzt oder berührt. Diese Keime können dann auf der Haut sich wieder vermehren. Das geht sehr schnell und dann kann natürlich aus einem normalen

Hautkeim, kann dann im Prinzip, die wandern dann, und auch in Öffnungen gehen. Das ist dann im Prinzip immer noch eine Wunden oder eben natürlich Körperöffnungen, die halt vielleicht nicht so geschützt sind, wenn man krank ist. Das können auch Respiratorische Transfer geben, dass die halt dann wieder ausgewirbelt werden durch die Luft und dann gehen sie in die Luft. Das heißt also, so funktioniert halt die Transmission. Hat man ja bei Corona gesehen. Da waren es eher Viren, die groß genug waren oder schwer genug waren, dass die nicht einfach so vom Tisch draufklopfen und dann wieder in den in den Mund gehen. Aber das weiß man am Anfang nicht

4.I: Würden Sie das Produkt in den Alltag des Patienten integrieren?

H02: Ja, das Projekt ist ja da. Natürlich, das ist das Ziel. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser verbesserten Compliance. Das ist im Prinzip Hygiene-Compliance. Wir haben die Hände Compliance und natürlich die Flächen-Compliance auch ein bisschen hebt vom heutigen Standard, reduziert man das Risiko einer Infektion.

→ Wo und wann würden Sie die Desinfektionstücher „Bacillol 30 Sensitive Tissues“ in den Alltag eines Patienten integrieren?

H02: Also faktisch würde ich sagen, jetzt in einem Patientenzimmer würde ich idealerweise zwei Ablageorte vorsehen. Der eine Ablageort ist natürlich die Toilette. Jetzt hängt es ein bisschen darauf an, wie die baulichen Maßnahmen das ermöglichen. Idealerweise so, dass wenn man eben in der Toilette ist, dass man gerade zum Beispiel auf Toilette, sie sind meistens klein und sehr handlich, aber dann ist es so in der Nähe, dort, wo halt auch die die WC Rolle ist, in der Nähe. Man kann es an die Wand hängen mit einem Halter oder man kann analog, diese Handschuhboxen oder Papiertuchboxen einfach auf ein auf eine Fläche legen und dann kann man sie rausnehmen. Also das ist so die Möglichkeit. Im Zimmer reicht ein Ablageort, der gut erreichbar ist und den man teilen kann, wenn man zum Beispiel ein Mehrbettzimmer hat. Es gibt ja immer diese Patiententische oder es gibt vielleicht eine gute Rückablage wo man gut hinkommt, weil idealerweise kann der Patient es direkt vom Bett nehmen und muss nicht aufstehen. Das ist jetzt sehr luxuriös, wenn man es so machen kann. Sonst muss man kurz aufstehen und das Tuch nehmen, oder man hat sowieso eine begleitende Personen wie Pfleger oder wie Besucher, die das dann für den Patienten machen. Weil der Patient selber, wenn er ja nicht mobil ist, kann ja nur beschränkt Flächen berühren und die Flächen die er berühren kann sind dann wahrscheinlich so gut geschützt von den Leuten, die ihm Unterstützung geben. Also die Gefahr ist ja nicht die eigene Kontamination, sondern die Gefahr ist Fremdkontamination, das heißt also, der Patient muss beobachten oder muss eine Sensibilität aufbauen, dass man sich überlegt, kann ich von jemand anderem infiziert werden.

5.I: Welche Herausforderungen oder Risiken vermuten Sie könnten bei der Benutzung der Tücher durch Patienten auftreten?

H02: Also gut, ich denke das Erste ist natürlich die Dosis macht, die Gefahr. Also wenn jemand hypersensibel und übertrieben diese Desinfektionstücher anwendet und im Prinzip fast schon missbraucht, indem Sie eine ganze Packung innerhalb von einer Minute verbrauchen. Das wäre gefährlich, weil eben die Dosis ist dann zu hoch. Oder das zweite ist, wie ich gesagt habe, dass diese Tücher falsch entsorgt werden, also vor allem in der Toilette, das darf nicht sein. Sonst sehe ich nur beschränkte Risiken. Aber es kann natürlich sein, dass jemand natürlich allergisch auf das Produkt reagiert und so, aber grundsätzlich ist das Produkt eigentlich unbedenklich in dem Umfeld, wo wir es anwenden. Wenn Kinder im Raum sind, muss man auch aufpassen. Aber man kann ja jedes Risiko so tief [auseinandernehmen].

6.1: Haben Sie bei Ihrem letzten Krankenhausbesuch oder Aufenthalt an der Flächenhygiene teilgenommen?

H02: Also ich habe darauf geachtet, aber sicher nicht teilgenommen, weil A, bin ich nur Besucher gewesen und nicht selber Patient. Deshalb hab ich das nur beschränkt als Risiko gesehen für mich als Besucher. Zweitens ist es natürlich so auch im Wissen, dass es möglich wäre, die Flächen zu desinfizieren, gibt es zum Teil ja die Produkte nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nicht proaktiv, dann vielleicht als Besucher, schon Flächendesinfektionsmittel mit ins Haus nehme, also sprich was ich ja vielleicht mache, wenn ich eine öffentliche Toilette besuche, da habe ich solche Tüchlein mit dabei, das fehlt natürlich im Krankenhaus, wenn man dann annimmt, dass das Krankenhaus ja per se eigentlich hygienisch ist. Und wenn natürlich im Raum kein Desinfektionstuch da ist. Ja, man beobachtet es, aber man bemängelt es nicht, das ist das erste, weil das natürlich auch eine Mutfrage ist. Wenn dann dein Vater, deine Mutter oder wer auch immer, deinen Liebsten im Bett liegen und die Pflegekraft macht etwas Falsches, ist immer so ein bisschen eine Hürde. Das ist ja auch die Arbeit, die sie machen. Dass man eben vielleicht dieses Patient Empowerment wirklich auch soweit kriegt, dass der Patient oder auch der Besucher den Respekt vor der Autorität am Krankenhaus und auch Autorität am medizinischen Personal an Wissen nicht verliert. Ich mach immer das Beispiel mit dem Mechaniker des Autos. Auch dort verstehe ich nichts und trotzdem sage ich was, wenn ich das Gefühl habe es passt nicht. Also wenn irgendwo ein Tropfen Öl irgendwo noch runter fällt, nach dem Ölwechsel, sag ich es. Wenn hingegen in der Klinik irgendwo noch etwas nicht sauber ist, dann sage ich wahrscheinlich eher nichts oder weil ich auch vielleicht das Gefühl hab, ich werde dann als Fachidiot dargestellt. Und das ist etwas, das ich in meinem persönlichen Umfeld persönlich selber gemerkt habe. Es ging jetzt nicht nur um Fläche, sondern Hände, aber es hätte wahrscheinlich bei der Fläche genau das Gleiche sein können. Ich beobachte das jetzt mehr und mehr, im Krankenhaus ist das eine aber, wenn man beim Hausarzt irgendwo eine Impfung oder eine Blutabnahme hat. Das sieht man ja auch, dass nicht alles desinfiziert wird oder auch nach der Anwendung nicht vielleicht die Fläche, die ich benutzt habe, desinfiziert wird. Das heißt also, ich sitze auf einem Tisch, lange alles an, vielleicht auch die Armlehnen, und dann geh ich weg und dann kommt ja die nächste Person und die macht das gleiche, und wenn das 10 Leute machen die wird vielleicht einmal am Tag dann desinfiziert. Vielleicht kommt irgendeiner, der ist wirklich

Krebs Patient und hat irgendwelche immunsupprimierten Situationen und dann könnte die Person einen Infekt kriegen, weil einfach diese einfache Routine in der Flächendesinfektion nicht gemacht wurde. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder das machen muss. Und ich würde eben den Patienten so sensibilisieren, dass wenn du Risiko Patient bist, nimm dir einfach die Zeit oder frage nach der Desinfektion. Das sag ich so. Es ist jetzt noch nie bewusst gemacht.

→ **6a.I: Sehen Sie die Teilnahme der Patienten dann als unterstützende Maßnahme oder sollen die Patienten die komplette Flächenhygiene übernehmen?**

H02: Nein, nein. Also das muss man trennen. Man darf nicht den Patienten für die Flächenhygiene Verantwortung geben, das ist die Verantwortung des Krankenhauses, der Hygiene, und die soll auch dann entsprechend über die Hygieneplanung sagen, wer was wann, wo routinemäßig desinfiziert. Also diese berühmte Routinedesinfektion, die bleibt beim Fachpersonal. Was wir ja anstreben, ist nicht die Routinedesinfektion, weil die hat einfach eine Grenze, weil die Routine wäre, je nach Risiko, normalerweise in einem Patientenzimmer der Klasse Normalpatientenzimmer, meistens die Desinfektion mehrheitlich nur, wenn der Patientenwechsel stattfindet. Ein neuer Patient kommt rein, das Zimmer ist sauber und desinfiziert, dann bleibt der Patient drin und dann gibt es ein paar Routinedesinfektionen, eben bei Risikopunkten, aber es geht nicht, zum Beispiel die Toilette wird gereinigt und desinfiziert, aber dass wir nicht routinemäßig der ganze Raum alle Flächen desinfizieren und da sehe ich eben, dass der Patient, zusätzlich zu der Routinedesinfektion, Zwischendesinfektionsschritte machen kann. Gerade im Sinne des Selbstschutzes. Also es ist ein Selbstschutzprozess. Denn nur diejenige machen müssen, die auch Risiko haben und das muss natürlich dann vom Ablauf her natürlich bei der Patientenannahme, bei der Patienten Einweisung dann entsprechend natürlich aufgenommen werden. Dann weiß der Patient, er kann mit eigenen Maßnahmen, sowohl Selbstschutz als eben auch andere darauf hinweisen, dass er geschützt werden soll. Dann kann er im Prinzip sein Risiko minimieren, eine Infektion zu kriegen.

Usability-Testskript

Testplan:

Das Ziel des Usability Test ist es festzustellen, ob Patienten bei der Nutzung von den Desinfektionstüchern Schwierigkeiten haben und wo und wie genau sie diese anwenden. Am Ende soll auch ihre persönliche Einschätzung zum Thema Flächendesinfektion abgegeben werden.

Es werden hierzu fünf Benutzer aus der Benutzergruppe „Patient“ als Testteilnehmer rekrutiert.

Die Länge des Tests soll sich über zwei Tage erstrecken, sodass die Nutzer genug Zeit haben das Produkt Situationsabhängig zu nutzen.

Die Testsitzung erfolgt in der Woche vom 18.03 – 22.03. Die Tücher werden den ausgewählten Patienten in der früh an Tag eins zur Verfügung gestellt und an Tag drei zu den Erfahrungen befragt.

Rekrutierungsskript und Fragen:

Guten Tag, mein Name ist Kristina Gräfenstein. Ich bin Studentin und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Ich möchte mehr über die Flächenhygiene im Krankenhaus, sowie die potentielle Bereitschaft der Patienten bei der Teilnahme an der Flächen Hygiene, im Hinblick auf die Benutzung von Desinfektionstüchern, verstehen. Dazu würde ich gerne mit ein paar Patienten einen Test durchführen.

- 1. Hätten Sie in den kommenden zwei Tagen etwas Zeit, um an einem kurzen Test teilzunehmen?**
- 2. Haben Sie bereits in medizinischen Einrichtungen Desinfektionstücher benutzt?**
- 3. Wären Sie bereit in den zwei Tagen Desinfektionstücher zu benutzen und anschließend mit mir Ihre Erfahrungen bei einer kleinen Befragung zu teilen?**
- 4. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?**
- 5. Welches Geschlecht?**

Briefing:

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben an diesem Test teilzunehmen. Ich werde Ihnen bis Mittwoch eine persönliche Packung Desinfektionstücher zur Verfügung stellen. Ich möchte Sie darum bitten heute und morgen diese zu nutzen. Am Mittwoch werde ich nochmal vorbeikommen und Sie zu Ihren Erfahrungen oder Schwierigkeiten befragen. Mit Ihrer Hilfe werde ich ein besseres Verständnis für die Integration von Patienten in Flächenhygiene bekommen. Handeln Sie so wie Sie es für richtig halten und bitte antworten Sie mir bei der Befragung ehrlich. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Leider kann ich diese

zwei Tage nicht an Ihrer Seite verbringen, sodass ich auf Ihre sorgfältigen Antworten angewiesen bin. Vorab habe ich eine dringende Bitte und Warnung:

Wichtig! Diese Tücher sind nur für Flächen, also NICHT für die Händedesinfektion gedacht! Diese Tücher müssen im Müll entsorgt werden und dürfen NICHT in der Toilette runtergespült werden! Bitte säubern Sie damit keine medizinischen Geräte!

Testaufgaben:

Aufgaben in Präsenz:

1. Bitte öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie ein Tuch.
2. Bitte säubern Sie eine Fläche Ihrer Wahl, zum Beispiel den Tisch.
3. Bitte entsorgen Sie das Tuch.
4. Bitte lagern Sie die Verpackung an einen für Sie gut erreichbaren Ort.

Aufgaben in meiner Abwesenheit:

1. Bitte verwenden Sie die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf Ihren patientennahen Flächen wie zum Beispiel Esstisch, ausklappbarer Tisch, Nachtschränkchen, Bettgestell oder Griffe.
2. Verwenden Sie die Tücher vor und nach der Benutzung der Toilette. Wischen Sie dabei den **Toilettenrand** ab. Entsorgen Sie die benutzten Tücher in einem Müllbeutel.
3. Benutzen Sie bitte die Tücher im Bad zum Säubern des Waschbeckens oder jeglicher Ablagen oder Spiegels bei Verschmutzung.
4. Wenn Sie Besuch durch Verwandte oder eine Visite vom Pflegepersonal bekommen, wischen Sie die berührten Flächen ab.
5. Bei aktiver Kontamination oder Verschmutzung durch andere Mitpatienten, benutzen Sie die Tücher.

Postsession Interview:

1. Wie leicht fanden Sie es, die Aufgaben durchzuführen?
2. Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen hatten Sie?
3. Was fanden Sie besonders gut oder hilfreich?
4. Was ist Ihnen positiv aufgefallen?
5. Was ist Ihnen negativ aufgefallen?
6. Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder Unannehmlichkeiten?
7. Wo/ Für welche Flächen haben Sie die Tücher benutzt?
8. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der Tücher ein?
9. Wo haben Sie die Verpackung gelagert?
10. Hatten Sie Probleme bei der Benutzung?
11. Wie viele Tücher/ wie oft haben Sie die Tücher benutzt?

12. Wo haben Sie sie entsorgt?
13. Was halten Sie von der Menge und Größe der Verpackung/Tücher?
14. Was würden Sie verbessern? (An der Verpackung, Tuch, Lagerung...?)
15. Wurden Ihre Bedenken bezüglich der Hygiene im Krankenhaus verringert?
16. Gab Ihnen die Verwendung von Desinfektionstüchern ein erhöhtes Sicherheitsgefühl?
17. In welchen Situationen waren die Tücher besonders hilfreich?
18. Würden Sie sich Desinfektionstücher für Ihren Krankenhausaufenthalt wünschen?
19. Wie würden Sie Ihre Gesamterfahrung zu der Verwendung zusammenfassen?

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Sie haben mir hierbei sehr weitergeholfen! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag!

Usability-Test Transkripte

Unmoderierter Usability Test

18.03 – 19.03

Moderator/Protokollant (M): Kristina Gräfenstein

Teilnehmer Patient (P): P1

Weiblich, 74 Jahre, allein im Zimmer

Rekrutierungsfragen:

6. **Hätten Sie in den kommenden zwei Tagen etwas Zeit, um an einem kurzen Test teilzunehmen?**
→ Ja
7. **Haben Sie bereits in medizinischen Einrichtungen Desinfektionstücher benutzt?**
→ Nein
8. **Wären Sie bereit in den zwei Tagen Desinfektionstücher zu benutzen und anschließend mit mir Ihre Erfahrungen bei einer kleinen Befragung zu teilen?**
→ Ja
9. **Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?**
→ 74 Jahre
10. **Welches Geschlecht?**
→ Weiblich

Testaufgaben:

(In Präsenz)

5. Bitte öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie ein Tuch.
6. Bitte säubern Sie eine Fläche Ihrer Wahl, zum Beispiel den Tisch.
7. Bitte entsorgen Sie das Tuch.
8. Bitte lagern Sie die Verpackung an einen für Sie gut erreichbaren Ort.

Beobachtung durch M :

1. Patient hat keine Schwierigkeiten die neue Verpackung mit Klebverschluss zu öffnen.
P1: „Ich habe gerade keinen Geruchssinn, deshalb rieche ich nichts“
2. Patient hat keine Anmerkungen oder Schwierigkeiten beim Benutzen des Tuches.

3. Das Tuch wird in einem Müllbeutel, welcher am Nachkästchen befestigt ist, entsorgt.
4. Die Verpackung wird auf Regal des Nachtkästchens, griffbereit neben dem Bett abgelegt.

(In Abwesenheit des Moderators über den Tag hinweg)

6. Bitte verwenden Sie die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf Ihren patientennahen Flächen wie zum Beispiel Esstisch, ausklappbarer Tisch, Nachtschränkchen, Bettgestell oder Griffe.
7. Verwenden Sie die Tücher vor und nach der Benutzung der Toilette. Wischen Sie dabei den **Toilettenrand** ab. Entsorgen Sie die benutzten Tücher in einem Müllbeutel.
8. Benutzen Sie bitte die Tücher im Bad zum Säubern des Waschbeckens oder jeglicher Ablagen oder Spiegels bei Verschmutzung.
9. Wenn Sie Besuch durch Verwandte oder eine Visite vom Pflegepersonal bekommen, wischen Sie die berührten Flächen ab.
10. Bei aktiver Kontamination oder Verschmutzung durch andere Mitpatienten, benutzen Sie die Tücher.

Postsession Interview:

M: Wie leicht fanden Sie es, die Aufgaben durchzuführen? Gab es Schwierigkeiten?

P1.1: Nein, überhaupt nicht.

M: Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen hatten Sie?

P1.2: Es gab keine.

M: Was fanden Sie besonders gut oder hilfreich?

P1.3: Die Box lässt sich gut öffnen und schließen, die Feuchtigkeit ist genügend. Ich habe Zuhause so Bodenwasch-Tücher die sind zu schnell trocken, das ist aber bei denen nicht.

M: Was ist Ihnen negativ aufgefallen?

P1.4 Vom Geruch her kann ich nichts sagen, weil ich gerade nichts rieche und Hände waschen hinterher ist ja eh normal weil man hinterher ein klebriges Gefühl hat. Aber man wäscht sich ja danach eh die Hände.

M: Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder Unannehmlichkeiten?

P1.5: Nein, überhaupt nicht.

M: Wo/ Für welche Flächen haben Sie die Tücher benutzt?

P1.6: Nachdem ich der Putzfrau zugeschaut hatte, sind mir noch weitere Flächen aufgefallen. Ich bin über also mein Nachtkästchen, den Esstisch, die Türklinke, in der Toilette den Toilettenring, die Spülung und bin auch über das Waschbecken und den Wasserhahn gefahren. Mir ist aufgefallen, ich habe der Putzfrau zugeschaut, und mir sind die Haare zu Berge gestanden. Sie kam mit einem blauen feuchten Lappen und fing die Tische, den Bettrahmen, den Heizkörper, die Stuhllehnen, die Tischbeine, die Ablage, die Lichtschalter, Türgriff, rein ins Klo, alles mit einem Lappen [zu wischen]. Und da bin ich hier gesessen und hab gedacht: „Oh ich bin das letzte Zimmer auf dem Flur, was macht die Frau mit dem Lappen anschließend? Wirft sie ihn hoffentlich weg?“ Da hat es mich geграust. Vielleicht bin ich zu pingelig, aber ich finde das nicht in Ordnung. Mit einem Lappen wischt man doch nicht alles? Ich war anschließend beschäftigt.

M: Wie viele Tücher/ wie oft haben Sie die Tücher benutzt?

P1.7: So acht vielleicht. Aber heute [am Tag des Interviews] habe ich nichts gemacht.

M: Wo haben Sie die Verpackung gelagert?

P1.8: Hier Griffbereit [am Nachtkästchen]. Ich bin jetzt alleine [im Zimmer] aber bei mehreren Patienten, kriegt dann jeder eins? Den Gedanken hatte ich nämlich. Jetzt bin ich Gott sei dank allein, aber wo tut man es dann hin wenn alle Zugriff haben wollen? In der Toilette würde ich es unästhetisch finden. Mit dem Lappen wird ja der Tisch gewischt. Da bin ich zu pingelig.

M: Wo haben Sie sie entsorgt?

P1.9: Ich habe einen eigenen Müllsack hier [am Nachtkästchen] und im Bad ist auch Behälter für Papier. Den Deckel habe ich auch noch abgewischt.

M: Was würden Sie verbessern? (An der Verpackung, Tuch, Lagerung...?)

P1.10: Nichts, nein.

Gab Ihnen die Verwendung von Desinfektionstüchern ein erhöhtes Sicherheitsgefühl?

P1.11: Ja, auf jeden Fall.

M: Würden Sie sich Desinfektionstücher für Ihren Krankenhausaufenthalt wünschen?

P1.12: Ja, auf jeden Fall.

M: Wie würden Sie Ihre Gesamterfahrung zu der Verwendung zusammenfassen?

P1.13: Also ich find halt, abgesehen davon das Corona vorbei ist, find ich es in Zeiten wo Erkältung ist, ungeheuer wichtig. Ich bin auch vorsichtig wenn ich Husten habe, oder wo viele Leute hinlangen. Ich würde jetzt nie an der Rolltreppe den Handlauf benutzen, weil gerade die Stellen, die viele Leute benutzen, oder im Krankenhaus die Türklinke und die Klobrille, also ich das muss einen höchsten Hygienestandard haben. Wenn ich mit meinem

Enkel unterwegs bin, da sind wir sogar jetzt dabei und wischen die Griffe ab, weil ein Kind steckt die Finger in den Mund. All die Flächen, wo viele Leute hin fassen, da bin ich pingelig.

M: Sie haben die Packung bei sich am Nachtkästen aufbewahrt aber die Tücher auch im Bad verwendet. Haben Sie die Tücher mitgenommen?

P1.14: Ich habe immer zwei genommen. Eine für die Türklinke und eine im Bad.

M: War das für Sie umständlich? Oder hätten Sie sich eine separate Packung im Bad gewünscht?

P1.15: Ne eigentlich nicht.

M: Wie finden Sie die Verpackungsgröße?

P1.16: Ist schon sehr viel. Ich kaufe immer so Feuchttücher für meinen Enkel und ich glaube, dass es so die Hälfte ist. Es würde wahrscheinlich genügen, aber ich weiß nicht wie lange die wirklich feucht bleiben. Ist auch schwer dieses Ding [Verpackung]. Die, die ich kaufe sind [kleiner].

Unmoderierter Usability Test

18.03 – 19.03

Moderator/Protokollant (M): Kristina Gräfenstein

Teilnehmer Patient (P): P2

Weiblich, 77 Jahre, teilt sich Zimmer

Rekrutierungsfragen:

11. Hätten Sie in den kommenden zwei Tagen etwas Zeit, um an einem kurzen Test teilzunehmen?

➔ Ja

12. Haben Sie bereits in medizinischen Einrichtungen Desinfektionstücher benutzt?

➔ Nein

13. Wären Sie bereit in den zwei Tagen Desinfektionstücher zu benutzen und anschließend mit mir Ihre Erfahrungen bei einer kleinen Befragung zu teilen?

➔ Ja

14. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

➔ 77 Jahre

15. Welches Geschlecht?

➔ Weiblich

Testaufgaben:

(In Präsenz)

9. Bitte öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie ein Tuch.
10. Bitte säubern Sie eine Fläche Ihrer Wahl, zum Beispiel den Tisch.
11. Bitte entsorgen Sie das Tuch.
12. Bitte lagern Sie die Verpackung an einen für Sie gut erreichbaren Ort.

Beobachtung durch M :

5. Patient hat keine Schwierigkeiten die neue Verpackung mit Klebverschluss zu öffnen.
P2: „Die Box ist aber toll“
6. Patient hat keine Anmerkungen oder Schwierigkeiten beim Benutzen des Tuches.
7. Das Tuch wird in einem Müllbeutel, welcher am Nachkästchen befestigt ist, entsorgt.
8. Die Verpackung wird auf Regal des Nachtkästchens, griffbereit neben dem Bett abgelegt.

(In Abwesenheit des Moderators über den Tag hinweg)

11. Bitte verwenden Sie die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf Ihren patientennahen Flächen wie zum Beispiel Esstisch, ausklappbarer Tisch, Nachtschränkchen, Bettgestell oder Griffe.
12. Verwenden Sie die Tücher vor und nach der Benutzung der Toilette. Wischen Sie dabei den **Toilettenrand** ab. Entsorgen Sie die benutzten Tücher in einem Müllbeutel.
13. Benutzen Sie bitte die Tücher im Bad zum Säubern des Waschbeckens oder jeglicher Ablagen oder Spiegels bei Verschmutzung.
14. Wenn Sie Besuch durch Verwandte oder eine Visite vom Pflegepersonal bekommen, wischen Sie die berührten Flächen ab.
15. Bei aktiver Kontamination oder Verschmutzung durch andere Mitpatienten, benutzen Sie die Tücher.

Postsession Interview:

M: Wie fanden Sie die Aufgaben? Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen hatten Sie?

P2.1: Sehr gut. Das einzige [Problem] ,wenn ich mit dem Päckchen auf die Toilette lauf aber ansonsten super.

M: Wo haben Sie die Verpackung gelagert?

P2.2: Hier unten [im Nachtkästchen]. Aber wenn ich geh habe ich die ganze mit rein [ins Bad].

M: War dies für Sie umständlich? Haben Sie sich eine separate Verpackung im Bad gewünscht?

P2.3: Wäre fast geschickter.

M: Was ist Ihnen positiv aufgefallen?

P2.4: Die Sauberkeit. Es ist sauber.

M: Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder Unannehmlichkeiten?

P2.5: Nein. Absolut keine.

M: Wo/ Für welche Flächen haben Sie die Tücher benutzt?

P2.6: Ich habe sie als erstes im Wachbecken, Toilette und dann hinterher das gleiche nochmal, dann habe ich hier den Tisch, wo ich so war. Meinen Rollator.

M: Hatten Sie Probleme bei der Benutzung?

P2.7: Nein, sehr angenehm das Tuch. Von der Größe und vom Geruch wunderbar.

M: Wie viele Tücher/ wie oft haben Sie die Tücher benutzt?

P2.8: Ich nehme sie nur einmal und werfe sie dann weg. Sechs am Tag.

M: Wo haben Sie sie entsorgt?

P2.9: Im Bad ist so ein Mülleimer. Am Bett in den Müllbeutel.

M: Was halten Sie von der Menge und Größe der Verpackung/Tücher?

P2.10: Da habe ich mir keine Gedanken gemacht.

M: Was würden Sie verbessern? (An der Verpackung, Tuch, Lagerung...?)

P2.11: Nein ich finde die super.

M: Wurden Ihre Bedenken bezüglich der Hygiene im Krankenhaus verringert? Hatten Sie ein erhöhtes Sicherheitsgefühl?

P2.12: Ich finde ja. Da hat man schnell was griffbereit, wenn etwas stört und es ist auch angenehm.

M: In welchen Situationen waren die Tücher besonders hilfreich?

P2.13: Auf der Toilette.

M: Würden Sie sich Desinfektionstücher für Ihren Krankenhausaufenthalt wünschen?

P2.14: Ja.

M: Wie würden Sie Ihre Gesamterfahrung zu der Verwendung zusammenfassen?

P2.15: Perfekt. Ja, muss ich sagen.

Unmoderierter Usability Test

18.03 – 19.03

Moderator/Protokollant (M): Kristina Gräfenstein

Teilnehmer Patient (P): P3

Männlich, 65 Jahre, teilt sich Zimmer (mit motivierten Bettnachbarn, die sich mitbeteiligt haben)

Rekrutierungsfragen:

16. Hätten Sie in den kommenden zwei Tagen etwas Zeit, um an einem kurzen Test teilzunehmen?

→ Ja

17. Haben Sie bereits in medizinischen Einrichtungen Desinfektionstücher benutzt?

→ Nein

18. Wären Sie bereit in den zwei Tagen Desinfektionstücher zu benutzen und anschließend mit mir Ihre Erfahrungen bei einer kleinen Befragung zu teilen?

→ Ja

19. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

→ 65 Jahre

20. Welches Geschlecht?

→ Männlich

Testaufgaben:

(In Präsenz)

13. Bitte öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie ein Tuch.

14. Bitte säubern Sie eine Fläche Ihrer Wahl, zum Beispiel den Tisch.

15. Bitte entsorgen Sie das Tuch.

16. Bitte lagern Sie die Verpackung an einen für Sie gut erreichbaren Ort.

Beobachtung durch M :

9. Patient hat keine Schwierigkeiten die neue Verpackung mit Klebverschluss zu öffnen.
10. Patient hat keine Anmerkungen oder Schwierigkeiten beim Benutzen des Tuches.
11. Das Tuch wird in einem Müllbeutel, welcher am Nachkästchen befestigt ist, entsorgt.
12. Die Verpackung wird auf Regal des Nachtkästchens, griffbereit neben dem Bett abgelegt.

(In Abwesenheit des Moderators über den Tag hinweg)

16. Bitte verwenden Sie die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf Ihren patientennahen Flächen wie zum Beispiel Esstisch, ausklappbarer Tisch, Nachtschränkchen, Bettgestell oder Griffe.
17. Verwenden Sie die Tücher vor und nach der Benutzung der Toilette. Wischen Sie dabei den **Toilettenrand** ab. Entsorgen Sie die benutzten Tücher in einem Müllbeutel.
18. Benutzen Sie bitte die Tücher im Bad zum Säubern des Waschbeckens oder jeglicher Ablagen oder Spiegels bei Verschmutzung.
19. Wenn Sie Besuch durch Verwandte oder eine Visite vom Pflegepersonal bekommen, wischen Sie die berührten Flächen ab.
20. Bei aktiver Kontamination oder Verschmutzung durch andere Mitpatienten, benutzen Sie die Tücher.

Postsession Interview:

M: Wie leicht fanden Sie es, die Aufgaben durchzuführen?

P3.1: Die Aufgaben waren leicht. Alles in Ordnung.

M: Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen hatten Sie?

P3.2: Abputzen und drüberfahren ist überhaupt keine Schwierigkeit.

M: Was ist Ihnen positiv aufgefallen? (negativer Punkt)

P3.3: Der Geruch ist nicht so... ein wenig zu stark. Gut, nach zwei Minuten ist er weg, aber manche Vertragen es nicht.

M: Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder Unannehmlichkeiten?

P3.4: Ich nutze schon seit Jahren solche Sachen. Bedenken habe ich immer.

M: Wo/ Für welche Flächen haben Sie die Tücher benutzt?

P3.5: Fensterbänke, Tische, Nachtschränke, die Ablage, das Gelände von dem Bett. Also alles. Alles was möglich ist. Alles, komplettes Zimmer.

M: Wo haben Sie die Verpackung gelagert?

P3.6: Da liegt es [auf der Fensterbank].

M: Haben Sie die Tücher auch im Bad benutzt?

P3.7: Ja. Alle Griffe, den Sitz.

M: Haben Sie die Verpackung dabei mitgenommen?

P3.8: Nein, ich habe mir was rausgenommen.

M: Hätten Sie sich eine Verpackung auch im Bad gewünscht?

P3.9: Es wäre eigentlich nicht schlecht im Bad. Weil dann hätte man eines fürs Zimmer und eins im Bad.

M: Was halten Sie von der Menge und Größe der Verpackung/Tücher?

P3.10: Die Größe ist gut und die Feuchtigkeit, die da drauf ist auch gut. Vielleicht muss man sie oft wechseln. Das reicht gut .

M: Was würden Sie verbessern? (An der Verpackung, Tuch, Lagerung...?)

P3.11 Eine Box wäre bequemer zum Aufmachen, als die Tüte. Man macht einmal auf, dann kann man den Kleber zweimal draufmachen und dann nicht mehr.

M: Wurden Ihre Bedenken bezüglich der Hygiene im Krankenhaus verringert?

P3.12: Ja gut, wahrscheinlich verbessert schon. Aber das hängt nicht von den Flächen ab, sondern im Krankenhaus von den Menschen, von den Leuten was da rein kommt, von den Besuchern her. Das was im Zimmer passiert ist nicht so viel. Aber was da frisch reinkommt, an denen liegt das.

M: In welchen Situationen waren die Tücher besonders hilfreich?

P3.13: Am Tisch, die Sitzbänke. Da wo die Menschen sind.

M: Würden Sie sich Desinfektionstücher für Ihren Krankenhausaufenthalt wünschen?

P3.14: Es wäre nicht schlecht.

M: Hätten Sie dann gerne wieder eine eigene Verpackung oder wäre Ihnen ein Spender lieber?

P3.15: Der [Spender] wäre nicht schlecht. Das würde reichen. [Verpackung wurde zusammen von allen Bettnachbarn genutzt]

M: Wie würden Sie Ihre Gesamterfahrung zu der Verwendung zusammenfassen?

P3.16: Alles gut, schlecht ist es nicht. [Erzählt, dass sich Bettnachbarn gegenseitig bei der Flächenhygiene motiviert haben]. Es war positiv, da hat man gleich Lust gehabt. Er hat den

Vorschlag gemacht „Komm wir machen das jetzt“ Unser Tisch war ein wenig verschmutzt und den haben wir abgewischt. Für uns selber ist es auch gut. Wie gesagt ich nutze es seit Jahren. Bei mir liegt es im Auto. Ich nutze es gerne.

Unmoderierter Usability Test

18.03 – 19.03

Moderator/Protokollant (M): Kristina Gräfenstein

Teilnehmer Patient (P): P4

Männlich, 64 Jahre, teilt sich Zimmer

Rekrutierungsfragen:

21. Hätten Sie in den kommenden zwei Tagen etwas Zeit, um an einem kurzen Test teilzunehmen?

➔ Ja

22. Haben Sie bereits in medizinischen Einrichtungen Desinfektionstücher benutzt?

➔ Nein

23. Wären Sie bereit in den zwei Tagen Desinfektionstücher zu benutzen und anschließend mit mir Ihre Erfahrungen bei einer kleinen Befragung zu teilen?

➔ Ja

24. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

➔ 64 Jahre

25. Welches Geschlecht?

➔ Männlich

Testaufgaben:

(In Präsenz)

17. Bitte öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie ein Tuch.

18. Bitte säubern Sie eine Fläche Ihrer Wahl, zum Beispiel den Tisch.

19. Bitte entsorgen Sie das Tuch.

20. Bitte lagern Sie die Verpackung an einen für Sie gut erreichbaren Ort.

Beobachtung durch M :

13. Patient hat keine Schwierigkeiten die neue Verpackung mit Klebverschluss zu öffnen.

14. Patient hat keine Anmerkungen oder Schwierigkeiten beim Benutzen des Tuches.
15. Das Tuch wird in einem Müllbeutel, welcher am Nachkästchen befestigt ist, entsorgt.
16. Die Verpackung wird auf Regal des Nachtkästchens, griffbereit neben dem Bett abgelegt.

(In Abwesenheit des Moderators über den Tag hinweg)

21. Bitte verwenden Sie die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf Ihren patientennahen Flächen wie zum Beispiel Esstisch, ausklappbarer Tisch, Nachtschränkchen, Bettgestell oder Griffe.
22. Verwenden Sie die Tücher vor und nach der Benutzung der Toilette. Wischen Sie dabei den **Toilettenrand** ab. Entsorgen Sie die benutzten Tücher in einem Müllbeutel.
23. Benutzen Sie bitte die Tücher im Bad zum Säubern des Waschbeckens oder jeglicher Ablagen oder Spiegels bei Verschmutzung.
24. Wenn Sie Besuch durch Verwandte oder eine Visite vom Pflegepersonal bekommen, wischen Sie die berührten Flächen ab.
25. Bei aktiver Kontamination oder Verschmutzung durch andere Mitpatienten, benutzen Sie die Tücher.

Postsession Interview:

M: Wie leicht fanden Sie es, die Aufgaben durchzuführen?

P4.1: Es war einfach. Einfach putzen. Aber normalerweise bin ich keine Putzfrau.

M: Welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen hatten Sie?

P4.2: Nein, keine.

M: Was ist Ihnen positiv aufgefallen?

P4.3: Ich kann das Ihnen nicht sagen. Ich habe noch nie sowas benutzt.

M: Was ist Ihnen negativ aufgefallen?

P4.4: Nichts.

M: Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder Unannehmlichkeiten?

P4.5: Nein, auch nicht.

M: Wo/ Für welche Flächen haben Sie die Tücher benutzt?

P4.6: Den Tisch hab ich geputzt, Toilette auch.

M: Wie haben Sie die Wirkung der Tücher eingeschätzt?

P4.7: Ich habe nichts gemerkt. Ich glaube schon dass alles desinfiziert wird. Mein Kollege hat aber gesagt, es ist eine gute Sache.

M: Wo haben Sie die Verpackung gelagert?

P4.8: Beim Nachtkästchen. Da ist es die ganze Zeit gelegen und liegt bis jetzt noch.

M: Wie viele Tücher/ wie oft haben Sie die Tücher benutzt?

P4.9: Weiß nicht, fünf bis sechs Stück. Heute früh haben sie mir Blut abgenommen und da war es ein wenig dreckig, da hab ich der Krankenschwester eins gegeben.

M: Wo haben Sie sie entsorgt?

P4.10: Im Müll am Bett.

M: Was halten Sie von der Menge und Größe der Verpackung/Tücher?

P4.11: Passt schon. Ist gut.

M: Was würden Sie verbessern? (An der Verpackung, Tuch, Lagerung...?)

P4.12: Weiß nicht. Was könnte ich daran verbessern? Es ist alles gut.

M: Wurden Ihre Bedenken bezüglich der Hygiene im Krankenhaus verringert?

P4.13: Ich hatte keine Bedenken.

M: Gab Ihnen die Verwendung von Desinfektionstüchern ein erhöhtes Sicherheitsgefühl?

P4.14: Es war richtig alkoholisch. Die haben richtig gut geputzt und desinfiziert sozusagen.

M: In welchen Situationen waren die Tücher besonders hilfreich?

P4.15: Vor allem auf der Toilette.

M: Haben Sie die ganze Verpackung immer mitgenommen?

P4.16: Nein, immer nur eins. Was brauche ich die ganze Verpackung?

M: Hätten Sie sich im Bad eine weitere Verpackung gewünscht?

P4.17: Nein, das braucht man nicht. Zuhause kann man das vielleicht im Bad oder so lassen, aber hier nein.

M: Würden Sie sich Desinfektionstücher für Ihren Krankenhausaufenthalt wünschen?

P4.18: Naja, ich bin nicht so oft im Krankenhaus. Weiß nicht kann ich nicht sagen.

M: Wie würden Sie Ihre Gesamterfahrung zu der Verwendung zusammenfassen?

P4.19: Es ist schon gut. Meine Nachbarn meinten es ist eine gute Sache.

Unmoderierter Usability Test

18.03 – 19.03

Moderator/Protokollant (M): Kristina Gräfenstein

Teilnehmer Patient (P): P5

Männlich, 65 Jahre, teilt sich Zimmer

Rekrutierungsfragen:

26. Hätten Sie in den kommenden zwei Tagen etwas Zeit, um an einem kurzen Test teilzunehmen?

→ Ja

27. Haben Sie bereits in medizinischen Einrichtungen Desinfektionstücher benutzt?

→ Nein

28. Wären Sie bereit in den zwei Tagen Desinfektionstücher zu benutzen und anschließend mit mir Ihre Erfahrungen bei einer kleinen Befragung zu teilen?

→ Ja

29. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

→ 65 Jahre

30. Welches Geschlecht?

→ Männlich

Testaufgaben:

(In Präsenz)

21. Bitte öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie ein Tuch.
22. Bitte säubern Sie eine Fläche Ihrer Wahl, zum Beispiel den Tisch.
23. Bitte entsorgen Sie das Tuch.
24. Bitte lagern Sie die Verpackung an einen für Sie gut erreichbaren Ort.

Beobachtung durch M :

17. Patient hat keine Schwierigkeiten die neue Verpackung mit Klebverschluss zu öffnen.
18. Patient hat keine Anmerkungen oder Schwierigkeiten beim Benutzen des Tuches.
19. Das Tuch wird in einem Müllbeutel, welcher am Nachkästchen befestigt ist, entsorgt.

20. Die Verpackung wird auf Regal des Nachtkästchens, griffbereit neben dem Bett abgelegt.

(In Abwesenheit des Moderators über den Tag hinweg)

26. Bitte verwenden Sie die Tücher bei sichtbaren Verschmutzungen auf Ihren patientennahen Flächen wie zum Beispiel Esstisch, ausklappbarer Tisch, Nachtschränkchen, Bettgestell oder Griffe.
27. Verwenden Sie die Tücher vor und nach der Benutzung der Toilette. Wischen Sie dabei den **Toilettenrand** ab. Entsorgen Sie die benutzten Tücher in einem Müllbeutel.
28. Benutzen Sie bitte die Tücher im Bad zum Säubern des Waschbeckens oder jeglicher Ablagen oder Spiegels bei Verschmutzung.
29. Wenn Sie Besuch durch Verwandte oder eine Visite vom Pflegepersonal bekommen, wischen Sie die berührten Flächen ab.
30. Bei aktiver Kontamination oder Verschmutzung durch andere Mitpatienten, benutzen Sie die Tücher.

Postsession Interview:

M: Wie leicht fanden Sie es, die Aufgaben durchzuführen? Gab es Schwierigkeiten?

P5.1: Nein, keine.

M: Was fanden Sie besonders gut oder hilfreich? Was ist Ihnen positiv aufgefallen?

P5.2: Ich bin halt einmal durchgelaufen, was die Leute so berührt haben und habe abgewischt.

M: Wo/ Für welche Flächen haben Sie die Tücher benutzt?

P5.3: Das Bettgestell, Griffe, Tür, Schränke, Toilette, Wasserhahn, Arbeitstisch.

M: Was ist Ihnen negativ aufgefallen?

P5.4: Nichts.

M: Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder Unannehmlichkeiten?

P5.5: Bedenken habe ich schon. Erstens mal, gibt es selten Patienten, die in der Lage sind sowas zu machen, wenn er ans Bett gefesselt ist oder sonst wie gehandicaped ist, das ist das erste. Dann habe ich Bedenken hinsichtlich der Koordination: Wer soll das machen? Wer teilt es zu? Wer teilt es ein? Als nächstes: Wie sieht es aus mit der Haftung? Es gibt ja Keime und Erreger oder was weiß ich, ob das im Nacheinen Schwierigkeiten geben könnte, wenn sich wirklich ein Keim verbreitet. Es heißt dann: „Du hast nicht gescheit geputzt“. Ich unterscheide es zur Händedesinfektion, wo ich schnell diesen mache [reibt sich Hände] oder das Gelände putze. Vor allem da hast du so ein Putztüchle und denkst dir nichts dabei, putzt den Toilettensitz damit, gehst dann an die Türklinke... Da sollte es schon ein Profi machen oder der Putzdienst.

M: Wie würden Sie es als zusätzliche, unterstützende Maßnahme finden?

P5.6: Das genau gleiche Päckchen, dass Sie mir dagelassen haben, liegt eh schon im Bad. Da fehlt es an Aufklärung „Sie können, wenn.... diese Tücher benutzen“. Das habe ich noch nie gehört.

M: Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der Tücher ein? Was halten Sie von der Menge und Größe der Verpackung/Tücher?

P5.7: Größe, Geruch, Feuchtigkeit ist schon in Ordnung, aber für Chrome, Wasserhahn oder den Spiegel ist es ungeeignet. Es ist nicht rückstandsfrei und es gibt eine Schmiererei und Putzstreifen.

M: Wie viele Tücher/ wie oft haben Sie die Tücher benutzt?

P5.8: Sechs Stück.

Was würden Sie verbessern? (An der Verpackung, Tuch, Lagerung...?)

P5.9: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß wie schnell die austrocknen in der Packung.

M: Wo haben Sie die Verpackung gelagert?

P5.10: Genau hier am Nachtkästchen.

M: Die gleiche Verpackung liegt auch genauso im Bad, haben Sie die Tücher aus der eigenen verwendet oder im Bad.

P5.11: Schon eigene und dann bin ich ins Bad und habe gesehen, hoppla, die gibt es auch hier.

M: Finden Sie es gut wenn es eine zweite separate Verpackung im Bad gibt oder reicht ihnen hier eine?

P5.12: Es ist nicht zielführend. Patienten die da liegen, haben hier so ein Päckchen und können nicht aufstehen weil Sie am Tropfen hängen oder Schmerzen haben. Es nicht zielführend. Und wenn es im Bad liegt, die Packung, muss man schon darauf hinweisen „Liebe Leut, die kann man benutzen“. So denkt man es ist nur für den Reinigungsdienst und das Personal.

M: Würden Sie sich für mobile Patienten mit einer erhöhten Compliance eine Aufklärung wünschen?

P5.13: Ja, klar. Abhängig vom Zustand. Wenn man ins Krankenhaus kommt, will man davon gar nichts wissen. Im Prinzip eine Vorlesung über Hygiene und Hände und Putztüchle.

M: Wäre Ihnen eine kurze Information oder ein Hinweis lieber?

P5.14: Das genügt völlig.

M: Wurden Ihre Bedenken bezüglich der Hygiene im Krankenhaus verringert? Hatten Sie ein erhöhtes Sicherheitsgefühl?

P5.15: Mein Gott, das ist Einbildung. Es ist halt nicht sichtbar.

M: Würden Sie sich Desinfektionstücher für Ihren Krankenhausaufenthalt wünschen?

P5.16: Das würde für mich keinen Unterschied machen. Also im Bad liegt es dran, aber keiner weiß wofür es ist, wer das benutzen darf. Wenn jeder auf die Box Zugriff hat finde ich es schon kontraproduktiv.

M: Meinen Sie mit kontraproduktiv, dass da jeder dann hin fasst?

P5.17: Genau das mein ich. Ob es dann zu ist, oder richtig zu. Und vor allem man kann sich nicht auf die Leut verlassen, wenn sich einer eins rausnimmt und macht die Türklinke sauber und dann Toilette und und und... Das würde nicht funktionieren.

M: Was wäre wenn jeder eine eigene Verpackung hätte?

P5.18: Das wäre besser.

M: In welchen Situationen waren die Tücher besonders hilfreich?

P5.19: Auf der Toilette. Ganz klar. Auf so einer Station haben Leute Durchfall und es ist nicht sonderlich sauber. Da finde ich es angebracht, dass man über die Brille fahren kann, bevor man sich draufsetzt.

M: Wie würden Sie Ihre Gesamterfahrung zu der Verwendung zusammenfassen?

P5.20: Wenn man sowas einführen sollte, dann jedem Patient ein kleines Päckchen geben. Bei so einem großen ist es nicht nachhaltig, da kann man es nicht weitergeben denk ich mal, wenn es noch nicht aufgebraucht. Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Wenn man es nach Hause mitnehmen kann, wäre es anders.

Hygieneplan Klinikum Heidenheim

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

 **Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH**

Hygieneplan

Hygienemerkbblatt 36: Rotavirus-Enteritis

Erreger	Rotaviren (unbehüllte, sehr umweltresistente RNA-Viren aus der Familie der Reoviridae)
Inkubationszeit	1 bis 3 Tage
Infektiöses Material	Stuhl, Erbrochenes, kontaminierte Oberflächen; in der akuten Phase der Erkrankung Übertragung über Atemwegssekrete nicht ausgeschlossen; hohe Infektiosität - sehr niedrige Infektionsdosis
Übertragungswege	Fäkal-oral, Kontaktinfektion, kontaminiertes Wasser und Lebensmittel
Meldepflicht	• Labormeldepflicht nach § 7 IfSG Abs. 1 bei direktem oder indirektem Erregernachweis in Verbindung mit einer akuten Infektion • Infektiöse Gastroenteritiden bei Gastronomiemitarbeitern sind namentlich nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 a) IfSG zu melden • Fallhäufungen (≥ 2) von infektiösen Gastroenteritiden sind vom Kliniker nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 b) IfSG namentlich zu melden • Das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen ist nach § 6 Abs. 3 IfSG als Ausbruch nichtnamentlich zu melden
Dauer der speziellen Schutzmaßnahmen	Bis 48 Stunden nach Sistieren der klinischen Symptome (= keine weiteren Durchfälle), bei Immunsupprimierten ggf. länger In Früh- und Neugeborenenbereichen: 3 negative Kontrollabstiche an drei aufeinanderfolgenden Tagen (da die Viren noch über einen längeren Zeitraum (ca. 8 Tage) mit dem Stuhl ausgeschieden werden können, ist auch nach der akuten Erkrankung eine sorgfältige Sanitär- und Händehygiene erforderlich)
Räumliche Unterbringung	• Einzelzimmer mit eigener Nasszelle • Kohortenisolierung bei gleichem Erkrankungsstadium möglich
Schutzkittel	• Langärmeliger, flüssigkeitsabweisender Einmalschutzkittel mit Rückenschluss und Abschlussbündchen an den Ärmeln • Anlegen bei Betreten des Zimmers • Nach Gebrauch im Zimmer bzw. in der Schleuse entsorgen
Handschuhe	• Anlegen bei Betreten des Zimmers • Nach Gebrauch im Zimmer bzw. in der Schleuse entsorgen
Atemschutz	Basishygiene entsprechend Hygieneplan 1.2
Schutzbrille	Basishygiene entsprechend Hygieneplan 1.2

Dokument Name	Verabschiedet am... von...	Gültig bis	Version	roXtra ID
Hygienemerkbblatt Rotavirus-Enteritis	25.03.2021 Hygienekommission	25.03.2024	3	7023

Seite 1

Abbildung 12:Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 1

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsantrag

Hygieneplan

Hygienische Händedesinfektion	• Entsprechend Hygieneplan 1.1 mit Sterillium® classic pure oder Desderman® • Patient: nach jedem Toilettenbesuch • Da die Viren über einen längeren Zeitraum im Stuhl ausgeschieden werden können, sollte noch 8 Tage nach Ende der akuten Erkrankung eine Händedesinfektion nach Toilettenbesuch durchgeführt werden.
Geschirr	Geschirr als letztes in den Wagen stellen, Wagen schließen
Instrumente	In geschlossenem Behälter zur ZSVA geben
Wäsche/Textilien	Wäsche im Zimmer in weiß-blauem Stoffsack entsorgen; Stoffsäcke max. ¾ füllen; Ausschleusen aus dem Zimmer in einem durchsichtigen Plastikübersack
Bett	• Im Zimmer Bettwäsche abziehen • Für Transport: Alle Kontaktflächen (Kopf- und Fußteil, Galgen, Aufrichthilfe, Handgriffe und Bedienelemente, Matratzenoberseite, Nachtkästchen) desinfizieren • Bett desinfizierend aufbereiten • Vor Abtransport Bett mit Folie abdecken und Türaushang dem Bett in Kopie beifügen
Müll	Standardentsorgung (Restmüll schwarzer Müllsack), Säcke max. ¾ füllen; Ausschleusen aus dem Zimmer in einem grünen Plastikübersack
Transporte	• Nur zwingend notwendige Diagnostik außerhalb des Patientenzimmers durchführen • Zieleinrichtung informieren, Wartezeiten vermeiden • Vor Transport im Bett: alle Kontaktstellen desinfizieren • Transportpersonal: Schutzkittel und Einmalhandschuhe, Abwurf in Zieleinrichtung • Patient: frischer Mund-Nasen-Schutz in der akuten Krankheitsphase • Desinfektion aller Patientenkontaktflächen des Transportmittels und der Kontaktflächen in der Funktionsabteilung
Laufende Desinfektion	B: mit Incidin® rapid 0,25 %, Dosiergerät verwenden
Schlussdesinfektion	C: mit Incidin® rapid 0,25 %, Dosiergerät verwenden
Personal	• Erkranktes Personal sollte bei gastrointestinalen Beschwerden unverzüglich vom Dienst befreit werden und darf frühestens 48 Stunden nach Sistieren der klinischen Symptome die Arbeit unter sorgfältiger Beachtung der Händehygiene wieder aufnehmen • Ein Monitoring bzgl. Überwachung der Virusausscheidung ist nicht angezeigt • Da die Viren über einen längeren Zeitraum im Stuhl ausgeschieden werden können, sollte noch 8 Tage nach Ende der akuten Erkrankung eine Händedesinfektion nach dem Toilettenbesuch durchgeführt werden

Dokument Name	Verabschiedet am... von...	Gültig bis	Version	roXtra ID
Hygienemerkblatt Rotavirus-Enteritis	25.03.2021 Hygienekommission	25.03.2024	3	7023

Seite 2

Abbildung 13:Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 2

Abbildung 14:Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 3

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst

Hygieneplan

Impfung	Die Impfung mit Rotaviren nach STIKO kann und soll, wenn indiziert (d.h. wenn das chronologisch Alter für die Impfung erreicht ist, nach einer Risikoabwägung durch den behandelnden Arzt), während des stationären Aufenthaltes bei langliegenden Neugeborenen durchgeführt werden. Es werden Impfviren ausgeschieden, bei Virusübertragungen kommt es in der Regel jedoch nicht zu Erkrankungen bei Nachbarpatienten. Die üblichen Basishygienemaßnahmen reichen aus. Dazu gehören beim Wickeln das Tragen von Schutzkittel und Handschuhen sowie die korrekte Händedesinfektion. Da nach der Impfung mit Rotateq® im Rahmen der enteralen Virusreplikation in seltenen Fällen pathogene Reassortanten (mit der Folge von Symptomen bei Übertragung auf Nichtgeimpfte) entstehen, wird die Impfung mit Rotarix® bevorzugt empfohlen.
----------------	---

☐ Basisplan ☐ < 1m vom Patienten ☐ 5m > 1m vom Patienten ☐ mit Schutzhandschuhen ☐ mit Stoff-Hand ☐ Waschen der Hände ☐ Desinfektionsmittel 2 Mal je 30sec. in die trockenen Hände einwirken ☐ keine besonderen Maßnahmen ☐ transparenter Plastikbezug bei Übergabe auf Fuß notwendig ☐ gelber Plastikbezug bei Übergabe auf Fuß notwendig ☐ Wäsche als Infektionsmüll entsorgen ☐ Ständereinigung ☐ für Transport Alle Kontaminations (Kopf- und Fußteil, Gorden, Autoclave, Handgelenk und Bodenmatten, Matratzen, Bettwäsche, Nachtkleider) desinfizieren, Ausrücken (Kopf- und Fußteil, Gorden, Bettzeug (Kopfkissen + Bettdecke) als Infektionsmüll entsorgen ☐ keine besonderen Maßnahmen ☐ gelber Plastikbezug bei Übergabe auf Fuß notwendig ☐ kontaminiertes Material Infektionsmüll (z. B. verschmutzte Bettwäsche) vor Ausscheidung ☐ Incidin rapid 0.25% / Utasol active 1% / Incidin OxWipe 2	Hand- desinfektion Wäsche Bett, Nachtkleid Abfall Flächen-
---	---

Dokument Name	Verabschiedet am... von...	Gültig bis	Version	roXtra ID
Hygienemerklblatt Rotavirus-Enteritis	25.03.2021 Hygienekommission	25.03.2024	3	7023

Seite 3

Abbildung 15Hygieneplan Klinikum Heidenheim Teil 4

Bilder aus dem Klinikum

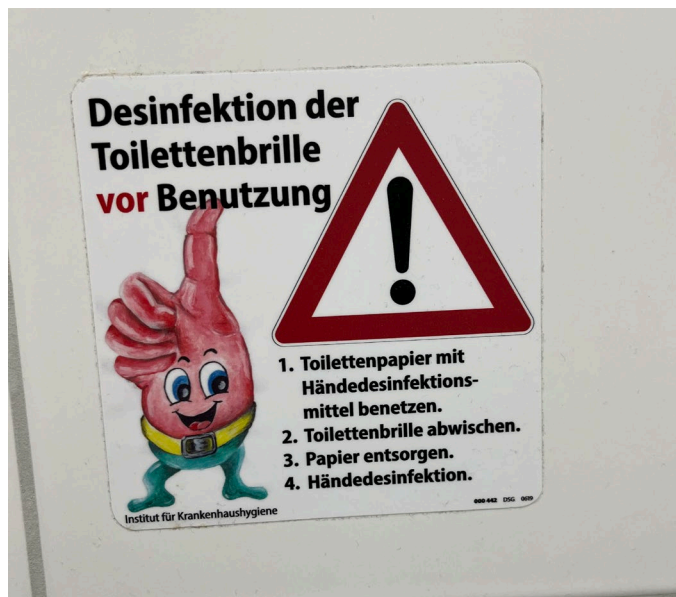


Abbildung 16: Information Besuchertoilette in Kabine (eigene Darstellung)

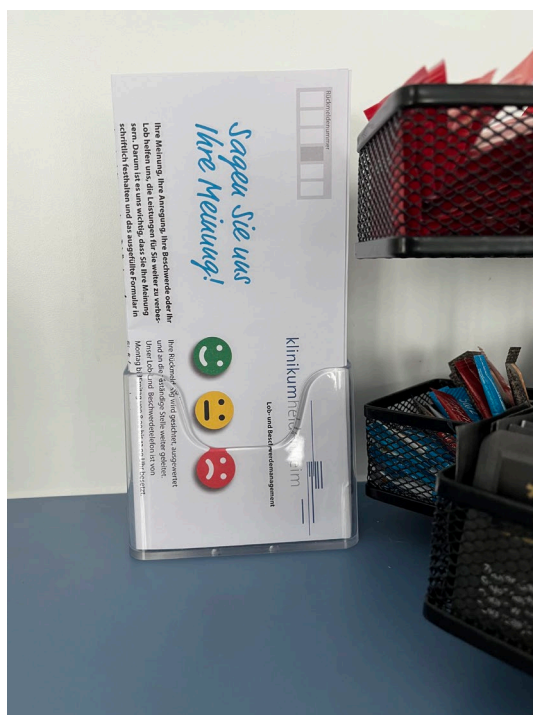


Abbildung 17: Feedbackbögen im Besucherraum (eigene Darstellung)



Abbildung 18: Patientenzimmer (eigene Darstellung)



Abbildung 19: Nachtkästchen (eigene Darstellung)



Abbildung 20: Patientenbadezimmer Teil 1 (eigene Darstellung)



Abbildung 21: Patientenbadezimmer Teil 2 (eigene Darstellung)



Abbildung 22: Patientenbadezimmer Teil 3 (eigene Darstellung)



Abbildung 23: Patientenzimmer Handschuhspender und Desinfektionsmittel (eigene
Darstellung)

Excel-Auswertung Aussagen

Zur besseren Lesbarkeit und Darstellung wurden die Excel Dateien, die zur Auswertung der Aussagen aus den Interviews verwendet wurden, dem beigefügten Ordner angehängt bzw. dem auf dem beigefügten USB-Stick gesichert.

Miro: Affinity Diagram und Card Sorting Auswertung



Aufenthalt der Patienten im Krankenhaus



Desinfektion und Reinigung im Klinikum



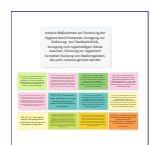
Informationen und Äußerungen zur Flächenhygiene von Patienten



Beteiligung der Patienten an Flächenhygiene



Bacillol 30
sensitive
Tissues



Auswertung Patienteninterviews:

Patienteninformationen

11 Patienten
5 Weiblich
6 Männlich
Zwischen 41-82 Jahren

CA 12: 47 Jahre, Weiblich	CA 17: 78 Jahre, Weiblich	CA 18: 62 Jahre, Weiblich	CA 19: 55 Jahre, Weiblich	CA 20: 68 Jahre, Weiblich
CA 21: 72 Jahre, Weiblich	CA 22: 65 Jahre, Weiblich	CA 23: 75 Jahre, Weiblich	CA 24: 60 Jahre, Weiblich	CA 25: 70 Jahre, Weiblich
CA 26: 58 Jahre, Weiblich	CA 27: 73 Jahre, Weiblich	CA 28: 63 Jahre, Weiblich	CA 29: 77 Jahre, Weiblich	CA 30: 67 Jahre, Weiblich

6 Patienten teilen sich Zimmer mit anderen Patienten;
5 Patienten haben ein Einzelzimmer

CA 12b: 47 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 17b: 78 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 18b: 62 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 19b: 55 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 20b: 68 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer
CA 21b: 72 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 22b: 65 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 23b: 75 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 24b: 60 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 25b: 70 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer
CA 26b: 58 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 27b: 73 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 28b: 63 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 29b: 77 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer	CA 30b: 67 Jahre, Weiblich, teilw. im Zimmer

Meinungen/Einschätzung von Hygiene und Umgang

Hygiene an öffentlichen Orten, ist...

Sehr wichtig, weil an öffentlichen Orten eine hohe Ansteckungsgefahr vorliegt, schneller zu handeln

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, sehr wichtig

Allen Patienten ist der Schutz vor Krankheitserregern sehr wichtig

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, sehr wichtig

Praktische Überlegung von Eingangs- oder Flächen in allen Patientenbereich

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, sehr wichtig

Weniger zum Umgang mit Hygiene, da Patienten nicht darauf achten, sondern eher auf andere

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, weniger wichtig
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, weniger wichtig
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, weniger wichtig	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, weniger wichtig

Der ideale Bettnachbar sollte vor allem das Bett sauber halten und Hände desinfizieren

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, idealer Nachbar

Beteiligung an Flächenhygiene

welche Hygienemaßnahmen leiten die Patienten ein: Hände desinfizieren

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, sehr wichtig
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, sehr wichtig	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, sehr wichtig

7 von 11 Patienten sind an Flächenhygiene beteiligt

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, beteiligt
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, beteiligt
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, beteiligt	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, beteiligt

4 von 11 Patienten sind nicht an Flächenhygiene beteiligt, da sie keine Rolle spielen

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, nicht beteiligt

weil...

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, weil...	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, weil...	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, weil...	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, weil...	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, weil...
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, weil...	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, weil...	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, weil...	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, weil...	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, weil...
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, weil...	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, weil...	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, weil...	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, weil...	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, weil...

Patienten achten aktiv auf Hygiene im Krankenhaus, weil...

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, aktiv
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, aktiv
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, aktiv	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, aktiv

Menschen nach Desinfektionsmittel im Patientenbereich und im Bad

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, nach Desinfektionsmittel

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, alle Patienten haben keine Hygienemaßnahmen

Einschätzung der Krankenhaushygiene

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, Einschätzung
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, Einschätzung
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, Einschätzung	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, Einschätzung

Alle 11 Patienten haben keine Hygienemaßnahmen

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen

Das Klinikum gibt keine Vorgaben bezüglich Hygiene vor, an die sich Patienten halten müssen. Patienten handeln aus Eigeninitiative.

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, Eigeninitiative

Negative Bedirke im Klinikum zur Reinigung

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, negative Bedirke
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, negative Bedirke
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, negative Bedirke	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, negative Bedirke

7 von 11 Patienten haben keine Hygienemaßnahmen

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen

Schutz der Besucher vor Ansteckung:

5 von 11 Patienten schützen ihre Besucher nicht aktiv

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, nicht aktiv
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, nicht aktiv
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, nicht aktiv	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, nicht aktiv

Patienten desinfizieren sich bei Besuch die Hände

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, desinfizieren
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, desinfizieren
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, desinfizieren	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, desinfizieren

Besucher helfen vor sich an Infektionsmaßnahmen und Handhygiene

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, Besucher helfen
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, Besucher helfen
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, Besucher helfen	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, Besucher helfen

Mehr als die Hälfte hat keine Hygienemaßnahmen

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, keine Hygienemaßnahmen

Weniger als die Hälfte nutzt eine Hygienemaßnahme

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, Hygienemaßnahme

nur 2; selten 3; Häufig 3; Immer 3

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, Häufig 3
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, Häufig 3
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, Häufig 3	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, Häufig 3

Nutzung von Desinfektionsprodukten im privaten Bereich:

CA 12: 47 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 17: 78 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 18: 62 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 19: 55 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 20: 68 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel
CA 21: 72 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 22: 65 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 23: 75 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 24: 60 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 25: 70 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel
CA 26: 58 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 27: 73 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 28: 63 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 29: 77 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel	CA 30: 67 Jahre, Weiblich, Desinfektionsmittel

[illegible]

H2,F2,A1: geliebten Patienten aus der Welt, die natürlich auch mit allgemeinen Immunorganen und Immunzellen im Blutgefäß liegen. Und die Fläche im Blutgefäß für Nahrung.	H1,F2,A2: um einfach das Infektionsfeld für die Angewandten und andere Patienten zusammen zu stellen, auch um Personal zu ersetzen.
H1,F2,A3: Weil gerade jetzt, wo wir in der Normalität leben und Pflege oder allgemein alle Angelegenheiten natürlich stark überfordert sind.	H1,F2,A3: Außerdem finde ich, schafft das auch ein Bewusstsein beim Patienten, wie wichtig Nahrung sein kann und wie wichtig Nahrung auch bei Infektion sein sollte.
H2,F2,A2: -wenn sie im Krankenhaus kennenlernen, können sie es natürlich später auch nach Hause mitbringen. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Produktivmoment.	H2,F2,A3: das Risiko einer möglichen Infektion von gefährdeten Patienten ist der Fall von Patienten, die dann eben damit Nahrung nehmen, reduziert und.
H2,F2,A4: natürlich auch das Pflegepersonal, weil die muss natürlich regelmäßig reinigen und desinfizieren.	H2,F2,A3: Ich bin der Person kann viel besser sein, wenn sie selber dazu beitragen, dass mein Risiko reduziert wird und sich nicht davon abwaschen, dass mir jemand aus der Umgebung (Pflegepersonal) oder eben auch das Pflegepersonal mit sich gibt.
H1,F2,A5: Jede Desinfektion vermindert das Infektionsrisiko.	H1,F2,A4: -I, falls eine andere Situation besteht, -I, Der Patient kann es auch machen, ist nicht durch angestrengt, dass ein Personal kontrolliert.
H2,F2,A4: nicht nur die Desinfektionsmittel, sondern auch eine Handgelenkung. Der Patient könnte es auch einfach tun, wenn er seine eigene Umgebung in ein bisschen sauberer halten kann.	

H02_P1_K2: „Wenn auch ohne Handschuhe anwenden kann [...] wenn Patienten oder wenn man es zu Hause anwenden will, muss man nicht immer einen Handschuh mit annehmen, man kann es auch wunderbar in die Hand nehmen und anwenden.“	H01_F1a_K3: „Zu Bewusstseinsverlust gehen Bakterien und Infektionen auf und machen viele, also Grippeinfen, Coronaviren oder SARS. Da ist die 30 Sekunden voll wirksam.“
H01_P1_K1: „Auf Abstreifer handbucht geprüft und wir haben es auch schon in der Praxis selbst, weil es eine ausgiebige Nutzung bringt bei der Patienten keine Handgelenke auf. Bei Handwäsche muss man die Hände waschen, Handgelenke waschen.“	H02_P1_K1: „es ist wirksam gegen die 30 Sekunden Keime, also Bakterien und Viren, die in ein Krankenhaus in der Routine vorkommen und Wirkum natürlich auch in der Zeit, also innerhalb von einer Minute.“

H01_F2_A2: Dadurch, dass das Produkt auch so hautfreundlich ist, ist es auch nicht schlimm, wenn es ohne Handschuhe verwendet wird.	H01_F2b_A6: Desinfektionsmittel werden aber bevor der sie zugelassen werden, nach verschiedenen Normen getestet.
---	--

H01_F1_A1 : sehr
verträglich und löst
auch keine Allergien
aus

H01_F2_A1: Das Produkt ist sehr materialverträglich, also sie können damit auch über Flächen wischen, ohne, dass jetzt Gefahr besteht, dass irgendeine Fläche oder ein Medizinprodukt Schaden nimmt.

H01_F2c_A7 : die hohe Materialfreundlichkeit.

von fidei_A12 : Es riecht ein bisschen
kohlensäure, aber nicht, dass es in der
Haut brennt, wie wenn man jetzt zum
ersten Mal gegessen würde oder so [...]
ist das ein Gefühl von Sauberkeit und
Defekation vermittelt.

H01_F2e_A12: Man kann die Tücher ganz normal entsorgen. Wenn sie kontaminiert sind, müssen sie gewaschen/entsorgt werden. Aber das ist im Krankenhaus üblich.

[illegible]

H02_F3_A2 : Man darf sie nicht in die Toilette werfen das heißt, die korrekte Entsorgung ist wichtiger.

H01_F3a_A2 : Patientennähe, irgendein Tisch [...] so klassische Flächen, wo ich denke, da könnte der Patient eigenverantwortlich auch einmal drüber wischen.

H02_F2a_A4: Alle diese Flächen, die man berührt, also wo man Hand drauf legt. Telefone, Tastatur, Tische, Bettkanten, Bett, ... Natürlich Toilettendeckel, Toile

W4, F4, A1 – dass das Produkt über die Wirkung von der Wirkung des Produktes aus, dass, was sich gerade auf der Fläche befindet, angenommen ist. Ist eine Durchdringung mit einem bestimmten Gegenstand, muss ich auch sicherstellen, dass das Produkt dann genau und das Produkt selbst enthält.

H01_F4_A3: Ich würde mir wünschen, dass da auch ein bisschen Schulung oder Training beim Patienten stattfindet

H01_F3a_A4 : Gerade wenn man sich zu zweit die Sanitäranlagen teilt oder die Nasszelle teilt, im Mehrbettzimmer oder so.

H02_FEa_A3: Man darf nicht den Patienten für die Flächenhygiene Verantwortung geben, das ist die Verantwortung des Krankenhauses, [...] es ist ein Selbstschutzprozess.

H01_F4_Aid : ja, man muss sicher und es klar sein, dass das, was der Patient macht, nicht das ersetzt, was momentan passiert. Es ist nur ein Add-on, ein Zusatz sozusagen.

H01_F5_A2 : das Krankenhaushausventil nicht beschädigt wird also im Rahmen von teuren Geräten oder Rächen, wo klar ist, dass die nicht desinfiziert werden dürfen.

H01_F5_A1 : [...] dass er es nicht falsch anwendet, für sich selber, [...] jetzt Make-up Entfernung.

H02_F4_A1 : jetzt in einem
Zentralzimmer würde ich idealerweise
viel Ablageorte vorsehen. Der eine
Lageort ist natürlich die Toilette. [...]
hält auch die die WC Rolle ist, in der
s. Man kann es an die Wand hängen

H02_F4_A2 : Im Zimmer reicht ein Ablageort, der gut erreichbar ist und den man teilen kann, wenn man zum Beispiel ein

421_F4_A2: in einer Art Halterung in der Nähe des Patienten anbringen, aberung bewegen, damit es nicht erschwindet oder eingesteckt wird.

H01_FSb_A5 : Halterung ins Bett macht, dann ist es auch immer dabei, wenn der Patient sich bewegt

St_F8b_A6: so kleine Fächer, so im Chranksystem so ein kleines Loch, das man aufmachen kann, da kommt das Flowpack, also die Packung dann rein,

101_FSb_A7: Ansonsten sehe ich eher, dass jeder Patient eine individuelle, ein eigenes

H22_F6_A1: natürlich so auch im W...
dass es möglich wäre, die Flächen s...
desinfizieren, gibt es zum Teil ja di...
Produkte nicht. Das heißt, wenn ich j...
nicht produktiv, dann vielleicht als...
Benutzer, schon
Flächendesinfektionsmittel mit I...

H02_F6_A2: natürlich auch eine
Frage ist [...] die Pflegekraft macht
etwas Falsches, ist immer so ein
bißchen eine Hürde. Das ist ja auch
Arbeit, die sie machen. [...] oder weil
auch vielleicht das Gefühl hat, ich ver-
danne als Fachkraft darzustellen

1401_F4_A5 : [...] irgendein 2. Stationen miteinander zu vergleichen. Die einen benutzen das Tuch, die anderen benutzen das nicht, dann müsste man über einen längeren Zeitraum schauen

Witz, J. & J. - wir haben hier das mal so gesehen. Ich weiß nicht ob das langweilig sein könnte. Das ist schon so sagen. Es wäre eine sehr uninteressante Studie, langweilig sein könnte, das ist eigentlich die Frage, die man sich über das Thema stellen sollte. Ich würde mir das mal so vorstellen, dass man sich das mal so vorstellen sollte, dass man sich das mal so vorstellen sollte.

H01_F6_A1 : in
Arztpraxen ist
Flächenhygiene nicht
so im Fokus
